Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Muh. Abdurrouf • Iwan Ardian • Putro Simeulu • Thahirah
Hetti Marlina Pakpahan • Sri Hayulita • Sri Wahyuni

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



BUKU AJAR
MANAJEMEN KEPERAWATAN

Penulis:
Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep, Ns. M.Kep.
Dr. Iwan Ardian, SKM., S.Kep., M.Kep.
Ns. Putro Simeulu, S.Kep., M.Kep.
Thahirah, S.kep., Ns., M.Kep.
Hetti Marlina Pakpahan, S.kep., Ners., M.Kep.
Ns. Sri Hayulita, S.Kep, M.Kep
Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:
Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar Manajemen Keperawatan

Penulis:
Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep, Ns. M.Kep.
Dr. Iwan Ardian, SKM., S.Kep., M.Kep.
Ns. Putro Simeulu, S.Kep., M.Kep.
Thahirah, S.kep., Ns., M.Kep.
Hetti Marlina Pakpahan, S.kep., Ners., M.Kep.
Ns. Sri Hayulita, S.Kep, M.Kep
Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:
Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-65-1

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Ajar Manajemen Keperawatan** ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai konsep dan penerapan manajemen dalam pelayanan keperawatan, mulai dari konsep dasar manajemen, kepemimpinan, perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen kinerja, mutu dan keselamatan pasien, hingga manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan. Pembahasan disusun dengan menghubungkan landasan teori dengan situasi yang dijumpai dalam praktik pelayanan sehingga pembaca dapat memahami bahwa manajemen keperawatan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga berperan penting dalam menjaga efektivitas pelayanan, keselamatan pasien, kualitas kerja tim, dan keberlangsungan organisasi pelayanan kesehatan.

Buku ini terdiri atas tujuh bab yang saling berkaitan. Bab awal membahas konsep dasar manajemen keperawatan serta kepemimpinan dan berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam praktik. Pembahasan dilanjutkan dengan perencanaan strategis dan operasional unit keperawatan, manajemen sumber daya manusia yang mencakup *staffing*, *scheduling*, analisis beban kerja, *skill mix*, pengelolaan shift, serta evaluasi tenaga. Bab selanjutnya menguraikan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan perawat, kemudian manajemen mutu, keselamatan pasien, insiden keselamatan, dan manajemen risiko. Pada bagian akhir, buku membahas manajemen perubahan, inovasi, serta informatika keperawatan sebagai bagian dari upaya adaptasi pelayanan terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Untuk memperkuat pemahaman, materi dilengkapi dengan studi kasus, *mini case*, aktivitas pemecahan masalah, OSCE, DOPS, rangkuman, serta tabel *red flags* dan eskalasi.

Penulis berharap **Buku Ajar Manajemen Keperawatan** ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, pendidik, perawat klinis, kepala ruangan, serta tenaga keperawatan lain yang ingin memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan pelayanan keperawatan. Buku ini diharapkan tidak hanya membantu pembaca memahami teori manajemen, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, memimpin tim, mengelola sumber daya, meningkatkan mutu, serta menghadapi perubahan dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih dapat terus disempurnakan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan praktik manajemen keperawatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN **1**
A. Pendahuluan 2
B. Konsep Manajemen Keperawatan 2
C. Teori dan Model Manajemen Keperawatan 9
D. Fungsi Manajemen dalam Keperawatan 15
E. Peran dan Kompetensi Manajer Keperawatan 17
F. Mini-Case Manajemen Keperawatan (Diskusi Kelompok) 18
G. Referensi 19

BAB 2 KEPEMIMPINAN DAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN **23**
A. Pengertian Kepemimpinan dalam Keperawatan 24
B. Fungsi Kepemimpinan dalam Keperawatan 24
C. Karakteristik Pemimpin Keperawatan yang Efektif 24
D. Teori Kepemimpinan dalam Keperawatan 25
E. Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan 25
F. Kepemimpinan Situasional dalam Keperawatan 26
G. Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja Tim 26
H. Peran Pemimpin Keperawatan dalam Praktik Klinis 26
I. Kepemimpinan, Delegasi, dan Supervisi 27
J. Kepemimpinan dan Keselamatan Pasien 27
K. Aktivitas 1 — Knows How 27
L. Aktivitas 2 — Shows How 28
M. OSCE 29
N. Rubrik Penilaian 30
O. Rangkuman Masteri 40
P. Tabel Red Flags & Eskalasi 42
Q. Daftar Pustaka 44

BAB 3 PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL UNIT KEPERAWATAN **45**

A. Pendahuluan....45
B. Definisi Perencanaan Strategis dalam Keperawatan....45
C. Definisi Perencanaan Operasional dalam Keperawatan....46
D. Tujuan Perencanaan dalam Unit Keperawatan....47
E. Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Keperawatan....47
F. Teori Pendukung dalam Perencanaan Keperawatan....49
G. Hambatan dalam Perencanaan Unit Keperawatan....49
H. Peran Kepala Ruangan dalam Perencanaan....50
I. Rangkuman Materi....50
J. Studi Kasus 1: Keterlambatan Dokumentasi Asuhan Keperawatan....51
K. Studi Kasus 2: Peningkatan Risiko Pasien Jatuh....51
L. Studi Kasus 3: Kekurangan Tenaga Perawat di IGD....51
M. Daftar Pustaka....52

BAB 4 MANAJEMEN SDM KEPERAWATAN (STAFFING & SCHEDULING).....55
A. Konsep Dasar Manajemen SDM Keperawatan....59
B. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Keperawatan....70
C. Karakteristik Unit Pelayanan....77
D. Jumlah dan Tingkat Ketergantungan Pasien....78
E. Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga....79
F. Perencanaan Tenaga Berdasarkan Kebutuhan Pelayanan....81
G. Analisis Beban Kerja Tenaga Keperawatan....83
H. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan....95
I. Staffing dan Penempatan Tenaga Keperawatan....106
J. Skill Mix dan Model Penugasan Keperawatan....114
K. Konsep dan Prinsip Scheduling Tenaga Keperawatan....125
L. Penyusunan Jadwal Dinas dan Pengelolaan Shift....135
M. Kelelahan Kerja dan Keselamatan dalam Sistem Shift....145
N. Evaluasi dan Optimalisasi Staffing dan Scheduling....158
O. Latihan Soal....171
P. Rangkuman Materi....176
Q. Daftar Pustaka....178
R. Glosarium....179

BAB 5 MANAJEMEN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENDIDIKAN.....181
A. Pendahuluan....182

B. Konsep Manajemen Kinerja Keperawatan 184
C. Pengembangan Kompetensi Perawat 197
D. Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan 202
E. Aktivitas 1 — Knows How 208
F. Aktivitas 2 — Problem Solving 209
G. Daftar Pustaka 211

BAB 6 MANAJEMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 215
A. Pendahuluan 217
B. Konsep Dasar Manajemen Mutu 218
C. Konsep Dasar Keselamatan Pasien 233
D. Insiden Keselamatan Pasien Dan Manajemen Resiko 239
E. Mini Case 244
F. Rangkuman Materi 245
G. Daftar Pustaka 246

BAB 7 MANAJEMEN PERUBAHAN, INOVASI, DAN INFORMATIKA KEPERAWATAN 251
A. Teori Dasar 255
B. Faktor Keberhasilan Perubahan 255
C. Konsep Inovasi Keperawatan 255
D. Informatika Keperawatan 256
E. Langkah Menyusun Rencana Perubahan 256
F. Analisis Kasus 257
G. Aktivitas Belajar 257
H. DOPS (Does) 270
I. Rangkuman Materi 279
J. Tabel Red Flags & Eskalasi 280
K. Daftar Pustaka 284

PROFIL PENULIS 287

BAB 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN

CPL	CPMK	Sub-CPMK
CPL 1 Menerapkan prinsip profesionalisme, etik-legal, dan tata kelola layanan dalam manajemen keperawatan.	CPMK 1 Menjelaskan konsep, fungsi, dan prinsip dasar manajemen keperawatan serta implikasinya pada tata kelola unit.	1.1 Menguraikan fungsi manajemen (perencanaan–pengorganisasian–pelaksanaan–pengendalian) pada konteks unit. 1.2 Mengidentifikasi prinsip tata kelola, akuntabilitas, dan peran manajer keperawatan pada skenario.
	CPMK 2 Menganalisis kepemimpinan, pengambilan keputusan, delegasi, dan supervisi untuk mencapai tujuan unit keperawatan.	1.3 Menganalisis konsep dan, pengambilan keputusan, serta prinsip delegasi dalam manajemen keperawatan berdasarkan teori dan situasi klinik. 1.4 Mengevaluasi penerapan kepemimpinan, pengambilan keputusan, delegasi, dan supervisi dalam pengelolaan unit keperawatan untuk meningkatkan kinerja tim dan mutu pelayanan.
	CPMK 6 Menerapkan manajemen mutu dan keselamatan pasien termasuk audit, indikator mutu, dan tindak lanjut perbaikan.	1.5 Menganalisis konsep manajemen mutu termasuk indikator mutu dan proses audit keperawatan dalam pelayanan kesehatan. 1.6 Menerapkan langkah-langkah manajemen mutu interpretasi indikator, serta penyusunan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan di unit keperawatan.

Uraian Materi

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menentukan mutu dan keselamatan pasien. Perawat menjadi tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan pasien, sehingga kualitas pelayanan keperawatan sangat memengaruhi hasil pelayanan secara keseluruhan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan yang sistematis, terarah, dan berbasis ilmu pengetahuan melalui penerapan manajemen keperawatan.

Manajemen keperawatan berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan mutu pelayanan mendorong perawat untuk tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pengelola pelayanan yang profesional. Kemampuan manajerial menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh perawat dalam berbagai tatanan pelayanan, baik di rumah sakit maupun di komunitas.

Bab ini membahas konsep dasar manajemen keperawatan yang meliputi definisi, ruang lingkup, filosofi dan nilai profesional, serta peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan. Pembahasan juga mencakup teori dan model manajemen keperawatan sebagai landasan dalam pengelolaan pelayanan, serta fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Peran dan kompetensi manajer keperawatan menjadi bagian penting yang dibahas untuk memberikan gambaran tentang kemampuan yang diperlukan dalam praktik manajerial.

Pemahaman terhadap konsep manajemen keperawatan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Penguasaan konsep ini memungkinkan perawat untuk mengelola pelayanan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Penerapan manajemen keperawatan yang baik akan mendukung terciptanya pelayanan yang aman, bermutu, serta mampu menjawab tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang dinamis (Alnajjar, 2022; Arslanlı et al., 2025; Cisic et al., 2025; Pinto- & Pérez-, 2025).

B. Konsep Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengelola sumber daya keperawatan secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang bermutu. Konsep ini tidak hanya

berfokus pada pengaturan tenaga keperawatan, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan pelayanan, sistem kerja, serta pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien. Manajemen keperawatan berkembang dari konsep manajemen umum yang diadaptasi ke dalam konteks pelayanan kesehatan. Pendekatan ini menekankan bahwa perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pengelola pelayanan yang bertanggung jawab terhadap kualitas, kontinuitas, dan akuntabilitas pelayanan keperawatan. Hal ini menjadikan manajemen keperawatan sebagai elemen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan modern .

Secara konseptual, manajemen keperawatan mencakup serangkaian fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan pelayanan dan strategi pencapaiannya berdasarkan kebutuhan pasien dan sumber daya yang tersedia. Pengorganisasian berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan koordinasi antar anggota tim keperawatan. Pengarahan menekankan pada kemampuan kepemimpinan dalam memotivasi, membimbing, dan mengarahkan tenaga keperawatan agar bekerja secara optimal. Pengendalian dilakukan melalui proses evaluasi dan monitoring untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Konsep manajemen keperawatan juga tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai profesional, seperti caring, etika, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan manajerial, sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga bermakna secara humanistik. Pendekatan sistem dalam manajemen keperawatan menempatkan pelayanan keperawatan sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas. Setiap komponen, baik input (tenaga, sarana, metode), proses (asuhan keperawatan), maupun output (hasil pelayanan), saling berinteraksi dan memengaruhi kualitas pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, manajer keperawatan dituntut untuk mampu mengintegrasikan berbagai komponen tersebut secara optimal (Ardian et al., 2023; Kiwanuka et al., 2021; Saifan et al., 2021).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendorong perubahan dalam konsep manajemen keperawatan. Digitalisasi layanan kesehatan, penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit, serta penerapan evidence-based practice menjadi bagian integral dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Tantangan ini menuntut perawat, khususnya manajer keperawatan, untuk memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, konsep manajemen keperawatan merupakan

fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang profesional. Penguasaan konsep ini memungkinkan perawat untuk tidak hanya memberikan asuhan yang berkualitas, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Layden et al., 2024; Reynolds, 2021).

1. Definisi manajemen dan manajemen keperawatan

Manajemen secara umum didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Konsep ini menekankan bahwa manajemen bukan hanya sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan pengambilan keputusan, koordinasi, serta optimalisasi sumber daya manusia dan non-manusia. Menurut pendekatan klasik, manajemen dipandang sebagai fungsi-fungsi yang terstruktur dan rasional dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa manajemen juga melibatkan aspek perilaku manusia, hubungan interpersonal, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Oleh karena itu, manajemen modern tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses dan kualitas interaksi dalam organisasi (Ilhami, 2022; Peronja, 2024; Todingbua et al., 2024).

Manajemen keperawatan merupakan aplikasi prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pelayanan keperawatan. Manajemen keperawatan diartikan sebagai suatu proses pengelolaan pelayanan keperawatan melalui pemanfaatan sumber daya keperawatan secara optimal untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Fokus utama manajemen keperawatan adalah menjamin terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional, berkesinambungan, dan sesuai dengan standar praktik serta kode etik keperawatan. Manajemen keperawatan tidak hanya mencakup pengelolaan tenaga keperawatan, tetapi juga melibatkan pengaturan sistem pelayanan, pengembangan kompetensi perawat, serta pengendalian mutu pelayanan. Dalam praktiknya, manajemen keperawatan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap intervensi keperawatan dilakukan secara terkoordinasi, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun hukum.

Pendekatan manajemen keperawatan juga menekankan pentingnya integrasi antara aspek klinis dan manajerial. Perawat, khususnya yang berada pada posisi manajerial, dituntut untuk mampu menggabungkan kemampuan

klinis dengan keterampilan manajemen, seperti kepemimpinan, komunikasi efektif, pengambilan keputusan, serta manajemen konflik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan(Aqtash et al., 2022; Jun, 2017; Kiwanuka et al., 2021; Mehrad et al., 2022; Suwarno, 2023; Yusnaini et al., 2021).

2. Ruang lingkup dalam pelayanan kesehatan

Ruang lingkup manajemen keperawatan dalam pelayanan kesehatan mencakup seluruh aktivitas pengelolaan pelayanan keperawatan yang terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Lingkup ini tidak hanya berfokus pada pemberian asuhan keperawatan secara langsung, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya, sistem pelayanan, serta upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Manajemen keperawatan memiliki peran strategis karena berada pada posisi yang menghubungkan antara pelayanan klinis dengan sistem organisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ruang lingkupnya dapat dijelaskan menurut (Maweikere et al., 2021; Ridlon et al., 2021) melalui beberapa aspek utama berikut:

a. Pengelolaan Pelayanan Asuhan Keperawatan

Manajemen keperawatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Proses ini melibatkan pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, serta evaluasi hasil. Pengelolaan asuhan dilakukan secara sistematis untuk menjamin kontinuitas dan kualitas pelayanan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan

Lingkup ini meliputi manajemen tenaga keperawatan, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja. Selain itu, mencakup pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan keperawatan agar berjalan efektif dan efisien.

c. Pengorganisasian Sistem Pelayanan Keperawatan

Manajemen keperawatan berperan dalam menentukan model praktik keperawatan yang digunakan, seperti primary nursing, team nursing, atau metode lainnya. Pengorganisasian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi tim, efisiensi kerja, serta mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.

d. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien

Ruang lingkup ini mencakup pengembangan dan penerapan standar pelayanan keperawatan, audit keperawatan, serta upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Manajer keperawatan juga bertanggung jawab dalam membangun budaya keselamatan pasien serta meminimalkan risiko kejadian tidak diinginkan.

e. Kolaborasi Interprofesional

Pelayanan kesehatan bersifat multidisiplin, sehingga manajemen keperawatan mencakup koordinasi dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter, apoteker, ahli gizi, dan profesi lainnya. Kolaborasi ini penting untuk menjamin pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien.

f. Manajemen Informasi dan Dokumentasi Keperawatan

Pendokumentasian asuhan keperawatan menjadi bagian penting dalam manajemen keperawatan. Dokumentasi yang akurat dan lengkap berfungsi sebagai alat komunikasi, bukti hukum, serta dasar evaluasi mutu pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, juga menjadi bagian dari lingkup ini.

g. Pengembangan Profesional dan Pendidikan Keperawatan

Manajemen keperawatan mencakup upaya peningkatan kapasitas perawat melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan pengembangan karier. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga keperawatan dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi.

h. Manajemen Lingkungan dan Budaya Kerja

Lingkup ini melibatkan penciptaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kinerja perawat. Budaya kerja yang positif, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang inspiratif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja tim keperawatan.

Secara keseluruhan, ruang lingkup manajemen keperawatan dalam pelayanan kesehatan bersifat luas dan komprehensif, mencakup aspek klinis, administratif, dan profesional. Pemahaman yang menyeluruh terhadap ruang lingkup ini memungkinkan manajer keperawatan untuk mengelola pelayanan secara optimal, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

3. Filosofi dan nilai profesional keperawatan

Filosofi keperawatan merupakan landasan pemikiran yang menjadi dasar dalam memberikan asuhan keperawatan serta dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Filosofi ini mencerminkan keyakinan, pandangan, dan nilai yang dianut oleh profesi keperawatan terhadap manusia, kesehatan, lingkungan, dan praktik keperawatan. Dalam konteks manajemen keperawatan, filosofi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, serta pengelolaan sumber daya keperawatan secara etis dan profesional.

Filosofi keperawatan menempatkan manusia sebagai makhluk holistik yang memiliki kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual. Pelayanan keperawatan diberikan dengan menghargai martabat, hak, dan nilai-nilai yang dimiliki setiap individu. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang adil, aman, dan bermutu tanpa diskriminasi. Keperawatan juga memandang kesehatan sebagai suatu kondisi dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pelayanan keperawatan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Nilai profesional keperawatan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman perilaku perawat dalam menjalankan praktiknya. Nilai-nilai ini tidak hanya mengatur hubungan perawat dengan pasien, tetapi juga dengan keluarga, tim kesehatan, dan masyarakat. Salah satu nilai utama dalam keperawatan adalah *caring*, yaitu sikap peduli yang diwujudkan melalui perhatian, empati, dan kehadiran terapeutik dalam memberikan asuhan. Caring menjadi inti dari praktik keperawatan karena membedakan keperawatan dari profesi kesehatan lainnya.

Nilai etika menjadi bagian penting dalam profesionalisme keperawatan. Perawat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, seperti menghormati otonomi pasien, berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), serta keadilan (*justice*). Penerapan nilai etika sangat penting dalam pengambilan keputusan klinis maupun manajerial, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh dilema.

Tanggung jawab dan akuntabilitas merupakan nilai yang harus dimiliki oleh perawat profesional. Setiap tindakan keperawatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etik, dan hukum. Perawat dituntut bekerja sesuai dengan standar praktik, prosedur operasional, serta regulasi yang berlaku. Dokumentasi yang akurat dan lengkap menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dalam praktik keperawatan.

Nilai profesional lainnya meliputi integritas, kolaborasi, dan komitmen terhadap pengembangan diri. Integritas mencerminkan kejujuran dan konsistensi dalam bertindak sesuai dengan nilai dan standar profesi. Kolaborasi menunjukkan kemampuan perawat untuk bekerja sama secara efektif dengan tim kesehatan lain dalam memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien. Komitmen terhadap pengembangan diri diwujudkan melalui upaya pembelajaran berkelanjutan dan penerapan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Sehingga dalam konteks manajemen keperawatan, filosofi dan nilai profesional menjadi dasar dalam membangun budaya organisasi yang positif. Manajer keperawatan berperan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh tenaga keperawatan melalui kepemimpinan yang teladan, komunikasi yang efektif, serta sistem penghargaan dan pengembangan yang mendukung profesionalisme.

Filosofi dan nilai profesional keperawatan tidak hanya menjadi konsep abstrak. Nilai-nilai tersebut harus terinternalisasi dalam setiap tindakan perawat. Penerapan yang konsisten akan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

4. Peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan

Manajemen keperawatan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena menjadi penghubung antara pelayanan klinis dan pengelolaan organisasi. Posisi ini menempatkan manajemen keperawatan sebagai elemen kunci dalam menjamin mutu pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keselamatan pasien.

Pelayanan keperawatan merupakan komponen terbesar dalam layanan kesehatan yang berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam. Kondisi ini menjadikan manajemen keperawatan berperan penting dalam memastikan kontinuitas asuhan, koordinasi pelayanan, serta pencapaian hasil kesehatan yang optimal. Kualitas pelayanan keperawatan sangat memengaruhi kepuasan pasien dan citra institusi pelayanan kesehatan.

Peran strategis manajemen keperawatan terlihat dalam pengelolaan sumber daya manusia keperawatan. Perencanaan kebutuhan tenaga, pengaturan beban kerja, serta pengembangan kompetensi perawat menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja pelayanan. Pengelolaan yang efektif akan meningkatkan produktivitas, menurunkan kejadian kesalahan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Manajemen keperawatan juga berperan dalam pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Keputusan yang diambil harus berbasis data, standar praktik, serta prinsip keselamatan pasien. Kemampuan analisis dan kepemimpinan menjadi kunci dalam menghadapi situasi kompleks di pelayanan kesehatan yang dinamis.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Manajemen keperawatan bertanggung jawab dalam penerapan standar pelayanan, pelaksanaan audit keperawatan, serta pengembangan program peningkatan mutu berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kejadian tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas hasil pelayanan.

Kolaborasi interprofesional menjadi bagian integral dari peran strategis manajemen keperawatan. Koordinasi dengan tenaga kesehatan lain memungkinkan terciptanya pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Manajer keperawatan berperan dalam membangun komunikasi yang efektif dan kerja sama tim yang solid.

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan turut memperluas peran manajemen keperawatan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit, dokumentasi elektronik, serta data berbasis digital mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Adaptasi terhadap perkembangan ini menjadi tuntutan bagi manajer keperawatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Manajemen keperawatan juga memiliki kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi pelayanan kesehatan. Keterlibatan dalam perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, serta evaluasi kinerja organisasi menunjukkan bahwa peran manajemen keperawatan tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis.

Peran strategis manajemen keperawatan pada akhirnya menentukan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Optimalisasi peran ini akan meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi organisasi, serta keselamatan pasien secara berkelanjutan.

C. Teori dan Model Manajemen Keperawatan

Teori dan model manajemen keperawatan merupakan landasan ilmiah yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengelola pelayanan keperawatan secara sistematis. Keberadaan teori memberikan kerangka konseptual dalam pengambilan keputusan, sedangkan model memberikan gambaran operasional dalam penerapan praktik keperawatan di lapangan. Pemahaman yang mendalam

terhadap teori dan model menjadi penting untuk menjamin pelayanan yang efektif, efisien, dan bermutu.

1. Teori manajemen (klasik, neoklasik, modern)

Teori manajemen merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi dikelola secara efektif dan efisien. Perkembangan teori manajemen menunjukkan adanya pergeseran fokus dari aspek struktural menuju pendekatan yang lebih humanistik dan adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks manajemen keperawatan, pemahaman terhadap teori-teori ini sangat penting untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang optimal.

a. Teori Manajemen Klasik

Teori manajemen klasik menekankan pada efisiensi kerja, struktur organisasi, serta pembagian tugas yang jelas. Pendekatan ini berkembang pada era revolusi industri yang menuntut produktivitas tinggi.

Tokoh utama dalam teori ini adalah Frederick Winslow Taylor yang mengembangkan *scientific management*. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan efisiensi kerja melalui standarisasi prosedur dan pengukuran waktu kerja. Penerapan dalam keperawatan terlihat pada penggunaan standar operasional prosedur (SOP) dalam tindakan keperawatan.

Tokoh lain adalah Henri Fayol yang mengemukakan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Konsep ini menjadi dasar dalam praktik manajemen keperawatan hingga saat ini.

Teori klasik memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem kerja yang terstruktur. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena kurang memperhatikan aspek manusia dan hubungan sosial dalam organisasi.

b. Teori Manajemen Neoklasik

Teori manajemen neoklasik berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan teori klasik. Pendekatan ini menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi, termasuk motivasi, komunikasi, dan hubungan interpersonal.

Tokoh penting dalam teori ini adalah Elton Mayo melalui penelitian Hawthorne. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan sosial dan psikologis pekerja dapat meningkatkan produktivitas.

Pendekatan neoklasik sangat relevan dalam manajemen keperawatan karena pelayanan keperawatan melibatkan interaksi intensif

antar individu. Lingkungan kerja yang suportif, komunikasi efektif, dan kepemimpinan yang partisipatif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja perawat.

Teori ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur dan sistem, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar anggota tim.

c. Teori Manajemen Modern

Teori manajemen modern menekankan pendekatan yang lebih kompleks, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi. Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Dalam keperawatan, pelayanan dipahami sebagai sistem yang melibatkan input (tenaga, sarana), proses (asuhan keperawatan), dan output (hasil pelayanan).

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang paling tepat untuk semua situasi. Keputusan manajerial harus disesuaikan dengan kondisi spesifik organisasi, karakteristik pasien, serta sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan. Pendekatan modern juga mencakup manajemen berbasis bukti (*evidence-based management*) dan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan data dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Teori manajemen modern memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam pengelolaan organisasi. Pendekatan ini memungkinkan manajer keperawatan untuk merespons perubahan secara cepat dan tepat.

2. Teori sistem dan kontingensi

Teori sistem dan kontingensi merupakan pendekatan modern dalam manajemen yang menekankan keterkaitan antar komponen organisasi serta pentingnya penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi. Kedua teori ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memahami kompleksitas pelayanan keperawatan dan mendukung pengambilan keputusan yang adaptif.

a. Teori Sistem dalam Manajemen Keperawatan

Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan saling

bergantung. Setiap komponen dalam sistem memiliki peran yang memengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan pada satu bagian akan berdampak pada bagian lain.

Dalam konteks keperawatan, pelayanan keperawatan dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Input mencakup sumber daya yang digunakan, seperti tenaga keperawatan, sarana prasarana, serta kebijakan organisasi. Proses meliputi pelaksanaan asuhan keperawatan yang mencakup pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Output merupakan hasil pelayanan yang dapat dilihat dari tingkat kepuasan pasien, kualitas pelayanan, serta indikator kesehatan yang dicapai.

Pendekatan sistem membantu manajer keperawatan dalam melihat pelayanan secara menyeluruh dan terintegrasi. Analisis sistem memungkinkan identifikasi masalah secara komprehensif serta perencanaan intervensi yang lebih tepat. Koordinasi antar unit dan profesi kesehatan juga menjadi lebih efektif karena setiap komponen dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem.

Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik sebagai mekanisme evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan kinerja pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

b. Teori Kontingensi dalam Manajemen Keperawatan

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang paling tepat untuk semua situasi. Keputusan manajerial harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, termasuk karakteristik organisasi, lingkungan kerja, serta kebutuhan pasien.

Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi. Manajer keperawatan dituntut untuk mampu menganalisis situasi secara tepat sebelum menentukan strategi yang akan digunakan. Faktor-faktor seperti jumlah tenaga keperawatan, tingkat kompleksitas pasien, budaya organisasi, serta ketersediaan sumber daya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dalam praktik keperawatan, teori kontingensi terlihat pada pemilihan model asuhan keperawatan. Tidak semua unit pelayanan cocok menggunakan model yang sama. Unit dengan pasien kritis mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan unit rawat

inap biasa. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Teori kontingensi juga relevan dalam kepemimpinan keperawatan. Gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi, seperti tingkat pengalaman staf, beban kerja, serta dinamika tim. Manajer keperawatan harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tim.(Lecler et al., 2020).

3. Model praktik keperawatan (Primary Nursing, Team Nursing, Case Method, Modular)

Model praktik keperawatan merupakan kerangka operasional yang digunakan dalam pengorganisasian pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Model ini menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang perawat diatur dalam suatu sistem pelayanan. Pemilihan model praktik keperawatan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, efisiensi kerja, serta kepuasan pasien dan tenaga keperawatan.

a. Primary Nursing

Model *Primary Nursing* menempatkan satu perawat sebagai penanggung jawab utama terhadap asuhan keperawatan pasien sejak awal masuk hingga keluar dari pelayanan. Perawat primer bertanggung jawab dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi seluruh kebutuhan pasien.

Model ini menekankan kontinuitas asuhan dan hubungan terapeutik yang kuat antara perawat dan pasien. Pasien mendapatkan pelayanan yang lebih personal dan terintegrasi. Model ini membutuhkan tingkat kompetensi perawat yang tinggi serta jumlah tenaga yang memadai.

b. Team Nursing

Model *Team Nursing* melibatkan sekelompok perawat yang bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan kepada sekelompok pasien. Tim biasanya terdiri dari perawat profesional dan tenaga pendukung dengan pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing.

Koordinasi dalam tim dipimpin oleh seorang ketua tim yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan. Model ini meningkatkan efisiensi kerja dan memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan model ini.

c. Case Method

Model *Case Method* merupakan pendekatan di mana satu perawat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan pasien selama satu periode dinas atau shift. Perawat memberikan asuhan secara langsung dan menyeluruh kepada pasien tanpa pembagian tugas dengan perawat lain.

Model ini memberikan pelayanan yang komprehensif dan memudahkan pengawasan terhadap kondisi pasien. Keterbatasan model ini terletak pada kebutuhan tenaga yang lebih banyak serta potensi kurangnya kontinuitas asuhan antar shift.

d. Modular Nursing

Model *Modular Nursing* merupakan pengembangan dari *Team Nursing* dengan pendekatan berbasis area atau modul tertentu. Sekelompok perawat bertanggung jawab terhadap pasien dalam satu wilayah atau unit kecil.

Model ini meningkatkan koordinasi karena anggota tim berada dalam area yang sama. Efisiensi kerja dan respons terhadap kebutuhan pasien menjadi lebih baik. Model ini juga memungkinkan peningkatan komunikasi antar anggota tim karena kedekatan lokasi kerja (Jia et al., 2022; Kamalia et al., 2020; Sulastien & Sudariane, 2020)

4. Integrasi teori dengan praktik keperawatan

Integrasi teori dengan praktik keperawatan merupakan proses penerapan konsep, prinsip, dan kerangka teoritis ke dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan secara nyata. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik keperawatan yang tidak didasarkan pada teori berisiko menjadi tidak konsisten, kurang efektif, dan sulit dievaluasi.

Teori memberikan dasar konseptual dalam memahami fenomena keperawatan, sedangkan praktik merupakan implementasi nyata dalam pelayanan kepada pasien. Hubungan antara teori dan praktik bersifat saling melengkapi. Teori membantu perawat dalam membuat keputusan yang rasional, sementara praktik memberikan umpan balik untuk pengembangan teori yang lebih relevan dengan kondisi lapangan.

Integrasi teori dalam praktik keperawatan terlihat dalam penerapan proses keperawatan yang sistematis, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Setiap tahap dalam proses tersebut didasarkan pada konsep ilmiah yang mendukung pengambilan keputusan klinis. Penggunaan standar praktik,

pedoman klinis, serta prosedur operasional juga merupakan bentuk penerapan teori dalam praktik.

Pendekatan *evidence-based practice* menjadi salah satu wujud nyata integrasi teori dan praktik. Keputusan keperawatan didasarkan pada hasil penelitian terkini, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Pendekatan ini meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Integrasi teori dengan praktik juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Perawat dituntut untuk mampu menganalisis situasi klinis, mengidentifikasi masalah, serta memilih intervensi yang paling sesuai berdasarkan teori dan bukti yang tersedia. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas pelayanan kesehatan.

Peran manajer keperawatan sangat penting dalam mendukung integrasi teori dan praktik. Manajer bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, akses terhadap sumber informasi ilmiah, serta pelatihan yang berkelanjutan. Dukungan organisasi akan meningkatkan kemampuan perawat dalam menerapkan teori ke dalam praktik sehari-hari.

Hambatan dalam integrasi teori dan praktik dapat berupa keterbatasan waktu, kurangnya akses terhadap sumber ilmiah, serta rendahnya budaya penelitian di lingkungan kerja. Upaya mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan berkelanjutan, pengembangan budaya ilmiah, serta penerapan sistem manajemen berbasis bukti.

Integrasi teori dengan praktik keperawatan menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Penerapan yang konsisten akan menghasilkan pelayanan yang lebih efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, serta mendukung profesionalisme perawat dalam sistem pelayanan kesehatan.

D. Fungsi Manajemen dalam Keperawatan

Fungsi manajemen dalam keperawatan merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk mengelola pelayanan keperawatan secara sistematis dan terarah. Fungsi ini menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya keperawatan agar tujuan pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen yang optimal akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kinerja tenaga keperawatan (Deudeu et al., 2025; Huda et al., 2024)

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam fungsi manajemen yang berfokus pada penetapan tujuan serta strategi untuk mencapainya. Dalam

keperawatan, perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan pasien, penentuan prioritas masalah, serta penyusunan rencana asuhan keperawatan.

Perencanaan juga melibatkan pengelolaan sumber daya, seperti perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan, penjadwalan dinas, serta penyusunan program kerja. Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pengaturan sumber daya agar dapat bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi. Fungsi ini mencakup pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja antar anggota tim. Pengorganisasian terlihat pada penentuan model praktik keperawatan, pembagian pasien, serta pengelolaan alur pelayanan. Pengorganisasian yang efektif akan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi tumpang tindih tugas.

3. Pengarahan/kepemimpinan (*leading*)

Pengarahan atau kepemimpinan merupakan proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan tenaga keperawatan agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan pelayanan. Fungsi ini sangat berkaitan dengan kemampuan komunikasi, motivasi, serta kepemimpinan manajer keperawatan.

Kepemimpinan yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan semangat kerja, serta memperkuat kerja sama tim. Peran pemimpin sangat penting dalam menghadapi konflik, perubahan, serta dinamika organisasi.

4. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Fungsi ini mencakup kegiatan monitoring, supervisi, audit, serta evaluasi kinerja. Dalam keperawatan, pengendalian dilakukan melalui indikator mutu, audit keperawatan, serta evaluasi hasil asuhan. Pengendalian yang efektif memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan keperawatan.

5. Penerapan fungsi manajemen dalam pelayanan keperawatan

Penerapan fungsi manajemen dalam keperawatan dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam praktik sehari-hari. Setiap fungsi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Perencanaan menjadi dasar dalam menentukan arah pelayanan, pengorganisasian memastikan sumber daya tersusun dengan baik,

pengarahan menggerakkan tim untuk bekerja secara optimal, dan pengendalian menjamin bahwa pelayanan sesuai dengan standar. Integrasi keempat fungsi tersebut akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada pasien.

Penerapan fungsi manajemen juga terlihat dalam pengelolaan unit pelayanan keperawatan, seperti ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, maupun pelayanan komunitas. Manajer keperawatan berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pasien.

Fungsi manajemen dalam keperawatan pada akhirnya menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang profesional. Implementasi yang konsisten akan meningkatkan efisiensi organisasi, kualitas pelayanan, serta kepuasan pasien dan tenaga keperawatan (Asmaningrum et al., 2023; Kamalia et al., 2020; Nursalam, 2021; Sulastien & Sudariane, 2020; Zakiyah et al., 2022)

E. Peran dan Kompetensi Manajer Keperawatan

Manajer keperawatan memiliki posisi strategis dalam mengelola pelayanan keperawatan serta menjembatani antara kebijakan organisasi dan praktik klinis. Peran ini menuntut kemampuan dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, serta memastikan mutu dan keselamatan pelayanan. Keberhasilan pelayanan keperawatan sangat dipengaruhi oleh efektivitas peran dan kompetensi manajer keperawatan.

1. Tingkatan manajer keperawatan

Manajer keperawatan terdiri dari beberapa tingkatan sesuai dengan struktur organisasi pelayanan kesehatan.

Manajer tingkat atas berperan dalam perencanaan strategis, pengembangan kebijakan, serta pengambilan keputusan jangka panjang. Posisi ini biasanya dipegang oleh kepala bidang atau direktur keperawatan.

Manajer tingkat menengah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan serta mengelola unit pelayanan tertentu. Posisi ini biasanya dipegang oleh kepala ruangan atau koordinator pelayanan.

Manajer tingkat bawah atau lini pertama berperan langsung dalam pengawasan operasional sehari-hari. Posisi ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan berjalan sesuai dengan standar (Asmaningrum et al., 2023; Nursalam, 2021; Staryo et al., 2024; Zakiyah et al., 2022).

2. Peran manajer (interpersonal, informasional, pengambilan keputusan)

Peran manajer keperawatan dapat dilihat berdasarkan fungsi manajemen dan interaksi dalam organisasi.

Peran interpersonal mencerminkan kemampuan manajer dalam membangun hubungan kerja yang efektif dengan staf, pasien, dan tim kesehatan lainnya. Manajer berfungsi sebagai pemimpin, motivator, dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Peran informasional berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola informasi. Manajer keperawatan bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan.

Peran pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam manajemen keperawatan. Manajer harus mampu menganalisis masalah, menentukan alternatif solusi, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek klinis, manajerial, etik, dan hukum.

Peran manajer juga mencakup pengelolaan perubahan dan inovasi dalam pelayanan keperawatan. Manajer dituntut untuk responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu mengimplementasikan perubahan secara efektif (Sulastien & Sudariane, 2020; Todingbua et al., 2024).

F. Mini-Case Manajemen Keperawatan (Diskusi Kelompok)

Kasus

Seorang kepala ruangan di unit rawat inap sebuah rumah sakit menghadapi peningkatan jumlah pasien dalam dua minggu terakhir. Tingkat hunian tempat tidur (BOR) mencapai 95%, sementara jumlah tenaga keperawatan tetap.

Beberapa masalah mulai muncul:

1. Perawat mengeluh kelelahan dan beban kerja meningkat
2. Dokumentasi asuhan keperawatan tidak lengkap
3. Terjadi keterlambatan pemberian obat pada beberapa pasien
4. Kepuasan pasien menurun berdasarkan hasil survei internal
5. Terjadi satu insiden keselamatan pasien (medication error ringan)

Hasil evaluasi menunjukkan:

1. Tidak ada penyesuaian perencanaan tenaga
2. Pembagian tugas tidak merata
3. Supervisi kepala ruangan belum optimal
4. Belum dilakukan audit keperawatan secara berkala

Kepala ruangan diminta oleh manajemen untuk segera melakukan perbaikan pelayanan keperawatan di unit tersebut.

Tugas Mahasiswa

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus berdasarkan konsep manajemen keperawatan.

RUBRIK PENIALAIN AKTIVITAS

Aspek	Indikator	1 (Kurang)	2 (Cukup)	3 (Baik)	4 (Sangat Baik)
Analisis Masalah	Ketepatan identifikasi masalah manajemen	Tidak tepat	Sebagian tepat	Tepat	Sangat komprehensif
Analisis Fungsi Manajemen	Planning–Organizing–Leading–Controlling	Tidak mampu	Terbatas	Cukup jelas	Mendalam & sistematis
Peran Manajer	Analisis peran & dampak	Tidak relevan	Kurang lengkap	Cukup tepat	Sangat kritis & aplikatif
Pengambilan Keputusan	Prioritas & solusi	Tidak logis	Kurang sistematis	Cukup logis	Sangat tepat & berbasis evidence
Mutu & Patient Safety	Indikator & perbaikan	Tidak sesuai	Kurang lengkap	Cukup sesuai	Sangat komprehensif
Presentasi	Kejelasan & argumentasi	Tidak jelas	Kurang sistematis	Baik	Sangat meyakinkan

G. Referensi

Alnajjar, H. (2022). *Exploring the relationship between leadership and conflict management styles among nursing students*. *April*. https://doi.org/10.7748/nm.2022.e2023

Aqtash, S., Alnusair, H., Brownie, S., Alnjadat, R., Fonbuena, M., & Perinchery, S. (2022). Evaluation of the Impact of an Education Program on Self-Reported Leadership and Management Competence Among Nurse Managers. *SAGE Open Nursing*, *8*(1), 1–10. https://doi.org/10.1177/23779608221106450

Ardian, I., Nursalam, Ahsan, Haiya, N. N., & Azizah, I. R. (2023). Investigating the complex relationships between nurses' work factors, Sharia-based nursing care, and patient satisfaction in an Islamic hospital: A PLS-SEM approach. *Belitung Nursing Journal*, *9*(6), 530–538. https://doi.org/10.33546/bnj.2865

Arslanlı, S. E., Duru, H. A., & Ünal, E. (2025). *The impact of clinical nurse leadership models on the quality of care at the unit level : a systematic review*.

Asmaningrum, N., Wijaya, D., Ardiana, A., & Purwandari, R. (2023). Buku Ajar Manajemen Keperawatan. In *PT. Literasi Nusantara Abadi Grup* (1st ed., Vol. 1). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Cisic, R. S., Miethlich, B., & Gacina, S. (2025). Insights into the role of emotional intelligence in nursing leadership. *Central European Journal of Nursing and Midwifery*, *16*(1), 2127–2144. https://doi.org/10.15452/cejnm.2025.16.0007

Deudeu, A., Dewi, M., Farhan, Y., Sahal, D., Tinggi, S., Islam, A., Agama, I., Darussalam, I., & Ciamis, I. (2025). The Perspective of Islamic Education Management is Seen from The Management of George R . Terry. *Journal of Social and Humanities*, *3*(1), 1–16.

Huda, K., Abdoe, T. Al, Sari, L. A., & Wantika, A. (2024). Studi Literatur Penerapan Konsep dan Peran Manajemen pada Organisasi. *Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *4*, 80–91.

Ilhami, D. A. (2022). Analisis Manajemen Fundraising Wakaf Infaq dan Shodaqoh. *Filantropi:Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, *3*(1), 74–102.

Jia, J., Jiao, Y., & Han, H. (2022). Inclusive leadership and team creativity : a moderated mediation model of Chinese talent management Inclusive leadership and team creativity : *The International Journal of Human Resource Management*, *33*(21), 4284–4307. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1966073

Jun, S. Y. (2017). The Mediating Effect of Social Capital on the Relationship Between Public Health Managers' Transformational Leadership and Public Health Nurses' Organizational Empowerment in Korea Public Health. *Asian Nursing Research*, *11*(4), 246–252. https://doi.org/10.1016/j.anr.2017.08.006

Kamalia, L. O., Said, A., & Risky, S. (2020). *Manajemen Keperawatan*. Media Sains Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_KEPERAWATAN_Nursing_Management/cLYHEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Definisi+Kepemimpinan+perawat&pg=PA2&printsec=frontcover

Kiwanuka, F., Nanyonga, R. C., Sak-Dankosky, N., Muwanguzi, P. A., & Kvist, T. (2021). Nursing Leadership Styles and Their Impact on Intensive Care Unit Quality Measures: An Integrative Review. *Journal of Nursing Management*, *29*(2), 133–142. https://doi.org/10.1111/jonm.13151

Layden, T., Gulbransen, K., & Lightbown, S. (2024). Nurse Education Today Using a knowledge translation framework for effective interprofessional leadership : A nursing student perspective. *Nurse Education Today*, *133*(July 2023), 106035. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.106035

Lecler, L., Kannedy, K., & Campins, S. (2020). Human-centred leadership in health care: A contemporary nursing leadership theory generated via constructivist grounded theory. *Journal of Nursing Mangement*, *29*(2), 294–306. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jonm.13154

Maweikere, Y., Menampiring, A. E., & Toar, J. M. (2021). Hubungan Beban Kerja Perawat dengan Tingkat Kepuasan Pasien dalam Pemberian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Keperawatan*, *9*(1), 71–77.

Mehrad, A., Fernández-Castro, J., de Olmedo, M. P. G. G., & García-Sierra, R. (2022). Mediation Role of Perceived Organizational Support on Nurses' Work Engagement and Leadership Styles. *Nurse Media Journal of Nursing*, *12*(2), 208–222. https://doi.org/10.14710/nmjn.v12i2.45872

Nursalam. (2021). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional* (6th ed.). Salemba Medika.

Peronja, I. (2024). Controlling In The Function of Management By Objectives. *Diem*, *1*, 131–142. https://doi.org/10.17818/DIEM/2024/1.9

Pinto-, A. G.-G. A., & Pérez-, D. B.-M. S. (2025). *Characteristics of Nurse Managers ' Conflict Management Competency . A Systematic Review*. 1717–1733. https://doi.org/10.1111/jan.16600

Reynolds, S. S. (2021). *How to Win Friends and In fl uence People — as a Nursing Leader*. *February*, 87–89. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2020.07.013

Ridlon, S., Fitriya, E. T., Aziz, A. N., Roni, F., Mahasiswa, S., Stikes, K., Ulum, B., Dosen, S., Stikes, K., & Ulum, B. (2021). The Experiance of The Person In Charge of The Room In Managing The Medical Ward In Tembelang Public Health Centre , Jombang. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, *17*(2).

Saifan, A., Devadas, B., Mekkawi, M., Amoor, H., Matizha, P., James, J., & Al-Yateem, N. (2021). Managing the theory-practice gap in nursing education and practice: Hearing the voices of nursing students in the United Arab Emirates. *Journal of Nursing Management*, *29*(6), 1869–1879. https://doi.org/10.1111/jonm.13407

Staryo, N., Ridwan, E. S., Mariana, D., Ramadhan, K., Kafilawati, B. N., Yusuf, H., Sahabuddin, L., Agni, M. K., & Setiawan, S. (2024). Buku Ajar Manajemen Konflik. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 2, Issue 2).

Sulastien, H., & Sudariane, P. W. (2020). *Buku Ajar Manajemen Keperawatan dan Kepemimpinan*. Gramedia.

Suwarno, B. (2023). Analysis Head Nurses' Leadership Styles to Staff Inpatient Nurses' Job Performance in Hospital. *International Journal of Science, Technology & Management*, *4*(2), 317–326. https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i2.770

Todingbua, U. N., Saleh, H., & Suriani, S. (2024). *Analisis Penerapan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar*. *2*(2), 154–162. https://doi.org/10.56326/jebd.v2i2.2873

Yusnaini, Y., Arif, Y., & Dorisnita, D. (2021). Kemampuan Kepemimpinan Klinis Perawat Pelaksana Berdasarkan Pendekatan Clinical Leadership Competency Framework dan Faktor-Faktor Determinannya. *Jurnal Keperawatan Silampari*, *4*(2), 337–350. https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1914

Zakiyah, A., Khusniyah, Z., Mahanani, S., Erianti, S., & Fithriyani. (2022). *Buku Ajar Manajemen Keperawatan S1 Keperawatan Jilid 1*. PT Mahakarya Citra Utama Group. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Manajemen_Keperawatan/W8bYEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=manajemen+keperawatan+metode+tim&pg=PA35&printsec=frontcover

BAB 2

KEPEMIMPINAN DAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

CPL, CPMK, Sub-CPMK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Menganalisis fungsi manajemen dan kepemimpinan untuk pengambilan keputusan dalam unit pelayanan keperawatan (CPL 2).

CPMK

Menganalisis kepemimpinan, pengambilan keputusan, delegasi, dan supervisi untuk mencapai tujuan unit keperawatan.

Sub-CPMK

Sub-CPMK 1

Menganalisis gaya kepemimpinan sesuai situasi untuk meningkatkan kinerja tim.

Sub-CPMK 2

Menentukan langkah delegasi dan supervisi yang aman dan efektif.

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktik profesional, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai koordinator pelayanan, fasilitator komunikasi, serta penggerak tim kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh perawat (Marquis & Huston, 2021).

Kepemimpinan dalam keperawatan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim kesehatan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Yoder-Wise, 2019). Dalam sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat, melakukan koordinasi lintas profesi, serta mengelola konflik dalam tim (Huber, 2018).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan kerja perawat

Uraian Materi

A. Pengertian Kepemimpinan dalam Keperawatan

Kepemimpinan dalam keperawatan merupakan kemampuan seorang perawat untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim kesehatan dalam mencapai tujuan pelayanan keperawatan secara efektif dan efisien. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan interpersonal, komunikasi, dan pengambilan keputusan klinik (Marquis & Huston, 2021).

Menurut Yoder-Wise (2019), kepemimpinan dalam keperawatan mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, mengoordinasikan pelayanan, serta memastikan keselamatan pasien dalam berbagai situasi klinik. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang kompleks, kepemimpinan perawat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien (Alilyyani et al., 2024).

B. Fungsi Kepemimpinan dalam Keperawatan

Kepemimpinan dalam keperawatan tidak terlepas dari fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Huber, 2018).

1. **Perencanaan (Planning)** : Pemimpin keperawatan merencanakan kegiatan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien dan sumber daya yang tersedia.
2. **Pengorganisasian (Organizing)** : Pemimpin mengatur pembagian tugas serta koordinasi tim keperawatan.
3. **Pengarahan (Directing)** : Pemimpin memberikan arahan dan motivasi kepada anggota tim untuk mencapai tujuan pelayanan.
4. **Pengendalian (Controlling)** : Pemimpin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan agar sesuai standar.

Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam memastikan pelayanan keperawatan berjalan efektif dan aman bagi pasien (Marquis & Huston, 2021).

C. Karakteristik Pemimpin Keperawatan yang Efektif

Pemimpin keperawatan yang efektif memiliki karakteristik seperti kemampuan komunikasi yang baik, integritas, kemampuan pengambilan keputusan, serta kemampuan bekerja sama dalam tim (Yoder-Wise, 2019). Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan problem solving dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja perawat, retensi tenaga keperawatan, serta kualitas pelayanan kesehatan (Yu et al., 2024).

D. Teori Kepemimpinan dalam Keperawatan

1. Teori Kepemimpinan Klasik (Trait Theory)

Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti kepercayaan diri, kecerdasan, dan kemampuan interpersonal (Northouse, 2022).

2. Teori Perilaku (Behavioral Theory)

Teori ini menekankan pada perilaku pemimpin dalam berinteraksi dengan anggota tim, termasuk cara komunikasi dan pemberian instruksi (Huber, 2018).

3. Teori Kepemimpinan Situasional

Menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson (2013), kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan dan kompetensi anggota tim. Pendekatan ini sangat relevan dalam praktik keperawatan yang dinamis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan situasional meningkatkan efektivitas tim dan adaptasi terhadap perubahan dalam pelayanan kesehatan (Wang et al., 2024).

4. Teori Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim melalui visi yang jelas dan hubungan interpersonal yang kuat (Bass & Riggio, 2006). Gaya ini terbukti meningkatkan kinerja perawat, kepuasan kerja, serta kualitas pelayanan kesehatan (Alilyyani et al., 2024).

E. Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi anggota tim.

1. Gaya Otoriter

Pemimpin mengambil keputusan secara sepihak dan memberikan instruksi yang jelas. Gaya ini efektif pada kondisi darurat atau situasi krisis (Huber, 2018).

2. Gaya Demokratis

Pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif (Marquis & Huston, 2021).

3. **Gaya Laissez-faire**
   Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim dalam bekerja. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah kompeten (Yoder-Wise, 2019).
4. **Gaya Transformasional**
   Pemimpin memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota tim untuk mencapai kinerja optimal. Penelitian menunjukkan bahwa gaya ini berhubungan dengan peningkatan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan (Yu et al., 2024).

F. Kepemimpinan Situasional dalam Keperawatan

Kepemimpinan situasional menekankan pentingnya fleksibilitas dalam memilih gaya kepemimpinan sesuai kondisi. Faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Kompetensi anggota tim
2. Motivasi
3. Kompleksitas tugas
4. Kondisi pasien

Pendekatan ini terbukti meningkatkan efektivitas kepemimpinan dalam praktik keperawatan (Wang et al., 2024).

G. Hubungan Kepemimpinan dengan Kinerja Tim

Kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja tim keperawatan. Pemimpin yang efektif dapat meningkatkan:

1. Kepuasan kerja
2. Motivasi
3. Kolaborasi tim
4. Kualitas pelayanan

Sebaliknya, kepemimpinan yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja tim dan meningkatkan risiko kesalahan klinik (Moradi et al., 2024).

H. Peran Pemimpin Keperawatan dalam Praktik Klinis

Pemimpin keperawatan memiliki peran penting dalam praktik klinis, yaitu:

1. Pengambil keputusan
2. Koordinator tim
3. Fasilitator komunikasi
4. Supervisor
5. Motivator

Peran ini sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Huber, 2018).

I. Kepemimpinan, Delegasi, dan Supervisi

Delegasi adalah pelimpahan tugas kepada anggota tim, sedangkan supervisi adalah proses pengawasan untuk memastikan tindakan sesuai standar (Marquis & Huston, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa delegasi dan supervisi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan pasien (Alhassan et al., 2025).

J. Kepemimpinan dan Keselamatan Pasien

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar dan prosedur. Kepemimpinan transformasional terbukti berkontribusi dalam menciptakan budaya keselamatan pasien serta mengurangi kejadian tidak diinginkan (Yu et al., 2024).

K. Aktivitas 1 — Knows How

Mini Case (Diskusi Kelompok)

Skenario Kasus

Seorang kepala ruangan di ruang penyakit dalam memimpin tim yang terdiri dari 1 perawat senior dan 2 perawat junior. Pada satu shift, terdapat pasien dengan kondisi tidak stabil yang membutuhkan pemantauan ketat.

Kepala ruangan memberikan tugas pemantauan kepada perawat senior, sementara perawat junior menangani pasien dengan kondisi stabil. Dalam pelaksanaannya, kepala ruangan tetap memberikan arahan dan memantau kerja tim. Salah satu perawat junior terlihat ragu dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

1. Menganalisis peran kepemimpinan dalam praktik keperawatan
2. Mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang digunakan
3. Menentukan kesesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi

Pertanyaan Diskusi

1. Apa peran kepala ruangan sebagai pemimpin dalam kasus tersebut?
2. Gaya kepemimpinan apa yang digunakan? Jelaskan alasan Anda!
3. Apakah gaya kepemimpinan tersebut sudah sesuai dengan kondisi tim?

4. Bagaimana seharusnya kepala ruangan bersikap terhadap perawat junior yang ragu?

Petunjuk Diskusi

1. Diskusi kelompok kecil (4–5 mahasiswa)
2. Waktu diskusi 20–30 menit
3. Presentasi hasil diskusi

Output

Mahasiswa mampu memahami:

1. Peran kepemimpinan dalam situasi klinik
2. Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat
3. Pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan

L. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / Skill Lab (Kepemimpinan dalam Keperawatan)

Fokus

1. Urutan tindakan kepemimpinan
2. Komunikasi efektif dalam tim
3. Keselamatan pasien (patient safety)

Skenario Simulasi

Mahasiswa berperan sebagai **ketua tim/perawat penanggung jawab shift** di ruang rawat inap dengan anggota tim terdiri dari perawat senior dan junior.

Terdapat pasien dengan kondisi yang membutuhkan perhatian khusus, sementara anggota tim memiliki tingkat kompetensi yang berbeda.

Mahasiswa diminta untuk:

1. Menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai
2. Memberikan arahan kepada tim
3. Membagi tugas secara tepat
4. Melakukan komunikasi efektif
5. Menjaga keselamatan pasien

Langkah Simulasi

1. Mengidentifikasi situasi tim dan kondisi pasien
2. Menentukan gaya kepemimpinan yang digunakan
3. Memberikan instruksi kepada anggota tim
4. Melakukan komunikasi yang jelas dan empatik
5. Melakukan monitoring singkat terhadap pelaksanaan tugas
6. Menyimpulkan tindakan dengan mempertimbangkan patient safety

Catatan untuk Penulis

1. Tidak langsung ke ujian

2. Mahasiswa dilatih **bertahap (knows → shows how)**
3. Fokus pada **proses berpikir dan tindakan**, bukan hanya hasil

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case kepemimpinan
Shows How	OSCE Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan

Catatan untuk Penulis

1. Karena capaian pembelajaran adalah **mendemonstrasikan kepemimpinan**, maka **OSCE menjadi metode yang logis (bukan dipaksakan)**
2. Penilaian menekankan pada:
   a. Pengambilan keputusan
   b. Komunikasi tim
   c. Patient safety

M. OSCE

Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan

Tujuan

Menilai kemampuan mahasiswa dalam:

1. Menentukan gaya kepemimpinan
2. Memberikan arahan kepada tim
3. Melakukan komunikasi efektif
4. Menjamin keselamatan pasien

Skenario OSCE

Mahasiswa berperan sebagai ketua tim keperawatan dalam satu shift dengan anggota tim yang memiliki kompetensi berbeda. Mahasiswa diminta untuk memimpin tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Komunikasi instruksi jelas dan tidak ambigu
2. Pemilihan gaya kepemimpinan sesuai situasi
3. Pembagian tugas sesuai kompetensi anggota tim
4. Menjaga keselamatan pasien (patient safety)
5. Melakukan monitoring/supervisi singkat

N. Rubrik Penilaian

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Pengambilan keputusan (kepemimpinan)	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk
Gaya kepemimpinan	Sangat sesuai situasi	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Catatan untuk Penulis

1. Nilai tinggi **tidak menutup kegagalan pada aspek keselamatan pasien**
2. Jika critical item gagal → mahasiswa **tidak lulus OSCE**

SOAL OSCE (KEPEMIMPINAN & GAYA KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN)

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Pengelolaan Tim Keperawatan
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam menganalisis situasi tim keperawatan, menentukan gaya kepemimpinan yang tepat, melakukan komunikasi dan delegasi tugas, serta menjaga keselamatan pasien.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan koordinasi tim 2. Pengambilan keputusan 3. Kepemimpinan klinik 4. Delegasi dan supervisi 5. Patient safety 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Manajemen keperawatan 2. Keselamatan pasien 3. Komunikasi tim 4. Pengambilan keputusan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda adalah perawat penanggung jawab shift pagi di ruang rawat inap. Tim Anda terdiri dari 1 perawat senior dan 1 perawat junior. Terdapat satu pasien dengan kondisi tidak stabil yang membutuhkan pemantauan

No.	Komponen	Isi
		ketat. Perawat junior tampak ragu dalam melaksanakan tugasnya. TUGAS: 1. Lakukan analisis singkat terhadap situasi tim dan pasien. 2. Tentukan gaya kepemimpinan yang akan Anda gunakan. 3. Lakukan pembagian tugas (delegasi) kepada anggota tim. 4. Tunjukkan komunikasi yang jelas dan efektif kepada tim. 5. Pastikan keselamatan pasien menjadi prioritas dalam arahan Anda.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: (sama seperti peserta) INSTRUKSI PENGUJI: 1.Menilai kemampuan peserta dalam menganalisis situasi tim dan kondisi pasien. 2.Menilai ketepatan peserta dalam menentukan gaya kepemimpinan (misalnya situasional/demokratis/otoriter sesuai kondisi). 3. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan delegasi sesuai kompetensi anggota tim. 4. Menilai kemampuan komunikasi (jelas, sistematis, dan empatik). 5.Menilai kemampuan peserta dalam menjaga keselamatan pasien (prioritas pasien kritis, monitoring). 6. Monitor perilaku profesional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau bertanya di luar skenario.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. KS berperan sebagai perawat junior. 2. Tampilkan sikap ragu-ragu dan kurang percaya diri. 3. Jika diberi tugas berat, tanyakan: "Apakah saya mampu melakukannya?" 4. Tunggu arahan dari peserta sebelum bertindak. 5. Jika diberi penjelasan yang jelas, respon menjadi lebih percaya diri. 6. Jika komunikasi peserta tidak jelas, tetap menunjukkan kebingungan.
10	Setting station	Ruang Rawat Inap - Tempat tidur pasien (simulasi) - KS sebagai perawat junior - Penguji - Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur pasien 2. Kursi KS 3. Meja penguji

No.	Komponen	Isi
		4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Handrub/hand sanitizer 2. Lembar instruksi peserta 3. Lembar penilaian penguji 4. Alat tulis Peran laboran: Mempersiapkan dan merapikan ruang serta memastikan kesiapan station sebelum peserta masuk.
12	Penulis	....
13	Referensi	Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). Leadership roles and management functions in nursing. Yoder-Wise, P. S. (2019). Leading and managing in nursing. Huber, D. (2018). Leadership and nursing care management. Wang, X., et al. (2024). Situational leadership theory in nursing management. BMC Nursing. Yu, Q., et al. (2024). Transformational leadership and nursing outcomes. BMC Nursing.

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: KEPEMIMPINAN DAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Situasi	Mengidentifikasi kondisi pasien dan tim (kompetensi, beban kerja, prioritas pasien)					1	
2	Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan	Menentukan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai situasi					2	
3	Implementasi Kepemimpinan (Delegasi & Komunikasi)	Memberikan instruksi jelas, melakukan delegasi sesuai kompetensi, dan komunikasi efektif					5	
4	Perilaku Profesional	Komunikasi terapeutik, sikap profesional, sistematis, aman, responsif					2	
	Jumlah						**10**	

Keterangan skor:

- **0** = tidak dilakukan
- **1** = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- **2** = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **3** = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION: KEPEMIMPINAN DAN GAYA KEPEMIMPINAN DALAM KEPERAWATAN

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1. Pengkajian Situasi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menganalisis kondisi pasien dan tim, termasuk prioritas pasien, kompetensi anggota tim, serta kebutuhan pelayanan.					1	
2. Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai situasi (situasional, demokratis, atau direktif) berdasarkan kondisi tim dan pasien.					2	
3. Implementasi Kepemimpinan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan delegasi, memberikan instruksi yang jelas, serta berkomunikasi secara efektif kepada anggota tim.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional, komunikasi yang baik, serta menjaga keselamatan pasien.					2	

Deskripsi Performa Tiap Skor

1. **Pengkajian Situasi**
   - **Skor 0**: Tidak melakukan analisis situasi atau tidak relevan
   - **Skor 1**: Analisis sangat terbatas, tidak sistematis
   - **Skor 2**: Analisis cukup baik, namun belum lengkap
   - **Skor 3**: Analisis lengkap, sistematis, dan mampu menentukan prioritas
2. **Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan**
   - **Skor 0**: Tidak menentukan gaya kepemimpinan atau tidak sesuai
   - **Skor 1**: Menentukan gaya tetapi tidak tepat
   - **Skor 2**: Cukup tepat namun kurang konsisten
   - **Skor 3**: Tepat, sesuai situasi, dan jelas alasan pemilihannya

3. **Implementasi Kepemimpinan (Delegasi & Komunikasi)**
   - **Skor 0**: Tidak melakukan delegasi atau komunikasi tidak jelas
   - **Skor 1**: Delegasi tidak sesuai kompetensi, instruksi tidak jelas
   - **Skor 2**: Delegasi cukup tepat, komunikasi cukup jelas
   - **Skor 3**: Delegasi tepat, instruksi jelas, komunikasi efektif dan sistematis
4. **Perilaku Profesional**
   - **Skor 0**: Tidak menunjukkan sikap profesional
   - **Skor 1**: Profesionalitas sangat kurang
   - **Skor 2**: Profesional cukup baik
   - **Skor 3**: Profesional, komunikatif, aman, dan responsif

Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan
1	Sangat kurang
2	Cukup
3	Baik dan lengkap

Global Performance

Beri tanda (√) sesuai penilaian:

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Perhitungan Nilai:

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

Penguji : .....

DOPS (Does) – KEPEMIMPINAN KEPERAWATAN

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung kepemimpinan dalam tim keperawatan
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan DOPS pada Kepemimpinan Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh
Metode penilaian	Observasi langsung performa klinik mahasiswa	Mahasiswa memimpin shift di ruang rawat
Tujuan	Menilai kemampuan kepemimpinan nyata	Mahasiswa mengatur tim dan pasien
Kasus klinik	Situasi nyata di ruangan	Pasien kritis + tim junior
Aktivitas mahasiswa	Memimpin, delegasi, komunikasi	Membagi tugas dan supervisi
Aspek yang dinilai	Kepemimpinan, komunikasi, patient safety	Instruksi jelas, prioritas pasien
Umpan balik	Diberikan langsung	Perbaikan komunikasi/delegasi
Keputusan	Kompeten / supervisi / remedial	Berdasarkan performa
Makna OBE	Bukti kemampuan level does	Mahasiswa benar-benar memimpin

PORTOFOLIO (KEPEMIMPINAN)

Bukti yang dikumpulkan:

1. OSCE
2. DOPS
3. Catatan kasus kepemimpinan
4. Refleksi patient safety
5. Feedback CI

Tabel Portofolio Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh
Hakikat	Bukti perkembangan kompetensi	Mahasiswa memimpin tim
Tujuan	Dokumentasi kemampuan	Dari simulasi → praktik
OSCE & DOPS	Bukti skill & praktik nyata	OSCE kepemimpinan

Komponen	Deskripsi	Contoh
Catatan kasus	Ringkasan kasus tim	Delegasi pada pasien kritis
Refleksi	Analisis keselamatan	Risiko salah delegasi
Feedback	Masukan CI	Perbaikan komunikasi
Makna OBE	Bukti autentik	Kompetensi nyata

Tabel. Case Report pada Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kepemimpinan Keperawatan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan situasi klinik secara ilmiah dan profesional.	Mahasiswa menyusun laporan tentang situasi di ruang rawat inap, di mana ia berperan sebagai perawat penanggung jawab shift yang harus mengelola tim terdiri dari perawat senior dan junior, serta menangani pasien dengan kondisi tidak stabil.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian situasi, pengambilan keputusan kepemimpinan, delegasi, supervisi, serta evaluasi hasil pelayanan keperawatan.	Mahasiswa tidak hanya menjelaskan kondisi pasien dan tim, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia menentukan gaya kepemimpinan, melakukan pembagian tugas, serta mengevaluasi efektivitas tindakan tim.
Isi laporan	Isi case report mencakup situasi klinik, kondisi tim, data penting pasien, analisis masalah, keputusan kepemimpinan (gaya yang digunakan), tindakan	Mahasiswa menuliskan kondisi pasien yang membutuhkan pemantauan ketat, kondisi perawat junior yang belum berpengalaman, keputusan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kepemimpinan Keperawatan
	delegasi dan supervisi, implementasi, evaluasi hasil, serta pembelajaran dari kasus.	menggunakan gaya kepemimpinan situasional, pembagian tugas sesuai kompetensi, komunikasi instruksi, serta hasil berupa peningkatan koordinasi tim dan stabilisasi kondisi pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan analisis situasi, logika pengambilan keputusan kepemimpinan, kesesuaian gaya kepemimpinan, ketepatan delegasi, efektivitas komunikasi, serta kemampuan mengevaluasi hasil.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kondisi pasien dan tim dengan gaya kepemimpinan yang dipilih, melakukan delegasi yang aman, serta memastikan pelayanan berjalan efektif dan pasien terpantau dengan baik.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning dalam kepemimpinan, keterampilan komunikasi tim, serta kemampuan refleksi terhadap praktik manajemen keperawatan.	Dari kasus tersebut, mahasiswa belajar bahwa pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dan komunikasi yang jelas sangat berpengaruh terhadap kinerja tim dan keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan konsep kepemimpinan ke dalam praktik nyata secara sistematis, terukur, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi mampu mengimplementasikan dalam situasi klinik nyata melalui pengelolaan tim, delegasi, dan supervisi yang efektif.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kepemimpinan Keperawatan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan tindakan pencegahan dalam konteks kepemimpinan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa kepemimpinan yang tidak efektif, seperti komunikasi yang tidak jelas atau delegasi yang tidak tepat, dapat meningkatkan risiko kesalahan tindakan dan membahayakan keselamatan pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan tanggung jawab utama dalam setiap praktik kepemimpinan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan dalam pengambilan keputusan, kurangnya supervisi, atau miskomunikasi dalam tim dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kepemimpinan klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah miskomunikasi tim, kesalahan delegasi, kurangnya koordinasi, dan keterlambatan pengambilan keputusan dalam situasi klinik.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi kepemimpinan yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain instruksi yang tidak jelas, delegasi tidak sesuai kompetensi, kurangnya supervisi, keterlambatan respons terhadap kondisi pasien, serta kegagalan koordinasi tim.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kepemimpinan Keperawatan
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk meminimalkan risiko keselamatan pasien melalui praktik kepemimpinan yang efektif.	Mahasiswa menuliskan pentingnya komunikasi yang jelas dan terstruktur, delegasi sesuai kompetensi, supervisi aktif, penggunaan briefing tim, serta memastikan setiap anggota memahami tugasnya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien, sehingga diperlukan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan cepat, serta koordinasi tim yang baik.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menjadi bukti perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam praktik kepemimpinan.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu memimpin tim, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

O. Rangkuman Masteri

Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan dalam Keperawatan

Bab ini menekankan bahwa kepemimpinan dalam keperawatan merupakan kompetensi penting yang berperan langsung dalam menentukan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dalam praktik klinik yang dinamis, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan, mengoordinasikan, dan memastikan setiap tindakan tim berjalan secara efektif dan aman.

Mahasiswa perlu memahami bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga kemampuan dalam mengambil keputusan, berkomunikasi, melakukan delegasi, serta melakukan supervisi. Gaya

kepemimpinan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi klinik, kondisi pasien, serta kompetensi anggota tim.

Dalam praktik keperawatan, beberapa gaya kepemimpinan yang umum digunakan meliputi gaya otoriter, demokratis, laissez-faire, dan transformasional. Selain itu, pendekatan kepemimpinan situasional menjadi sangat penting karena memungkinkan perawat menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan dan kemampuan anggota tim.

Alur kepemimpinan dalam keperawatan dimulai dari pengkajian situasi, meliputi kondisi pasien, beban kerja, serta kompetensi tim. Selanjutnya, perawat menentukan gaya kepemimpinan yang sesuai, melakukan pembagian tugas (delegasi), memberikan instruksi yang jelas, serta melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tindakan. Komunikasi yang efektif dan terstruktur menjadi kunci dalam memastikan tidak terjadi miskomunikasi yang dapat berdampak pada keselamatan pasien.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan kemampuan memimpin tim secara sistematis, termasuk memberikan arahan, memastikan tugas dilakukan sesuai standar, serta melakukan evaluasi terhadap hasil kerja tim. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan koordinasi, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan keperawatan.

Evaluasi kepemimpinan dilakukan dengan melihat efektivitas tim, ketepatan tindakan, serta keselamatan pasien. Apabila ditemukan masalah seperti kesalahan komunikasi, delegasi yang tidak tepat, atau keterlambatan pengambilan keputusan, maka perlu dilakukan perbaikan segera melalui supervisi dan koordinasi ulang.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa kepemimpinan dalam keperawatan harus dilakukan secara adaptif, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori kepemimpinan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata melalui pengelolaan tim, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan yang tepat.

P. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kepemimpinan dalam Keperawatan

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Instruksi tidak jelas	Risiko miskomunikasi dan kesalahan tindakan	Klarifikasi segera, ulangi instruksi dengan teknik closed-loop communication
Delegasi tidak sesuai kompetensi	Risiko tindakan tidak aman	Evaluasi ulang tugas, sesuaikan dengan kemampuan anggota
Tidak ada supervisi	Risiko kesalahan tidak terdeteksi	Lakukan supervisi aktif dan monitoring berkala
Keterlambatan pengambilan keputusan	Risiko perburukan kondisi pasien	Segera koordinasi dengan tim dan eskalasi ke penanggung jawab
Komunikasi tim buruk	Koordinasi tidak efektif	Lakukan briefing dan komunikasi terstruktur (SBAR)
Beban kerja tidak seimbang	Risiko kelelahan dan error	Redistribusi tugas
Konflik dalam tim	Mengganggu pelayanan	Mediasi dan komunikasi terbuka
Tidak melakukan eskalasi saat perlu	Risiko keterlambatan penanganan	Laporkan segera sesuai alur layanan
Tidak memperhatikan patient safety	Risiko kejadian tidak diinginkan	Terapkan prinsip keselamatan pasien secara konsisten

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Kepemimpinan dan Gaya Kepemimpinan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep kepemimpinan keperawatan	☐	☐	____
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi gaya kepemimpinan	☐	☐	____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
3	Saya sudah bisa menganalisis situasi tim	☐	☐	____
4	Saya sudah bisa memilih gaya kepemimpinan yang sesuai	☐	☐	____
5	Saya sudah bisa melakukan komunikasi efektif dalam tim	☐	☐	____
6	Saya sudah bisa melakukan delegasi tugas	☐	☐	____
7	Saya sudah bisa melakukan supervisi	☐	☐	____
8	Saya sudah bisa mengambil keputusan klinik	☐	☐	____
9	Saya sudah bisa menjaga keselamatan pasien dalam kepemimpinan	☐	☐	____
10	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko dalam tim	☐	☐	____
11	Saya sudah bisa melakukan koordinasi tim	☐	☐	____
12	Saya sudah bisa melakukan eskalasi bila diperlukan	☐	☐	____
13	Saya sudah bisa menyelesaikan konflik dalam tim	☐	☐	____
14	Saya sudah bisa mengevaluasi kinerja tim	☐	☐	____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional dalam memimpin	☐	☐	____

Refleksi singkat mahasiswa:

Q. Daftar Pustaka

Alilyyani, B., Wong, C. A., & Cummings, G. G. (2024). Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 137, 104391.

Alhassan, A. A., Yakubu, I., & Atinga, R. A. (2025). Delegation practices and patient safety outcomes among nurses: A cross-sectional study. *BMC Nursing*, 24(1), 55.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Huber, D. (2018). *Leadership and nursing care management* (6th ed.). Elsevier.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.

Moradi, M., Nouhi, E., & Khoshknab, M. F. (2024). The relationship between leadership styles and nursing performance: A systematic review. *Journal of Nursing Management*, 32(2), 215–223.

Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and practice* (9th ed.). Sage Publications.

Wang, X., Liu, Y., & Wang, J. (2024). Situational leadership and team effectiveness in healthcare: A cross-sectional study. *BMC Nursing*, 23(1), 210.

Yoder-Wise, P. S. (2019). *Leading and managing in nursing* (7th ed.). Elsevier.

Yu, Q., Li, H., & Li, X. (2024). Transformational leadership and patient safety outcomes in nursing: A systematic review. *BMC Nursing*, 23(1), 198.

BAB 3

PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL UNIT KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen keperawatan yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Dalam konteks unit keperawatan, perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien berlangsung secara efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar profesi (Marquis & Huston, 2021). Perencanaan yang baik akan membantu kepala ruangan maupun manajer keperawatan dalam mengatur sumber daya manusia, sarana, serta kegiatan pelayanan sehingga tujuan organisasi kesehatan dapat tercapai.

Perencanaan dalam unit keperawatan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jangka pendek, tetapi juga mencakup perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Oleh karena itu, dikenal dua bentuk utama perencanaan dalam manajemen keperawatan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Kedua bentuk perencanaan ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di lingkungan pelayanan kesehatan (Huber, 2022).

B. Definisi Perencanaan Strategis dalam Keperawatan

Perencanaan strategis adalah proses penyusunan tujuan jangka panjang organisasi serta penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam unit keperawatan, perencanaan strategis digunakan untuk menentukan arah pengembangan pelayanan keperawatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perubahan sistem kesehatan (Sullivan, 2018).

Perencanaan strategis biasanya disusun oleh pimpinan rumah sakit atau manajemen keperawatan tingkat atas dengan mempertimbangkan visi, misi, nilai organisasi, serta analisis situasi internal dan eksternal. Hasil dari perencanaan strategis akan menjadi pedoman bagi seluruh tenaga keperawatan dalam menjalankan pelayanan.

Menurut teori manajemen modern, perencanaan strategis memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Berorientasi jangka panjang.
2. Memiliki tujuan yang jelas.
3. Menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.
4. Melibatkan pengambilan keputusan penting.
5. Menjadi dasar bagi perencanaan operasional.

Dalam praktik keperawatan, perencanaan strategis dapat berupa pengembangan budaya keselamatan pasien, peningkatan kompetensi perawat, digitalisasi dokumentasi keperawatan, serta pengembangan pelayanan berbasis mutu (Yoder-Wise, 2019).

Contoh Perencanaan Strategis

Sebuah rumah sakit menetapkan visi untuk menjadi rumah sakit dengan pelayanan keperawatan terbaik di wilayahnya dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian keperawatan menyusun strategi berupa:

1. Pelatihan kompetensi perawat secara berkala.
2. Pengembangan sistem dokumentasi elektronik.
3. Peningkatan standar keselamatan pasien.
4. Program peningkatan kepuasan pasien.
5. Penguatan komunikasi terapeutik.

Strategi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program kerja yang lebih spesifik pada masing-masing unit pelayanan.

C. Definisi Perencanaan Operasional dalam Keperawatan

Perencanaan operasional adalah proses penyusunan kegiatan jangka pendek yang lebih rinci untuk melaksanakan rencana strategis. Perencanaan operasional berfokus pada aktivitas harian, mingguan, atau bulanan yang dilakukan oleh unit keperawatan (Marquis & Huston, 2021).

Jika perencanaan strategis menentukan "apa yang ingin dicapai", maka perencanaan operasional menjelaskan "bagaimana cara mencapainya". Oleh karena itu, perencanaan operasional sangat berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan keperawatan sehari-hari. Perencanaan operasional meliputi:

1. Penyusunan jadwal dinas perawat.
2. Pengaturan kebutuhan alat kesehatan.
3. Pembagian tugas tenaga keperawatan.
4. Penyusunan program supervisi.
5. Pelaksanaan audit mutu.
6. Penyediaan logistik unit.

Perencanaan operasional biasanya dilakukan oleh kepala ruangan atau manajer unit berdasarkan kebutuhan pelayanan.

Contoh Perencanaan Operasional

Apabila rumah sakit memiliki strategi peningkatan keselamatan pasien, maka unit keperawatan dapat membuat rencana operasional berupa:

1. Melakukan briefing keselamatan pasien setiap pergantian shift.
2. Memastikan identifikasi pasien menggunakan gelang identitas.
3. Melaksanakan audit hand hygiene setiap minggu.
4. Menyediakan formulir pelaporan insiden keselamatan pasien.
5. Mengadakan edukasi bulanan terkait patient safety.

Kegiatan tersebut merupakan langkah konkret yang dilaksanakan secara rutin di unit pelayanan.

D. Tujuan Perencanaan dalam Unit Keperawatan

Perencanaan dalam unit keperawatan memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan

Perencanaan membantu tenaga keperawatan memberikan pelayanan yang terarah dan sesuai standar. Dengan adanya perencanaan, risiko kesalahan tindakan dapat dikurangi (Huber, 2022).

2. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Rumah sakit memiliki sumber daya yang terbatas, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Perencanaan membantu penggunaan sumber daya secara efisien.

3. Mempermudah Pengawasan

Kegiatan yang telah direncanakan akan lebih mudah dipantau dan dievaluasi. Kepala ruangan dapat mengetahui apakah target pelayanan telah tercapai.

4. Meningkatkan Kepuasan Pasien

Pelayanan yang terorganisir dengan baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan.

5. Mendukung Keselamatan Pasien

Perencanaan yang matang membantu mencegah kejadian yang tidak diharapkan dan meningkatkan budaya keselamatan pasien (World Health Organization, 2021).

E. Langkah-Langkah Penyusunan Perencanaan Keperawatan

Dalam manajemen keperawatan, penyusunan perencanaan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. **Identifikasi Masalah**

   Tahap pertama adalah mengenali masalah yang terjadi di unit pelayanan. Masalah dapat diketahui melalui laporan insiden, hasil evaluasi, keluhan pasien, maupun hasil supervisi. Contohnya, ditemukan tingginya angka keterlambatan dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap.

2. **Analisis Situasi**

   Setelah masalah ditemukan, dilakukan analisis penyebab menggunakan pendekatan seperti SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis SWOT membantu manajer keperawatan memahami:

   - Kekuatan unit.
   - Kelemahan yang perlu diperbaiki.
   - Peluang pengembangan.
   - Ancaman dari lingkungan eksternal.

3. **Penentuan Tujuan**

   Tujuan harus dibuat secara spesifik, realistis, dan terukur. Dalam manajemen dikenal konsep SMART, yaitu:

   - Specific
   - Measurable
   - Achievable
   - Relevant
   - Time-bound

   Contoh tujuan:

   "Menurunkan keterlambatan dokumentasi keperawatan sebesar 50% dalam waktu tiga bulan."

4. **Penyusunan Strategi dan Kegiatan**

   Pada tahap ini ditentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

   Contoh kegiatan:

   - Pelatihan dokumentasi keperawatan.
   - Supervisi harian.
   - Monitoring kelengkapan rekam medis.
   - Evaluasi mingguan.

5. **Pelaksanaan**

   Rencana yang telah disusun kemudian dilaksanakan oleh seluruh tim keperawatan sesuai pembagian tugas.

6. **Evaluasi**

   Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Jika tujuan belum tercapai, maka dilakukan perbaikan atau revisi perencanaan.

F. Teori Pendukung dalam Perencanaan Keperawatan

Perencanaan dalam manajemen keperawatan didukung oleh berbagai teori manajemen yang umum digunakan dalam pelayanan kesehatan.

1. **Teori Manajemen Fayol**

   Henri Fayol menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Menurut teori ini, perencanaan merupakan dasar dari seluruh fungsi manajemen (Fayol, 1949). Dalam keperawatan, teori Fayol membantu kepala ruangan dalam menyusun program pelayanan yang sistematis dan terarah.

2. **Teori Sistem**

   Teori sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan. Unit keperawatan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan unit lain seperti farmasi, laboratorium, dan rekam medis. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan hubungan antarunit agar pelayanan berjalan optimal.

3. **Konsep Total Quality Management (TQM)**

   TQM menekankan pentingnya perbaikan mutu secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi (Goetsch & Davis, 2016). Dalam pelayanan keperawatan, konsep ini diterapkan melalui:

   - Audit mutu.
   - Supervisi rutin.
   - Pelaporan insiden.
   - Evaluasi kepuasan pasien.
   - Pelatihan peningkatan kompetensi.

G. Hambatan dalam Perencanaan Unit Keperawatan

Meskipun perencanaan memiliki peranan penting, pelaksanaannya sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. **Keterbatasan Sumber Daya**

   Jumlah tenaga perawat yang terbatas dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal.

2. **Kurangnya Komunikasi**

Komunikasi yang kurang efektif antaranggota tim dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. **Perubahan Kebijakan**
   Perubahan regulasi rumah sakit atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan rencana yang telah disusun.
4. **Kurangnya Komitmen**
   Sebagian tenaga kesehatan mungkin kurang memahami pentingnya perencanaan sehingga pelaksanaan program menjadi tidak maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan kepemimpinan yang baik, komunikasi efektif, serta keterlibatan seluruh anggota tim.

H. Peran Kepala Ruangan dalam Perencanaan

Kepala ruangan memiliki peran penting dalam keberhasilan perencanaan unit keperawatan. Tugas kepala ruangan meliputi:

1. Menyusun program kerja unit.
2. Mengatur pembagian tugas perawat.
3. Melakukan supervisi pelayanan.
4. Memastikan standar pelayanan diterapkan.
5. Melakukan evaluasi kinerja.
6. Memberikan motivasi kepada staf.

Seorang kepala ruangan juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik agar program kerja dapat berjalan efektif (Sullivan, 2018).

I. Rangkuman Materi

Perencanaan strategis dan operasional merupakan bagian penting dalam manajemen unit keperawatan. Perencanaan strategis berfungsi menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi, sedangkan perencanaan operasional berfokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perencanaan membantu meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi penggunaan sumber daya, keselamatan pasien, serta kepuasan masyarakat. Penyusunan perencanaan dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, analisis situasi, penetapan tujuan, pelaksanaan program, dan evaluasi.

Keberhasilan perencanaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala ruangan, komunikasi tim, serta dukungan seluruh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, setiap tenaga keperawatan perlu memahami pentingnya perencanaan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan berkualitas.

J. Studi Kasus 1: Keterlambatan Dokumentasi Asuhan Keperawatan

Di ruang rawat inap penyakit dalam, kepala ruangan menemukan bahwa banyak perawat belum menyelesaikan dokumentasi asuhan keperawatan tepat waktu. Akibatnya, informasi kondisi pasien sering tidak lengkap saat pergantian shift. Beberapa dokter juga mengeluhkan keterlambatan data keperawatan yang diperlukan untuk evaluasi pasien.

Selain itu, hasil audit mutu menunjukkan bahwa kelengkapan dokumentasi hanya mencapai 65%, sedangkan standar rumah sakit minimal 90%. Kepala ruangan kemudian diminta menyusun perencanaan untuk memperbaiki masalah tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang terjadi pada kasus tersebut?
2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan keterlambatan dokumentasi?
3. Jelaskan bentuk perencanaan strategis yang dapat dilakukan manajemen keperawatan.
4. Sebutkan contoh perencanaan operasional yang dapat diterapkan kepala ruangan.
5. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan program tersebut?

K. Studi Kasus 2: Peningkatan Risiko Pasien Jatuh

Di ruang geriatri sebuah rumah sakit, dalam waktu dua bulan terjadi tiga kasus pasien jatuh saat menuju kamar mandi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa pasien berisiko tinggi jatuh tidak mendapatkan pengawasan optimal. Selain itu, sebagian perawat belum melakukan asesmen risiko jatuh secara lengkap.

Kejadian tersebut menyebabkan keluarga pasien mulai mempertanyakan kualitas pelayanan rumah sakit. Direktur keperawatan meminta setiap unit menyusun program peningkatan keselamatan pasien.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah keperawatan pada kasus di atas.
2. Apa dampak kejadian pasien jatuh terhadap mutu pelayanan rumah sakit?
3. Jelaskan strategi jangka panjang yang dapat dibuat manajemen keperawatan.
4. Sebutkan kegiatan operasional yang dapat dilakukan di unit keperawatan.
5. Bagaimana peran kepala ruangan dalam mengurangi risiko pasien jatuh?

L. Studi Kasus 3: Kekurangan Tenaga Perawat di IGD

Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengalami peningkatan jumlah pasien setiap hari, terutama pada malam hari dan akhir pekan. Namun jumlah tenaga perawat tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang. Kondisi tersebut

menyebabkan waktu tunggu pasien menjadi lebih lama dan beban kerja perawat meningkat.

Beberapa perawat mulai mengalami kelelahan kerja, sedangkan pasien mengeluhkan lambatnya pelayanan. Kepala ruangan IGD diminta membuat perencanaan untuk mengatasi masalah tersebut tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus tersebut?
2. Bagaimana dampak kekurangan tenaga perawat terhadap keselamatan pasien?
3. Jelaskan bentuk perencanaan strategis yang dapat dilakukan rumah sakit.
4. Sebutkan langkah operasional yang dapat dilakukan kepala ruangan IGD.
5. Bagaimana cara menjaga mutu pelayanan meskipun jumlah tenaga terbatas?

Tugas Diskusi Kelompok

Petunjuk:

1. Bentuk kelompok yang terdiri dari 4–5 mahasiswa.
2. Diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompok.
3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas.
4. Buat kesimpulan kelompok secara tertulis.

M. Daftar Pustaka

Abdillah, A., Harum, H., Jumadi, H., & Pratiwi, S. W. (2024). Analysis of planning for health workforce needs at Lasinrang Pinrang Regional General Hospital. *Journal of Community Health Provision, 4*(2), 111–117. https://doi.org/10.55885/jchp.v4i2.422

Goetsch, D. L., & Davis, S. B. (2016). *Quality management for organizational excellence* (8th ed.). Pearson.

Huber, D. (2022). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.

Sanger, A. Y., & Pitoy, F. F. (2024). The importance of shared planning in nursing practice. *International Scholars Conference, 12*(1). https://doi.org/10.35974/isc.v12i1.3503

Sudrajat, D. A. (2021). Overview the implementation of discharge planning by nurses in hospitals: Literature review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan, 7*(1), 45–53.

Sullivan, E. J. (2018). *Effective leadership and management in nursing* (9th ed.). Pearson.

Weston, M. J. (2022). Strategic planning for a very different nursing workforce. *Nurse Leader, 20*(1), 51–56. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2021.08.009

Wildan, W., Handiyani, H., Pujasari, H., & Kuntarti, K. (2025). Analysis of strategic planning and the role of managers in improving nursing resource performance: Systematic review. *Indonesian Journal of Global Health Research, 7*(4), 651–660. https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i4.6398

World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO.

Yoder-Wise, P. S. (2019). *Leading and managing in nursing* (7th ed.). Elsevier.

BAB 4

MANAJEMEN SDM KEPERAWATAN (STAFFING & SCHEDULING)

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etik-legal, dan tata kelola layanan dalam manajemen keperawatan.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-6
CPL-2	Menganalisis fungsi manajemen dan kepemimpinan untuk pengambilan keputusan dalam unit pelayanan keperawatan.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3
CPL-3	Menyusun perencanaan strategis-operasional dan pengorganisasian pelayanan keperawatan yang efektif.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Mengelola SDM keperawatan meliputi staffing, scheduling, supervisi, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Mengelola sumber daya unit (keuangan dan logistik) secara efisien, akuntabel, dan berorientasi mutu.	CPMK-5, CPMK-6
CPL-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, komunikasi-kolaborasi, serta perubahan dan informatika untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-6, CPMK-7, CPMK-2

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Mendesain pengorganisasian pelayanan dan pengelolaan SDM (model asuhan, staffing, scheduling) sesuai beban kerja dan kompetensi.
CPMK-5	Menyusun rencana pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi serta mengintegrasikan aspek anggaran dan logistik unit.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu dan keselamatan pasien termasuk audit, indikator mutu, dan tindak lanjut perbaikan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Manajemen SDM Keperawatan (Staffing & Scheduling)	5.1 Menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dan kompetensi.	5.2 Menyusun jadwal dinas yang adil dan aman serta rencana penyesuaian saat kekurangan staf.	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	Praktik penyusunan organisasi & jadwal (workshop)	Akurasi model asuhan/struktur ≥80%; jadwal dinas memenuhi aturan keselamatan ≥90% item	15	Struktur organisasi, staffing plan, roster
CPMK-5	Proyek anggaran–logistik & rencana pengembangan	Akurasi komponen anggaran/logistik ≥80%; rencana pengembangan berbasis gap ≥80%	15	Draft anggaran, logistik plan, rencana pelatihan
CPMK-6	Audit mutu mini + laporan QI	Ketepatan indikator & temuan audit ≥80%; rencana perbaikan (QI) lengkap ≥85% item	15	Form audit, analisis data, rencana QI

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)
Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Ketepatan desain organisasi/model asuhan	Model tidak sesuai; peran tumpang tindih; alur kerja tidak jelas.	Model cukup sesuai namun ada ketidakseimbangan peran; alur kurang rapi.	Model sesuai; peran jelas; alur kerja efektif.	Model sangat sesuai; mempertimbangkan beban kerja, risiko, dan kontinuitas asuhan.
4.2 Kualitas staffing & scheduling (adil, aman, adaptif)	Jadwal tidak adil/berisiko; aturan keselamatan dilanggar.	Jadwal cukup namun ada potensi risiko; penyesuaian belum jelas.	Jadwal adil dan aman; rencana penyesuaian saat krisis tersedia.	Jadwal sangat optimal; mempertimbangkan kompetensi shift; strategi mitigasi shortage sangat jelas.

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Akurasi rencana kinerja & pengembangan kompetensi	Indikator kinerja tidak jelas; rencana pengembangan tidak berbasis kebutuhan.	Indikator cukup; rencana umum; keterkaitan dengan gap belum kuat.	Indikator jelas; rencana berbasis gap; implementasi realistis.	Sangat kuat; indikator dan rencana terintegrasi; evaluasi efektivitas pelatihan terukur.
5.2 Kelayakan rancangan anggaran dan logistik unit	Anggaran/logistik tidak realistis; komponen penting hilang.	Cukup realistis namun kurang rinci; kontrol biaya belum tampak.	Realistis dan cukup rinci; kontrol dan monitoring memadai.	Sangat rinci dan efisien; prioritas jelas; monitoring biaya dan stok terstruktur.

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan audit/indikator mutu dan analisis temuan	Indikator tidak tepat; data tidak valid; analisis keliru.	Indikator cukup tepat; data terbatas; analisis belum mendalam.	Indikator tepat; data memadai; analisis temuan jelas.	Indikator sangat tepat; analisis berbasis tren/akar masalah; prioritas perbaikan kuat.
6.2 Kualitas rencana perbaikan (QI) dan tindak lanjut insiden	Rencana tidak operasional; tanpa PIC/timeline; tindak lanjut insiden lemah.	Rencana cukup namun PIC/timeline kurang jelas; tindak lanjut terbatas.	Rencana operasional (PIC, timeline, indikator); tindak lanjut insiden sesuai.	Rencana sangat operasional; monitoring ketat; pembelajaran insiden dan pencegahan berkelanjutan jelas.

Pendahuluan

Manajemen sumber daya manusia keperawatan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena mutu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan teknologi, tetapi juga oleh kecukupan, kompetensi, serta penempatan tenaga keperawatan. Pengelolaan tenaga tidak cukup dilihat dari jumlah perawat, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman, kewenangan klinis, tingkat ketergantungan dan kompleksitas pasien, beban kerja, karakteristik unit, serta kebutuhan pelayanan. Dalam konteks tersebut, staffing dan scheduling menjadi dua komponen utama. Staffing berkaitan dengan penentuan jumlah, jenis, kompetensi, komposisi, distribusi, dan penempatan tenaga, sedangkan scheduling mengatur waktu kerja, pembagian shift, hari kerja, hari libur, cuti, dan rotasi agar pelayanan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Perencanaan tenaga keperawatan perlu didasarkan pada beban kerja dan kondisi aktual pelayanan. Jumlah pasien yang sama belum tentu membutuhkan tenaga yang sama karena tingkat acuity, ketergantungan, intensitas tindakan, serta pola admisi dan pemulangan dapat berbeda. Selain jumlah tenaga, skill mix juga perlu diperhatikan agar setiap shift memiliki kombinasi tenaga berdasarkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan kewenangan klinis yang sesuai. Pengaturan tersebut berkaitan pula dengan pemilihan model penugasan, seperti metode fungsional, metode tim, metode kasus, dan primary nursing. Pada saat yang sama, penyusunan jadwal harus menjamin pelayanan selama dua puluh empat jam dengan tetap memperhatikan pemerataan beban kerja, waktu istirahat, keadilan pembagian shift, serta keselamatan tenaga. Pengaturan jadwal yang tidak tepat dapat meningkatkan lembur, ketidakhadiran, ketidakpuasan, dan kelelahan kerja atau fatigue yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsentrasi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta keselamatan pasien.

Oleh karena itu, staffing dan scheduling perlu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kecukupan dan distribusi tenaga, absensi, keterlambatan, lembur, produktivitas, kepuasan kerja, turnover, missed nursing care, serta indikator mutu dan keselamatan pasien. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki distribusi tenaga, pola jadwal, pengembangan kompetensi, sistem penugasan, dan pemanfaatan teknologi dalam penjadwalan. Bab ini membahas konsep dasar manajemen SDM keperawatan, perencanaan dan perhitungan kebutuhan tenaga, analisis beban kerja, staffing dan penempatan, skill mix dan model penugasan, scheduling, pengelolaan shift, kelelahan kerja, serta evaluasi dan optimalisasi staffing dan scheduling sebagai bagian strategis dalam menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, efektivitas organisasi, dan kesejahteraan tenaga keperawatan.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Manajemen SDM Keperawatan

1. Pengertian Manajemen SDM Keperawatan

Manajemen sumber daya manusia (SDM) keperawatan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, dan evaluasi tenaga keperawatan agar tersedia dalam jumlah, kompetensi, komposisi, serta waktu yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dalam organisasi pelayanan kesehatan, tenaga keperawatan merupakan salah satu unsur penting karena perawat memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan memiliki kontak yang intensif dengan pasien. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga keperawatan tidak hanya berhubungan dengan persoalan administratif kepegawaian, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan, mutu asuhan, keselamatan pasien, efisiensi organisasi, serta kesejahteraan tenaga keperawatan.

Manajemen SDM keperawatan dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa tenaga yang tepat berada pada tempat yang tepat, memiliki kompetensi yang sesuai, tersedia pada waktu yang dibutuhkan, dan mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kecukupan tenaga tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah perawat secara keseluruhan. Suatu unit dapat memiliki jumlah perawat yang terlihat mencukupi, tetapi tetap menghadapi masalah apabila komposisi kompetensinya tidak sesuai dengan tingkat kompleksitas pasien. Sebaliknya, tenaga dengan kompetensi tinggi juga tidak dapat bekerja secara optimal apabila jumlah tenaga yang tersedia terlalu sedikit dibandingkan dengan beban pelayanan.

Dalam konteks tersebut, konsep staffing menjadi bagian penting dari manajemen SDM keperawatan. Staffing berkaitan dengan penentuan kebutuhan, jumlah, jenis, kompetensi, komposisi, dan penempatan tenaga keperawatan pada suatu unit pelayanan. Proses staffing harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah pasien, tingkat ketergantungan dan kompleksitas kondisi pasien, jumlah pasien masuk dan keluar, beban kerja, kompetensi tenaga, pengalaman klinis, ketersediaan tenaga pendukung, karakteristik unit, hingga teknologi yang digunakan dalam pelayanan. AHRQ menekankan bahwa kecukupan staffing tidak dapat

ditentukan hanya melalui rasio perawat-pasien karena kebutuhan tenaga dapat berubah sesuai acuity pasien, turnover pasien, skill mix, serta kondisi unit pelayanan.

Sementara itu, scheduling merupakan proses pengaturan waktu kerja tenaga keperawatan sehingga kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi secara terus-menerus. Pelayanan keperawatan di rumah sakit umumnya berlangsung selama 24 jam sehingga membutuhkan pengaturan shift yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan tanpa mengabaikan waktu istirahat, keselamatan, serta kesejahteraan tenaga. Scheduling mencakup penentuan jumlah tenaga pada setiap shift, distribusi kompetensi, pola rotasi, hari kerja, hari libur, cuti, pergantian jadwal, serta penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan pelayanan.

Staffing dan scheduling memiliki hubungan yang sangat erat. Staffing menjawab pertanyaan mengenai berapa banyak tenaga yang dibutuhkan dan kompetensi apa yang harus tersedia, sedangkan scheduling menjawab pertanyaan mengenai kapan tenaga tersebut bekerja dan bagaimana tenaga didistribusikan pada setiap periode pelayanan. Perencanaan staffing yang baik dapat menjadi tidak efektif apabila jadwal kerja tidak disusun dengan tepat. Sebaliknya, jadwal yang terlihat rapi tidak menjamin pelayanan aman apabila jumlah dan kompetensi tenaga yang dijadwalkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.

Manajemen SDM keperawatan dengan demikian perlu dipandang sebagai proses dinamis. Kebutuhan tenaga dapat berubah mengikuti jumlah pasien, karakteristik kasus, tingkat ketergantungan, perubahan teknologi, pola penyakit, perkembangan pelayanan, maupun perubahan organisasi. Oleh karena itu, perencanaan tenaga tidak dapat hanya dilakukan sekali dan kemudian digunakan dalam jangka panjang tanpa evaluasi. Manajer keperawatan perlu melakukan penilaian secara berkala dan menyesuaikan kebutuhan tenaga dengan kondisi aktual pelayanan.

WHO dalam State of the World's Nursing 2025 menempatkan ketersediaan tenaga keperawatan yang memadai, distribusi tenaga yang adil, serta dukungan terhadap tenaga keperawatan sebagai bagian penting dalam penguatan sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen SDM keperawatan tidak hanya memiliki arti bagi pengelolaan internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari kapasitas sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan yang dapat diakses, bermutu, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Manajemen SDM dalam Pelayanan Keperawatan

Tujuan utama manajemen SDM keperawatan adalah memastikan tersedianya tenaga keperawatan yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara efektif, efisien, aman, dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pasien, kebutuhan tenaga keperawatan, dan kemampuan sumber daya organisasi. Pengelolaan SDM yang baik bukan semata-mata bertujuan memenuhi jumlah formasi tenaga, tetapi memastikan bahwa tenaga yang tersedia benar-benar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pelayanan.

Salah satu tujuan penting adalah menjamin kecukupan tenaga. Kekurangan tenaga dapat meningkatkan beban kerja setiap perawat, membatasi waktu yang tersedia untuk melakukan pengkajian dan intervensi, serta meningkatkan kemungkinan adanya aktivitas keperawatan yang terlambat atau tidak terlaksana. Pada sisi lain, penempatan tenaga yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya tanpa memberikan peningkatan manfaat yang sebanding. Oleh sebab itu, kebutuhan tenaga perlu ditetapkan berdasarkan analisis yang objektif.

Manajemen SDM juga bertujuan memastikan kesesuaian antara kompetensi tenaga dan kebutuhan pasien. Pasien dengan kondisi kompleks membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan klinis, pengalaman, dan kewenangan yang sesuai. Dalam satu shift pelayanan, bukan hanya jumlah perawat yang perlu diperhatikan, tetapi juga komposisi tenaga atau skill mix. Unit dengan tingkat ketergantungan pasien yang tinggi membutuhkan komposisi kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan unit yang menangani pasien dengan kebutuhan perawatan minimal.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan distribusi beban kerja yang rasional dan adil. Ketidakseimbangan beban kerja dapat menyebabkan sebagian tenaga mengalami kelelahan berlebihan sementara tenaga lainnya memiliki beban yang lebih ringan. Kondisi tersebut dapat menurunkan efisiensi, memicu ketidakpuasan kerja, menimbulkan konflik, dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap burnout maupun keinginan untuk meninggalkan organisasi. Karena itu, pembagian tenaga harus memperhatikan jumlah pasien, kompleksitas kebutuhan, jumlah tindakan, karakteristik shift, serta kondisi aktual unit.

Manajemen SDM keperawatan juga bertujuan menjaga kontinuitas pelayanan. Pergantian shift tidak boleh menyebabkan terputusnya informasi

maupun pelayanan kepada pasien. Pengaturan jadwal, handover, distribusi tenaga, dan penempatan perawat harus mendukung kesinambungan asuhan dari satu shift ke shift berikutnya. Dalam pelayanan yang bersifat 24 jam, kontinuitas menjadi bagian penting dalam mempertahankan mutu dan mencegah terjadinya kesenjangan pelayanan.

Selain kepentingan pasien, manajemen SDM bertujuan menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Pengaturan waktu kerja yang tidak proporsional, shift malam yang berlebihan, waktu istirahat yang tidak mencukupi, lembur berkepanjangan, dan beban kerja yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kelelahan. Kelelahan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan perawat, tetapi juga dapat memengaruhi konsentrasi, ketelitian, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan.

Tujuan lainnya adalah mendukung pengembangan profesional tenaga keperawatan. Organisasi tidak hanya membutuhkan tenaga dalam jumlah yang mencukupi, tetapi juga membutuhkan tenaga yang kompetensinya berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pasien, dan standar pelayanan. Oleh karena itu, manajemen SDM perlu menyediakan kesempatan pendidikan, pelatihan, orientasi, supervisi, pengembangan karier, serta pembinaan kompetensi.

Pada tingkat organisasi, manajemen SDM bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Biaya tenaga merupakan salah satu komponen penting dalam operasional pelayanan kesehatan. Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai mengurangi jumlah tenaga sebanyak mungkin. Efisiensi berarti memperoleh hasil pelayanan yang optimal melalui penggunaan tenaga secara tepat. Pengurangan tenaga yang menyebabkan meningkatnya insiden keselamatan, keterlambatan pelayanan, lembur, turnover, atau ketidakpuasan pasien justru dapat meningkatkan beban organisasi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, tujuan manajemen SDM keperawatan mencakup dua kepentingan yang harus berjalan bersama, yaitu mempertahankan mutu dan keselamatan pelayanan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi tenaga keperawatan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena kondisi kerja perawat akan memengaruhi kemampuan tenaga dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

3. Ruang Lingkup Manajemen SDM Keperawatan

Ruang lingkup manajemen SDM keperawatan mencakup seluruh siklus pengelolaan tenaga sejak organisasi mengidentifikasi kebutuhan tenaga hingga melakukan evaluasi terhadap kinerja dan keberlanjutan tenaga dalam organisasi. Dengan cakupan tersebut, manajemen SDM bukan hanya tugas bagian kepegawaian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pimpinan keperawatan, kepala unit, bagian pendidikan dan pelatihan, manajemen rumah sakit, serta tenaga keperawatan itu sendiri.

Perencanaan tenaga merupakan tahap awal yang sangat penting. Organisasi perlu menentukan jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan berdasarkan pelayanan yang diberikan. Perencanaan perlu mempertimbangkan kapasitas tempat tidur, tingkat hunian, karakteristik pasien, tingkat ketergantungan pasien, jam perawatan, pola kunjungan, perubahan volume pelayanan, jenis tindakan, kompetensi yang dibutuhkan, dan rencana pengembangan organisasi.

Ruang lingkup berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Proses ini bertujuan memperoleh tenaga yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Seleksi tidak cukup berdasarkan ijazah atau latar belakang pendidikan, tetapi perlu mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kemampuan berkomunikasi, integritas, kemampuan bekerja dalam tim, kesiapan bekerja dalam sistem shift, serta kesesuaian individu dengan karakteristik pelayanan.

Setelah tenaga diterima, diperlukan proses orientasi dan penempatan. Orientasi membantu tenaga baru memahami organisasi, standar pelayanan, budaya keselamatan, kebijakan, sistem dokumentasi, alur komunikasi, serta tanggung jawab profesionalnya. Penempatan kemudian dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit. Penempatan yang tidak tepat dapat mengurangi produktivitas serta meningkatkan risiko kesalahan, khususnya apabila tenaga ditempatkan pada lingkungan klinis yang membutuhkan kompetensi khusus tanpa persiapan yang memadai.

Pengembangan kompetensi juga menjadi bagian dari ruang lingkup manajemen SDM. Perawat perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya secara berkala. Pengembangan dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, mentoring, coaching, supervisi klinis, diskusi kasus, simulasi, maupun kegiatan ilmiah. Pengembangan kompetensi juga perlu diarahkan sesuai kebutuhan unit dan perkembangan karier tenaga.

Manajemen kinerja merupakan bagian berikutnya. Kinerja tenaga perlu dievaluasi untuk mengetahui pencapaian, kebutuhan pengembangan, serta masalah yang dapat memengaruhi mutu pelayanan. Evaluasi kinerja sebaiknya

tidak hanya berfokus pada kesalahan atau kekurangan, tetapi digunakan sebagai dasar pembinaan dan peningkatan kemampuan. Umpan balik yang konstruktif membantu tenaga memahami kekuatan dan area yang masih memerlukan pengembangan.

Staffing merupakan bagian yang sangat penting dalam ruang lingkup manajemen SDM. Staffing mencakup analisis kebutuhan jumlah tenaga, distribusi tenaga antarunit, pengaturan komposisi kompetensi, penggantian tenaga yang tidak hadir, serta penyesuaian tenaga terhadap perubahan beban pelayanan. Staffing perlu dilakukan secara fleksibel karena kebutuhan pasien dapat berubah dari waktu ke waktu.

Scheduling kemudian mengatur distribusi tenaga berdasarkan waktu. Penyusunan jadwal harus memastikan setiap shift memiliki jumlah dan komposisi tenaga yang memadai. Jadwal juga perlu mempertimbangkan waktu istirahat, pemerataan shift malam, cuti, kebutuhan pribadi yang dapat diakomodasi, pendidikan atau pelatihan, serta kebijakan organisasi. Jadwal yang baik perlu cukup fleksibel untuk menghadapi ketidakhadiran mendadak atau peningkatan kebutuhan pelayanan, tetapi tetap memiliki aturan yang transparan.

Retensi tenaga juga merupakan bagian penting dalam manajemen SDM keperawatan. Organisasi perlu menciptakan kondisi yang mendukung tenaga untuk bertahan dan berkembang. Faktor seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, penghargaan, kesempatan pengembangan karier, hubungan antarprofesi, beban kerja, keseimbangan kehidupan kerja, serta dukungan organisasi dapat memengaruhi keputusan perawat untuk tetap bekerja. Tantangan terkait rekrutmen, retensi, beban kerja, staffing yang aman, serta burnout juga menjadi perhatian organisasi keperawatan secara internasional.

Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, manajemen SDM keperawatan pada dasarnya mengelola perjalanan tenaga di dalam organisasi sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi. Pendekatannya harus bersifat strategis dan berkelanjutan, bukan sekadar menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga ketika masalah sudah terjadi.

4. Fungsi Manajemen SDM dalam Organisasi Pelayanan Kesehatan

Fungsi manajemen SDM keperawatan dapat dipahami melalui fungsi manajemen secara umum, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut saling berhubungan dan diterapkan dalam pengelolaan tenaga keperawatan.

Fungsi perencanaan dilakukan dengan menentukan kebutuhan tenaga berdasarkan kondisi pelayanan saat ini dan proyeksi kebutuhan pada masa mendatang. Dalam tahap ini, manajer mengidentifikasi jumlah tenaga yang tersedia, kompetensi tenaga, pola pelayanan, kebutuhan unit, tingkat ketergantungan pasien, beban kerja, hingga kemungkinan perubahan pelayanan. Perencanaan yang baik dapat mencegah organisasi hanya bersikap reaktif ketika kekurangan tenaga telah terjadi.

Perencanaan SDM perlu didasarkan pada data. WHO melalui kajian mengenai health and care workforce planning menekankan pentingnya pendekatan perencanaan tenaga yang menggunakan informasi kebutuhan layanan, kapasitas tenaga, dan instrumen perencanaan yang sesuai. Artinya, keputusan mengenai tenaga idealnya tidak hanya menggunakan perkiraan subjektif, tetapi didasarkan pada informasi yang dapat dianalisis dan dievaluasi.

Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, pola komunikasi, serta hubungan kerja. Dalam keperawatan, pengorganisasian dapat terlihat melalui struktur organisasi keperawatan, pembagian unit, model penugasan, pembentukan tim, penempatan tenaga, serta distribusi tanggung jawab. Pengorganisasian yang jelas mencegah tumpang tindih pekerjaan dan membantu setiap tenaga memahami peran yang harus dilakukan.

Fungsi pengarahan berkaitan dengan kemampuan pimpinan dalam menggerakkan tenaga agar mencapai tujuan pelayanan. Pengarahan meliputi komunikasi, motivasi, supervisi, delegasi, penyelesaian konflik, pemberian umpan balik, coaching, dan pembinaan. Kepala ruang atau manajer keperawatan tidak cukup hanya membuat jadwal kerja. Mereka juga perlu memastikan bahwa tenaga memahami tanggung jawab, memperoleh dukungan ketika menghadapi masalah, dan mampu bekerja sama secara efektif.

Komunikasi menjadi unsur penting dalam fungsi pengarahan. Pelayanan keperawatan melibatkan interaksi yang intensif antara perawat, pasien, keluarga, dokter, apoteker, ahli gizi, tenaga rehabilitasi, serta profesi lainnya. AHRQ menempatkan perawat pada posisi penting dalam pemantauan kondisi pasien, pengenalan deteriorasi klinis, komunikasi perubahan kondisi, dan koordinasi pelayanan. Karena itu, pengelolaan SDM yang efektif harus mendukung komunikasi yang terbuka dan aman.

Fungsi pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. Manajer perlu mengevaluasi apakah jumlah tenaga telah sesuai, jadwal dapat

dijalankan, beban kerja terdistribusi dengan baik, tingkat ketidakhadiran dapat dikendalikan, kompetensi terpenuhi, serta indikator mutu menunjukkan hasil yang diharapkan. Data mengenai absensi, lembur, turnover, insiden keselamatan, keluhan pasien, missed nursing care, kepuasan tenaga, dan produktivitas dapat menjadi bahan evaluasi.

Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan. Apabila ditemukan bahwa shift tertentu berulang kali mengalami kekurangan tenaga, manajer perlu mengidentifikasi penyebabnya. Apabila masalah disebabkan distribusi tenaga yang tidak tepat, maka diperlukan perubahan pola penempatan. Apabila disebabkan tingginya absensi, faktor yang menyebabkan absensi perlu dianalisis. Apabila kekurangan terjadi akibat peningkatan volume pasien, kebutuhan staffing perlu dihitung kembali.

Dengan demikian, fungsi manajemen SDM membentuk siklus yang terus berjalan. Hasil pengendalian menjadi masukan bagi perencanaan berikutnya. Siklus tersebut memungkinkan organisasi beradaptasi terhadap perubahan dan menjaga agar pengelolaan tenaga tetap sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

5. Prinsip Pengelolaan Tenaga Keperawatan

Pengelolaan tenaga keperawatan harus didasarkan pada sejumlah prinsip agar keputusan staffing dan scheduling tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mendukung kualitas pelayanan.

Prinsip pertama adalah kesesuaian antara kebutuhan pasien dan ketersediaan tenaga. Jumlah tenaga perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pelayanan, bukan hanya jumlah tempat tidur atau jumlah pasien. Dua unit dengan jumlah pasien yang sama dapat membutuhkan jumlah perawat yang berbeda apabila tingkat ketergantungan dan kompleksitas kasusnya berbeda. Oleh sebab itu, acuity pasien menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebutuhan tenaga.

Prinsip berikutnya adalah kompetensi. Penempatan tenaga perlu sesuai dengan kemampuan, pendidikan, pengalaman, kewenangan klinis, serta karakteristik pasien yang dilayani. Kesalahan dalam penempatan dapat menimbulkan risiko apabila tenaga harus melakukan pelayanan yang melampaui kompetensi atau belum dikuasainya. Skill mix menjadi penting karena pelayanan membutuhkan kombinasi tenaga dengan kompetensi yang berbeda.

Prinsip keadilan juga perlu diterapkan. Keadilan tidak berarti seluruh perawat harus mendapatkan jumlah shift yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi. Keadilan berarti pembagian tanggung jawab dilakukan berdasarkan aturan yang transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian shift malam, hari libur, beban pasien, lembur, serta kesempatan mengikuti pendidikan perlu dikelola secara adil untuk mencegah konflik dan ketidakpuasan.

Prinsip fleksibilitas dibutuhkan karena pelayanan kesehatan bersifat dinamis. Jumlah pasien dapat berubah, kondisi pasien dapat memburuk, tenaga dapat mengalami sakit, terjadi peningkatan kunjungan, atau muncul situasi kedaruratan. Oleh karena itu, staffing dan scheduling perlu memiliki mekanisme penyesuaian, misalnya melalui redistribusi tenaga, tenaga pengganti, perubahan penugasan, atau mekanisme lain yang tetap memperhatikan keselamatan.

Prinsip efisiensi mengarahkan organisasi untuk memanfaatkan tenaga secara optimal. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan keselamatan. Efisiensi dalam manajemen keperawatan berarti mencapai pelayanan yang berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang tepat, bukan semata-mata meminimalkan jumlah tenaga. Keputusan staffing perlu mempertimbangkan konsekuensi klinis maupun organisasional apabila tenaga terlalu sedikit.

Prinsip keselamatan menempatkan keselamatan pasien dan tenaga sebagai pertimbangan utama. Jam kerja yang panjang, kurangnya waktu istirahat, kerja lembur berkepanjangan, dan beban pasien yang terlalu tinggi dapat memengaruhi konsentrasi serta performa tenaga. Karena itu, penyusunan jadwal tidak seharusnya hanya berorientasi pada terpenuhinya seluruh shift, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan manusia untuk bekerja secara aman.

Prinsip partisipasi juga penting dalam pengelolaan SDM. Perawat sebagai pihak yang menjalankan pelayanan memiliki pengetahuan langsung mengenai beban kerja dan kondisi unit. Keterlibatan tenaga dalam memberikan masukan terhadap jadwal, pola kerja, serta masalah operasional dapat membantu manajemen memperoleh informasi yang lebih realistis sekaligus meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan organisasi.

Prinsip transparansi diperlukan agar proses pengelolaan tenaga dapat dipahami. Kriteria penempatan, pembagian jadwal, perubahan shift, pemberian kesempatan pelatihan, dan evaluasi kinerja sebaiknya memiliki dasar yang jelas. Transparansi dapat mengurangi persepsi ketidakadilan dan meningkatkan kepercayaan terhadap pimpinan.

Prinsip terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Staffing yang dianggap sesuai pada satu periode belum tentu tetap sesuai pada periode berikutnya. Perubahan jumlah pasien, profil kasus, pola pelayanan, teknologi, kompetensi, serta kondisi tenaga dapat mengubah kebutuhan. Oleh karena itu, evaluasi perlu menjadi bagian rutin dari manajemen SDM.

6. Hubungan Manajemen SDM dengan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Manajemen SDM keperawatan memiliki hubungan erat dengan mutu pelayanan karena sebagian besar proses asuhan membutuhkan keterlibatan langsung tenaga keperawatan. Perawat melakukan pengkajian, pemantauan, pemberian intervensi, administrasi obat sesuai kewenangan dan sistem pelayanan, edukasi, dokumentasi, koordinasi, serta pengenalan dini perubahan kondisi pasien. Kemampuan melaksanakan seluruh fungsi tersebut dipengaruhi oleh jumlah pasien yang harus ditangani, kompleksitas kebutuhan pasien, kompetensi tenaga, waktu yang tersedia, serta dukungan lingkungan kerja.

Ketika jumlah tenaga tidak sesuai dengan kebutuhan, waktu yang tersedia bagi perawat untuk setiap pasien menjadi lebih terbatas. Dalam kondisi beban kerja tinggi, perawat mungkin harus menentukan prioritas terhadap tindakan yang dianggap paling mendesak. Akibatnya, beberapa aktivitas lain dapat tertunda atau tidak terlaksana. Kondisi ini dikenal dalam literatur sebagai missed nursing care atau omitted nursing care. Kajian sistematis menunjukkan adanya hubungan antara staffing yang lebih rendah dan meningkatnya laporan mengenai asuhan keperawatan yang terlewat.

Asuhan yang terlewat dapat meliputi berbagai aktivitas seperti edukasi, mobilisasi, pemantauan, bantuan kebutuhan dasar, komunikasi, atau tindakan lain yang sebenarnya diperlukan pasien. Walaupun tidak seluruh tindakan yang tertunda secara langsung menghasilkan kejadian tidak diharapkan, akumulasi dari pelayanan yang tidak terlaksana dapat memengaruhi pengalaman pasien dan hasil pelayanan.

Staffing juga berkaitan dengan kemampuan perawat melakukan surveillance atau pemantauan terhadap perubahan kondisi pasien. Perawat sering menjadi tenaga yang pertama mengenali perubahan tanda vital, penurunan kesadaran, perubahan pola pernapasan, nyeri yang memburuk, atau tanda klinis lain yang menunjukkan deteriorasi. Apabila beban pasien terlalu tinggi, kesempatan melakukan pemantauan secara konsisten dapat

berkurang. Oleh karena itu, kecukupan tenaga menjadi bagian dari sistem pertahanan terhadap kejadian keselamatan pasien.

Bukti penelitian secara umum menunjukkan bahwa tingkat staffing perawat berhubungan dengan berbagai luaran pasien. AHRQ mencatat bahwa peningkatan jumlah pasien yang harus ditangani seorang perawat pada berbagai konteks telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian keselamatan, morbiditas, dan mortalitas. Namun, hubungan tersebut tidak seharusnya disederhanakan hanya menjadi satu angka rasio universal karena kebutuhan tenaga dipengaruhi oleh acuity, turnover pasien, skill mix, dukungan tenaga lain, teknologi, dan karakteristik unit.

Pada pelayanan gawat darurat, misalnya, tinjauan sistematis tahun 2024 menemukan bahwa beberapa penelitian menghubungkan staffing yang lebih rendah dengan waktu tunggu yang lebih panjang, keterlambatan pemberian obat atau terapi, serta sejumlah luaran keselamatan lainnya, meskipun kekuatan hasil berbeda antarpenelitian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efek staffing dapat berbeda sesuai konteks pelayanan.

Manajemen SDM juga berhubungan dengan pencegahan infeksi. Tingkat staffing yang tidak sesuai dapat meningkatkan beban kerja dan memengaruhi konsistensi penerapan berbagai proses pelayanan. Sebuah tinjauan sistematis mengenai staffing rumah sakit dan infeksi terkait pelayanan kesehatan menemukan bahwa peningkatan staffing secara umum berhubungan dengan penurunan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan.

Selain jumlah tenaga, kualitas SDM merupakan faktor penting. Penambahan jumlah tenaga tanpa memperhatikan kompetensi tidak selalu menghasilkan peningkatan mutu yang optimal. Skill mix yang tepat membantu memastikan bahwa setiap shift memiliki tenaga yang mampu menangani kebutuhan pasien. Unit dengan pasien berisiko tinggi memerlukan tenaga dengan pengalaman dan kompetensi yang sesuai untuk mengenali masalah, melakukan intervensi, serta mengambil keputusan secara cepat.

Scheduling juga berhubungan dengan keselamatan. Jadwal kerja yang tidak sehat dapat menyebabkan kelelahan, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, dan berkurangnya kewaspadaan. Apabila kondisi tersebut terjadi berulang, risiko kesalahan dapat meningkat. Dengan demikian, jadwal dinas perlu memperhatikan waktu istirahat dan distribusi shift, bukan hanya memastikan bahwa setiap jadwal terisi.

Mutu pelayanan juga dipengaruhi oleh stabilitas tenaga. Tingginya turnover dapat menyebabkan organisasi kehilangan tenaga berpengalaman, meningkatkan kebutuhan orientasi tenaga baru, serta mengubah dinamika tim.

Manajemen SDM yang baik karena itu harus memperhatikan retensi dan lingkungan kerja. Upaya mempertahankan tenaga tidak semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan individu, tetapi juga dengan mempertahankan pengetahuan, pengalaman, dan stabilitas tim pelayanan.

Hubungan antara SDM dan mutu juga berlangsung dua arah. Pengelolaan SDM yang baik mendukung pelayanan yang bermutu, sementara lingkungan pelayanan yang bermutu dapat mendukung kepuasan dan retensi tenaga. Sebaliknya, staffing yang tidak memadai dapat meningkatkan beban kerja dan ketidakpuasan, sedangkan ketidakpuasan dan turnover kemudian dapat semakin memperburuk kecukupan tenaga. Situasi ini dapat membentuk siklus yang merugikan apabila tidak ditangani oleh organisasi.

Oleh karena itu, indikator SDM perlu dipertimbangkan bersama indikator mutu. Manajer keperawatan tidak cukup hanya melihat apakah jumlah tenaga sesuai dengan formasi. Evaluasi dapat mencakup tingkat absensi, lembur, turnover, distribusi kompetensi, beban kerja, missed nursing care, insiden keselamatan, keluhan pasien, kepuasan pasien, serta kepuasan tenaga. Analisis berbagai indikator tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai efektivitas pengelolaan SDM.

Pada akhirnya, manajemen SDM keperawatan merupakan bagian integral dari manajemen mutu dan keselamatan pasien. Ketersediaan tenaga yang memadai, kompeten, terdistribusi secara tepat, serta bekerja dalam jadwal yang aman memungkinkan perawat melaksanakan asuhan secara lebih konsisten. Sebaliknya, ketidaksesuaian jumlah tenaga, skill mix, beban kerja, dan jadwal dapat menciptakan kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan, asuhan yang terlewat, kelelahan tenaga, serta masalah keselamatan. Oleh karena itu, staffing dan scheduling seharusnya dipandang sebagai keputusan klinis dan strategis, bukan sekadar persoalan administrasi penyusunan tenaga dan jadwal kerja.

B. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Keperawatan

1. Pengertian Perencanaan Tenaga Keperawatan

Perencanaan tenaga keperawatan merupakan proses sistematis untuk menentukan jumlah, jenis, kualifikasi, kompetensi, distribusi, dan waktu ketersediaan tenaga keperawatan yang diperlukan agar kebutuhan pelayanan pasien dapat dipenuhi secara efektif, efisien, aman, dan berkesinambungan. Perencanaan tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia keperawatan karena keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, teknologi, dan

sistem pelayanan, tetapi juga sangat bergantung pada kecukupan tenaga yang melaksanakan asuhan secara langsung.

Perencanaan tenaga keperawatan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan menghitung berapa jumlah perawat yang dibutuhkan dalam suatu ruangan. Proses ini jauh lebih kompleks karena harus mempertimbangkan karakteristik pasien, tingkat ketergantungan pasien, jenis pelayanan, intensitas tindakan, pola kunjungan, jumlah tempat tidur, tingkat hunian, kompetensi tenaga, pola shift, waktu kerja efektif, hari libur, cuti, pelatihan, ketidakhadiran, serta perubahan kebutuhan pelayanan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perencanaan tenaga merupakan proses pengambilan keputusan yang menghubungkan kebutuhan pelayanan dengan kapasitas tenaga yang tersedia.

Dalam praktik manajemen keperawatan, jumlah tenaga yang sama belum tentu dapat diterapkan pada dua unit pelayanan yang berbeda. Sebagai contoh, unit rawat inap dengan pasien yang relatif mandiri memiliki kebutuhan tenaga yang berbeda dengan unit yang sebagian besar pasiennya membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Demikian pula, kebutuhan tenaga pada unit perawatan intensif berbeda dengan ruang rawat inap biasa, meskipun jumlah pasien pada kedua unit tersebut sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tenaga harus didasarkan pada kebutuhan nyata pelayanan dan bukan semata-mata pada jumlah pasien.

Perencanaan tenaga juga perlu memperhitungkan perubahan kondisi pelayanan. Pada waktu tertentu, jumlah pasien dapat meningkat secara signifikan, tingkat ketergantungan pasien dapat berubah, atau terdapat lebih banyak pasien yang membutuhkan observasi ketat. Selain itu, tenaga yang tersedia dapat berkurang akibat cuti, sakit, pendidikan, pelatihan, mutasi, atau pengunduran diri. Oleh karena itu, perencanaan tenaga yang baik harus memiliki tingkat fleksibilitas yang memungkinkan organisasi menyesuaikan kebutuhan dengan perubahan situasi.

Dalam pendekatan manajemen modern, perencanaan tenaga keperawatan sebaiknya berbasis data. Informasi mengenai jumlah pasien, tingkat ketergantungan, lama perawatan, pola admisi dan pemulangan, beban kerja, penggunaan lembur, tingkat absensi, turnover, serta indikator mutu dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan tenaga secara lebih objektif. WHO juga menekankan pentingnya data tenaga kesehatan dan perencanaan berbasis kebutuhan layanan untuk mendukung keputusan mengenai ketersediaan, distribusi, pendidikan, dan pemanfaatan tenaga kesehatan.

Perencanaan yang berbasis data memungkinkan manajer keperawatan menghindari keputusan yang semata-mata berdasarkan kebiasaan. Misalnya, suatu ruangan mungkin selama bertahun-tahun menggunakan jumlah tenaga yang sama pada setiap shift. Namun, apabila jumlah pasien, jenis tindakan, teknologi, atau kompleksitas pelayanan telah berubah, pola tenaga tersebut belum tentu masih sesuai. Evaluasi berkala diperlukan agar jumlah dan komposisi tenaga tetap mencerminkan kebutuhan pelayanan aktual.

Perencanaan tenaga keperawatan juga memiliki dimensi jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan jangka pendek dapat berkaitan dengan pemenuhan tenaga setiap shift, penggantian tenaga yang tidak hadir, atau penyesuaian tenaga akibat peningkatan jumlah pasien. Perencanaan jangka menengah dapat mencakup kebutuhan rekrutmen, rotasi, pelatihan, atau pengembangan kompetensi selama beberapa bulan hingga satu tahun. Sementara itu, perencanaan jangka panjang berhubungan dengan proyeksi kebutuhan tenaga berdasarkan pengembangan rumah sakit, pembukaan unit baru, perkembangan teknologi, perubahan pola penyakit, serta rencana strategis organisasi.

Dengan demikian, perencanaan tenaga keperawatan merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Hasil perencanaan tidak bersifat tetap, tetapi perlu dikaji kembali berdasarkan perubahan kebutuhan pasien, pelayanan, dan organisasi. Perencanaan yang tepat menjadi dasar bagi staffing dan scheduling karena organisasi harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan tenaga sebelum menentukan penempatan dan penyusunan jadwal kerja.

2. Tujuan Perencanaan Kebutuhan Tenaga

Tujuan utama perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan adalah memastikan bahwa pelayanan memiliki tenaga yang cukup, kompeten, dan tersedia pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kecukupan tenaga harus dipahami tidak hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dari kesesuaian kompetensi dan distribusi tenaga. Ruang pelayanan dengan jumlah perawat yang cukup secara numerik belum tentu memiliki staffing yang memadai apabila sebagian besar tenaga belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat kompleksitas pasien.

Perencanaan tenaga bertujuan mencegah kekurangan tenaga yang dapat meningkatkan beban kerja. Apabila seorang perawat harus merawat terlalu banyak pasien atau menangani pasien dengan kebutuhan yang sangat kompleks tanpa dukungan tenaga yang memadai, waktu yang tersedia untuk melakukan pengkajian, intervensi, pemantauan, edukasi, dokumentasi, dan

komunikasi dapat menjadi terbatas. Dalam kondisi tersebut, risiko terjadinya keterlambatan pelayanan, kelelahan, dan asuhan yang tidak terselesaikan dapat meningkat.

Sebaliknya, perencanaan juga bertujuan mencegah penggunaan tenaga yang tidak proporsional terhadap kebutuhan. Kelebihan tenaga secara terus-menerus dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Oleh sebab itu, manajemen perlu memperoleh keseimbangan antara kecukupan tenaga untuk menjamin mutu dan keselamatan dengan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Efisiensi bukan berarti mengurangi tenaga semaksimal mungkin, tetapi mengalokasikan tenaga secara tepat sesuai kebutuhan.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan distribusi tenaga yang rasional. Organisasi pelayanan kesehatan dapat memiliki jumlah tenaga keperawatan yang secara keseluruhan mencukupi, tetapi distribusinya belum tentu merata. Ada unit yang mengalami kekurangan tenaga sementara unit lain memiliki beban pelayanan yang lebih rendah. Perencanaan yang baik membantu manajemen mengidentifikasi ketidakseimbangan tersebut dan menentukan apakah diperlukan redistribusi, rotasi, penambahan, atau perubahan pola penempatan.

Perencanaan kebutuhan tenaga juga bertujuan mendukung kontinuitas pelayanan. Pelayanan keperawatan berlangsung sepanjang waktu, khususnya pada fasilitas rawat inap. Oleh karena itu, tenaga harus tersedia tidak hanya pada jam kerja pagi, tetapi juga pada shift sore, malam, akhir pekan, dan hari libur. Perencanaan perlu memastikan bahwa kebutuhan pelayanan dapat dipenuhi secara konsisten pada seluruh periode kerja.

Tujuan lainnya adalah memastikan tersedianya kombinasi kompetensi yang tepat. Tidak seluruh perawat memiliki pengalaman, kewenangan klinis, dan kompetensi yang sama. Dalam satu shift diperlukan komposisi tenaga yang seimbang antara tenaga berpengalaman dan tenaga yang masih membutuhkan supervisi. Kondisi ini penting agar pelayanan dapat tetap berjalan aman sekaligus memberikan ruang bagi proses pengembangan profesional.

Perencanaan juga memberikan dasar bagi rekrutmen. Tanpa perencanaan yang jelas, organisasi dapat melakukan rekrutmen hanya ketika kekurangan tenaga sudah menjadi masalah. Pendekatan seperti ini bersifat reaktif dan dapat menyebabkan pelayanan mengalami kekurangan tenaga dalam periode tertentu. Melalui proyeksi kebutuhan, organisasi dapat

memperkirakan kebutuhan rekrutmen sebelum kekurangan tenaga mencapai tingkat yang mengganggu pelayanan.

Selain itu, perencanaan kebutuhan tenaga membantu organisasi merencanakan pendidikan dan pengembangan SDM. Apabila suatu unit akan mengembangkan pelayanan tertentu, organisasi tidak hanya perlu memikirkan jumlah tenaga tambahan, tetapi juga kompetensi yang harus dimiliki. Tenaga yang ada dapat dipersiapkan melalui pendidikan, pelatihan, orientasi, sertifikasi, atau supervisi agar ketika pelayanan tersebut mulai berjalan, kompetensi yang dibutuhkan telah tersedia.

Perencanaan tenaga juga bertujuan mendukung kesejahteraan dan retensi perawat. Kekurangan tenaga yang berlangsung lama dapat menyebabkan penggunaan lembur yang berlebihan, frekuensi shift malam yang tinggi, perubahan jadwal secara mendadak, serta kesulitan memperoleh waktu istirahat atau cuti. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepuasan kerja dan meningkatkan risiko burnout. Perencanaan yang realistis membantu organisasi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan tenaga.

Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan tenaga keperawatan memiliki tujuan strategis untuk memastikan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. WHO menempatkan kecukupan, distribusi yang adil, kondisi kerja, pendidikan, dan dukungan terhadap tenaga keperawatan sebagai bagian penting dalam penguatan tenaga kesehatan dan pencapaian pelayanan kesehatan yang lebih merata.

3. Faktor yang Memengaruhi Kebutuhan Tenaga Keperawatan

Kebutuhan tenaga keperawatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, perencanaan tidak dapat hanya menggunakan satu indikator. Jumlah pasien memang menjadi faktor penting, tetapi tidak cukup digunakan sebagai satu-satunya dasar karena pasien memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda.

Salah satu faktor utama adalah volume pelayanan. Volume pelayanan dapat tercermin dari jumlah pasien, tingkat hunian tempat tidur, jumlah kunjungan, jumlah pasien masuk, pasien pulang, dan pasien pindah. Semakin tinggi volume pelayanan, semakin besar pula aktivitas yang harus dilaksanakan oleh tenaga keperawatan. Namun, hubungan tersebut tidak selalu linier karena kompleksitas setiap pasien dapat berbeda.

Faktor berikutnya adalah tingkat ketergantungan dan kompleksitas pasien. Pasien yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan dasarnya

sendiri membutuhkan waktu pelayanan yang berbeda dibandingkan pasien yang mengalami keterbatasan mobilitas, penurunan kesadaran, ketergantungan penuh, atau membutuhkan observasi ketat. Karena itu, dua ruangan dengan jumlah pasien yang sama dapat membutuhkan tenaga yang berbeda apabila tingkat ketergantungan pasiennya tidak sama.

Jenis dan intensitas tindakan keperawatan turut menentukan kebutuhan tenaga. Unit dengan banyak tindakan kompleks, pemantauan kontinu, pemberian terapi yang membutuhkan pengawasan tinggi, perawatan luka kompleks, atau edukasi intensif akan membutuhkan alokasi waktu tenaga yang lebih besar. Aktivitas tersebut perlu diperhitungkan karena kebutuhan tenaga tidak hanya berasal dari aktivitas dasar seperti pemberian makan atau kebersihan pasien.

Pola admisi, pemulangan, dan transfer pasien juga memengaruhi beban kerja. Pasien baru membutuhkan proses pengkajian awal, orientasi, pengumpulan data, rekonsiliasi informasi, perencanaan asuhan, serta dokumentasi. Pasien yang akan dipulangkan membutuhkan edukasi, koordinasi, dokumentasi, serta persiapan kesinambungan perawatan. Pasien yang berpindah unit juga membutuhkan proses komunikasi dan serah terima. Oleh sebab itu, unit dengan turnover pasien yang tinggi dapat memiliki beban kerja lebih besar dibandingkan unit dengan jumlah pasien yang relatif stabil.

Faktor lain adalah model pemberian asuhan keperawatan. Metode fungsional, metode tim, primary nursing, atau model lainnya dapat memiliki kebutuhan distribusi tenaga yang berbeda. Model penugasan menentukan bagaimana tanggung jawab dibagi, bagaimana komunikasi dilakukan, dan bagaimana perawat berkoordinasi. Oleh karena itu, perencanaan tenaga harus selaras dengan model pelayanan yang digunakan organisasi.

Ketersediaan tenaga penunjang juga memengaruhi kebutuhan. Apabila unit memiliki tenaga administrasi, transporter, tenaga kebersihan, atau tenaga pendukung lainnya yang memadai, perawat dapat lebih fokus pada aktivitas keperawatan. Sebaliknya, apabila perawat harus melakukan banyak pekerjaan nonkeperawatan, beban kerja meningkat dan waktu yang tersedia bagi pasien berkurang.

Teknologi dapat memberikan pengaruh yang berbeda. Sistem dokumentasi elektronik, alat pemantauan otomatis, sistem distribusi obat, atau teknologi komunikasi dapat meningkatkan efisiensi apabila dirancang dan digunakan dengan baik. Namun, teknologi yang kompleks, sering bermasalah, atau membutuhkan input data yang berlebihan dapat justru menambah beban

kerja. Oleh sebab itu, dampak teknologi terhadap waktu kerja perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga.

Tata ruang dan kondisi fisik unit juga dapat memengaruhi kebutuhan. Ruangan yang sangat luas, memiliki banyak kamar terpisah, atau memiliki jarak yang jauh antararea dapat meningkatkan waktu mobilisasi tenaga. Desain unit yang memudahkan observasi dan akses terhadap peralatan dapat membantu efisiensi kerja.

Kondisi tenaga juga menjadi faktor penting. Tingkat absensi, cuti, pendidikan, pelatihan, mutasi, turnover, kehamilan, maupun keterbatasan tertentu dapat memengaruhi jumlah tenaga yang benar-benar tersedia. Karena itu, jumlah tenaga pada daftar kepegawaian tidak selalu sama dengan jumlah tenaga efektif yang dapat dijadwalkan.

Pola kerja dan kebijakan organisasi turut memengaruhi kebutuhan. Lama shift, jumlah hari kerja, waktu istirahat, ketentuan hari libur, kebijakan lembur, serta pola rotasi menentukan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan secara terus-menerus. Semakin besar kebutuhan untuk menggantikan waktu tidak produktif seperti cuti atau pelatihan, semakin besar pula kebutuhan tenaga total.

Perubahan epidemiologi dan pola penyakit juga perlu dipertimbangkan. Peningkatan penyakit kronis, populasi usia lanjut, penyakit dengan kebutuhan perawatan kompleks, atau kejadian wabah dapat mengubah kebutuhan pelayanan. WHO menegaskan bahwa tenaga keperawatan perlu direncanakan sesuai perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat dan tuntutan sistem kesehatan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan historis tenaga.

Faktor finansial organisasi juga tidak dapat diabaikan. Setiap institusi memiliki keterbatasan anggaran. Namun, pertimbangan biaya perlu diseimbangkan dengan kebutuhan mutu dan keselamatan. Penghematan tenaga yang terlalu agresif dapat menimbulkan biaya lain melalui peningkatan lembur, turnover, rekrutmen ulang, orientasi tenaga baru, keterlambatan pelayanan, atau kejadian tidak diharapkan.

Dengan demikian, perencanaan tenaga memerlukan analisis multidimensional. Menggunakan satu rasio secara kaku tanpa mempertimbangkan karakteristik pasien dan unit dapat menghasilkan kebutuhan yang kurang sesuai dengan kondisi aktual pelayanan.

C. Karakteristik Unit Pelayanan

Karakteristik unit pelayanan merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan kebutuhan tenaga keperawatan. Setiap unit memiliki tujuan, jenis pasien, pola pelayanan, tingkat kegawatan, teknologi, serta kebutuhan kompetensi yang berbeda. Perbedaan tersebut memengaruhi jumlah maupun komposisi tenaga yang diperlukan.

Unit rawat inap umum, misalnya, memberikan pelayanan selama 24 jam kepada pasien dengan tingkat ketergantungan yang beragam. Dalam unit ini, kebutuhan tenaga dipengaruhi oleh jumlah tempat tidur, tingkat hunian, tingkat ketergantungan pasien, jumlah pasien baru dan pasien pulang, serta jenis tindakan yang dilakukan. Distribusi beban kerja juga dapat berubah antara pagi, sore, dan malam. Shift pagi sering memiliki aktivitas lebih banyak karena adanya visite, pemeriksaan diagnostik, tindakan, pemulangan, penerimaan pasien, dan koordinasi dengan berbagai profesi.

Unit perawatan intensif memiliki karakter berbeda. Pasien membutuhkan pemantauan kontinu, teknologi medis yang lebih kompleks, intervensi yang cepat, serta kompetensi klinis khusus. Walaupun jumlah pasien lebih sedikit dibandingkan ruang rawat biasa, kebutuhan tenaga per pasien dapat lebih tinggi karena intensitas pelayanan dan risiko klinis lebih besar.

Unit gawat darurat menghadapi fluktuasi yang tinggi. Jumlah pasien tidak selalu dapat diprediksi, tingkat kegawatan sangat bervariasi, dan pelayanan membutuhkan respons cepat. Kebutuhan tenaga dalam unit ini perlu mempertimbangkan pola kunjungan berdasarkan waktu, hari, musim, maupun karakteristik daerah pelayanan. Penggunaan angka rata-rata harian saja dapat tidak cukup apabila terdapat jam-jam tertentu dengan lonjakan pasien.

Unit kamar operasi memiliki kebutuhan yang dipengaruhi jumlah operasi, jenis tindakan, lama prosedur, kebutuhan persiapan, pemulihan, serta kompetensi perioperatif. Jadwal tenaga perlu disesuaikan dengan jadwal operasi elektif sekaligus mempertimbangkan kemungkinan operasi emergensi.

Unit rawat jalan memiliki pola lain. Kebutuhan tenaga lebih banyak dipengaruhi jumlah kunjungan, jenis klinik, durasi pelayanan, kebutuhan tindakan, dan pola jam operasional. Sebagian unit memiliki puncak kunjungan pada jam tertentu sehingga pembagian tenaga perlu disesuaikan.

Pelayanan komunitas dan home care juga memiliki karakteristik khusus. Waktu perjalanan, jarak geografis, jumlah kunjungan, kompleksitas kondisi pasien, kebutuhan edukasi keluarga, serta keamanan tenaga ketika bekerja di lapangan perlu diperhitungkan.

Selain jenis unit, karakteristik fisik ruangan perlu diperhatikan. Distribusi kamar, jumlah lantai, jarak menuju fasilitas pendukung, ketersediaan nurse station, sistem komunikasi, serta lokasi alat dapat memengaruhi waktu yang digunakan perawat dalam menyelesaikan pekerjaan.

Karakteristik unit juga dapat dilihat dari tingkat spesialisasi. Unit onkologi, dialisis, neonatal, pediatrik, psikiatri, atau stroke memerlukan kompetensi tertentu. Karena itu, perencanaan tidak cukup menentukan "berapa orang perawat", tetapi juga "perawat dengan kemampuan apa yang harus tersedia".

Data historis unit dapat digunakan untuk memperkirakan pola kebutuhan. Namun, data historis perlu dikaji secara kritis. Jika pelayanan mengalami pengembangan, perubahan kapasitas tempat tidur, perubahan sistem, atau peningkatan kompleksitas pasien, penggunaan data lama tanpa penyesuaian dapat menghasilkan perencanaan yang tidak akurat.

D. Jumlah dan Tingkat Ketergantungan Pasien

Jumlah pasien merupakan salah satu indikator paling mudah diamati dalam perencanaan tenaga, tetapi jumlah saja tidak menggambarkan keseluruhan kebutuhan. Kebutuhan pelayanan setiap pasien sangat bervariasi. Oleh sebab itu, perencanaan perlu mempertimbangkan tingkat ketergantungan atau kebutuhan asuhan pasien.

Tingkat ketergantungan menggambarkan sejauh mana pasien membutuhkan bantuan tenaga keperawatan dalam memenuhi kebutuhan, menjalani terapi, mempertahankan keselamatan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar waktu dan intensitas pelayanan yang diperlukan.

Secara umum, pasien dapat digambarkan berada dalam spektrum dari kebutuhan perawatan minimal hingga ketergantungan total. Pasien dengan kebutuhan minimal relatif mandiri dalam aktivitas dasar, memiliki kondisi stabil, dan membutuhkan bantuan terbatas. Walaupun demikian, pasien tetap membutuhkan pengkajian, observasi, pemberian terapi, edukasi, koordinasi, dan dokumentasi.

Pasien dengan ketergantungan sebagian membutuhkan bantuan pada beberapa aktivitas, misalnya mobilisasi, personal hygiene, makan, eliminasi, atau pemantauan lebih sering. Waktu yang diperlukan tenaga menjadi lebih besar karena aktivitas langsung kepada pasien meningkat.

Pasien dengan ketergantungan total membutuhkan bantuan pada hampir seluruh kebutuhan. Pasien dapat mengalami keterbatasan mobilitas yang berat, penurunan kesadaran, kondisi kritis, atau kebutuhan pemantauan intensif. Pada

kelompok ini, kebutuhan waktu perawatan lebih tinggi dan sering membutuhkan lebih dari satu tenaga untuk tindakan tertentu.

Tingkat ketergantungan tidak selalu tetap selama masa perawatan. Pasien dapat mengalami perbaikan sehingga kebutuhan menurun, atau sebaliknya mengalami deteriorasi yang meningkatkan kebutuhan. Karena itu, klasifikasi pasien perlu diperbarui secara berkala dan tidak hanya dilakukan ketika pasien masuk.

Jumlah pasien baru, transfer, dan pasien yang akan pulang juga perlu diperhatikan. Meskipun secara statistik jumlah pasien pada suatu hari sama dengan hari sebelumnya, beban kerja dapat meningkat apabila terdapat banyak pasien baru karena masing-masing membutuhkan proses penerimaan dan pengkajian awal.

Perencanaan tenaga berdasarkan tingkat ketergantungan membantu manajer mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat. Sebagai contoh, 20 pasien yang sebagian besar mandiri tidak dapat disamakan kebutuhan tenaganya dengan 20 pasien yang sebagian besar membutuhkan perawatan total.

Selain tingkat ketergantungan fisik, kebutuhan psikologis, edukasi, komunikasi, dan dukungan keluarga juga dapat menambah intensitas pelayanan. Pasien dengan kecemasan tinggi, gangguan kognitif, risiko jatuh, perilaku tidak kooperatif, atau kebutuhan edukasi kompleks dapat membutuhkan waktu lebih banyak meskipun secara fisik relatif mandiri.

Dengan demikian, pendekatan berdasarkan acuity dan kebutuhan aktual pasien memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai beban pelayanan dibandingkan hanya menggunakan jumlah pasien.

E. Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga

Perencanaan kebutuhan tenaga tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas tenaga. Organisasi harus memastikan bahwa tenaga yang ditempatkan memiliki pendidikan, kompetensi, pengalaman, kewenangan, dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Kualifikasi mengacu pada persyaratan formal yang dimiliki tenaga, seperti latar belakang pendidikan, registrasi, sertifikasi, atau persyaratan profesional lainnya. Kompetensi mencakup kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, penalaran klinis, dan pengambilan keputusan dalam praktik.

Dua perawat dengan tingkat pendidikan yang sama belum tentu memiliki pengalaman dan kompetensi klinis yang sama. Perawat yang telah lama bekerja pada unit tertentu dapat memiliki kemampuan mengenali perubahan kondisi pasien secara lebih cepat dibandingkan perawat yang baru memasuki unit

tersebut. Karena itu, jumlah tenaga perlu dilengkapi dengan pertimbangan pengalaman.

Skill mix menggambarkan komposisi berbagai tingkat kompetensi dan peran dalam tim pelayanan. Perencanaan skill mix bertujuan memastikan bahwa setiap shift memiliki kombinasi tenaga yang mampu memenuhi kebutuhan pasien. Suatu shift tidak ideal apabila seluruh tenaga relatif baru tanpa tenaga berpengalaman yang dapat memberikan supervisi dan menangani kondisi kompleks.

Kompetensi juga harus sesuai dengan karakteristik unit. Tenaga yang bekerja pada intensive care membutuhkan kompetensi yang berbeda dengan tenaga di rawat jalan atau komunitas. Demikian pula perawat yang menangani pasien anak, neonatal, jiwa, onkologi, atau perioperatif memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Perencanaan kompetensi juga perlu mempertimbangkan pengembangan pelayanan. Apabila rumah sakit berencana membuka layanan baru, kebutuhan kompetensi sebaiknya dipersiapkan sebelum layanan dimulai. Organisasi dapat melakukan rekrutmen tenaga yang telah kompeten atau mengembangkan tenaga yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan.

Orientasi tenaga baru menjadi bagian penting. Meskipun seseorang memenuhi persyaratan pendidikan, tenaga baru tetap membutuhkan orientasi terhadap lingkungan, kebijakan, standar pelayanan, penggunaan alat, budaya keselamatan, dan sistem dokumentasi. Selama periode orientasi, tenaga baru mungkin belum dapat dihitung memiliki produktivitas yang sama dengan tenaga berpengalaman.

Kompetensi perlu dipelihara melalui pendidikan berkelanjutan. Perubahan teknologi, obat, pedoman pelayanan, dan pola penyakit menuntut tenaga untuk terus memperbarui kemampuan. Karena itu, perencanaan tenaga harus memasukkan kebutuhan waktu untuk pelatihan dan pengembangan, bukan menganggap seluruh tenaga selalu tersedia untuk pelayanan langsung.

Selain kemampuan klinis, kompetensi komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, dokumentasi, dan keselamatan pasien juga penting. Pelayanan keperawatan merupakan pelayanan tim. Seorang perawat tidak bekerja secara terisolasi, sehingga kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi menentukan efektivitas tim.

WHO dalam laporan tenaga keperawatan global terbaru juga menekankan keterkaitan antara pendidikan, employment, regulation, working conditions, leadership, dan service delivery dalam membangun tenaga keperawatan yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

F. Perencanaan Tenaga Berdasarkan Kebutuhan Pelayanan

Perencanaan tenaga berdasarkan kebutuhan pelayanan merupakan pendekatan yang menempatkan kebutuhan pasien sebagai dasar utama dalam menentukan tenaga. Pendekatan ini berbeda dengan pola yang hanya mempertahankan jumlah tenaga berdasarkan kebiasaan, formasi lama, atau jumlah tempat tidur tanpa menilai kondisi aktual.

Tahap awal dimulai dengan memahami jenis pelayanan yang diberikan. Manajer perlu mengetahui populasi pasien, jenis penyakit, tingkat kompleksitas, aktivitas utama perawat, jam pelayanan, serta target mutu yang harus dicapai. Pemahaman tersebut memberikan gambaran mengenai karakter tenaga yang diperlukan.

Selanjutnya perlu dilakukan analisis volume pelayanan. Pada rawat inap, data dapat meliputi jumlah tempat tidur, tingkat hunian, jumlah pasien harian, admisi, pemulangan, dan transfer. Pada rawat jalan dapat digunakan jumlah kunjungan dan tindakan. Pada unit khusus dapat digunakan indikator yang sesuai dengan karakter pelayanan.

Tahap berikutnya adalah menilai kebutuhan asuhan pasien. Tingkat ketergantungan, acuity, kebutuhan observasi, tindakan, edukasi, dukungan psikososial, dan kebutuhan koordinasi menjadi dasar memperkirakan waktu pelayanan yang dibutuhkan.

Setelah kebutuhan pelayanan diketahui, aktivitas tenaga perlu dianalisis. Aktivitas tersebut mencakup pelayanan langsung kepada pasien dan aktivitas tidak langsung. Pelayanan langsung meliputi pengkajian, tindakan, bantuan kebutuhan dasar, pemberian terapi sesuai kewenangan, pemantauan, dan edukasi. Aktivitas tidak langsung dapat meliputi dokumentasi, handover, koordinasi, persiapan alat, rapat, serta komunikasi interprofesional. Kedua kelompok aktivitas menggunakan waktu kerja sehingga perlu dipertimbangkan.

Selanjutnya organisasi menghitung waktu kerja efektif. Tenaga tidak dapat dianggap tersedia 365 hari dalam setahun untuk memberikan pelayanan. Hari libur, cuti, sakit, pendidikan, pelatihan, rapat, dan kebutuhan lainnya mengurangi waktu pelayanan efektif. Oleh karena itu, perencanaan harus membedakan jumlah tenaga nominal dengan tenaga efektif.

Setelah diperoleh gambaran kebutuhan waktu pelayanan dan waktu kerja efektif, organisasi dapat menentukan kebutuhan jumlah tenaga dengan metode perhitungan yang digunakan. Metode tersebut harus digunakan secara konsisten dan disesuaikan dengan jenis pelayanan. Hasil perhitungan kemudian perlu diverifikasi dengan kondisi nyata di lapangan.

Perencanaan juga perlu menentukan distribusi tenaga menurut shift. Kebutuhan pagi, sore, dan malam tidak selalu sama. Shift pagi biasanya memiliki aktivitas diagnostik, tindakan, kunjungan profesi lain, admisi, dan pemulangan yang lebih banyak. Namun, kondisi masing-masing unit dapat berbeda sehingga distribusi harus didasarkan pada pola aktual.

Selain jumlah, setiap shift harus memiliki skill mix yang sesuai. Keberadaan tenaga berpengalaman penting untuk menangani situasi kompleks dan memberikan supervisi kepada tenaga baru. Karena itu, jadwal tidak boleh hanya memenuhi jumlah kepala atau head count.

Perencanaan harus memasukkan cadangan terhadap ketidakhadiran yang dapat diprediksi, seperti cuti dan pelatihan, serta memiliki mekanisme untuk kondisi yang tidak dapat diprediksi seperti sakit mendadak. Jika setiap ketidakhadiran langsung menyebabkan suatu unit kekurangan tenaga, berarti sistem perencanaan terlalu rapuh.

Evaluasi merupakan tahap penting setelah perencanaan diterapkan. Manajer dapat membandingkan rencana tenaga dengan kondisi aktual. Apakah lembur masih terlalu tinggi? Apakah staf sering dipanggil pada hari libur? Apakah terjadi kekurangan tenaga pada shift tertentu? Apakah banyak pelayanan yang tertunda? Apakah terdapat peningkatan keluhan atau insiden? Data tersebut menunjukkan apakah perencanaan telah sesuai.

Perencanaan tenaga berbasis kebutuhan pelayanan pada akhirnya harus bersifat adaptif. Perubahan jumlah pasien, acuity, teknologi, model pelayanan, dan kondisi tenaga harus diikuti dengan peninjauan kebutuhan. WHO menekankan bahwa ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan harus diselaraskan dengan kebutuhan kesehatan serta kapasitas pelayanan, sehingga perencanaan tenaga seharusnya menjadi proses berkelanjutan dan berbasis bukti.

Dengan demikian, perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan bukan sekadar proses administratif untuk menentukan jumlah perawat dalam suatu unit. Perencanaan merupakan bagian strategis dari manajemen keperawatan yang mengintegrasikan jumlah pasien, tingkat ketergantungan, beban kerja, karakteristik unit, kompetensi, waktu kerja efektif, serta sasaran mutu dan keselamatan. Perencanaan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan organisasi menyediakan tenaga dalam jumlah dan komposisi yang tepat, mengurangi ketidakseimbangan beban kerja, menjaga kontinuitas pelayanan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Perencanaan ini selanjutnya menjadi landasan bagi proses analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan tenaga, staffing, dan penyusunan jadwal dinas keperawatan.

G. Analisis Beban Kerja Tenaga Keperawatan

1. Pengertian Beban Kerja Keperawatan

Beban kerja keperawatan merupakan keseluruhan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga keperawatan dalam periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mendukung keberlangsungan pelayanan. Beban kerja tidak hanya menggambarkan banyaknya tugas yang dilakukan, tetapi juga mencakup tingkat kesulitan pekerjaan, intensitas pelayanan, tanggung jawab profesional, kebutuhan pengambilan keputusan, tekanan waktu, kompleksitas kondisi pasien, serta kemampuan tenaga dalam menyelesaikan seluruh aktivitas secara aman dan tepat.

Dalam pelayanan keperawatan, beban kerja memiliki karakteristik yang kompleks karena perawat tidak hanya melakukan tindakan yang terlihat secara langsung di hadapan pasien. Perawat juga melakukan pengkajian, perencanaan asuhan, pemantauan kondisi, pemberian terapi sesuai kewenangan, komunikasi, edukasi, dokumentasi, koordinasi dengan profesi lain, serah terima, persiapan alat, pengelolaan lingkungan, hingga berbagai aktivitas administratif. Seluruh aktivitas tersebut menggunakan waktu, tenaga fisik, konsentrasi, kemampuan kognitif, dan tanggung jawab profesional sehingga perlu dipertimbangkan dalam analisis beban kerja.

Beban kerja keperawatan juga berkaitan erat dengan waktu yang tersedia. Suatu jumlah pekerjaan mungkin dapat diselesaikan dengan baik apabila tersedia waktu yang cukup, tetapi menjadi beban yang tinggi apabila harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Oleh sebab itu, penilaian beban kerja tidak cukup hanya menghitung jumlah aktivitas. Analisis perlu melihat hubungan antara volume pekerjaan, kompleksitas tugas, waktu yang diperlukan, jumlah tenaga yang tersedia, serta kondisi lingkungan pelayanan.

Selain aspek kuantitatif, beban kerja memiliki aspek kualitatif. Beban kerja kuantitatif terjadi ketika jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan terlalu banyak dibandingkan dengan kapasitas tenaga atau waktu yang tersedia. Sebaliknya, beban kerja kualitatif berkaitan dengan tingkat kesulitan pekerjaan, tuntutan keterampilan, tanggung jawab, dan kompleksitas keputusan yang harus dilakukan. Seorang perawat mungkin merawat jumlah pasien yang relatif sedikit, tetapi apabila seluruh pasien berada dalam kondisi tidak stabil dan membutuhkan observasi ketat, beban kerjanya tetap dapat tinggi.

Dalam praktik manajemen keperawatan, analisis beban kerja digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan aktual tenaga. Data tersebut dapat membantu manajer menentukan apakah jumlah tenaga yang

tersedia telah sesuai dengan aktivitas pelayanan, apakah terdapat ketidakseimbangan antarshift, serta apakah diperlukan redistribusi tenaga atau perubahan pola penugasan. WHO melalui pendekatan Workload Indicators of Staffing Need (WISN) menempatkan aktivitas pelayanan dan waktu kerja sebagai dasar penting untuk memperkirakan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja aktual di fasilitas kesehatan.

Beban kerja bersifat dinamis dan dapat berubah dari satu shift ke shift lainnya. Pada shift pagi, misalnya, aktivitas dapat meningkat karena adanya visite, pemeriksaan diagnostik, pemberian terapi, penerimaan pasien baru, persiapan pemulangan, koordinasi dengan berbagai profesi, serta aktivitas administratif. Shift malam dapat memiliki jumlah tindakan terjadwal yang lebih sedikit, tetapi tetap membutuhkan kesiapan untuk menghadapi perubahan kondisi pasien, keadaan darurat, gangguan tidur pasien, serta keterbatasan jumlah tenaga.

Dengan demikian, beban kerja keperawatan sebaiknya dipahami sebagai interaksi antara kebutuhan pasien, jumlah dan kompleksitas aktivitas, waktu kerja, kompetensi tenaga, kondisi lingkungan, serta sumber daya pendukung. Pemahaman yang tepat terhadap beban kerja menjadi dasar penting dalam perencanaan kebutuhan tenaga, staffing, scheduling, pengendalian kelelahan kerja, serta upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien.

2. Jenis Beban Kerja Tenaga Keperawatan

Beban kerja tenaga keperawatan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Salah satu pembagian yang umum adalah beban kerja fisik dan beban kerja mental atau kognitif. Keduanya sering terjadi secara bersamaan dalam pelayanan keperawatan.

Beban kerja fisik muncul dari aktivitas yang membutuhkan penggunaan tenaga tubuh, seperti membantu mobilisasi pasien, memindahkan pasien, mengubah posisi, membantu personal hygiene, mengangkat atau membawa peralatan, berdiri dalam waktu lama, berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, serta melakukan berbagai tindakan keperawatan. Beban fisik dapat meningkat ketika jumlah pasien dengan ketergantungan tinggi bertambah atau fasilitas pendukung seperti alat bantu transfer pasien terbatas.

Aktivitas fisik yang dilakukan secara berulang tanpa waktu istirahat yang memadai dapat menimbulkan kelelahan, nyeri muskuloskeletal, penurunan stamina, serta meningkatkan risiko cedera kerja. Karena itu, beban fisik menjadi salah satu aspek penting dalam pengaturan tenaga, khususnya pada unit yang

banyak merawat pasien dengan keterbatasan mobilitas atau ketergantungan total.

Beban kerja mental atau kognitif berkaitan dengan kebutuhan untuk berpikir, berkonsentrasi, mengingat, menilai, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan. Perawat harus memproses informasi dari berbagai sumber secara simultan. Dalam satu waktu, perawat dapat harus memperhatikan perubahan tanda vital seorang pasien, mempersiapkan terapi pasien lain, menerima instruksi baru, menjawab pertanyaan keluarga, melakukan dokumentasi, sekaligus merespons panggilan dari anggota tim.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban kerja tidak selalu tampak secara fisik. Seorang perawat dapat terlihat tidak melakukan tindakan fisik yang berat, tetapi sedang menghadapi beban kognitif tinggi karena harus mengintegrasikan berbagai informasi dan mengambil keputusan dalam waktu singkat.

Beban kerja emosional juga menjadi bagian penting dalam profesi keperawatan. Perawat sering berhadapan dengan penderitaan, nyeri, kecemasan, kematian, konflik keluarga, pasien dengan penyakit kronis, serta situasi yang membutuhkan komunikasi sensitif. Menjaga sikap profesional sambil memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga memerlukan energi psikologis.

Selain itu, terdapat beban kerja berdasarkan waktu, yaitu tekanan yang muncul ketika banyak tugas harus diselesaikan dalam waktu terbatas. Kondisi ini sering terjadi pada periode tertentu, misalnya saat pergantian shift, pemberian obat, penerimaan beberapa pasien baru secara bersamaan, atau ketika kondisi pasien memburuk secara mendadak.

Dalam perspektif manajemen, beban kerja juga dapat dibedakan menjadi beban kerja normal, berlebih, dan kurang. Beban kerja normal terjadi ketika tuntutan pekerjaan relatif seimbang dengan jumlah tenaga, kompetensi, serta waktu yang tersedia. Pada kondisi tersebut, perawat memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan asuhan sesuai standar.

Beban kerja berlebih terjadi apabila tuntutan pekerjaan melampaui kemampuan tenaga dalam periode kerja tertentu. Kondisi ini dapat disebabkan jumlah pasien yang terlalu banyak, ketergantungan pasien tinggi, kekurangan tenaga, peningkatan admisi, banyaknya tindakan, keterbatasan sarana, maupun perubahan kondisi pasien secara mendadak.

Sebaliknya, beban kerja kurang dapat terjadi ketika tenaga yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Walaupun masalah ini tidak selalu memiliki risiko langsung seperti kelebihan beban,

ketidakseimbangan tersebut dapat menunjukkan bahwa distribusi tenaga belum optimal dan sumber daya organisasi belum dimanfaatkan secara efisien.

Manajer keperawatan perlu memahami bahwa tujuan analisis beban kerja bukan menciptakan kondisi di mana seluruh tenaga selalu bekerja pada kapasitas maksimum. Pelayanan keperawatan membutuhkan cadangan kapasitas untuk menghadapi kondisi tidak terduga. Jika seluruh tenaga selalu bekerja pada batas maksimal, sedikit peningkatan jumlah atau kompleksitas pasien dapat segera menyebabkan overload.

3. Aktivitas Keperawatan Langsung dan Tidak Langsung

Analisis beban kerja keperawatan perlu membedakan aktivitas keperawatan langsung dan tidak langsung. Pemisahan ini penting karena keduanya menggunakan waktu kerja dan keduanya diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang lengkap.

Aktivitas keperawatan langsung merupakan aktivitas yang dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan pasien atau dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pasien. Aktivitas tersebut mencakup pengkajian kondisi, pemeriksaan tanda vital, pemberian obat sesuai kewenangan dan sistem pelayanan, perawatan luka, bantuan mobilisasi, pemenuhan personal hygiene, pemberian nutrisi, pemasangan dan pemantauan alat, pengendalian nyeri, edukasi, dukungan emosional, tindakan pencegahan risiko, serta berbagai intervensi keperawatan lainnya.

Aktivitas langsung dapat berbeda menurut tingkat ketergantungan pasien. Pasien yang mandiri mungkin hanya membutuhkan pengkajian, pemantauan, edukasi, dan intervensi tertentu. Sebaliknya, pasien dengan ketergantungan total membutuhkan bantuan hampir pada seluruh kebutuhan dasar sehingga waktu pelayanan langsung meningkat.

Waktu aktivitas langsung juga dipengaruhi kondisi klinis. Satu tindakan yang biasanya berlangsung singkat dapat membutuhkan waktu lebih lama apabila pasien mengalami kecemasan, gangguan komunikasi, keterbatasan gerak, obesitas, gangguan kognitif, atau kondisi lain yang membutuhkan pendekatan khusus.

Aktivitas keperawatan tidak langsung adalah berbagai kegiatan yang mendukung pelayanan pasien tetapi tidak selalu dilakukan di sisi tempat tidur. Dokumentasi merupakan salah satu aktivitas tidak langsung yang cukup besar dalam praktik keperawatan. Perawat perlu mencatat pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, respons pasien, pemberian terapi, edukasi, serta berbagai informasi klinis lainnya.

Serah terima atau handover juga merupakan aktivitas tidak langsung yang penting. Pada proses ini, informasi mengenai kondisi pasien, terapi, risiko, perubahan klinis, dan rencana pelayanan disampaikan dari satu tenaga atau shift kepada tenaga berikutnya. Handover yang baik membutuhkan waktu tetapi sangat penting bagi kesinambungan dan keselamatan pelayanan.

Aktivitas tidak langsung lainnya mencakup koordinasi dengan dokter dan profesi lain, konsultasi, persiapan alat, pengambilan kebutuhan logistik, komunikasi dengan laboratorium atau radiologi, pengaturan rujukan, persiapan pasien pulang, pengelolaan obat tertentu, rapat pelayanan, serta komunikasi dengan keluarga.

Selain aktivitas langsung dan tidak langsung, analisis beban kerja dapat mempertimbangkan aktivitas pribadi dan aktivitas nonproduktif yang wajar. Tenaga membutuhkan waktu untuk makan, minum, ke toilet, beristirahat, dan memenuhi kebutuhan fisiologis lainnya. Mengabaikan kebutuhan tersebut dalam perencanaan tenaga dapat menghasilkan perhitungan yang tidak realistis.

Analisis juga dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi keperawatan tetapi tetap dilakukan perawat karena keterbatasan tenaga pendukung. Misalnya, perawat mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mencari alat, membawa dokumen, melakukan tugas administratif tertentu, atau menangani kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh petugas lain. Kondisi tersebut merupakan informasi penting bagi manajemen karena penambahan jumlah perawat bukan selalu satu-satunya solusi. Perbaikan sistem kerja dan pembagian tugas dapat mengurangi beban yang tidak diperlukan.

Perbandingan waktu antara aktivitas langsung, tidak langsung, dan aktivitas lainnya memberikan gambaran bagaimana waktu kerja perawat digunakan. Jika sebagian besar waktu habis untuk pekerjaan administratif yang sebenarnya dapat disederhanakan, manajemen dapat melakukan perbaikan sistem agar perawat memiliki lebih banyak waktu untuk pelayanan pasien.

4. Faktor yang Memengaruhi Beban Kerja

Beban kerja tenaga keperawatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari pasien, tenaga, organisasi, lingkungan, dan sistem pelayanan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi sehingga perubahan pada satu faktor dapat memengaruhi beban kerja secara keseluruhan.

Jumlah pasien merupakan salah satu faktor yang paling mudah diamati. Semakin banyak pasien yang menjadi tanggung jawab perawat, semakin

banyak aktivitas yang harus dilakukan. Namun, rasio pasien-perawat saja tidak menggambarkan beban kerja secara utuh. AHRQ menegaskan bahwa staffing dipengaruhi pula oleh acuity pasien, admisi, transfer, pemulangan, skill mix, pengalaman tenaga, tata ruang unit, teknologi, serta sumber daya pendukung.

Tingkat ketergantungan pasien merupakan faktor penting. Pasien yang membutuhkan bantuan penuh memerlukan waktu pelayanan lebih besar. Pasien dengan gangguan kesadaran, ventilasi mekanik, risiko jatuh tinggi, luka kompleks, gangguan perilaku, atau kebutuhan monitoring intensif juga meningkatkan tuntutan pekerjaan.

Jumlah pasien masuk dan keluar atau patient turnover turut memengaruhi beban kerja. Penerimaan pasien baru membutuhkan pengkajian awal, verifikasi informasi, orientasi, dokumentasi, persiapan terapi, dan perencanaan asuhan. Pemulangan pasien membutuhkan edukasi, koordinasi, dokumentasi, serta persiapan kesinambungan pelayanan. Karena itu, dua shift dengan jumlah pasien yang sama dapat memiliki beban kerja berbeda apabila salah satunya memiliki turnover pasien lebih tinggi. AHRQ juga mencatat bahwa patient turnover dapat meningkatkan beban kerja dan berkaitan dengan luaran pasien meskipun staffing nominal tampak memadai.

Kompetensi dan pengalaman tenaga juga memengaruhi beban kerja. Perawat berpengalaman mungkin dapat melakukan beberapa aktivitas dengan lebih efisien karena telah memiliki keterampilan, pola pengenalan masalah, dan kemampuan menentukan prioritas yang lebih matang. Sebaliknya, tenaga baru membutuhkan orientasi, supervisi, dan waktu lebih lama untuk beberapa aktivitas.

Skill mix dalam satu shift juga perlu diperhatikan. Jika sebagian besar tenaga merupakan tenaga baru, perawat senior dapat mengalami beban tambahan karena harus melakukan supervisi sambil tetap bertanggung jawab terhadap pasien. Oleh karena itu, jumlah tenaga yang sama belum tentu menghasilkan beban yang sama apabila komposisi kompetensinya berbeda.

Kondisi fisik unit turut memengaruhi beban. Jarak yang jauh antar kamar, penyebaran pasien di beberapa area, tata letak peralatan yang tidak efisien, atau lokasi unit yang jauh dari fasilitas pendukung dapat meningkatkan waktu berjalan dan memperpanjang penyelesaian tugas.

Ketersediaan sarana dan alat juga berpengaruh. Kekurangan alat, alat yang rusak, persediaan yang sulit ditemukan, atau sistem pengadaan yang tidak efisien dapat menyebabkan tenaga menghabiskan waktu untuk mencari atau menunggu kebutuhan pelayanan.

Sistem dokumentasi dapat menjadi faktor penting. Dokumentasi elektronik dapat membantu akses informasi dan standardisasi, tetapi sistem yang lambat atau memiliki banyak duplikasi input dapat meningkatkan beban administrasi. Oleh karena itu, teknologi perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap alur kerja, bukan hanya keberadaannya.

Faktor organisasi seperti kepemimpinan, komunikasi, teamwork, kebijakan, dan budaya kerja juga memengaruhi beban yang dirasakan. Lingkungan kerja dengan kerja sama tim yang baik memungkinkan anggota tim saling membantu ketika terjadi peningkatan pekerjaan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan duplikasi, konflik, keterlambatan, atau kesalahan koordinasi.

Jadwal kerja merupakan faktor berikutnya. Rotasi shift yang terlalu cepat, shift malam berturut-turut, lembur, pergantian jadwal mendadak, dan waktu istirahat yang tidak memadai dapat meningkatkan kelelahan sehingga pekerjaan yang sama terasa lebih berat.

Faktor individu seperti kondisi kesehatan, usia, kebugaran, kemampuan adaptasi, pengalaman, serta kondisi psikologis juga dapat memengaruhi persepsi beban. Namun, analisis manajemen tidak boleh menyederhanakan masalah struktural sebagai kelemahan individu. Bila sejumlah besar tenaga secara konsisten melaporkan beban yang terlalu tinggi, manajemen perlu mengevaluasi sistem kerja, staffing, dan organisasi pelayanan.

5. Metode Pengukuran Beban Kerja

Pengukuran beban kerja bertujuan memperoleh data yang lebih objektif mengenai aktivitas tenaga dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasilnya dapat menjadi dasar perhitungan kebutuhan tenaga, pembagian tugas, evaluasi proses kerja, maupun perbaikan sistem pelayanan.

Salah satu pendekatan adalah observasi langsung. Dalam metode ini, aktivitas tenaga diamati selama periode tertentu dan dicatat berdasarkan jenis kegiatan serta waktu yang digunakan. Observasi memungkinkan peneliti atau manajer memperoleh gambaran nyata mengenai pola aktivitas di lapangan.

Time and motion study merupakan metode yang mencatat jenis aktivitas serta durasi waktu secara lebih rinci. Pengamat mengikuti aktivitas tenaga dan mengukur berapa lama waktu digunakan untuk setiap pekerjaan. Metode ini dapat memberikan data detail mengenai penggunaan waktu, tetapi membutuhkan sumber daya pengamatan yang cukup besar dan dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku ketika individu menyadari sedang diamati.

Work sampling merupakan pendekatan yang melakukan pengamatan pada interval tertentu untuk melihat aktivitas yang sedang dilakukan. Berdasarkan sejumlah besar pengamatan, dapat dihitung proporsi waktu yang digunakan untuk kegiatan langsung, tidak langsung, pribadi, atau kegiatan lainnya. Metode ini lebih praktis dibandingkan pengamatan terus-menerus apabila melibatkan banyak tenaga.

Self-report atau pencatatan mandiri dapat digunakan dengan meminta tenaga mencatat aktivitas dan waktu yang digunakan. Metode ini relatif mudah, tetapi keakuratannya sangat bergantung pada konsistensi pencatatan dan kemampuan tenaga mengingat aktivitas.

Analisis dokumen dan data elektronik juga semakin banyak digunakan. Sistem informasi rumah sakit dapat menyediakan informasi mengenai jumlah pasien, tingkat hunian, tindakan, dokumentasi, admisi, pemulangan, serta aktivitas lainnya. Data tersebut dapat dikombinasikan dengan informasi staffing untuk menilai pola beban kerja.

Metode WISN merupakan salah satu pendekatan sistematis yang dikembangkan WHO untuk menentukan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja. Pendekatan ini menggunakan waktu kerja tersedia, komponen aktivitas, standar aktivitas, dan beban pelayanan aktual untuk memperkirakan kebutuhan staf. WHO menerbitkan pembaruan perangkat WISN pada 2025 untuk mendukung pencatatan, analisis, dan pelaporan kebutuhan tenaga pada fasilitas kesehatan.

Pada unit tertentu, pengukuran beban dapat menggunakan instrumen khusus. Di intensive care unit, misalnya, kebutuhan tenaga dapat dipengaruhi intervensi kompleks, pemantauan kontinu, dukungan organ, serta aktivitas terapeutik sehingga instrumen berbasis intensitas pelayanan dapat digunakan. Pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan pengukuran.

Selain pengukuran objektif, persepsi tenaga terhadap beban kerja juga penting. Dua unit dapat memiliki jumlah aktivitas yang serupa tetapi menghasilkan pengalaman kerja berbeda akibat dukungan tim, keteraturan sistem, kepemimpinan, atau kondisi lingkungan. Karena itu, wawancara, survei kepuasan, atau instrumen persepsi beban dapat melengkapi data kuantitatif.

Pengukuran sebaiknya dilakukan pada beberapa shift dan periode berbeda agar data tidak hanya menggambarkan satu kondisi. Pengamatan hanya pada satu hari yang relatif sepi dapat menghasilkan perkiraan kebutuhan yang terlalu rendah. Sebaliknya, pengukuran hanya saat terjadi

lonjakan luar biasa dapat menghasilkan angka yang tidak mewakili kondisi rutin.

Hasil pengukuran juga perlu dikaji bersama indikator lain seperti absensi, lembur, turnover, missed care, kepuasan pasien, keterlambatan pelayanan, dan insiden keselamatan. Dengan pendekatan tersebut, analisis beban kerja tidak hanya menghasilkan angka jam kerja, tetapi memberikan gambaran lebih luas mengenai apakah tenaga dan sistem kerja telah sesuai dengan kebutuhan.

6. Dampak Beban Kerja Berlebihan terhadap Perawat

Beban kerja yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus dapat memberikan dampak fisik, psikologis, profesional, dan organisasional terhadap tenaga keperawatan. Dampak tersebut tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat berkembang secara bertahap.

Dampak fisik yang sering terjadi adalah kelelahan. Perawat yang bekerja dengan intensitas tinggi dalam waktu lama dapat mengalami penurunan energi, gangguan tidur, nyeri otot, sakit kepala, serta penurunan kemampuan pemulihan. Kerja shift dan lembur dapat memperberat kondisi karena mengganggu ritme tidur dan waktu istirahat.

Kelelahan dapat memengaruhi kemampuan kognitif. Konsentrasi dapat berkurang, respons menjadi lebih lambat, dan kemampuan mempertahankan perhatian terhadap berbagai tugas dapat menurun. Dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, perubahan tersebut memiliki arti penting.

Beban kerja berlebihan juga dapat menimbulkan stres kerja. Ketika tenaga terus-menerus merasa waktu tidak cukup untuk menyelesaikan pelayanan, terjadi tekanan psikologis. Perawat dapat merasa tidak puas karena mengetahui terdapat kebutuhan pasien yang seharusnya dilakukan tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya.

Dalam jangka panjang, beban yang kronis dapat berkontribusi terhadap burnout. Burnout sering ditandai dengan kelelahan emosional, penurunan keterlibatan terhadap pekerjaan, serta berkurangnya rasa pencapaian profesional. Kondisi ini dapat memengaruhi hubungan dengan pasien, kerja sama tim, dan keinginan tenaga untuk tetap bekerja pada organisasi.

Beban tinggi juga dapat menyebabkan penurunan kepuasan kerja. Ketika jadwal terus berubah, lembur sering terjadi, waktu istirahat terbatas, dan tuntutan pelayanan tidak seimbang dengan sumber daya, tenaga dapat merasakan bahwa lingkungan kerja kurang mendukung.

Dampak organisasional dapat terlihat melalui meningkatnya absensi dan turnover. Apabila tenaga meninggalkan organisasi, beban pada tenaga yang

tersisa dapat meningkat. Organisasi kemudian harus melakukan rekrutmen dan orientasi tenaga baru, yang membutuhkan biaya dan waktu. Jika siklus ini tidak diputus, kekurangan tenaga dan beban kerja dapat saling memperburuk.

Dampak lainnya adalah berkurangnya kesempatan pengembangan profesional. Dalam unit yang terus-menerus kekurangan staf, tenaga mungkin sulit memperoleh waktu untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, diskusi kasus, atau kegiatan ilmiah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi pengembangan kompetensi.

Perawat juga dapat mengalami moral distress ketika mengetahui pelayanan tertentu seharusnya diberikan tetapi kondisi kerja tidak memungkinkan untuk melakukannya secara optimal. Situasi tersebut dapat menimbulkan konflik antara standar profesional yang ingin dicapai dengan kemampuan aktual karena keterbatasan waktu atau sumber daya.

Oleh sebab itu, manajemen beban kerja seharusnya tidak dilihat hanya sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Pengelolaan harus mempertimbangkan kapasitas manusia, waktu pemulihan, keamanan kerja, kesejahteraan psikologis, serta keberlanjutan tenaga.

7. Hubungan Beban Kerja dengan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Beban kerja memiliki hubungan yang erat dengan mutu pelayanan karena beban menentukan seberapa banyak waktu, perhatian, dan sumber daya yang dapat diberikan perawat kepada setiap pasien. AHRQ menegaskan bahwa perawat memiliki peran sentral dalam pemantauan pasien, deteksi deteriorasi, komunikasi perubahan kondisi, pengenalan kesalahan, serta koordinasi pelayanan. Apabila beban kerja terlalu tinggi, kemampuan untuk melaksanakan fungsi tersebut secara konsisten dapat terganggu.

Salah satu mekanisme yang banyak dibahas adalah missed nursing care. Istilah tersebut menggambarkan asuhan yang dibutuhkan pasien tetapi terlambat dilakukan, hanya dilakukan sebagian, atau tidak dilakukan. AHRQ menyebut tekanan waktu dan tuntutan yang saling bersaing sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya missed care, sementara staffing, lingkungan kerja, dan teamwork termasuk prediktor yang paling konsisten.

Ketika jumlah pekerjaan melebihi waktu yang tersedia, perawat secara tidak langsung harus menentukan prioritas. Aktivitas yang dianggap paling mendesak akan dilakukan terlebih dahulu, sedangkan aktivitas lain berpotensi tertunda. Dalam beberapa penelitian, aktivitas seperti ambulasi, perubahan posisi, perawatan mulut, edukasi, dukungan emosional, dan kegiatan

surveillance dilaporkan sebagai bagian yang dapat terlewat ketika terjadi tekanan beban kerja.

Missed care penting karena tidak semua konsekuensi muncul secara segera. Pasien yang tidak dimobilisasi sesuai kebutuhan mungkin tidak langsung mengalami komplikasi pada saat itu, tetapi risiko komplikasi dapat meningkat. Pemantauan yang terlambat juga dapat menyebabkan perubahan kondisi pasien dikenali lebih lambat.

AHRQ melaporkan bahwa missed nursing care berkorelasi dengan kualitas pelayanan dan sejumlah kejadian yang tidak diharapkan, termasuk medication error, jatuh, infeksi terkait pelayanan kesehatan, pressure injury, mortalitas, dan kepuasan pasien. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa beban kerja tidak hanya merupakan isu kenyamanan tenaga, melainkan bagian dari sistem keselamatan.

Beban tinggi juga dapat memengaruhi komunikasi. Dalam situasi dengan banyak tuntutan, informasi dapat disampaikan secara terburu-buru, handover menjadi kurang lengkap, atau koordinasi antarprofesi tertunda. Padahal komunikasi merupakan salah satu komponen penting dalam mencegah kesalahan pelayanan.

Dokumentasi juga dapat terdampak. Perawat yang menghadapi tekanan waktu dapat menunda dokumentasi hingga akhir shift atau melakukan pencatatan secara lebih singkat. Keterlambatan dokumentasi dapat memengaruhi kontinuitas informasi dan meningkatkan risiko informasi penting tidak tersedia ketika dibutuhkan.

Mutu pelayanan juga berkaitan dengan pengalaman pasien. Pasien menilai kualitas bukan hanya berdasarkan keberhasilan tindakan medis, tetapi juga berdasarkan respons tenaga, komunikasi, bantuan kebutuhan dasar, edukasi, rasa aman, dan perhatian. Ketika beban kerja terlalu tinggi, waktu untuk interaksi terapeutik dapat berkurang.

Hubungan antara beban kerja dan keselamatan tidak berarti bahwa setiap kejadian tidak diharapkan semata-mata disebabkan oleh jumlah pekerjaan. Keselamatan merupakan hasil dari berbagai faktor seperti kompetensi, sistem, teknologi, kepemimpinan, teamwork, komunikasi, dan kondisi pasien. Namun, beban kerja yang tidak terkendali dapat memperlemah berbagai lapisan pertahanan tersebut.

Karena itu, kecukupan staffing tidak sebaiknya dinilai hanya berdasarkan apakah seluruh shift telah terisi. Pendekatan yang lebih tepat adalah menilai apakah tenaga yang tersedia memiliki waktu dan kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan kebutuhan pelayanan secara aman. AHRQ menegaskan

bahwa staffing yang tepat bukan angka statis, melainkan harus mempertimbangkan workload, skill mix, expertise, kebutuhan pasien, dan sumber daya yang tersedia.

Manajer keperawatan perlu menghubungkan data beban kerja dengan indikator mutu. Apabila terdapat peningkatan missed care, keterlambatan pelayanan, keluhan pasien, jatuh, pressure injury, medication error, atau kejadian lain, salah satu aspek yang perlu dianalisis adalah apakah pada periode tersebut terdapat masalah staffing dan beban kerja.

Analisis juga perlu melihat indikator tenaga seperti lembur, absensi, sick leave, pergantian jadwal, kelelahan, dan turnover. Jika indikator tersebut meningkat secara bersamaan dengan memburuknya indikator mutu, organisasi perlu mengevaluasi sistem kerja secara lebih menyeluruh.

Upaya mengendalikan beban kerja dapat dilakukan melalui perencanaan tenaga berbasis kebutuhan pasien, penyesuaian staffing terhadap acuity dan turnover pasien, distribusi skill mix yang tepat, perbaikan alur kerja, pengurangan pekerjaan nonkeperawatan, penyediaan alat dan bahan yang mudah diakses, pemanfaatan teknologi yang efektif, penguatan teamwork, serta penjadwalan yang memberikan waktu pemulihan yang memadai.

Pengendalian beban tidak berarti menghilangkan seluruh tekanan dalam pekerjaan keperawatan karena pelayanan kesehatan secara alamiah memiliki situasi yang dinamis dan tidak seluruhnya dapat diprediksi. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang memiliki kapasitas cukup untuk menghadapi variasi kebutuhan tanpa membuat tenaga terus-menerus bekerja dalam kondisi overload.

Pada akhirnya, analisis beban kerja tenaga keperawatan merupakan bagian penting dalam manajemen SDM karena menyediakan informasi mengenai hubungan antara kebutuhan pasien, aktivitas pelayanan, waktu kerja, dan kapasitas tenaga. Analisis yang dilakukan secara tepat membantu organisasi menentukan kebutuhan tenaga secara lebih objektif, memperbaiki distribusi pekerjaan, mengurangi kelelahan, serta mencegah terjadinya asuhan yang terlambat atau terlewat. Dengan demikian, pengelolaan beban kerja yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi tenaga keperawatan, tetapi juga menjadi salah satu fondasi dalam mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

H. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan

1. Prinsip Dasar Perhitungan Kebutuhan Tenaga

Perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan merupakan proses menentukan jumlah tenaga yang diperlukan agar pelayanan keperawatan dapat diberikan secara aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perhitungan ini merupakan tahap lanjutan dari perencanaan tenaga dan analisis beban kerja. Jika analisis beban kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya aktivitas dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan, maka perhitungan kebutuhan tenaga menerjemahkan beban tersebut menjadi jumlah tenaga yang harus tersedia.

Perhitungan kebutuhan tenaga tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan jumlah tempat tidur atau jumlah pasien. Jumlah pasien yang sama dapat menghasilkan kebutuhan tenaga yang berbeda apabila tingkat ketergantungan, kompleksitas klinis, frekuensi tindakan, kebutuhan pemantauan, pola admisi dan pemulangan, serta karakteristik unit berbeda. Karena itu, prinsip utama perhitungan tenaga adalah menyesuaikan jumlah dan komposisi tenaga dengan beban pelayanan nyata.

Dalam konteks Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menetapkan bahwa perencanaan tenaga pada pendekatan institusi dapat menggunakan analisis beban kerja kesehatan dan/atau standar ketenagaan minimal. Untuk analisis beban kerja kesehatan, faktor yang diperhatikan mencakup kompetensi dan kewenangan, norma waktu, volume kerja, serta waktu kerja efektif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga seharusnya dihitung berdasarkan hubungan antara pekerjaan yang harus diselesaikan dengan kemampuan tenaga menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu kerja yang tersedia. Dengan demikian, perhitungan tidak hanya menjawab pertanyaan "berapa orang perawat yang dibutuhkan", tetapi juga "untuk pekerjaan apa", "berapa besar volume pekerjaannya", "berapa lama pekerjaan tersebut diselesaikan", dan "berapa banyak waktu efektif yang benar-benar tersedia dari seorang perawat".

Prinsip berikutnya adalah menggunakan data pelayanan yang representatif. Data yang digunakan idealnya menggambarkan kondisi normal pelayanan selama periode yang cukup panjang. Penggunaan data satu atau dua hari dapat menghasilkan perkiraan yang tidak tepat karena beban kerja rumah sakit berfluktuasi. Data yang dapat digunakan antara lain rata-rata

jumlah pasien, bed occupancy rate, jumlah admisi dan pemulangan, tingkat ketergantungan pasien, jumlah tindakan, serta pola beban kerja setiap shift.

Perhitungan tenaga juga perlu mempertimbangkan bahwa tidak seluruh waktu seorang perawat digunakan untuk pelayanan langsung. Perawat membutuhkan waktu untuk dokumentasi, handover, koordinasi interprofesional, rapat, pendidikan, pengembangan kompetensi, serta kebutuhan pribadi dan istirahat yang wajar. Selain itu, dalam satu tahun terdapat hari libur, cuti, pelatihan, izin, dan kemungkinan ketidakhadiran. Oleh karena itu, penggunaan jumlah hari kalender sebagai waktu kerja tenaga akan menghasilkan kebutuhan yang terlalu rendah.

Prinsip lain yang sangat penting adalah memperhatikan kompetensi dan skill mix. Dua puluh orang tenaga belum tentu memenuhi kebutuhan apabila sebagian besar belum memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menangani pasien pada unit tertentu. Sebaliknya, suatu unit membutuhkan kombinasi perawat dengan tingkat pengalaman dan kompetensi yang memadai pada setiap shift. Perencanaan tenaga dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 juga secara eksplisit menempatkan kompetensi dan kewenangan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan berbasis beban kerja.

Perhitungan kebutuhan tenaga perlu dibedakan dengan penyusunan jadwal. Hasil perhitungan menunjukkan berapa jumlah tenaga yang secara keseluruhan diperlukan oleh unit, sedangkan scheduling menentukan bagaimana tenaga tersebut didistribusikan dalam shift pagi, sore, malam, hari kerja, hari libur, dan periode lainnya. Kebutuhan total yang sudah dihitung dengan baik masih dapat menghasilkan pelayanan yang tidak optimal apabila distribusi jadwal tidak sesuai dengan pola beban kerja.

Perhitungan juga tidak bersifat permanen. Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 menyebut perencanaan berbasis analisis beban kerja pada pendekatan institusi dapat disusun untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun. Dalam praktik manajemen keperawatan, evaluasi bahkan dapat dilakukan lebih sering apabila terdapat perubahan signifikan pada kapasitas unit, jenis pelayanan, jumlah pasien, atau pola ketergantungan pasien.

2. Komponen dalam Perhitungan Kebutuhan Tenaga

Perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan memerlukan sejumlah komponen yang saling berhubungan. Komponen pertama adalah volume pelayanan. Pada unit rawat inap, volume dapat dinilai melalui jumlah pasien

rata-rata, jumlah tempat tidur, bed occupancy rate, jumlah hari perawatan, jumlah pasien masuk, pasien pulang, atau pasien transfer. Pada unit lain, indikator volume dapat disesuaikan dengan karakteristik layanan.

Jumlah tempat tidur tidak selalu sama dengan jumlah pasien yang dilayani. Sebuah unit dengan 30 tempat tidur tidak selalu dihuni oleh 30 pasien sepanjang tahun. Karena itu, apabila tersedia data bed occupancy rate, jumlah pasien rata-rata dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan tingkat hunian. Sebagai contoh, 30 tempat tidur dengan tingkat hunian rata-rata 80% berarti secara rata-rata sekitar 24 tempat tidur terisi.

Komponen kedua adalah kebutuhan waktu pelayanan pasien. Komponen ini menggambarkan berapa banyak waktu keperawatan yang diperlukan seorang pasien dalam satu hari atau satu episode pelayanan. Waktu tersebut dipengaruhi tingkat ketergantungan, kompleksitas kondisi, tindakan yang diperlukan, kebutuhan edukasi, pemantauan, dan koordinasi.

Komponen ketiga adalah norma waktu. Norma waktu merupakan rata-rata waktu yang diperlukan tenaga yang kompeten untuk menyelesaikan suatu aktivitas sesuai standar. Dalam pendekatan beban kerja, norma waktu dapat ditetapkan untuk berbagai kegiatan, misalnya pengkajian awal, perawatan luka, edukasi, dokumentasi, serah terima, atau tindakan lain yang menjadi bagian dari pelayanan.

Komponen keempat adalah volume kerja. Volume kerja menunjukkan berapa kali suatu kegiatan dilakukan dalam periode tertentu. Apabila suatu aktivitas membutuhkan waktu 15 menit dan dilakukan 1.000 kali dalam setahun, maka total beban waktu aktivitas tersebut adalah 15.000 menit atau 250 jam per tahun.

Komponen berikutnya adalah waktu kerja efektif atau waktu kerja tersedia. Waktu tersebut menunjukkan berapa jam dalam satu tahun yang secara realistis dapat digunakan seorang tenaga untuk melaksanakan pekerjaan setelah memperhitungkan hari kerja, hari libur, cuti, pelatihan, dan ketidakhadiran lain yang diperhitungkan sesuai kebijakan organisasi.

Selain itu, terdapat kegiatan penunjang yang tidak selalu tercermin langsung dalam statistik pasien, misalnya rapat unit, pendidikan internal, supervisi, kegiatan mutu, administrasi tertentu, serta kegiatan profesional lainnya. Dalam metode berbasis beban kerja seperti WISN, kegiatan-kegiatan ini dipertimbangkan melalui standar aktivitas dan allowance. WHO menjelaskan bahwa WISN menentukan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dengan menerapkan standar waktu pada setiap komponen kegiatan.

Komponen terakhir adalah faktor kompetensi. Perhitungan jumlah secara matematis tetap harus diverifikasi terhadap kebutuhan skill mix. Unit yang merawat pasien dengan kompleksitas tinggi memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi klinis sesuai, sehingga hasil akhir tidak boleh hanya berupa jumlah kepala, tetapi juga komposisi tenaga yang diperlukan.

3. Jam Perawatan Pasien

Jam perawatan pasien merupakan salah satu konsep penting dalam perhitungan kebutuhan tenaga di unit rawat inap. Istilah ini menggambarkan jumlah waktu pelayanan keperawatan yang diperlukan pasien dalam suatu periode, biasanya dinyatakan sebagai jam perawatan per pasien per hari atau nursing hours per patient day.

Secara sederhana, kebutuhan jam keperawatan harian dapat diperkirakan dengan mengalikan jumlah pasien dengan rata-rata jam keperawatan yang dibutuhkan setiap pasien. Apabila terdapat 20 pasien dan setiap pasien secara rata-rata memerlukan 4 jam pelayanan keperawatan dalam 24 jam, maka kebutuhan pelayanan adalah 80 jam keperawatan dalam satu hari.

Namun, konsep tersebut harus digunakan secara hati-hati karena kebutuhan waktu setiap pasien berbeda. Angka rata-rata tidak boleh diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik pasien dan unit. Pasien dengan ketergantungan total atau kondisi tidak stabil membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan pasien yang relatif mandiri.

Jam perawatan dapat mencakup pelayanan langsung maupun, tergantung metode yang digunakan, proporsi kegiatan tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung asuhan. Oleh karena itu, organisasi harus menentukan secara konsisten apa yang termasuk dalam jam perawatan agar hasil perhitungan tidak terjadi duplikasi.

Pengukuran jam perawatan sebaiknya dilakukan berdasarkan data aktual unit atau standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Angka dari literatur dapat digunakan sebagai referensi, tetapi belum tentu sesuai untuk seluruh rumah sakit karena model pelayanan, teknologi, komposisi tenaga, karakteristik pasien, dan sistem dokumentasi dapat berbeda.

Jam perawatan juga dapat berubah sepanjang waktu. Pasien yang baru masuk dapat membutuhkan waktu lebih banyak karena pengkajian awal dan orientasi. Pasien yang akan pulang membutuhkan edukasi, koordinasi, dan dokumentasi. Pasien yang mengalami deteriorasi mendadak juga

meningkatkan kebutuhan jam pelayanan meskipun jumlah pasien tidak berubah.

Oleh karena itu, jam perawatan sebaiknya dipahami sebagai indikator kebutuhan sumber daya yang dinamis, bukan angka statis yang berlaku untuk seluruh pasien dan seluruh unit.

4. Tingkat Ketergantungan Pasien

Tingkat ketergantungan pasien memberikan informasi mengenai intensitas bantuan yang dibutuhkan pasien dalam memenuhi kebutuhan dan menjalani pelayanan. Klasifikasi ketergantungan membantu menjelaskan mengapa dua unit dengan jumlah pasien yang sama dapat membutuhkan tenaga berbeda.

Pasien dengan ketergantungan rendah relatif mandiri dan membutuhkan bantuan terbatas. Namun, perawat tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, pemberian terapi, pemantauan, edukasi, dokumentasi, serta koordinasi. Oleh karena itu, ketergantungan rendah bukan berarti pasien tidak membutuhkan waktu perawat.

Pasien dengan ketergantungan sedang membutuhkan bantuan lebih besar, misalnya dalam mobilisasi, makan, eliminasi, personal hygiene, atau tindakan tertentu. Pada kelompok ini, waktu pelayanan langsung meningkat.

Pasien dengan ketergantungan tinggi atau total membutuhkan bantuan pada sebagian besar atau seluruh kebutuhan. Selain aktivitas dasar, pasien dapat memerlukan pemantauan lebih sering, tindakan kompleks, pencegahan komplikasi, bantuan perubahan posisi, dukungan teknologi, dan koordinasi yang lebih intensif.

Dalam perhitungan tenaga, klasifikasi pasien dapat dikaitkan dengan bobot waktu pelayanan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar kebutuhan jam keperawatan. Namun, penetapan bobot atau standar waktu sebaiknya berasal dari metode yang digunakan organisasi atau data valid yang sesuai, bukan angka arbitrer.

Ketergantungan juga perlu dinilai berulang. Seorang pasien dapat berpindah dari tingkat ketergantungan tinggi menjadi lebih rendah setelah kondisi membaik. Sebaliknya, pasien yang awalnya mandiri dapat mengalami komplikasi dan membutuhkan bantuan penuh. Karena itu, kebutuhan tenaga pada unit rawat inap idealnya dapat menyesuaikan perubahan acuity pasien.

Aspek psikososial juga perlu dipertimbangkan. Pasien yang secara fisik mandiri tetapi memiliki gangguan kognitif, delirium, risiko jatuh tinggi,

kecemasan berat, atau kebutuhan edukasi intensif dapat membutuhkan banyak waktu tenaga. Oleh karena itu, klasifikasi ketergantungan sebaiknya tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik.

5. Hari Kerja Efektif Tenaga Keperawatan

Hari kerja efektif adalah jumlah hari atau jam kerja yang secara nyata tersedia bagi seorang tenaga untuk melakukan pekerjaan dalam periode tertentu setelah dikurangi berbagai waktu ketika tenaga tidak tersedia untuk pelayanan.

Konsep ini sangat penting karena kebutuhan tenaga tidak dapat dihitung dengan asumsi setiap tenaga bekerja setiap hari sepanjang tahun. Dalam praktik, terdapat hari libur mingguan, hari libur resmi, cuti tahunan, pelatihan, izin, sakit, dan kegiatan lain.

Waktu kerja efektif dapat dihitung dalam satuan hari atau jam. Apabila organisasi menggunakan sistem shift, penggunaan jam sering memberikan gambaran yang lebih akurat karena lama shift dapat berbeda.

Secara konseptual, waktu kerja efektif tahunan dapat dituliskan sebagai:

Waktu kerja efektif = waktu kerja kalender yang ditetapkan − waktu tidak tersedia untuk bekerja

Apabila dinyatakan dalam hari:

Hari kerja efektif = jumlah hari kerja yang seharusnya dijalani − cuti − pelatihan − hari libur yang jatuh pada hari kerja − ketidakhadiran lain yang diperhitungkan

Setelah memperoleh hari kerja efektif, nilai tersebut dapat dikalikan dengan rata-rata jam kerja efektif per hari untuk mendapatkan waktu kerja tersedia dalam jam per tahun.

Sebagai ilustrasi, bukan sebagai angka standar, apabila seorang tenaga secara teoritis memiliki 250 hari kerja dalam satu tahun dan organisasi memperkirakan 12 hari cuti, 6 hari pelatihan, 15 hari libur yang mengurangi hari kerja, dan rata-rata 5 hari ketidakhadiran lain yang diperhitungkan, maka waktu kerja efektif adalah:

250 − 12 − 6 − 15 − 5 = **212 hari kerja efektif**

Apabila satu hari kerja efektif adalah 7,5 jam, maka:

212 × 7,5 = **1.590 jam per tahun**

Angka tersebut hanya contoh perhitungan. Nilai sebenarnya harus menggunakan kalender kerja, sistem shift, ketentuan ketenagakerjaan, serta kebijakan fasilitas yang berlaku.

Waktu kerja efektif menjadi penyebut penting dalam perhitungan kebutuhan tenaga. Semakin sedikit waktu kerja efektif seorang tenaga, semakin banyak jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk memenuhi volume pelayanan yang sama.

6. Faktor Cuti, Pelatihan, Izin, dan Ketidakhadiran

Cuti merupakan hak tenaga dan harus diperhitungkan sejak awal perencanaan. Apabila cuti tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, setiap kali seorang perawat mengambil cuti, unit akan mengalami kekurangan staf atau harus menutup kekurangan tersebut dengan lembur.

Pelatihan juga merupakan bagian penting karena tenaga kesehatan harus mempertahankan dan mengembangkan kompetensinya. Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 menempatkan pelatihan sebagai bagian dari pengelolaan SDM kesehatan, sehingga waktu pengembangan kompetensi tidak seharusnya dianggap sebagai kejadian yang "mengganggu" jadwal, tetapi merupakan bagian yang perlu direncanakan.

Izin dapat berupa berbagai bentuk sesuai ketentuan institusi. Walaupun sebagian izin sulit diprediksi secara tepat, data historis dapat digunakan untuk memperkirakan pola ketidakhadiran.

Sakit juga perlu diperhatikan. Organisasi dapat menggunakan rata-rata data beberapa tahun untuk memperkirakan jumlah hari ketidakhadiran akibat sakit. Penggunaan data aktual lebih realistis dibandingkan mengasumsikan semua tenaga memiliki kehadiran sempurna.

Ketidakhadiran karena rapat, kegiatan mutu, pendidikan internal, orientasi, maupun kewajiban profesional juga dapat mengurangi waktu pelayanan langsung. Bergantung metode yang digunakan, waktu tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengurangan waktu tersedia atau diperhitungkan sebagai kegiatan penunjang.

Jika faktor-faktor tersebut diabaikan, hasil perhitungan sering terlihat cukup di atas kertas tetapi tidak mencukupi dalam praktik. Kondisi ini dapat menyebabkan kepala ruang terus-menerus melakukan perubahan jadwal, meminta tenaga lembur, memanggil staf yang sedang libur, atau menjalankan shift dengan jumlah tenaga di bawah kebutuhan.

Karena itu, perencanaan yang baik harus memperhitungkan kebutuhan "replacement" atau pengganti terhadap waktu ketika tenaga secara sah tidak tersedia.

7. Metode Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan

Terdapat berbagai pendekatan untuk menghitung kebutuhan tenaga. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan, ketersediaan data, jenis fasilitas, serta regulasi yang berlaku.

Dalam kerangka regulasi Indonesia saat ini, Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 menyebut bahwa pendekatan institusi menggunakan metode analisis beban kerja kesehatan dan/atau standar ketenagaan minimal. Analisis beban kerja digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja aktual, sedangkan standar ketenagaan minimal digunakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang baru atau akan didirikan sesuai standar yang ditetapkan.

Analisis beban kerja kesehatan merupakan pendekatan yang kuat untuk fasilitas yang telah beroperasi karena memiliki data volume pelayanan. Dalam metode ini, kebutuhan ditentukan berdasarkan kompetensi dan kewenangan, norma waktu, volume kerja, serta waktu kerja efektif.

Secara konseptual, beban waktu suatu kegiatan dapat dihitung dengan:

Beban kerja kegiatan = volume kegiatan × norma waktu

Jika suatu kegiatan dilakukan 2.000 kali dalam setahun dan membutuhkan 15 menit setiap kegiatan, maka:

2.000 × 15 menit = 30.000 menit

atau:

30.000 ÷ 60 = **500 jam kerja**

Seluruh beban waktu dari aktivitas utama kemudian dijumlahkan. Total tersebut dibandingkan dengan waktu kerja efektif per tenaga untuk mendapatkan kebutuhan tenaga dasar.

Secara sederhana:

Kebutuhan tenaga dasar = total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban kerja ÷ waktu kerja efektif per tenaga

Hasil tersebut selanjutnya dapat disesuaikan dengan kegiatan penunjang, kebutuhan skill mix, dan faktor organisasi sesuai metode yang digunakan.

Pendekatan lain yang relevan adalah Workload Indicators of Staffing Need (WISN) dari WHO. WISN merupakan metode berbasis workload yang menerapkan standar aktivitas atau waktu pada setiap komponen pekerjaan. Metode ini menggunakan waktu kerja tersedia, komponen beban kerja, standar aktivitas, dan allowance untuk menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan. WHO menerbitkan manual WISN edisi kedua pada 2023 dan manual perangkat lunak WISN terbaru pada 2025.

Dalam konteks keperawatan rawat inap, pendekatan berbasis jam perawatan pasien juga dapat digunakan untuk membantu perencanaan internal. Tahap dasarnya adalah menghitung jumlah pasien rata-rata, menentukan jam perawatan rata-rata per pasien, menghitung total jam keperawatan per hari atau per tahun, kemudian membandingkannya dengan jam kerja efektif seorang perawat.

Pendekatan ini relatif mudah dipahami tetapi memiliki keterbatasan. Jika jam perawatan pasien yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi aktual, hasilnya juga tidak akurat. Oleh karena itu, nilai jam perawatan sebaiknya berasal dari pengukuran atau standar yang relevan.

Metode berbasis klasifikasi pasien menggunakan tingkat ketergantungan sebagai dasar untuk memberikan bobot kebutuhan waktu. Pasien dikelompokkan menurut intensitas kebutuhan, kemudian jumlah pasien pada setiap kategori dikalikan dengan standar waktu masing-masing. Total kebutuhan waktu kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan tenaga.

Dalam literatur manajemen keperawatan juga dikenal berbagai formula klasik untuk memperkirakan kebutuhan staf. Formula tersebut dapat digunakan untuk memahami konsep perhitungan dalam pendidikan, tetapi penggunaannya dalam keputusan institusional harus dikaji terhadap regulasi, standar terbaru, karakteristik organisasi, dan data aktual. Untuk konteks perencanaan institusi di Indonesia, pendekatan analisis beban kerja kesehatan yang sesuai ketentuan terbaru lebih tepat dijadikan kerangka utama.

Dengan demikian, tidak ada satu rumus yang secara otomatis cocok untuk seluruh unit. Metode harus dipilih sesuai karakteristik pelayanan dan diverifikasi terhadap kondisi aktual setelah diterapkan.

8. Contoh Perhitungan Kebutuhan Tenaga pada Unit Rawat Inap

Berikut contoh ilustratif untuk membantu memahami prinsip perhitungan. Contoh ini bukan standar baku jumlah perawat dan tidak dimaksudkan menggantikan metode ABK Kesehatan resmi yang berlaku di fasilitas.

Sebuah unit rawat inap memiliki **30 tempat tidur**. Data tahunan menunjukkan rata-rata tingkat hunian tempat tidur sebesar **80%**.

Jumlah pasien rata-rata dapat diperkirakan sebagai:

30 tempat tidur × 80% = **24 pasien per hari**

Berdasarkan analisis internal unit terhadap tingkat ketergantungan pasien dan waktu aktivitas keperawatan, diperoleh kebutuhan rata-rata sebesar **4,5 jam keperawatan per pasien per hari**.

Dengan demikian, total kebutuhan jam keperawatan dalam satu hari adalah:

24 pasien × 4,5 jam = **108 jam keperawatan per hari**

Dalam satu tahun:

108 jam × 365 hari = **39.420 jam keperawatan per tahun**

Selanjutnya dihitung waktu kerja efektif setiap tenaga. Misalnya, berdasarkan kalender dan kebijakan organisasi diperoleh rata-rata **222 hari kerja efektif** per tenaga dalam satu tahun, dengan rata-rata **7,5 jam kerja efektif per hari**.

Waktu kerja efektif seorang tenaga dalam satu tahun:

222 × 7,5 = **1.665 jam per tahun**

Kebutuhan tenaga untuk memenuhi jam pelayanan langsung dan tidak langsung yang telah dimasukkan dalam nilai 4,5 jam per pasien adalah:

39.420 ÷ 1.665 = **23,68**

Karena kebutuhan tenaga harus berupa individu, maka dibulatkan ke atas menjadi sekitar **24 tenaga**.

Namun, angka tersebut belum otomatis menjadi jumlah akhir. Manajer perlu memastikan apakah seluruh kegiatan penunjang sudah termasuk dalam nilai jam perawatan yang digunakan. Jika belum, harus diberikan allowance atau penyesuaian.

Misalnya secara ilustratif diketahui bahwa sekitar **15% waktu kerja** diperlukan untuk aktivitas pendukung yang belum dimasukkan ke dalam jam perawatan pasien. Maka jumlah tenaga dapat disesuaikan dengan faktor:

24 ÷ (1 − 0,15)

= 24 ÷ 0,85

= **28,24**

Sehingga kebutuhan menjadi sekitar **29 tenaga** setelah pembulatan ke atas.

Selanjutnya perlu dikaji apakah kepala ruang termasuk dalam perhitungan tenaga pelayanan langsung. Jika kepala ruang menjalankan fungsi manajemen penuh dan tidak dijadwalkan sebagai perawat pelaksana secara rutin, maka kebutuhan fungsi manajemen perlu dipisahkan dari kebutuhan staf pelayanan.

Hasil tersebut juga harus dikaji dari aspek skill mix. Misalnya, kebutuhan 29 tenaga tidak berarti setiap kombinasi 29 orang akan memberikan pelayanan yang sama. Setiap shift harus memiliki tenaga berpengalaman, tenaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai karakteristik unit, serta pembagian tanggung jawab yang aman.

Setelah jumlah total diperoleh, tahap berikutnya adalah menyusun distribusi shift. Distribusi tidak harus sama antara pagi, sore, dan malam. Jika analisis menunjukkan aktivitas terbesar terjadi pada pagi hari karena visite, tindakan, admisi, pemulangan, dan pemeriksaan diagnostik, maka proporsi tenaga pada shift pagi dapat lebih besar.

Sebagai ilustrasi, organisasi dapat menentukan distribusi berdasarkan analisis beban shift, bukan sekadar membagi rata. Apabila kebutuhan pada suatu hari adalah 18 tenaga pelaksana dan beban aktivitas menunjukkan proporsi sekitar 45% pada pagi hari, 35% pada sore hari, dan 20% pada malam hari, hasil awal dapat diterjemahkan menjadi sekitar delapan tenaga pagi, enam tenaga sore, dan empat tenaga malam. Angka tersebut tetap harus diverifikasi berdasarkan acuity, skill mix, dan kondisi aktual pasien.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa proses perhitungan kebutuhan tenaga tidak berhenti pada satu rumus. Tahapannya dimulai dari mengetahui volume pelayanan, memperkirakan kebutuhan waktu, menentukan waktu kerja efektif, memperhitungkan ketidakhadiran dan aktivitas pendukung, kemudian memeriksa kembali kompetensi serta distribusi tenaga.

Dalam pendekatan WISN, proses dilakukan lebih rinci karena setiap kategori aktivitas mempunyai standar aktivitas dan kebutuhan allowance tersendiri. WHO menekankan bahwa WISN memang dirancang untuk membandingkan beban kerja aktual dengan kapasitas tenaga berdasarkan waktu kerja tersedia dan standar aktivitas.

Dalam konteks Indonesia, hasil perhitungan internal juga harus disesuaikan dengan kebijakan fasilitas dan ketentuan yang berlaku. Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 menetapkan bahwa perencanaan institusi berbasis analisis beban kerja kesehatan memperhatikan kompetensi dan kewenangan, norma waktu, volume kerja, dan waktu kerja efektif. Kerangka tersebut sangat relevan dalam memastikan bahwa jumlah tenaga tidak hanya rasional secara matematis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan merupakan proses analitis yang menghubungkan kebutuhan pasien dengan kapasitas tenaga. Hasil yang baik diperoleh apabila organisasi menggunakan data pelayanan yang valid, standar waktu yang realistis, waktu kerja efektif yang sesuai, serta memperhitungkan cuti, pendidikan, ketidakhadiran, kegiatan penunjang, dan kompetensi tenaga. Perhitungan tersebut kemudian perlu dievaluasi melalui kondisi aktual pelayanan, seperti penggunaan lembur, kekurangan staf per shift, missed nursing care, insiden keselamatan,

produktivitas, dan kepuasan tenaga. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga tidak sekadar menjadi angka administratif, tetapi menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, efisiensi organisasi, mutu asuhan, dan keselamatan pasien.

I. Staffing dan Penempatan Tenaga Keperawatan

1. Pengertian Staffing dalam Keperawatan

Staffing dalam keperawatan merupakan proses menentukan jumlah, jenis, kompetensi, komposisi, dan penempatan tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan secara aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Staffing tidak hanya berkaitan dengan jumlah perawat yang tersedia dalam suatu unit, tetapi juga mencakup bagaimana tenaga tersebut ditempatkan sesuai kebutuhan pasien, karakteristik pelayanan, tingkat ketergantungan pasien, kompetensi klinis, pengalaman, kewenangan, serta beban kerja pada setiap periode pelayanan.

Dalam manajemen keperawatan, staffing menjadi salah satu fungsi penting karena pelayanan keperawatan berlangsung secara terus-menerus dan membutuhkan tenaga yang tersedia selama dua puluh empat jam, terutama pada unit rawat inap. Jumlah pasien, tingkat keparahan kondisi, jenis tindakan, pola admisi dan pemulangan, serta perubahan kondisi pasien dapat berbeda dari satu hari ke hari lainnya. Oleh karena itu, staffing harus mampu menyesuaikan kapasitas tenaga dengan kebutuhan pelayanan yang nyata.

Staffing berbeda dengan scheduling, meskipun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Staffing lebih menekankan pada pertanyaan mengenai berapa banyak tenaga yang dibutuhkan, tenaga dengan kompetensi seperti apa yang diperlukan, dan di unit mana tenaga tersebut ditempatkan. Sementara itu, scheduling berkaitan dengan kapan tenaga tersebut bekerja dan bagaimana distribusinya pada shift pagi, sore, malam, akhir pekan, maupun hari libur. Staffing yang tepat menjadi dasar bagi penyusunan jadwal yang efektif.

Dalam praktik, staffing dapat dipandang sebagai proses yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga berdasarkan karakteristik pasien dan pelayanan. Tahap berikutnya adalah menentukan jumlah tenaga yang tersedia, menilai kompetensi dan pengalaman tenaga, kemudian menempatkan tenaga sesuai kebutuhan unit. Setelah pelaksanaan, manajer perlu mengevaluasi apakah jumlah dan komposisi tenaga tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelayanan.

Konsep staffing juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan tenaga. Organisasi membutuhkan jumlah tenaga yang cukup untuk menjaga mutu pelayanan, tetapi tenaga juga membutuhkan pembagian pekerjaan dan jadwal yang tidak menimbulkan kelelahan berlebihan. Oleh karena itu, keputusan staffing harus mempertimbangkan keselamatan pasien sekaligus kesehatan dan kesejahteraan tenaga keperawatan.

Staffing yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah. Kekurangan tenaga dapat menyebabkan beban kerja meningkat, waktu pelayanan terbatas, keterlambatan tindakan, kelelahan, dan risiko pelayanan yang tidak optimal. Sebaliknya, kelebihan tenaga yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dapat menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi kurang efisien. Dengan demikian, staffing yang baik bertujuan mencapai keseimbangan yang rasional antara kecukupan tenaga, mutu pelayanan, keselamatan, dan efisiensi.

2. Tujuan Staffing

Tujuan utama staffing adalah memastikan tersedianya tenaga keperawatan dalam jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan pelayanan. Kecukupan jumlah tenaga merupakan syarat penting, tetapi tidak cukup. Staffing yang efektif juga harus memastikan bahwa setiap shift memiliki kombinasi tenaga dengan kompetensi dan pengalaman yang memadai.

Staffing bertujuan menjaga kontinuitas pelayanan. Pasien membutuhkan asuhan sepanjang waktu, sehingga tenaga harus tersedia secara berkesinambungan. Pergantian shift tidak boleh menyebabkan terputusnya pelayanan atau menurunnya kualitas pemantauan pasien. Oleh karena itu, staffing perlu dirancang agar jumlah dan kompetensi tenaga tetap memadai pada setiap periode kerja.

Tujuan berikutnya adalah mendistribusikan beban kerja secara lebih adil. Jika sebagian tenaga menangani terlalu banyak pasien sementara tenaga lain memiliki beban yang jauh lebih ringan, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan staffing. Distribusi yang tepat membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas tim.

Staffing juga bertujuan memastikan bahwa pasien memperoleh pelayanan dari tenaga yang sesuai dengan kebutuhan klinis. Pasien dengan kondisi kompleks memerlukan tenaga yang memiliki pengetahuan,

pengalaman, dan kemampuan yang memadai. Karena itu, staffing harus memperhatikan skill mix dan tidak hanya menghitung jumlah tenaga berdasarkan head count.

Selain itu, staffing bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi. Penggunaan tenaga perlu disesuaikan dengan volume dan intensitas pelayanan. Unit dengan peningkatan pasien dapat memerlukan tambahan tenaga, sedangkan unit dengan penurunan aktivitas dapat menyesuaikan distribusi sementara. Pendekatan tersebut memungkinkan penggunaan tenaga secara lebih efektif tanpa mengabaikan keselamatan.

Staffing juga memiliki tujuan menjaga kepuasan dan retensi tenaga keperawatan. Beban kerja yang terlalu tinggi, ketidakseimbangan penugasan, dan seringnya perubahan jadwal dapat menurunkan kepuasan kerja. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, risiko turnover dapat meningkat. Staffing yang lebih rasional membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

Pada akhirnya, staffing bertujuan mendukung tercapainya mutu pelayanan, keselamatan pasien, produktivitas tenaga, serta keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, staffing sebaiknya dipandang sebagai keputusan manajerial sekaligus keputusan yang memiliki konsekuensi klinis.

3. Prinsip Penempatan Tenaga Keperawatan

Penempatan tenaga keperawatan harus dilakukan berdasarkan prinsip yang jelas agar setiap tenaga dapat bekerja sesuai kemampuan dan kebutuhan unit. Prinsip pertama adalah kesesuaian antara kompetensi tenaga dan karakteristik pelayanan. Tenaga perlu ditempatkan pada area yang sesuai dengan pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kewenangan yang dimilikinya.

Prinsip kedua adalah kecukupan jumlah tenaga. Penempatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemerataan jumlah antarunit, tetapi harus menyesuaikan beban kerja. Unit dengan pasien lebih kompleks dapat membutuhkan tenaga lebih banyak daripada unit dengan jumlah pasien yang sama tetapi tingkat ketergantungannya lebih rendah.

Prinsip berikutnya adalah keseimbangan skill mix. Dalam satu unit dan satu shift sebaiknya tersedia kombinasi tenaga yang cukup dari sisi pengalaman dan kompetensi. Jika seluruh tenaga dalam satu shift merupakan tenaga baru, maka kemampuan tim dalam menghadapi kondisi kompleks dapat menjadi lebih terbatas.

Prinsip keadilan juga penting. Penempatan perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, bukan hanya preferensi atau kedekatan tertentu. Keadilan dalam penempatan membantu menjaga kepercayaan tenaga terhadap manajemen dan mengurangi konflik internal.

Prinsip fleksibilitas diperlukan karena kebutuhan pelayanan dapat berubah. Staffing yang terlalu kaku dapat menyulitkan organisasi merespons lonjakan pasien, wabah, kondisi kegawatdaruratan, atau absensi mendadak. Oleh karena itu, sistem perlu memungkinkan penyesuaian tenaga dengan tetap memperhatikan kompetensi dan keselamatan.

Prinsip kontinuitas pelayanan juga harus dijaga. Penempatan tenaga sebaiknya tidak berubah terlalu sering tanpa alasan yang jelas karena kontinuitas dapat membantu tenaga memahami karakteristik pasien dan alur kerja unit. Namun, rotasi tetap dapat dilakukan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi, pemerataan tenaga, atau kebutuhan organisasi.

Prinsip keselamatan menjadi dasar seluruh proses penempatan. Tidak tepat menempatkan tenaga pada unit yang membutuhkan kompetensi khusus apabila tenaga tersebut belum memiliki kemampuan atau belum menjalani orientasi yang memadai. Penempatan seperti itu dapat meningkatkan risiko bagi pasien maupun tenaga.

4. Penempatan Berdasarkan Kompetensi dan Kewenangan

Kompetensi merupakan kemampuan tenaga untuk menjalankan tugas secara benar berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan penilaian klinis. Penempatan tenaga keperawatan harus mempertimbangkan kompetensi karena setiap unit memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda.

Perawat yang bekerja pada unit intensif, misalnya, membutuhkan kemampuan dalam pemantauan pasien kritis, penggunaan alat tertentu, pengenalan perubahan kondisi secara cepat, serta respons terhadap situasi gawat. Kebutuhan tersebut berbeda dengan unit rawat jalan atau komunitas. Oleh karena itu, perpindahan tenaga antarunit tidak dapat dilakukan hanya karena terdapat kekosongan jadwal tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Kewenangan juga harus menjadi pertimbangan. Seorang tenaga hanya dapat melakukan tindakan sesuai ruang lingkup praktik dan kewenangan yang dimilikinya. Manajer perlu memastikan bahwa penempatan tidak menyebabkan tenaga melakukan tugas di luar kewenangan atau tanpa supervisi yang sesuai.

Pengalaman klinis menjadi faktor tambahan. Dua tenaga dengan pendidikan yang sama dapat memiliki tingkat pengalaman berbeda. Perawat

berpengalaman biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi prioritas, mengenali perubahan kondisi, dan menghadapi situasi kompleks. Oleh sebab itu, dalam satu shift sebaiknya terdapat kombinasi antara tenaga berpengalaman dan tenaga yang masih membutuhkan pembimbingan.

Orientasi menjadi penting ketika tenaga dipindahkan ke unit baru. Perawat perlu memahami karakteristik pasien, prosedur, alat, alur komunikasi, standar dokumentasi, serta risiko khusus unit. Penempatan tanpa orientasi dapat meningkatkan beban tenaga dan menurunkan efektivitas kerja.

Kompetensi juga perlu dievaluasi secara berkala. Kemampuan yang sesuai saat tenaga pertama kali ditempatkan belum tentu tetap memadai apabila terdapat perubahan teknologi atau jenis pelayanan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi harus menjadi bagian dari strategi staffing.

5. Distribusi Tenaga pada Setiap Unit Pelayanan

Distribusi tenaga merupakan proses pembagian sumber daya manusia ke berbagai unit berdasarkan kebutuhan pelayanan. Distribusi yang baik harus memperhatikan karakteristik masing-masing unit dan tidak hanya melakukan pembagian secara merata.

Unit rawat inap umum membutuhkan tenaga berdasarkan jumlah pasien, tingkat ketergantungan, pola tindakan, admisi, pemulangan, dan transfer. Shift pagi biasanya memiliki aktivitas lebih banyak, tetapi distribusi tidak boleh otomatis selalu lebih besar tanpa melihat data aktual.

Unit intensif membutuhkan rasio tenaga yang lebih tinggi karena pasien memerlukan observasi dan intervensi lebih intensif. Selain jumlah, tenaga juga harus memiliki kompetensi khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasien kritis.

Unit gawat darurat memiliki karakteristik beban yang fluktuatif. Distribusi tenaga perlu mengikuti pola kunjungan dan tingkat kegawatan. Jam tertentu dapat mengalami lonjakan pasien, sehingga staffing perlu cukup fleksibel.

Kamar operasi membutuhkan tenaga sesuai jumlah dan jenis tindakan, jadwal operasi, kompleksitas prosedur, serta kebutuhan kasus emergensi. Unit rawat jalan lebih banyak dipengaruhi jumlah kunjungan dan aktivitas tindakan pada jam tertentu.

Distribusi tenaga juga perlu memperhatikan lokasi dan tata ruang. Unit dengan banyak kamar terpisah atau jarak yang luas dapat membutuhkan tambahan tenaga dibandingkan unit yang lebih kompak.

Ketersediaan tenaga pendukung juga berpengaruh. Unit dengan dukungan administrasi dan logistik yang baik dapat memungkinkan perawat

fokus pada aktivitas keperawatan. Sebaliknya, jika perawat harus melakukan banyak tugas nonkeperawatan, kebutuhan tenaga dapat meningkat.

Distribusi sebaiknya dievaluasi secara rutin menggunakan data beban kerja, jumlah pasien, tingkat ketergantungan, lembur, absensi, serta indikator mutu. Jika satu unit terus-menerus membutuhkan bantuan dari unit lain, kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian staffing.

6. Penyesuaian Jumlah Tenaga dengan Kondisi Pasien

Jumlah tenaga perlu disesuaikan dengan kondisi pasien karena kebutuhan pelayanan tidak bersifat tetap. Jumlah pasien yang sama dapat menghasilkan beban kerja berbeda apabila tingkat ketergantungan dan acuity berubah.

Pasien dengan kondisi stabil dan mandiri membutuhkan lebih sedikit waktu pelayanan dibandingkan pasien dengan ketergantungan total. Pasien dengan risiko jatuh tinggi, gangguan kesadaran, kondisi hemodinamik tidak stabil, kebutuhan observasi ketat, luka kompleks, atau kebutuhan edukasi intensif dapat meningkatkan kebutuhan tenaga.

Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi pasien dan analisis beban kerja. Jika pada suatu hari sebagian besar pasien berada dalam kategori ketergantungan tinggi, manajer perlu mempertimbangkan penambahan tenaga atau perubahan distribusi.

Pasien baru juga menambah beban kerja karena membutuhkan pengkajian awal, orientasi, dokumentasi, dan perencanaan asuhan. Pasien yang akan dipulangkan membutuhkan edukasi, koordinasi, dan persiapan dokumen. Oleh karena itu, turnover pasien perlu diperhitungkan.

Perubahan kondisi mendadak dapat membutuhkan penyesuaian staffing secara cepat. Misalnya, apabila beberapa pasien mengalami deteriorasi dalam waktu bersamaan, beban satu unit dapat meningkat meskipun jumlah pasien tidak berubah.

Karena itu, sistem staffing yang baik sebaiknya memiliki mekanisme pemantauan harian atau per shift. Kepala ruang atau koordinator perlu mengetahui jumlah pasien, tingkat ketergantungan, pasien baru, pasien dengan risiko tinggi, serta tenaga yang tersedia sebelum menetapkan pembagian tugas.

7. Redistribusi Tenaga pada Kondisi Kekurangan atau Kelebihan Staf

Redistribusi tenaga merupakan proses memindahkan atau menyesuaikan penempatan staf untuk sementara guna menyeimbangkan kebutuhan

antarunit. Redistribusi dapat dilakukan ketika suatu unit mengalami kekurangan staf sementara unit lain memiliki kapasitas tenaga lebih besar.

Kekurangan tenaga dapat terjadi akibat peningkatan jumlah pasien, ketergantungan tinggi, absensi mendadak, cuti, sakit, atau kejadian luar biasa. Dalam kondisi tersebut, manajer perlu menentukan langkah yang aman dan rasional.

Langkah pertama sebaiknya adalah menilai kebutuhan aktual, bukan langsung memindahkan tenaga. Manajer perlu mengetahui berapa kekurangan yang terjadi, jenis kompetensi apa yang diperlukan, dan berapa lama kebutuhan tersebut berlangsung.

Jika redistribusi dilakukan, kompetensi harus menjadi pertimbangan utama. Tenaga dari unit lain tidak otomatis dapat ditempatkan di semua area. Perawat dari rawat inap umum, misalnya, tidak dapat langsung ditempatkan pada unit intensif tanpa kompetensi yang memadai.

Redistribusi juga dapat dilakukan berdasarkan sistem floating. Float nurse atau tenaga yang memiliki pengalaman lintas unit dapat digunakan untuk membantu area dengan beban tinggi. Sistem seperti ini membutuhkan perencanaan dan pelatihan agar tenaga benar-benar siap.

Redistribusi harus dilakukan secara transparan dan adil. Jika individu tertentu selalu menjadi pihak yang dipindahkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan. Manajer perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai prioritas dan mekanisme redistribusi.

Pada kondisi kelebihan staf sementara, tenaga dapat dialihkan untuk membantu unit lain, kegiatan mutu, edukasi, dokumentasi, audit, atau pengembangan kompetensi. Namun, organisasi tetap harus memastikan bahwa unit asal memiliki kapasitas memadai untuk menghadapi perubahan kondisi.

Lembur sebaiknya tidak menjadi satu-satunya strategi mengatasi kekurangan staf. Penggunaan lembur secara berulang dapat meningkatkan kelelahan dan justru memperburuk masalah. Redistribusi, tenaga cadangan, pengaturan jadwal, serta perencanaan jangka panjang perlu dikombinasikan.

8. Tantangan dalam Pelaksanaan Staffing

Pelaksanaan staffing menghadapi berbagai tantangan karena kebutuhan pelayanan dan ketersediaan tenaga sering berubah. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan antara jumlah tenaga yang tersedia dengan kebutuhan aktual.

Kekurangan tenaga dapat terjadi karena keterbatasan rekrutmen, turnover tinggi, pensiun, perpindahan tenaga, atau peningkatan kapasitas pelayanan. Apabila kebutuhan meningkat lebih cepat daripada penambahan staf, organisasi dapat mengalami tekanan staffing.

Tantangan berikutnya adalah variasi beban kerja. Jumlah dan kondisi pasien berubah setiap hari. Metode staffing yang terlalu statis tidak mampu merespons perubahan tersebut.

Kompetensi yang tidak merata juga menjadi masalah. Organisasi dapat memiliki jumlah tenaga cukup, tetapi tenaga yang memiliki kompetensi tertentu hanya sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan beberapa perawat berpengalaman menerima beban tanggung jawab lebih besar.

Absensi dan ketidakhadiran mendadak merupakan tantangan lain. Sakit, izin, keadaan keluarga, atau alasan lain dapat menyebabkan jadwal berubah secara tiba-tiba. Jika tidak tersedia sistem pengganti, unit dapat bekerja di bawah jumlah tenaga yang direncanakan.

Turnover juga memengaruhi staffing. Ketika tenaga berpengalaman meninggalkan organisasi, tidak hanya jumlah tenaga yang berkurang, tetapi juga pengalaman dan kompetensi tim. Tenaga baru membutuhkan orientasi dan belum tentu langsung memiliki produktivitas yang sama.

Perubahan teknologi dan sistem pelayanan dapat menimbulkan tantangan tambahan. Penerapan sistem baru membutuhkan adaptasi dan pelatihan. Selama proses transisi, kebutuhan waktu dan tenaga dapat meningkat.

Tekanan efisiensi biaya juga dapat memengaruhi keputusan staffing. Organisasi perlu mengendalikan biaya, tetapi pembatasan tenaga yang terlalu ketat dapat meningkatkan beban kerja dan risiko pelayanan. Oleh sebab itu, keputusan staffing harus mempertimbangkan konsekuensi klinis dan operasional, bukan hanya biaya jangka pendek.

Konflik jadwal dan preferensi tenaga juga dapat terjadi. Perawat memiliki kebutuhan pribadi, pendidikan, keluarga, atau kondisi kesehatan yang berbeda. Manajer harus menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kebutuhan individu secara adil.

Tantangan berikutnya adalah komunikasi antarunit dan antarlevel manajemen. Redistribusi tenaga membutuhkan koordinasi yang cepat. Jika informasi mengenai kondisi pasien dan kebutuhan unit tidak tersedia secara akurat, keputusan staffing dapat terlambat atau tidak tepat.

Ketersediaan data juga sering menjadi kendala. Staffing yang baik membutuhkan data jumlah pasien, acuity, beban kerja, absensi, overtime,

turnover, dan indikator mutu. Jika data tidak dikumpulkan dengan baik, keputusan cenderung berdasarkan perkiraan.

Tantangan lain adalah resistensi terhadap perubahan. Perubahan pola staffing, redistribusi, atau penerapan sistem baru dapat menimbulkan kekhawatiran. Manajemen perlu menjelaskan alasan perubahan dan melibatkan tenaga dalam proses implementasi.

Pada akhirnya, staffing merupakan proses dinamis yang membutuhkan kombinasi antara perencanaan, data, kepemimpinan, fleksibilitas, dan evaluasi. Staffing yang efektif tidak hanya memastikan jumlah tenaga tersedia, tetapi memastikan tenaga yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat dengan kompetensi yang sesuai. Dengan pengelolaan yang baik, staffing dapat membantu menyeimbangkan kebutuhan pasien, beban kerja tenaga, efisiensi organisasi, serta keselamatan pelayanan.

J. Skill Mix dan Model Penugasan Keperawatan

1. Pengertian Skill Mix

Skill mix dalam keperawatan merupakan komposisi tenaga yang dibentuk berdasarkan tingkat pendidikan, kompetensi, pengalaman, kewenangan klinis, serta peran masing-masing tenaga dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Skill mix tidak hanya menggambarkan berapa banyak tenaga yang tersedia dalam suatu unit, tetapi juga menunjukkan apakah kombinasi tenaga tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan karakteristik pasien dan kompleksitas pelayanan.

Dalam manajemen keperawatan, jumlah tenaga yang mencukupi belum tentu menghasilkan pelayanan yang optimal apabila komposisi kompetensinya tidak sesuai. Sebagai contoh, suatu unit dapat memiliki jumlah perawat yang secara numerik memenuhi kebutuhan, tetapi sebagian besar tenaga merupakan perawat baru yang belum memiliki pengalaman menangani pasien dengan kondisi kompleks. Dalam situasi tersebut, jumlah tenaga mungkin terlihat memadai, tetapi kemampuan tim dalam memberikan pelayanan secara aman belum tentu optimal.

Skill mix perlu dipahami sebagai bagian dari staffing. Staffing menentukan jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan, sedangkan skill mix memastikan bahwa tenaga tersebut memiliki kombinasi kemampuan yang tepat. AHRQ memasukkan skill mix dan tingkat keahlian tenaga sebagai salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kecukupan staffing, bersama dengan acuity pasien, turnover pasien, kondisi unit, teknologi, dan sumber daya pendukung.

Komposisi tenaga juga dapat dilihat berdasarkan proporsi jam pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kategori tenaga. Dalam pengukuran kualitas pelayanan keperawatan, American Nurses Association menjelaskan skill mix sebagai proporsi total jam pelayanan produktif yang diberikan oleh berbagai kelompok tenaga keperawatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa skill mix bukan hanya berkaitan dengan jumlah individu, tetapi juga kontribusi waktu pelayanan dari masing-masing kelompok tenaga.

Skill mix yang baik berarti terdapat keseimbangan antara jumlah tenaga, kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan pasien. Setiap shift idealnya memiliki tenaga yang mampu melakukan pengkajian, mengambil keputusan klinis, memberikan intervensi, melakukan supervisi, berkomunikasi dengan tim interprofesional, serta merespons perubahan kondisi pasien. Selain itu, perlu tersedia tenaga yang dapat menjalankan fungsi pendukung sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Pengaturan skill mix juga perlu bersifat dinamis. Komposisi yang sesuai pada suatu hari belum tentu sesuai pada hari berikutnya apabila terjadi perubahan tingkat ketergantungan pasien, peningkatan jumlah pasien baru, penurunan kondisi pasien, atau perubahan jumlah tenaga yang tersedia. Karena itu, kepala ruang atau penanggung jawab shift perlu menilai kembali komposisi tenaga secara berkala.

2. Tujuan Pengaturan Skill Mix

Pengaturan skill mix bertujuan memastikan bahwa pasien memperoleh pelayanan dari tim yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan tersebut menjadi penting karena pelayanan keperawatan melibatkan berbagai tingkat kompleksitas. Pasien yang stabil dan relatif mandiri memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan pasien dengan risiko tinggi, gangguan multisistem, atau kondisi yang memerlukan pemantauan intensif.

Skill mix juga bertujuan mendukung keselamatan pasien. Tenaga yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dapat lebih cepat mengenali perubahan kondisi, menentukan prioritas, serta melakukan eskalasi ketika ditemukan masalah. Sebaliknya, apabila seluruh tenaga dalam suatu shift memiliki pengalaman yang terbatas, respons terhadap kondisi yang kompleks dapat menjadi lebih lambat.

Tujuan lainnya adalah mendistribusikan tanggung jawab sesuai kemampuan. Tidak seluruh tugas harus dilakukan oleh tenaga dengan tingkat kompetensi tertinggi. Sebagian aktivitas dapat diberikan kepada anggota tim lain sesuai kewenangan dan kompetensinya. Pembagian seperti ini membantu

penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien sekaligus memberi kesempatan kepada setiap anggota tim untuk berkontribusi sesuai perannya.

Namun, delegasi tidak berarti memindahkan tanggung jawab secara sembarangan. Sebelum suatu tugas didelegasikan, perlu dipertimbangkan karakteristik pasien, jenis tindakan, kondisi klinis, kompetensi penerima delegasi, serta ruang lingkup praktik yang diperbolehkan. ANA menekankan bahwa delegasi harus mempertimbangkan kebutuhan perawatan, situasi, kompetensi staf, dan fungsi yang diperbolehkan dalam ruang lingkup praktik masing-masing.

Pengaturan skill mix juga bertujuan mengoptimalkan produktivitas tim. Tenaga dengan kemampuan yang sesuai dapat bekerja lebih efektif karena tugas diberikan berdasarkan kompetensi. Perawat berpengalaman dapat lebih fokus pada aktivitas yang membutuhkan penilaian klinis, supervisi, koordinasi, atau pengambilan keputusan, sedangkan aktivitas lain dapat dibagi kepada anggota tim sesuai kewenangan.

Skill mix juga mendukung pengembangan tenaga. Kehadiran perawat senior dalam satu tim memungkinkan proses mentoring, preceptorship, dan pembelajaran berlangsung selama pelayanan. Tenaga baru dapat memperoleh bimbingan langsung dalam menghadapi kasus yang lebih kompleks. ANA juga menekankan pentingnya memanfaatkan pengalaman tenaga senior dan menyediakan waktu serta sumber daya untuk mentoring dan pengembangan kompetensi.

Tujuan lainnya adalah meningkatkan fleksibilitas organisasi. Unit dengan komposisi tenaga yang baik lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasien. Ketika terjadi peningkatan kompleksitas kasus, terdapat tenaga yang dapat mengambil peran lebih besar tanpa menyebabkan seluruh sistem pelayanan terganggu.

Dengan demikian, pengaturan skill mix tidak semata-mata bertujuan menentukan siapa bekerja bersama siapa, tetapi memastikan bahwa setiap shift memiliki kapasitas klinis, pengalaman, dan struktur kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasien.

3. Komposisi Tenaga Berdasarkan Pendidikan dan Kompetensi

Komposisi tenaga keperawatan perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu dasar dalam pembentukan pengetahuan dan keterampilan profesional. Namun, pendidikan formal tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penempatan karena

kompetensi juga dipengaruhi oleh pengalaman, pelatihan, pengembangan profesional, dan hasil kredensial.

Dalam unit pelayanan, dapat terdapat tenaga dengan jenjang pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan fungsi yang berbeda. Manajer harus mengetahui karakteristik setiap tenaga sehingga pembagian tugas dapat dilakukan secara tepat.

Tenaga dengan kemampuan pengkajian dan pengambilan keputusan klinis yang lebih tinggi dapat ditempatkan pada pasien dengan kompleksitas lebih tinggi. Sementara itu, tenaga yang masih berada pada tahap pengembangan kompetensi dapat menangani pasien dengan kebutuhan yang lebih sederhana di bawah supervisi sesuai ketentuan.

Keseimbangan ini penting. Apabila seluruh pasien dengan kompleksitas tinggi diberikan hanya kepada satu perawat senior sementara tenaga lain menangani pasien ringan, perawat senior dapat mengalami beban berlebihan. Karena itu, pembagian pasien perlu mempertimbangkan keseluruhan beban dan dukungan tim.

Komposisi berdasarkan kompetensi juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus unit. Perawat di intensive care unit membutuhkan kompetensi berbeda dengan perawat di rawat jalan, rehabilitasi, komunitas, atau unit psikiatri. Demikian pula, unit neonatal, pediatrik, onkologi, perioperatif, dan kegawatdaruratan membutuhkan kemampuan khusus.

Skill mix tidak boleh bersifat statis berdasarkan jabatan semata. Kompetensi tenaga perlu diperbarui melalui evaluasi berkala. Seorang perawat yang telah lama bekerja belum tentu memiliki seluruh kompetensi baru yang dibutuhkan apabila teknologi atau standar pelayanan mengalami perubahan. Sebaliknya, tenaga yang lebih muda dapat memiliki keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan terbaru.

Dalam konteks tersebut, manajemen perlu memiliki data kompetensi tenaga. Pemetaan kompetensi dapat membantu kepala ruang mengetahui siapa yang memiliki kemampuan tertentu, siapa yang dapat menjadi preceptor, siapa yang membutuhkan pelatihan, serta siapa yang dapat ditempatkan pada pasien dengan risiko tertentu.

Pengaturan tenaga berbasis kompetensi juga membantu mencegah ketergantungan unit pada satu atau dua orang tertentu. Jika hanya satu tenaga yang mampu melakukan suatu pelayanan, ketidakhadiran tenaga tersebut dapat menyebabkan gangguan operasional. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi perlu direncanakan agar terdapat lebih dari satu tenaga yang mampu menjalankan fungsi penting.

4. Pengalaman dan Kewenangan Klinis Perawat

Pengalaman klinis merupakan salah satu komponen penting dalam skill mix. Pengalaman membantu perawat mengembangkan kemampuan mengenali pola klinis, menentukan prioritas, menghadapi situasi yang tidak terduga, serta mengintegrasikan berbagai informasi dalam pengambilan keputusan.

Perawat yang telah lama bekerja pada unit tertentu biasanya lebih mengenal karakteristik pasien, pola pelayanan, teknologi, komunikasi tim, dan risiko khas unit. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan efisiensi serta kemampuan merespons kondisi yang kompleks.

Namun, pengalaman kerja tidak boleh dianggap sama dengan kewenangan klinis. Seorang perawat mungkin memiliki masa kerja panjang, tetapi tindakan yang dapat dilakukan tetap harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinis yang diberikan.

Dalam regulasi Indonesia yang berlaku saat ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien atau pelayanan yang berdampak pada keselamatan pasien harus memberikan pelayanan sesuai kewenangan klinis. Kewenangan klinis diberikan setelah proses kredensial. Untuk rumah sakit, rekomendasi kewenangan klinis diberikan melalui Tim Ad hoc Kredensial dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Hal tersebut memiliki implikasi penting terhadap staffing dan skill mix. Kepala ruang tidak cukup hanya mengetahui bahwa seseorang adalah perawat yang telah bekerja selama beberapa tahun. Penempatan perlu mempertimbangkan apakah tenaga tersebut memiliki kewenangan klinis yang sesuai dengan tindakan dan tanggung jawab yang akan diberikan.

Penugasan berdasarkan kewenangan klinis juga melindungi pasien dan perawat. Pasien memperoleh pelayanan dari tenaga yang telah dinilai kompeten, sedangkan perawat tidak didorong untuk melaksanakan tindakan di luar kewenangannya.

Pengalaman dan kewenangan klinis perlu dipadukan dalam pembagian tugas. Tenaga yang memiliki kewenangan tertentu tetapi masih relatif baru dapat membutuhkan dukungan dari tenaga yang lebih berpengalaman. Sebaliknya, tenaga senior tetap harus menjalankan pelayanan sesuai kewenangan klinis yang telah ditetapkan.

Kombinasi antara pengalaman, kompetensi, dan kewenangan ini menjadi dasar penting dalam memilih model penugasan keperawatan.

5. Metode Penugasan Fungsional

Metode penugasan fungsional merupakan model pemberian asuhan yang membagi pekerjaan berdasarkan jenis tugas atau fungsi tertentu. Dalam model ini, masing-masing anggota tim bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu untuk sejumlah pasien.

Sebagai contoh, seorang perawat dapat bertanggung jawab terhadap pemberian obat, perawat lain bertanggung jawab terhadap perawatan luka, sementara tenaga lainnya menangani pemenuhan kebutuhan kebersihan dan mobilisasi. Dengan demikian, satu pasien dapat menerima pelayanan dari beberapa anggota tenaga keperawatan yang berbeda dalam satu shift.

Model fungsional berkembang sebagai pendekatan yang menekankan efisiensi dan pembagian pekerjaan. Ketika jumlah tenaga terbatas atau jumlah pasien sangat banyak, pembagian berdasarkan fungsi memungkinkan aktivitas dilakukan secara cepat karena masing-masing tenaga berfokus pada tugas tertentu.

Kelebihan utama metode ini adalah efisiensi. Tenaga dapat menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan aktivitas tertentu karena melakukan tugas yang sama secara berulang. Pembagian tanggung jawab juga relatif mudah dipahami karena masing-masing tenaga mengetahui pekerjaan yang harus diselesaikan.

Model ini juga dapat berguna dalam situasi tertentu ketika pelayanan membutuhkan respons cepat dengan sumber daya terbatas. Misalnya, pada kondisi lonjakan pasien atau keadaan darurat, pembagian berdasarkan fungsi dapat membantu organisasi menyelesaikan kebutuhan mendesak.

Namun, keterbatasan utama metode fungsional adalah fragmentasi pelayanan. Pasien menerima pelayanan dari beberapa tenaga sehingga hubungan terapeutik dapat menjadi kurang kuat. Perawat mungkin hanya memahami satu bagian kebutuhan pasien dan tidak melihat pasien secara utuh.

Fragmentasi juga dapat menimbulkan risiko komunikasi. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, informasi yang diketahui oleh satu perawat belum tentu diketahui oleh tenaga lain. Oleh sebab itu, metode fungsional membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang sangat jelas.

Model ini juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab menyeluruh terhadap pasien. Setiap tenaga dapat lebih berfokus pada penyelesaian tugas daripada hasil asuhan secara keseluruhan. Karena itu, metode ini kurang ideal apabila organisasi ingin menekankan pelayanan holistik dan continuity of care.

6. Metode Penugasan Tim

Metode tim merupakan model penugasan di mana sekelompok tenaga keperawatan bekerja bersama untuk memberikan asuhan kepada sekelompok pasien di bawah koordinasi seorang ketua tim.

Ketua tim biasanya merupakan perawat yang memiliki kemampuan koordinasi dan pengalaman yang memadai. Ketua tim bertanggung jawab mengatur pembagian pasien, mendelegasikan tugas, memantau pelaksanaan asuhan, membantu penyelesaian masalah, serta memastikan komunikasi antaranggota berjalan efektif.

Dalam model tim, masing-masing anggota dapat memiliki peran yang berbeda sesuai tingkat kompetensinya. Pembagian tidak hanya berdasarkan jenis tugas, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pasien dan kemampuan tenaga.

Kelebihan model tim adalah kemampuan memanfaatkan skill mix secara efektif. Anggota dengan tingkat kompetensi berbeda dapat bekerja bersama dan saling melengkapi. Perawat senior dapat menangani kebutuhan yang lebih kompleks sekaligus memberikan supervisi kepada anggota lain.

Metode tim juga memungkinkan pelayanan lebih holistik dibandingkan metode fungsional. Walaupun satu pasien dapat menerima pelayanan dari beberapa anggota, seluruh pelayanan tetap berada dalam koordinasi tim yang sama.

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan model ini. Ketua tim perlu memastikan seluruh anggota memahami kondisi pasien, prioritas, serta rencana pelayanan. Handover dan diskusi singkat dalam tim menjadi sangat penting.

Keterbatasannya adalah efektivitas sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan ketua tim. Jika ketua tim tidak mampu melakukan koordinasi, delegasi, dan supervisi, pembagian kerja dapat menjadi tidak jelas.

Metode ini juga dapat menghadapi masalah apabila komposisi tim tidak seimbang. Jika terlalu banyak anggota baru atau jumlah tenaga berpengalaman sangat terbatas, ketua tim dapat mengalami beban supervisi yang tinggi.

7. Metode Kasus

Metode kasus atau case method merupakan model di mana seorang perawat bertanggung jawab secara langsung terhadap seluruh kebutuhan

keperawatan seorang pasien atau sekelompok kecil pasien selama periode kerja tertentu.

Dalam model ini, perawat melakukan pengkajian, perencanaan, intervensi, evaluasi, edukasi, koordinasi, dan dokumentasi terhadap pasien yang menjadi tanggung jawabnya selama shift.

Model kasus memberikan tingkat tanggung jawab individual yang tinggi. Perawat memiliki kesempatan memahami kondisi pasien secara lebih menyeluruh karena tidak hanya melakukan satu aktivitas tertentu.

Kelebihan utama metode ini adalah pelayanan lebih holistik dan hubungan perawat-pasien lebih kuat. Pasien mengetahui tenaga yang bertanggung jawab terhadap dirinya selama shift sehingga komunikasi dapat lebih sederhana.

Metode kasus juga memungkinkan perawat menggunakan proses keperawatan secara lebih utuh karena satu tenaga mengikuti keseluruhan kebutuhan pasien selama periode tersebut.

Model ini cocok pada kondisi ketika pasien membutuhkan perhatian intensif atau ketika rasio pasien terhadap perawat relatif rendah. Unit dengan pasien kompleks atau pelayanan khusus dapat menggunakan prinsip case nursing pada situasi tertentu.

Namun, metode kasus membutuhkan jumlah tenaga dan kompetensi yang memadai. Jika seorang perawat menangani terlalu banyak pasien, manfaat model ini dapat hilang karena beban kerja menjadi terlalu tinggi.

Keterbatasan berikutnya adalah kontinuitas antarshift. Tanggung jawab perawat berakhir ketika shift selesai dan pasien kemudian dirawat perawat lain. Karena itu, handover yang baik sangat penting.

Model ini juga dapat menghasilkan variasi kualitas pelayanan apabila kompetensi perawat berbeda jauh. Karena masing-masing perawat memiliki tanggung jawab besar terhadap pasiennya, kurangnya kompetensi dapat lebih langsung memengaruhi pelayanan.

8. Primary Nursing

Primary nursing merupakan model pemberian asuhan yang menempatkan seorang perawat primer sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan dan koordinasi asuhan pasien selama periode perawatan, bukan hanya selama satu shift.

Perawat primer menyusun rencana keperawatan, menetapkan prioritas, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, serta mengoordinasikan

pelayanan. Ketika perawat primer tidak bertugas, pelaksanaan asuhan dapat dilanjutkan oleh perawat asosiet berdasarkan rencana yang telah disusun.

Karakteristik utama primary nursing adalah kontinuitas dan akuntabilitas. Pasien memiliki perawat utama yang memahami perjalanan perawatan sejak awal sehingga koordinasi dapat lebih konsisten.

Model ini mendukung hubungan terapeutik yang lebih kuat karena pasien dan keluarga memiliki tenaga yang dapat menjadi kontak utama terkait asuhan keperawatan. Perawat primer juga memiliki kesempatan untuk memahami perkembangan pasien secara longitudinal.

Kelebihan lainnya adalah peningkatan otonomi profesional. Perawat primer memiliki tanggung jawab lebih besar dalam perencanaan dan evaluasi asuhan. Kondisi ini dapat meningkatkan penggunaan kemampuan klinis dan rasa tanggung jawab profesional.

Namun, primary nursing membutuhkan tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Tidak semua tenaga dapat langsung menjalankan fungsi perawat primer tanpa pengalaman dan persiapan.

Model ini juga membutuhkan komunikasi antarshift yang sangat baik. Perawat asosiet harus memahami rencana yang dibuat dan melaksanakannya secara konsisten. Apabila komunikasi tidak baik, kontinuitas yang menjadi keunggulan primary nursing dapat terganggu.

Keterbatasan lainnya adalah kebutuhan sumber daya. Pada unit dengan kekurangan tenaga berat atau turnover staf sangat tinggi, implementasi primary nursing dapat menjadi lebih sulit.

9. Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Model Penugasan

Tidak ada satu model penugasan yang selalu lebih baik untuk semua situasi. Setiap model memiliki keunggulan dan keterbatasan serta harus dinilai sesuai kebutuhan unit.

Metode fungsional unggul dalam efisiensi dan pembagian pekerjaan yang jelas. Model ini dapat digunakan pada situasi dengan jumlah pasien tinggi atau ketika organisasi perlu melakukan pembagian pekerjaan secara cepat. Namun, risiko utama adalah fragmentasi pelayanan dan berkurangnya kontinuitas.

Metode tim memiliki keunggulan dalam penggunaan skill mix dan kerja sama. Model ini memungkinkan tenaga dengan kompetensi berbeda bekerja

dalam satu kelompok. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, dan kualitas ketua tim.

Metode kasus memberikan pelayanan lebih holistik dan tanggung jawab individual yang jelas dalam satu shift. Hubungan perawat-pasien dapat berkembang lebih baik dibandingkan metode fungsional. Akan tetapi, metode ini membutuhkan tenaga yang kompeten dan jumlah pasien yang memungkinkan satu perawat menjalankan seluruh kebutuhan asuhan.

Primary nursing menawarkan kontinuitas dan akuntabilitas paling kuat karena terdapat perawat utama yang bertanggung jawab terhadap rencana asuhan sepanjang periode perawatan. Namun, implementasinya membutuhkan kompetensi profesional, stabilitas tenaga, dan sistem komunikasi yang baik.

Dalam praktik, organisasi juga dapat menggunakan model modifikasi atau kombinasi. Sebuah unit dapat menggunakan metode tim sebagai struktur utama tetapi menerapkan prinsip primary nursing pada pasien tertentu. Unit lain dapat menggunakan case nursing untuk pasien kompleks dan pendekatan tim bagi pasien lainnya.

Kombinasi dapat memberikan fleksibilitas, tetapi harus memiliki struktur yang jelas. Penggabungan terlalu banyak model tanpa penjelasan tanggung jawab dapat justru menimbulkan kebingungan.

10. Pemilihan Model Penugasan Sesuai Karakteristik Unit

Pemilihan model penugasan harus dimulai dengan analisis karakteristik pasien dan pelayanan. Tidak tepat memilih model hanya karena telah lama digunakan atau karena digunakan oleh rumah sakit lain.

Faktor pertama adalah tingkat ketergantungan dan kompleksitas pasien. Pasien dengan kebutuhan kompleks membutuhkan koordinasi dan kontinuitas yang lebih tinggi. Model kasus atau primary nursing dapat memberikan keuntungan pada kondisi tersebut apabila tenaga tersedia dan kompeten.

Faktor kedua adalah jumlah dan kompetensi tenaga. Model primary nursing membutuhkan tingkat otonomi dan kompetensi yang relatif tinggi. Jika sebagian besar tenaga masih baru, metode tim dapat lebih sesuai karena menyediakan mekanisme supervisi dan dukungan.

Skill mix juga menjadi pertimbangan. Unit dengan variasi tingkat kompetensi tenaga dapat memanfaatkan metode tim karena tanggung jawab dapat dibagi sesuai kemampuan. ANA menekankan bahwa kebutuhan staffing harus mempertimbangkan status pasien dan kompetensi perawat, serta bahwa

tenaga perlu diberi kesempatan bekerja sesuai pendidikan, pelatihan, scope of practice, dan kompetensi terdokumentasi.

Karakteristik unit juga penting. Intensive care membutuhkan tingkat tanggung jawab individual dan pengawasan yang tinggi. Unit rawat inap umum dapat menggunakan model tim atau modifikasi sesuai jumlah tenaga dan tingkat ketergantungan. Pelayanan komunitas atau home care mungkin lebih dekat dengan pendekatan kasus karena satu tenaga menangani pasien atau keluarga secara lebih mandiri.

Volume pasien dan turnover perlu dipertimbangkan. Unit dengan pergantian pasien sangat tinggi membutuhkan model yang memungkinkan koordinasi cepat. Model yang terlalu kompleks dapat menghambat apabila tenaga harus sering melakukan reorganisasi tanggung jawab.

Budaya organisasi juga berpengaruh. Model tim membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang baik. Jika budaya kerja sangat individual dan komunikasi lemah, model tersebut tidak akan berfungsi optimal tanpa intervensi organisasi.

Sistem dokumentasi dan teknologi juga dapat memengaruhi. Sistem dokumentasi yang mendukung rencana asuhan terintegrasi akan membantu penerapan primary nursing atau model berbasis kontinuitas.

Ketersediaan tenaga pendukung perlu diperhatikan. Apabila perawat masih banyak melakukan tugas nonkeperawatan, model dengan tuntutan tanggung jawab yang tinggi dapat sulit diterapkan secara optimal.

Pemilihan model juga harus mempertimbangkan keselamatan pasien. Model penugasan harus memungkinkan pengawasan, komunikasi, eskalasi, dan pembagian tugas dilakukan secara jelas. AHRQ menekankan bahwa staffing aman merupakan proses kompleks yang perlu mempertimbangkan acuity pasien, turnover, skill mix, pengalaman, lingkungan unit, dan sumber daya yang tersedia.

Evaluasi model harus dilakukan secara berkala. Indikator yang dapat diamati antara lain kualitas dokumentasi, missed nursing care, kepuasan pasien, kepuasan perawat, insiden keselamatan, keterlambatan pelayanan, kerja sama tim, serta kontinuitas asuhan. Jika hasil menunjukkan masalah yang berulang, organisasi perlu mempertimbangkan penyesuaian model.

Model yang berhasil pada satu unit belum tentu berhasil di unit lain. Oleh karena itu, pemilihan harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar mengikuti tren. Yang paling penting adalah memastikan bahwa struktur penugasan menghasilkan tanggung jawab yang jelas, pelayanan yang

terkoordinasi, penggunaan kompetensi secara tepat, serta kontinuitas dan keselamatan pasien.

Pada akhirnya, skill mix dan model penugasan merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam manajemen pelayanan keperawatan. Skill mix memastikan tersedianya kombinasi tenaga dengan pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan kewenangan yang sesuai, sedangkan model penugasan mengatur bagaimana kemampuan tersebut digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kombinasi yang tepat antara keduanya membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya, memperjelas tanggung jawab, meningkatkan kolaborasi, mengurangi fragmentasi pelayanan, serta menjaga mutu dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, pengaturan skill mix dan model penugasan perlu dilakukan secara sistematis, berbasis kebutuhan pasien, memperhatikan kewenangan klinis, serta dievaluasi secara berkelanjutan mengikuti perubahan kondisi pelayanan.

K. Konsep dan Prinsip Scheduling Tenaga Keperawatan

1. Pengertian Scheduling Tenaga Keperawatan

Scheduling tenaga keperawatan merupakan proses perencanaan dan pengaturan waktu kerja tenaga keperawatan untuk memastikan bahwa pelayanan tersedia secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pasien dan karakteristik unit pelayanan. Scheduling mencakup penentuan siapa yang bertugas, kapan tenaga bekerja, pada shift mana tenaga ditempatkan, berapa jumlah tenaga pada setiap shift, bagaimana komposisi kompetensinya, serta bagaimana hari kerja, hari libur, cuti, dan pergantian jadwal diatur dalam suatu periode tertentu.

Dalam pelayanan keperawatan, scheduling memiliki posisi penting karena pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, berlangsung sepanjang hari dan tidak berhenti ketika jam kerja administratif berakhir. Pasien tetap membutuhkan pemantauan, pemberian terapi, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan perubahan kondisi, komunikasi, serta intervensi lainnya selama dua puluh empat jam. NIOSH menggambarkan pelayanan kesehatan sebagai industri yang berlangsung 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, sehingga sistem shift menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan perawat.

Scheduling berbeda dengan staffing, walaupun keduanya saling berkaitan. Staffing menentukan jumlah, komposisi, kompetensi, dan jenis tenaga yang diperlukan, sedangkan scheduling mengatur bagaimana tenaga tersebut didistribusikan ke dalam waktu pelayanan. Apabila suatu unit

membutuhkan sejumlah tenaga tertentu, hasil perhitungan staffing belum menjamin pelayanan berjalan baik sebelum tenaga tersebut dibagi secara tepat pada shift pagi, sore, malam, hari kerja, akhir pekan, maupun hari libur.

Oleh sebab itu, jadwal dinas tidak boleh dipandang hanya sebagai tabel berisi nama tenaga dan waktu kerja. Jadwal merupakan instrumen manajemen yang menghubungkan kebutuhan pasien, kebutuhan organisasi, kapasitas tenaga, keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan perawat. Jadwal yang disusun tanpa mempertimbangkan aspek tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, kekurangan tenaga pada periode tertentu, kelelahan, konflik antarstaf, peningkatan lembur, dan pada akhirnya dapat memengaruhi mutu pelayanan.

Scheduling juga harus memperhatikan bahwa kebutuhan tenaga tidak selalu sama sepanjang hari. Unit rawat inap dapat memiliki aktivitas lebih tinggi pada pagi hari karena adanya pengkajian, visite, tindakan diagnostik, pemberian terapi, penerimaan pasien, pemulangan, dan koordinasi antarprofesi. Namun, shift malam tetap membutuhkan tenaga yang mampu menghadapi deteriorasi pasien, keadaan darurat, serta kebutuhan pelayanan yang tidak dapat ditunda. Dengan demikian, jumlah tenaga setiap shift tidak selalu harus sama, tetapi harus disesuaikan dengan pola beban kerja.

Scheduling bersifat dinamis. Jadwal yang telah disusun dapat mengalami perubahan karena sakit, cuti mendadak, peningkatan jumlah pasien, perubahan acuity pasien, keadaan darurat, pelatihan, atau kebutuhan organisasi lainnya. Oleh sebab itu, selain membuat jadwal reguler, manajemen perlu memiliki mekanisme contingency staffing atau rencana pengganti agar pelayanan tetap berjalan ketika terjadi perubahan yang tidak diperkirakan.

2. Tujuan Penyusunan Jadwal Dinas

Tujuan utama penyusunan jadwal dinas adalah menjamin tersedianya tenaga keperawatan dalam jumlah dan komposisi yang memadai pada setiap periode pelayanan. Jadwal harus memastikan bahwa tidak ada waktu pelayanan yang mengalami kekurangan tenaga sehingga kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi.

Jadwal juga bertujuan menjaga kontinuitas pelayanan. Pasien yang menjalani rawat inap membutuhkan asuhan yang berkesinambungan dari satu shift ke shift berikutnya. Oleh karena itu, scheduling harus memungkinkan proses handover berlangsung dengan baik serta memastikan bahwa setiap

shift memiliki tenaga yang mampu melanjutkan rencana asuhan yang telah disusun.

Tujuan berikutnya adalah menyesuaikan jumlah tenaga dengan pola beban kerja. Tidak seluruh shift memiliki beban yang sama. Jadwal yang efektif mengalokasikan tenaga lebih besar pada waktu dengan aktivitas lebih tinggi, tanpa mengabaikan kebutuhan minimum dan kompetensi pada periode lainnya.

Penyusunan jadwal juga bertujuan menjaga keseimbangan skill mix. Tidak tepat apabila suatu shift memiliki jumlah tenaga yang cukup tetapi seluruhnya merupakan tenaga yang relatif baru. Setiap shift perlu memiliki kombinasi pengalaman dan kompetensi yang memungkinkan pelayanan dilakukan secara aman. Kehadiran tenaga berpengalaman juga penting untuk memberikan supervisi dan membantu pengambilan keputusan pada situasi kompleks.

Tujuan lainnya adalah mencegah beban kerja dan kelelahan yang tidak proporsional. Pola kerja yang terlalu panjang, terlalu banyak shift berturut-turut, atau waktu istirahat yang tidak cukup dapat menyebabkan fatigue. ANA dalam posisi terbarunya tahun 2026 menempatkan fatigue sebagai persoalan keselamatan yang dipengaruhi oleh staffing, workload, jam kerja, shift work, dan kondisi organisasi. Organisasi karena itu perlu mengelola jadwal sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan perawat dan pasien.

Scheduling juga bertujuan menciptakan kepastian bagi tenaga. Jadwal yang diterbitkan secara teratur dan cukup dapat diprediksi membantu perawat merencanakan waktu istirahat, kebutuhan keluarga, pendidikan, dan aktivitas pribadi. NIOSH menyebut jadwal yang teratur dan dapat diprediksi membantu tenaga merencanakan tidur serta tanggung jawab di luar pekerjaan.

Selain itu, jadwal membantu organisasi mengendalikan penggunaan lembur. Apabila scheduling tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan, unit dapat berulang kali membutuhkan overtime atau memanggil tenaga pada hari libur. Kondisi tersebut bukan hanya meningkatkan biaya, tetapi juga berpotensi menambah kelelahan tenaga.

Penyusunan jadwal yang baik pada akhirnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara tiga unsur utama, yaitu kebutuhan pasien, kebutuhan organisasi, dan kebutuhan tenaga. Ketiganya tidak selalu dapat dipenuhi sepenuhnya pada setiap situasi, tetapi jadwal harus disusun melalui keputusan yang transparan, rasional, dan berorientasi pada keselamatan.

3. Prinsip Penyusunan Jadwal yang Efektif

Prinsip pertama dalam penyusunan jadwal adalah berbasis kebutuhan pelayanan. Jadwal tidak boleh dibuat dengan cara membagi jumlah tenaga secara sama rata tanpa melihat kondisi unit. Jumlah pasien, acuity, tingkat ketergantungan, turnover pasien, jumlah tindakan, serta pola beban kerja perlu menjadi dasar penentuan jumlah tenaga pada setiap shift. Prinsip staffing ANA juga menekankan bahwa keputusan tenaga harus didasarkan pada jumlah serta kebutuhan populasi pasien yang dilayani dan karakteristik masing-masing tempat praktik.

Prinsip kedua adalah menjamin kompetensi yang sesuai pada setiap shift. Jadwal tidak cukup hanya memenuhi angka minimal tenaga. Perlu dipastikan terdapat tenaga dengan pengalaman, kompetensi, dan kewenangan yang diperlukan. Penanggung jawab shift atau perawat yang memiliki kemampuan menangani kondisi kompleks perlu tersedia secara proporsional.

Prinsip ketiga adalah kontinuitas. Jadwal sebaiknya meminimalkan perubahan yang tidak perlu sehingga kesinambungan pelayanan dan kerja sama tim dapat dipertahankan. Pergantian tenaga yang terlalu sering dapat meningkatkan kebutuhan handover dan berpotensi menimbulkan kehilangan informasi.

Prinsip berikutnya adalah prediktabilitas. Jadwal yang sering berubah secara mendadak dapat menimbulkan kesulitan bagi tenaga dalam mengatur istirahat dan kehidupan pribadi. Sebisa mungkin, jadwal diterbitkan dalam periode yang memungkinkan staf melakukan perencanaan.

Prinsip keselamatan merupakan unsur utama. Jadwal perlu menghindari pola kerja yang meningkatkan fatigue secara tidak perlu. NIOSH merekomendasikan agar shift malam berturut-turut pada sistem rotasi dijaga seminimal mungkin, serta menekankan pentingnya waktu pemulihan setelah rangkaian hari kerja yang panjang.

Prinsip berikutnya adalah waktu istirahat yang memadai. Tenaga memerlukan kesempatan pemulihan antardinas dan setelah beberapa hari kerja berturut-turut. Tidak tepat menyusun jadwal yang secara administratif memenuhi kebutuhan shift tetapi menghasilkan periode istirahat yang sangat pendek atau menyebabkan tenaga harus kembali bekerja sebelum pulih.

Prinsip fleksibilitas juga diperlukan. Walaupun jadwal perlu stabil, sistem harus memiliki kemampuan menyesuaikan perubahan kebutuhan. Fleksibilitas dapat berupa pertukaran shift yang terkontrol, penggunaan tenaga cadangan, float staff, atau redistribusi tenaga. Namun, fleksibilitas tidak boleh berarti jadwal dapat berubah tanpa aturan.

Prinsip partisipasi dapat membantu meningkatkan penerimaan jadwal. Staf dapat diberikan kesempatan menyampaikan preferensi atau kebutuhan tertentu selama tetap berada dalam batas kebutuhan pelayanan. NIOSH menyebut bahwa memberikan sebagian kontrol kepada perawat terhadap jadwal dapat membantu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, tetapi self-scheduling tetap memerlukan aturan untuk mencegah pola kerja yang berisiko.

Prinsip terakhir adalah evaluasi. Jadwal perlu dikaji setelah diterapkan. Manajer dapat melihat apakah terdapat banyak lembur, pertukaran shift, absensi, kekurangan tenaga, keluhan staf, atau gangguan mutu. Jika pola yang sama terus berulang, struktur jadwal perlu diperbaiki.

4. Keadilan dalam Pembagian Jadwal

Keadilan merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam scheduling tenaga keperawatan. Persepsi bahwa jadwal tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, penurunan motivasi, bahkan memengaruhi hubungan antaranggota tim.

Keadilan dalam scheduling tidak berarti setiap tenaga selalu mendapatkan jumlah shift pagi, sore, malam, akhir pekan, dan hari libur yang benar-benar sama. Kondisi setiap tenaga, kompetensi, tanggung jawab, serta kebutuhan pelayanan dapat berbeda. Keadilan lebih tepat dipahami sebagai pembagian berdasarkan aturan yang transparan, konsisten, proporsional, dan dapat dijelaskan.

Pembagian shift malam menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian. Jika tenaga tertentu terus-menerus memperoleh shift malam tanpa alasan yang jelas, dapat muncul persepsi ketidakadilan. Demikian pula dalam pembagian hari libur nasional, akhir pekan, maupun kesempatan cuti.

Keadilan juga mencakup distribusi beban, bukan hanya jumlah shift. Dua tenaga dapat sama-sama bekerja lima hari, tetapi salah satu memperoleh beberapa shift dengan beban lebih berat secara berturut-turut. Karena itu, jadwal perlu dilihat dalam konteks kualitas pola kerja, bukan sekadar jumlah hari.

Transparansi merupakan dasar penting dalam menciptakan keadilan. Unit sebaiknya memiliki ketentuan mengenai pembagian shift, prioritas cuti, pertukaran jadwal, batas shift berturut-turut, mekanisme pengajuan preferensi, dan prosedur menghadapi kekurangan tenaga.

Konsistensi juga penting. Aturan yang sama sebaiknya diterapkan kepada seluruh tenaga dalam situasi yang serupa. Pengecualian dapat diberikan jika

terdapat alasan yang objektif, tetapi alasan tersebut perlu dapat dipertanggungjawabkan.

Manajer juga perlu memperhatikan tenaga dengan kebutuhan khusus, seperti kondisi kesehatan tertentu atau kebutuhan yang telah mendapat persetujuan organisasi. Memberikan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang valid tidak otomatis berarti tidak adil. Prinsip keadilan bukan selalu memberikan perlakuan identik, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.

Partisipasi staf dapat membantu mengurangi konflik. Apabila tenaga memahami dasar penyusunan jadwal dan memiliki ruang menyampaikan preferensi, keputusan lebih mudah diterima meskipun tidak seluruh permintaan dapat dipenuhi.

5. Kebutuhan Pelayanan Selama 24 Jam

Pelayanan keperawatan pada unit rawat inap merupakan pelayanan berkesinambungan. Pasien tidak hanya membutuhkan pelayanan pada pagi atau sore hari. Perubahan kondisi dapat terjadi kapan saja sehingga sistem scheduling harus menjamin kesiapan tenaga selama dua puluh empat jam.

Kebutuhan pelayanan pada setiap periode dapat berbeda. Shift pagi sering memiliki aktivitas terjadwal lebih banyak. Selain asuhan rutin, terdapat visite, pemeriksaan, tindakan diagnostik, penerimaan pasien, discharge planning, koordinasi dengan dokter dan profesi lain, serta aktivitas administratif.

Shift sore tetap memiliki beban signifikan karena pelayanan pasien berlanjut, terdapat penerimaan pasien baru, pemberian terapi, monitoring, edukasi, dan kebutuhan keluarga. Aktivitas tertentu yang belum selesai pada pagi hari dapat berlanjut pada sore.

Shift malam memiliki karakteristik yang berbeda. Jumlah tindakan terjadwal mungkin lebih sedikit, tetapi staf tetap bertanggung jawab melakukan observasi, pemberian terapi, pemenuhan kebutuhan pasien, penanganan gangguan tidur, keadaan darurat, serta identifikasi deteriorasi. Jumlah tenaga yang lebih sedikit pada malam hari tidak boleh menyebabkan tidak tersedianya kompetensi yang diperlukan.

Pada malam hari, faktor fatigue juga perlu mendapat perhatian. NIOSH menjelaskan bahwa shift work dapat mengganggu tidur dan ritme sirkadian, sementara jam kerja panjang mengurangi waktu pemulihan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kelelahan dan risiko kesalahan.

Karena itu, distribusi shift tidak boleh sekadar membagi jumlah total tenaga menjadi tiga bagian. Organisasi perlu menganalisis pola beban berdasarkan waktu. Data historis dapat menunjukkan kapan admisi tertinggi terjadi, kapan tindakan paling banyak dilakukan, serta pada jam berapa kondisi darurat paling sering membutuhkan respons.

Handover antarshift juga harus dimasukkan dalam sistem waktu kerja. Pelayanan 24 jam membutuhkan transfer informasi yang akurat. Jika jadwal dibuat tanpa memberikan waktu yang cukup untuk handover, kontinuitas informasi dapat terganggu.

Kebutuhan 24 jam juga berarti harus tersedia contingency plan ketika tenaga yang dijadwalkan tidak hadir. Unit perlu memiliki mekanisme mengganti staf tanpa secara rutin bergantung pada lembur tenaga yang sama.

6. Keseimbangan antara Kebutuhan Organisasi dan Kebutuhan Perawat

Scheduling berada pada titik pertemuan antara kepentingan organisasi dan kebutuhan manusia yang bekerja di dalamnya. Organisasi membutuhkan pelayanan berkesinambungan, sedangkan perawat membutuhkan waktu istirahat, kehidupan keluarga, pengembangan profesional, serta kesempatan mempertahankan kesehatan fisik dan psikologis.

Jika jadwal hanya berorientasi pada organisasi, tenaga dapat mengalami kelelahan, ketidakpuasan, dan kesulitan menjaga keseimbangan kehidupan kerja. Sebaliknya, apabila seluruh preferensi individu selalu diprioritaskan tanpa mempertimbangkan pelayanan, kebutuhan pasien dapat tidak terpenuhi.

Keseimbangan tersebut memerlukan proses negosiasi dan aturan yang jelas. Organisasi dapat memberikan ruang bagi tenaga menyampaikan preferensi shift, hari libur, atau permintaan tertentu, tetapi keputusan akhir tetap mempertimbangkan staffing minimum, skill mix, dan kebutuhan unit.

Self-scheduling dapat menjadi salah satu cara memberikan partisipasi lebih besar kepada tenaga. Namun, NIOSH mengingatkan bahwa self-scheduling tetap perlu dilengkapi batasan karena individu dapat memilih pola yang justru meningkatkan risiko fatigue.

Keseimbangan juga berkaitan dengan kemampuan tenaga memperoleh istirahat. Jadwal seharusnya tidak membuat tenaga secara rutin bekerja dalam rangkaian shift panjang tanpa waktu pemulihan. ANA menekankan perlunya kebijakan mengenai panjang shift, waktu makan dan istirahat, serta overtime untuk menjaga kesehatan, stamina, dan mencegah kesalahan terkait fatigue.

Organisasi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pendidikan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan tidak boleh selalu dianggap sebagai gangguan terhadap jadwal. Jadwal perlu menyediakan ruang agar tenaga tetap dapat meningkatkan kemampuan tanpa menyebabkan unit kekurangan staf.

Keseimbangan yang baik dapat membantu retensi tenaga. Staf lebih mungkin mempertahankan keterlibatan kerja apabila kebutuhan profesional dan pribadi dipertimbangkan secara wajar.

7. Faktor yang Memengaruhi Penyusunan Jadwal

Penyusunan jadwal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah jumlah pasien dan tingkat ketergantungan. Peningkatan jumlah pasien atau tingginya acuity dapat meningkatkan kebutuhan tenaga pada suatu shift.

Faktor kedua adalah jumlah tenaga yang tersedia. Kepala ruang perlu mengetahui tenaga yang benar-benar dapat dijadwalkan setelah mempertimbangkan cuti, pelatihan, sakit, tugas lain, dan ketidakhadiran.

Kompetensi dan skill mix juga sangat menentukan. Jadwal harus memastikan terdapat tenaga yang memenuhi kebutuhan kompetensi unit pada setiap shift. Tidak tepat menempatkan seluruh tenaga senior pada pagi hari dan meninggalkan shift malam tanpa tenaga yang mampu menangani situasi kompleks.

Pola beban kerja berdasarkan waktu juga harus diperhatikan. Jumlah admisi, pemulangan, tindakan, dan kegiatan unit dapat berbeda menurut hari dan jam. Data tersebut dapat digunakan untuk membuat jadwal yang lebih responsif.

Jenis shift menjadi faktor berikutnya. Organisasi dapat menggunakan shift 8 jam, 10 jam, 12 jam, atau pola lainnya sesuai sistem kerja. Setiap pilihan memiliki implikasi terhadap jumlah pergantian shift, waktu istirahat, kontinuitas, dan fatigue. NIOSH menyebut shift panjang dan kerja malam memerlukan perhatian karena dapat menambah kelelahan; pada malam dan sore, shift yang lebih pendek umumnya lebih mudah ditoleransi daripada shift panjang.

Jumlah shift berturut-turut juga memengaruhi kondisi tenaga. Semakin panjang rangkaian hari kerja, semakin besar kemungkinan fatigue terakumulasi, terutama jika menggunakan shift panjang.

Pertukaran jadwal antartenaga menjadi faktor operasional lain. Sistem perlu memiliki prosedur agar pertukaran tidak menyebabkan komposisi kompetensi berubah menjadi tidak aman. Pertukaran bukan sekadar

mengganti nama pada roster, tetapi harus diperiksa kembali apakah skill mix tetap memadai.

Cuti dan hari libur perlu dimasukkan sejak awal. Jika terlalu banyak tenaga memperoleh cuti pada periode yang sama, unit dapat mengalami kekurangan tenaga. Karena itu, persetujuan cuti perlu dikaitkan dengan kebutuhan minimum unit.

Absensi mendadak merupakan faktor yang sulit diprediksi. Organisasi perlu memiliki mekanisme penggantian seperti float staff, tenaga on-call bila sistem menggunakannya, atau redistribusi yang aman.

Faktor terakhir adalah kebijakan dan sumber daya organisasi. Ketersediaan anggaran, ketentuan jam kerja, kebijakan lembur, sistem informasi, serta aturan internal akan memengaruhi desain jadwal.

8. Jenis dan Pola Penjadwalan Tenaga Keperawatan

Terdapat beberapa pola penjadwalan yang dapat digunakan dalam pelayanan keperawatan. Pemilihan pola perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi, jenis pelayanan, kebutuhan pasien, dan kondisi tenaga.

Fixed scheduling merupakan pola di mana tenaga bekerja pada shift yang relatif tetap. Seorang perawat dapat secara konsisten bekerja pada shift pagi, sore, atau malam. Kelebihan pola ini adalah prediktabilitas sehingga tenaga lebih mudah mengatur pola hidupnya. Namun, khusus untuk shift malam tetap, perlu diperhatikan dampak terhadap ritme sirkadian dan kemampuan adaptasi. NIOSH menyarankan agar penggunaan permanent night shift dilakukan secara hati-hati.

Rotating scheduling merupakan pola di mana tenaga berpindah antara shift pagi, sore, dan malam dalam periode tertentu. Keuntungannya adalah pembagian shift yang dianggap kurang diminati dapat lebih merata. Namun, perubahan waktu kerja yang sering dapat mengganggu ritme tidur dan membutuhkan adaptasi fisiologis.

Rotasi sebaiknya disusun dengan pola yang tidak terlalu cepat berubah. Rangkaian shift juga perlu mempertimbangkan waktu pemulihan. Rotasi yang tidak terencana dapat menyebabkan tenaga bekerja pagi, kemudian malam, kemudian kembali pagi dengan interval istirahat yang terbatas.

Cyclic scheduling menggunakan pola jadwal yang berulang setelah periode tertentu, misalnya siklus beberapa minggu. Setelah satu siklus selesai, pola kembali ke awal. Keunggulannya adalah jadwal lebih mudah diprediksi dan pembagian shift dapat dirancang secara sistematis.

Pola siklus juga memudahkan manajemen karena jadwal dasar tidak harus dibuat dari awal setiap bulan. Namun, penyesuaian tetap diperlukan apabila terdapat cuti, pelatihan, perubahan staffing, atau kebutuhan pelayanan.

Self-scheduling memberikan kesempatan kepada tenaga untuk memilih atau mengusulkan jadwal kerja berdasarkan kebutuhan pribadi, kemudian jadwal disesuaikan agar tetap memenuhi kebutuhan unit. Pendekatan ini dapat meningkatkan partisipasi dan rasa kontrol terhadap pekerjaan.

Namun, self-scheduling tidak berarti setiap tenaga bebas memilih semua shift yang diinginkan. Organisasi harus menetapkan batas mengenai jumlah tenaga per shift, skill mix, shift malam, akhir pekan, serta waktu istirahat. NIOSH secara khusus menyebut bahwa self-scheduling dapat digunakan, tetapi perlu aturan untuk mencegah tenaga memilih pola yang meningkatkan risiko fatigue.

Flexible scheduling memungkinkan jadwal disesuaikan dengan variasi kebutuhan pelayanan. Durasi atau waktu mulai kerja tenaga dapat berbeda untuk menyesuaikan jam sibuk. Contohnya, beberapa tenaga dapat masuk lebih awal atau lebih lambat apabila analisis menunjukkan terdapat lonjakan aktivitas pada periode tertentu.

Pendekatan fleksibel dapat meningkatkan efisiensi, tetapi membutuhkan data beban kerja yang baik dan koordinasi yang jelas. Fleksibilitas yang berlebihan tanpa sistem justru dapat membuat jadwal tidak stabil.

Compressed work schedule menggunakan jumlah hari kerja yang lebih sedikit dengan durasi shift lebih panjang sehingga total jam kerja tetap terpenuhi. Shift 12 jam merupakan salah satu bentuk yang banyak dikenal dalam pelayanan keperawatan. Keuntungannya adalah tenaga memiliki lebih banyak hari tanpa jadwal kerja dan jumlah handover dapat berkurang. Namun, shift panjang dapat meningkatkan fatigue apabila tidak disertai waktu istirahat dan pemulihan yang memadai. Bukti keselamatan menunjukkan risiko error meningkat dalam kondisi shift yang sangat panjang, overtime, dan istirahat yang tidak memadai.

Organisasi tidak harus menggunakan satu pola untuk seluruh unit. Kombinasi dapat digunakan selama memiliki aturan yang jelas. Unit tertentu mungkin menggunakan fixed scheduling, sementara unit lain menggunakan rotasi atau self-scheduling terbatas.

Pemilihan pola harus dievaluasi berdasarkan hasil, bukan sekadar preferensi. Indikator yang dapat digunakan antara lain ketidakhadiran, pertukaran shift, overtime, kelelahan, kepuasan staf, turnover, kejadian

keselamatan, keterlambatan pelayanan, serta kemampuan unit memenuhi kebutuhan staffing.

Pada akhirnya, scheduling tenaga keperawatan merupakan proses strategis untuk mengatur keberadaan tenaga berdasarkan waktu dan kebutuhan pelayanan. Jadwal yang baik tidak hanya memastikan seluruh kolom shift terisi, tetapi juga memastikan terdapat jumlah dan skill mix yang memadai, pembagian yang adil, waktu istirahat yang cukup, serta kemampuan sistem menghadapi perubahan kebutuhan. Scheduling harus mempertimbangkan pelayanan selama dua puluh empat jam sekaligus menyadari bahwa tenaga keperawatan memiliki batas fisiologis dan kebutuhan kehidupan di luar pekerjaan. Dengan mengintegrasikan kebutuhan pasien, data beban kerja, kompetensi, prinsip keadilan, keselamatan, dan partisipasi tenaga, organisasi dapat membangun sistem penjadwalan yang lebih efektif, berkelanjutan, serta mendukung mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

L. Penyusunan Jadwal Dinas dan Pengelolaan Shift

1. Identifikasi Kebutuhan Tenaga Setiap Shift

Penyusunan jadwal dinas tenaga keperawatan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan tenaga pada setiap shift. Tahap ini merupakan dasar penting karena jadwal yang baik tidak sekadar membagi seluruh perawat secara merata ke dalam shift pagi, sore, dan malam, tetapi menyesuaikan jumlah serta kompetensi tenaga dengan kebutuhan pelayanan pada masing-masing periode kerja. Kebutuhan tenaga dapat berbeda antara satu shift dengan shift lainnya karena jumlah aktivitas, kondisi pasien, pola penerimaan dan pemulangan pasien, serta jenis tindakan yang dilakukan tidak selalu sama.

Identifikasi kebutuhan tenaga sebaiknya menggunakan data aktual mengenai jumlah pasien, tingkat ketergantungan, acuity, jumlah pasien baru, pasien yang direncanakan pulang, pasien yang memerlukan pemantauan khusus, serta beban tindakan pada unit. Apabila sebagian besar pasien berada dalam kondisi stabil dan relatif mandiri, kebutuhan tenaga dapat berbeda dibandingkan ketika sebagian besar pasien membutuhkan bantuan total, pemantauan ketat, atau intervensi yang kompleks.

Selain jumlah pasien, manajer perlu memperhatikan komposisi kompetensi tenaga. Suatu shift tidak dapat dianggap aman hanya karena jumlah orang yang dijadwalkan telah memenuhi kebutuhan numerik. Apabila seluruh tenaga yang bertugas merupakan tenaga baru atau belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani kasus tertentu, maka kapasitas pelayanan tetap dapat tidak memadai. Oleh sebab itu, identifikasi

kebutuhan harus meliputi jumlah tenaga sekaligus skill mix, pengalaman, dan kewenangan klinis yang diperlukan.

Kebutuhan setiap shift juga dipengaruhi oleh pola aktivitas unit. Shift pagi pada banyak unit rawat inap memiliki beban aktivitas yang relatif tinggi karena terdapat pengkajian, pemberian terapi, visite, pemeriksaan diagnostik, tindakan keperawatan, persiapan operasi atau prosedur, penerimaan pasien, pemulangan, konsultasi, serta koordinasi dengan berbagai profesi. Shift sore dapat memiliki aktivitas berbeda, tetapi tetap membutuhkan kemampuan untuk menangani pasien baru, melaksanakan terapi, melakukan observasi, serta mempersiapkan pelayanan malam. Shift malam mungkin memiliki lebih sedikit kegiatan terjadwal, tetapi tetap membutuhkan tenaga yang mampu mendeteksi perubahan kondisi dan menangani keadaan darurat.

Identifikasi kebutuhan perlu dilakukan sebelum jadwal dibuat dan ditinjau kembali ketika jadwal diterapkan. Jika terjadi peningkatan jumlah atau kompleksitas pasien, jumlah tenaga yang semula dianggap cukup dapat menjadi tidak memadai. Sebaliknya, apabila tingkat hunian menurun, organisasi dapat mempertimbangkan redistribusi tenaga secara aman.

WHO menekankan bahwa tenaga kesehatan perlu tersedia dalam jumlah, keterampilan, kompetensi, dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Pendekatan staffing berbasis workload juga menempatkan beban pelayanan sebagai dasar penting dalam menentukan kebutuhan tenaga.

2. Pembagian Shift Pagi, Sore, dan Malam

Pelayanan keperawatan pada unit rawat inap umumnya berlangsung selama dua puluh empat jam sehingga pembagian waktu kerja menjadi shift diperlukan untuk mempertahankan kontinuitas pelayanan. Secara umum, organisasi dapat menggunakan shift pagi, sore, dan malam, meskipun jam mulai dan berakhirnya setiap shift dapat berbeda sesuai kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembagian tenaga pada ketiga shift tersebut tidak harus sama. Prinsip utama adalah menyesuaikan jumlah tenaga dengan kebutuhan pelayanan. Jika data menunjukkan bahwa aktivitas tertinggi terjadi pada shift pagi, maka jumlah tenaga pada shift pagi dapat lebih banyak daripada shift sore dan malam. Namun, jumlah tenaga pada shift malam tidak boleh diturunkan hanya karena pasien sedang beristirahat. Risiko klinis tetap ada dan perubahan kondisi pasien dapat terjadi sewaktu-waktu.

Shift pagi biasanya menjadi periode dengan interaksi pelayanan yang paling kompleks. Pada periode ini, perawat dapat melakukan pengkajian lanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian terapi, persiapan dan pendampingan pemeriksaan diagnostik, koordinasi dengan dokter dan profesi lain, edukasi, discharge planning, penerimaan pasien baru, serta dokumentasi. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga sering kali relatif lebih besar.

Shift sore berfungsi melanjutkan pelayanan dari shift pagi dan mempersiapkan kondisi pasien menuju malam. Kegiatan dapat meliputi pemberian terapi, monitoring, penerimaan pasien, bantuan aktivitas pasien, edukasi, pengelolaan kebutuhan keluarga, serta berbagai tindakan yang belum selesai pada periode sebelumnya.

Shift malam memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas perawat meliputi pemantauan kondisi, menjaga kenyamanan dan keselamatan, pemberian terapi yang terjadwal, pemenuhan kebutuhan pasien, merespons perubahan klinis, serta mempersiapkan informasi untuk shift berikutnya. Shift malam membutuhkan kewaspadaan khusus karena secara biologis manusia memiliki kecenderungan menurun dalam kewaspadaan pada malam hari. NIOSH menjelaskan bahwa kerja malam dan jam kerja panjang dapat mengganggu tidur dan ritme sirkadian serta meningkatkan fatigue.

Karena itu, pembagian tenaga malam perlu mempertimbangkan jumlah pasien, risiko klinis, luas unit, jarak antararea, kemungkinan kegawatdaruratan, serta ketersediaan tenaga pendukung. Unit intensif atau unit dengan pasien berisiko tinggi memerlukan struktur staffing malam yang berbeda dibandingkan unit dengan mayoritas pasien stabil.

Manajemen juga perlu memastikan bahwa pada setiap shift terdapat tenaga yang mampu bertindak sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab shift harus memiliki kompetensi, pengalaman, kemampuan komunikasi, serta kapasitas untuk melakukan koordinasi dan mengambil keputusan sesuai kewenangan.

3. Pola Rotasi Jadwal

Rotasi jadwal merupakan pengaturan perpindahan tenaga dari satu jenis shift ke shift lainnya dalam periode tertentu. Rotasi banyak digunakan agar beban bekerja pada pagi, sore, malam, akhir pekan, dan hari libur tidak hanya ditanggung oleh kelompok tenaga tertentu.

Pola rotasi perlu disusun secara hati-hati karena perubahan waktu kerja memengaruhi pola tidur dan ritme biologis. Perawat yang berpindah dari shift

pagi ke shift malam memerlukan adaptasi terhadap perubahan waktu tidur. Apabila perpindahan dilakukan terlalu cepat atau tidak memberikan waktu istirahat yang memadai, fatigue dapat meningkat.

Salah satu prinsip penting adalah menghindari pergantian shift yang terlalu cepat. NIOSH mencatat bahwa perubahan cepat dari shift sore yang berakhir malam hari menuju shift pagi berikutnya dapat memberikan waktu tidur yang terlalu pendek. Sumber tersebut juga mengemukakan bahwa rotasi maju, misalnya dari pagi menuju sore kemudian malam, secara umum lebih mudah diadaptasi dibandingkan rotasi mundur.

Sebagai contoh, pola:

Pagi → Sore → Malam

secara fisiologis dapat lebih mudah dibandingkan pola:

Malam → Sore → Pagi.

Namun, penerapan pola tetap perlu menyesuaikan kondisi organisasi, panjang shift, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebutuhan individu. Tidak ada satu pola rotasi yang otomatis sesuai untuk seluruh unit.

Rotasi juga tidak sebaiknya hanya dilihat berdasarkan pemerataan jumlah shift. Beban dari rangkaian shift perlu dipertimbangkan. Seorang perawat yang memperoleh tiga shift malam berturut-turut memiliki kebutuhan pemulihan yang berbeda dibandingkan perawat dengan tiga shift pagi.

Setelah menjalani rangkaian shift malam atau shift panjang, tenaga perlu memiliki waktu pemulihan yang memadai sebelum kembali pada pola kerja berikutnya. Jadwal yang menyebabkan tenaga pulang pagi dan kembali bekerja pada sore atau pagi berikutnya perlu diperiksa dari perspektif keselamatan dan fatigue.

Pola rotasi yang baik juga mempertimbangkan kontinuitas tim. Jika anggota tim berubah seluruhnya setiap hari, kerja sama dan kontinuitas dapat menjadi kurang stabil. Karena itu, kepala ruang dapat mempertimbangkan kombinasi rotasi yang memungkinkan terdapat anggota tim yang sudah memahami kondisi pasien dari periode sebelumnya.

4. Pengaturan Hari Kerja dan Hari Libur

Hari kerja dan hari libur harus diatur sebagai satu kesatuan dalam penyusunan jadwal. Hari libur bukan sekadar hari ketika tenaga tidak dijadwalkan, tetapi merupakan waktu yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan psikologis setelah menjalani tuntutan kerja.

Pengaturan hari kerja harus mempertimbangkan panjang shift, jumlah hari berturut-turut, jenis shift, serta pola beban kerja. Semakin panjang shift yang dijalani, semakin besar kebutuhan untuk memastikan terdapat waktu pemulihan yang memadai.

Jadwal yang terlalu padat dapat menyebabkan fatigue terakumulasi. Perawat mungkin secara administratif masih mampu hadir, tetapi kewaspadaan, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan dapat menurun. ANA menegaskan bahwa fatigue pada perawat berkaitan dengan jam kerja panjang, beban pasien, staffing yang tidak memadai, dan shift work, sehingga organisasi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan strategi sistemik yang mendukung keselamatan.

Hari libur juga perlu dibagikan secara adil. Pada pelayanan dua puluh empat jam, tenaga tetap dibutuhkan pada Sabtu, Minggu, maupun hari libur nasional. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki sistem agar kewajiban tersebut tidak terus-menerus dibebankan kepada orang yang sama.

Pembagian hari libur dapat disusun melalui rotasi atau sistem siklus. Tenaga dapat mengetahui sebelumnya kapan mereka memperoleh hari libur sehingga dapat mengatur kebutuhan pribadi dan keluarga.

Namun, hari libur tidak boleh terus digunakan untuk menutup kekurangan staffing. Jika tenaga yang seharusnya libur berulang kali diminta masuk karena unit kekurangan tenaga, maka masalah sebenarnya berada pada perencanaan staffing dan bukan sekadar scheduling.

5. Pengaturan Cuti dan Izin

Cuti dan izin merupakan bagian normal dari pengelolaan SDM dan harus diperhitungkan dalam penyusunan jadwal. Jadwal yang hanya dapat berjalan apabila tidak ada seorang pun yang mengambil cuti menunjukkan bahwa staffing terlalu ketat.

Pengaturan cuti perlu dilakukan melalui sistem yang jelas. Tenaga dapat mengajukan cuti dalam periode tertentu dan kepala ruang menilai apakah kebutuhan unit tetap dapat dipenuhi. Jika beberapa tenaga mengajukan cuti pada waktu yang sama, keputusan perlu dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Transparansi sangat penting dalam pengaturan cuti. Kriteria persetujuan, batas jumlah tenaga yang dapat cuti bersamaan, prioritas tertentu, serta mekanisme ketika permintaan tidak dapat dipenuhi perlu diketahui oleh seluruh staf.

Cuti yang telah direncanakan sebaiknya sudah dimasukkan saat penyusunan roster. Dengan demikian, manajer dapat mencari tenaga pengganti atau mengatur distribusi sebelum periode kerja dimulai.

Izin mendadak memiliki karakter berbeda karena tidak selalu dapat direncanakan. Kondisi keluarga, sakit, atau keadaan tertentu dapat menyebabkan tenaga tidak dapat bekerja sesuai jadwal. Organisasi perlu memiliki prosedur pelaporan yang jelas sehingga kepala ruang mengetahui kondisi tersebut sedini mungkin.

Pemberian izin tidak boleh ditangani hanya dengan memindahkan beban kepada staf lain tanpa evaluasi. Apabila satu tenaga tidak hadir, kepala ruang perlu menghitung kembali jumlah dan skill mix yang tersedia sebelum menentukan apakah perlu dilakukan penggantian.

6. Pergantian dan Pertukaran Jadwal

Pertukaran jadwal merupakan hal yang umum dalam pelayanan keperawatan karena staf dapat memiliki kebutuhan pribadi yang tidak selalu diketahui saat roster disusun. Fleksibilitas pertukaran dapat membantu kepuasan tenaga, tetapi harus diatur agar tidak menimbulkan risiko.

Pertukaran jadwal tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dua orang perawat. Setiap perubahan perlu mendapat persetujuan penanggung jawab karena dapat memengaruhi skill mix, jumlah jam kerja, kontinuitas pelayanan, dan waktu istirahat.

Sebagai contoh, perawat senior pada shift malam tidak dapat begitu saja bertukar dengan tenaga baru apabila setelah pertukaran tidak terdapat tenaga berpengalaman yang cukup di shift tersebut. Secara numerik jumlah tenaga tetap sama, tetapi kapasitas klinis shift dapat berubah.

Pertukaran juga perlu diperiksa apakah menimbulkan rangkaian kerja yang terlalu panjang. Seorang tenaga mungkin bersedia mengambil shift rekan kerja, tetapi jika hal tersebut menyebabkan tenaga bekerja beberapa shift berurutan tanpa istirahat memadai, manajer perlu mempertimbangkan konsekuensi fatigue.

Oleh sebab itu, sistem pertukaran sebaiknya mendokumentasikan nama tenaga, shift awal, shift pengganti, persetujuan penanggung jawab, dan pembaruan roster. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab hadir.

Pergantian jadwal yang terlalu sering juga perlu dievaluasi. Jika sebagian besar roster harus terus diperbaiki setelah diterbitkan, kemungkinan terdapat

masalah pada proses penyusunan awal atau jadwal tidak cukup memperhitungkan kebutuhan tenaga.

7. Pengelolaan Ketidakhadiran Mendadak

Ketidakhadiran mendadak merupakan salah satu tantangan paling sulit dalam pengelolaan shift. Seorang tenaga dapat sakit atau mengalami keadaan yang menyebabkan dirinya tidak dapat masuk, sementara pelayanan tetap harus berlangsung.

Ketika menerima laporan ketidakhadiran, langkah pertama adalah menilai kondisi staffing yang tersisa. Kepala ruang perlu mengetahui jumlah pasien, acuity, jumlah tenaga, kompetensi, serta kegiatan yang direncanakan pada shift tersebut.

Jika jumlah dan komposisi tenaga masih memadai, pelayanan dapat dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian pembagian tugas. Namun, apabila ketidakhadiran menyebabkan staffing berada di bawah kebutuhan, maka diperlukan tindakan tambahan.

Pilihan dapat meliputi penggunaan tenaga cadangan, float nurse, pemanggilan tenaga sesuai mekanisme on-call yang berlaku, redistribusi dari unit lain, atau bentuk contingency staffing lainnya yang tersedia di organisasi. ANA dalam pernyataan 2026 mengenai fatigue secara khusus memasukkan reliable contingency staffing plans sebagai bagian dari solusi organisasi untuk menjaga keselamatan tenaga dan pasien.

Pemanggilan tenaga yang sedang libur atau penggunaan lembur dapat menjadi pilihan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya strategi setiap kali terjadi ketidakhadiran. Jika lembur terus digunakan, risiko fatigue meningkat.

Ketidakhadiran mendadak juga perlu dicatat dan dianalisis secara berkala. Jika tingkat absensi tinggi, organisasi perlu menilai penyebabnya. Tingginya ketidakhadiran dapat menjadi tanda masalah kesehatan tenaga, burnout, kepuasan kerja rendah, beban kerja berlebihan, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung.

8. Penanganan Kekurangan Tenaga pada Suatu Shift

Kekurangan tenaga dapat terjadi meskipun jadwal telah dibuat dengan baik. Kondisi pasien dapat berubah, beberapa staf dapat tidak hadir, atau volume pelayanan dapat meningkat secara tidak terduga.

Ketika kekurangan terjadi, langkah pertama adalah menentukan tingkat risiko. Tidak semua kekurangan memiliki dampak yang sama. Kekurangan satu

tenaga pada unit dengan pasien stabil dapat memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan kekurangan tenaga pada unit dengan beberapa pasien yang mengalami deteriorasi.

Setelah kebutuhan dinilai, manajer dapat melakukan redistribusi beban. Pasien dengan kompleksitas tinggi diberikan kepada tenaga yang kompeten, sedangkan pembagian pasien lain disesuaikan agar beban tidak terkonsentrasi pada satu individu.

Jika redistribusi internal tidak cukup, bantuan dari unit lain dapat dipertimbangkan. Namun, tenaga yang dipindahkan harus memiliki kompetensi yang relevan. Memindahkan perawat yang tidak familiar dengan unit berisiko tinggi tanpa orientasi atau pendampingan bukan solusi yang aman.

Penggunaan tenaga cadangan atau float pool dapat menjadi strategi yang lebih terstruktur. Tenaga float idealnya telah dipersiapkan untuk bekerja pada beberapa unit dan memahami prosedur dasar di area tersebut.

Prioritas pelayanan juga perlu ditinjau ketika kekurangan tenaga terjadi. Kegiatan yang sangat penting bagi keselamatan pasien harus dipastikan terlaksana terlebih dahulu. Namun, penetapan prioritas tidak boleh menjadi alasan untuk terus-menerus membiarkan asuhan lain tidak dilakukan. Jika missed care menjadi pola yang berulang, staffing perlu dievaluasi secara struktural.

Manajer juga perlu melakukan eskalasi kepada level manajemen yang lebih tinggi apabila kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan sumber daya unit. Kekurangan tenaga yang berisiko terhadap keselamatan bukan hanya tanggung jawab kepala ruang, tetapi merupakan isu organisasi.

WHO menekankan bahwa ketersediaan, distribusi, keterampilan, dan dukungan terhadap tenaga kesehatan merupakan elemen penting bagi kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan pelayanan berkualitas. Karena itu, kekurangan staf kronis perlu ditangani melalui perencanaan tenaga, bukan hanya perbaikan jadwal harian.

9. Prinsip Penyusunan Jadwal yang Adil dan Transparan

Jadwal yang adil merupakan jadwal yang menggunakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan bukan berarti setiap orang memperoleh susunan shift yang sama persis, karena kebutuhan pelayanan, kompetensi, dan kondisi individu berbeda.

Pembagian shift pagi, sore, malam, akhir pekan, dan hari libur sebaiknya memiliki mekanisme rotasi yang diketahui bersama. Tenaga tidak seharusnya

merasa bahwa shift yang kurang diminati selalu diberikan kepada orang tertentu tanpa alasan objektif.

Transparansi dapat dimulai dari kriteria penyusunan jadwal. Seluruh tenaga perlu memahami berapa kebutuhan minimum setiap shift, bagaimana skill mix ditentukan, bagaimana cuti diproses, bagaimana hari libur dibagikan, serta bagaimana pertukaran jadwal dilakukan.

Jadwal juga sebaiknya diterbitkan cukup awal agar tenaga memiliki kesempatan mengatur kebutuhan pribadi. Perubahan setelah jadwal terbit sebaiknya diminimalkan kecuali terdapat kebutuhan pelayanan yang nyata.

Keterlibatan staf dapat diterapkan dengan meminta preferensi sebelum roster disusun. Namun, preferensi bukan jaminan seluruh permintaan dapat dipenuhi. Kepala ruang tetap perlu memastikan bahwa pelayanan aman.

Self-scheduling terbatas dapat digunakan pada organisasi tertentu. Dalam sistem ini, tenaga diberikan kesempatan memilih beberapa shift, kemudian manajemen menyesuaikan agar kebutuhan unit tetap terpenuhi. Kelebihannya adalah tenaga memiliki rasa kontrol lebih besar, tetapi diperlukan aturan untuk mencegah terjadinya kekurangan staf pada shift tertentu atau terbentuknya pola kerja yang meningkatkan fatigue.

Keadilan juga berarti tidak membebankan akibat kekurangan staf secara terus-menerus kepada individu yang dianggap paling fleksibel. Tenaga yang selalu bersedia menggantikan rekan kerja dapat mengalami beban berlebih apabila manajemen menjadikannya sebagai solusi tetap.

Jadwal yang transparan perlu memiliki dokumentasi. Perubahan jadwal, pertukaran shift, penggunaan lembur, serta ketidakhadiran sebaiknya tercatat sehingga dapat dievaluasi.

10. Contoh Penyusunan Jadwal Dinas Perawat

Sebagai ilustrasi, suatu ruang rawat inap memiliki **15 orang perawat pelaksana** selain kepala ruang. Berdasarkan analisis pasien dan pola beban kerja, kebutuhan pelayanan harian ditetapkan sebagai berikut: shift pagi membutuhkan lima perawat, shift sore membutuhkan empat perawat, dan shift malam membutuhkan tiga perawat. Angka ini hanya contoh untuk menjelaskan proses penyusunan jadwal dan bukan standar staffing universal.

Sebelum roster dibuat, kepala ruang terlebih dahulu memetakan kompetensi. Misalnya, dari 15 tenaga terdapat lima perawat senior yang dapat menjalankan fungsi penanggung jawab shift, enam perawat dengan pengalaman menengah, dan empat tenaga baru yang masih membutuhkan supervisi.

Kepala ruang tidak hanya mengisi lima nama pada pagi, empat nama pada sore, dan tiga nama pada malam. Setiap kelompok perlu memiliki komposisi yang aman. Sedapat mungkin, tidak ada shift yang hanya diisi oleh tenaga baru.

Tabel 4.1: Contoh sederhana distribusi dapat ditulis sebagai berikut:

Hari	Shift Pagi	Shift Sore	Shift Malam
Senin	P1, P2, P3, P4, P5	P6, P7, P8, P9	P10, P11, P12
Selasa	P4, P5, P6, P7, P8	P9, P10, P11, P13	P12, P14, P15
Rabu	P1, P2, P3, P7, P8	P4, P5, P13, P14	P9, P10, P15
Kamis	P2, P3, P6, P11, P12	P1, P7, P8, P14	P4, P5, P13

Tabel tersebut hanya menggambarkan distribusi sederhana. Dalam penyusunan sebenarnya, kepala ruang masih perlu memeriksa rangkaian shift setiap individu. Misalnya, tenaga yang baru menyelesaikan shift malam sebaiknya tidak langsung ditempatkan pada shift pagi pada hari yang sama atau dengan interval istirahat yang tidak memadai.

Selanjutnya, perlu diperiksa pembagian hari libur. Tenaga yang telah menjalani beberapa hari kerja berturut-turut perlu memperoleh kesempatan pemulihan. Shift malam juga perlu didistribusikan secara proporsional, dengan memperhatikan tenaga yang memiliki kondisi atau kebijakan khusus.

Permintaan cuti yang telah disetujui kemudian dimasukkan ke dalam roster. Jika P3 memperoleh cuti selama dua hari, jadwal tidak cukup hanya menghapus nama P3. Kepala ruang harus memastikan bahwa tenaga penggantinya memiliki kompetensi yang sesuai dan bahwa penggantian tersebut tidak menyebabkan tenaga lain bekerja terlalu panjang.

Setelah draf selesai, jadwal perlu diperiksa dari beberapa perspektif. Pertama, apakah jumlah tenaga setiap shift telah memenuhi kebutuhan? Kedua, apakah skill mix pada setiap shift sesuai? Ketiga, apakah terdapat tenaga yang bekerja terlalu banyak hari berturut-turut? Keempat, apakah terdapat transisi shift yang memberikan waktu istirahat terlalu singkat? Kelima, apakah pembagian malam, akhir pekan, dan hari libur cukup adil? Keenam, apakah cuti dan pelatihan telah dimasukkan? Ketujuh, apakah tersedia mekanisme jika salah satu tenaga tidak hadir?

Dengan demikian, penyusunan jadwal sebaiknya dilakukan sebagai proses bertahap. Kepala ruang terlebih dahulu menentukan kebutuhan setiap shift, memetakan jumlah serta kompetensi tenaga, memasukkan cuti dan kegiatan yang sudah diketahui, mendistribusikan tenaga, memeriksa pola

rotasi dan waktu istirahat, kemudian melakukan evaluasi sebelum jadwal diterbitkan.

Setelah jadwal berjalan, evaluasi tetap diperlukan. Banyaknya lembur, perubahan roster, pertukaran shift, ketidakhadiran, keluhan tenaga, fatigue, missed nursing care, serta insiden pelayanan dapat menjadi indikator bahwa jadwal membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, roster bukan dokumen yang selesai ketika diterbitkan, melainkan salah satu instrumen manajemen yang perlu terus dievaluasi.

Pada akhirnya, penyusunan jadwal dinas dan pengelolaan shift merupakan proses yang mengintegrasikan kebutuhan pasien, beban kerja, staffing, skill mix, kompetensi, waktu istirahat, kebutuhan tenaga, serta kemampuan organisasi menyediakan pelayanan selama dua puluh empat jam. Jadwal yang baik bukan jadwal yang sekadar berhasil mengisi seluruh shift, melainkan jadwal yang mampu menyediakan tenaga dalam jumlah dan kompetensi yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, memberikan pembagian beban yang adil, memungkinkan tenaga memperoleh pemulihan yang memadai, serta memiliki mekanisme untuk menghadapi perubahan kebutuhan pelayanan. Dengan pengelolaan tersebut, scheduling dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, kesehatan tenaga keperawatan, dan keberlangsungan pelayanan.

M. Kelelahan Kerja dan Keselamatan dalam Sistem Shift

1. Pengertian Kelelahan Kerja atau Fatigue

Kelelahan kerja atau fatigue merupakan kondisi menurunnya kapasitas fisik, mental, dan kognitif akibat kebutuhan istirahat yang tidak terpenuhi, kualitas tidur yang buruk, jam kerja yang panjang, aktivitas kerja yang intensif, atau kombinasi berbagai tuntutan pekerjaan. Dalam pelayanan keperawatan, fatigue menjadi persoalan penting karena pekerjaan perawat membutuhkan konsentrasi, ketelitian, kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan, koordinasi, serta respons yang cepat terhadap perubahan kondisi pasien. Penurunan kemampuan pada salah satu aspek tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan.

Fatigue berbeda dengan rasa lelah biasa yang dapat hilang setelah beristirahat singkat. Kelelahan kerja dapat berkembang secara akut maupun kumulatif. Fatigue akut dapat muncul setelah satu periode kerja yang sangat panjang, shift malam, atau aktivitas dengan intensitas tinggi. Sementara itu, kelelahan kumulatif berkembang ketika tenaga berulang kali bekerja tanpa memperoleh waktu pemulihan yang mencukupi. Kondisi tersebut dapat terjadi

apabila seorang perawat menjalani rangkaian shift panjang, sering melakukan lembur, mengalami perubahan jadwal, atau terus-menerus kekurangan waktu tidur.

AHRQ menjelaskan fatigue sebagai rasa lelah dan penurunan energi yang dapat muncul akibat waktu tidur yang tidak mencukupi, kualitas tidur yang buruk, peningkatan intensitas pekerjaan, atau jam kerja yang panjang. Kurang tidur juga dapat mengganggu berbagai fungsi kognitif, termasuk suasana hati, motivasi, waktu respons, serta kemampuan mengambil inisiatif. Dalam pekerjaan pelayanan kesehatan yang menuntut penilaian terhadap situasi yang berubah dengan cepat, gangguan tersebut memiliki konsekuensi penting terhadap keselamatan.

Fatigue juga perlu dibedakan dari burnout dan compassion fatigue. Burnout merupakan kondisi yang berkaitan dengan stres kerja kronis dan dapat mencakup kelelahan emosional, penurunan keterlibatan terhadap pekerjaan, serta menurunnya rasa pencapaian profesional. Compassion fatigue lebih berkaitan dengan kelelahan emosional akibat keterpaparan berulang terhadap penderitaan atau trauma pasien. Fatigue dalam pembahasan sistem shift lebih berfokus pada penurunan kapasitas akibat jam kerja, kurang tidur, beban kerja, staffing, dan pola kerja. American Nurses Association dalam pernyataan tahun 2026 secara khusus membedakan nurse fatigue dari moral fatigue, compassion fatigue, maupun burnout.

Kelelahan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan kemampuan individu dalam mengatur tidur. ANA pada 2026 menempatkan fatigue sebagai persoalan keselamatan perawat dan pasien serta menekankan bahwa faktor organisasi seperti staffing, workload, jam kerja, sistem shift, lingkungan kerja, dan keputusan manajemen memiliki peran penting dalam terjadinya fatigue. Dengan demikian, pencegahan fatigue merupakan tanggung jawab bersama antara tenaga keperawatan dan organisasi pelayanan kesehatan.

Dalam manajemen keperawatan, pemahaman tersebut penting karena solusi terhadap fatigue tidak cukup hanya berupa anjuran agar perawat tidur lebih banyak. Apabila organisasi terus-menerus mengalami kekurangan tenaga, menggunakan lembur sebagai mekanisme rutin, atau menyusun jadwal tanpa memperhatikan waktu pemulihan, maka risiko fatigue akan tetap tinggi. Oleh sebab itu, fatigue perlu dikelola melalui pendekatan sistem.

2. Penyebab Kelelahan pada Tenaga Keperawatan

Kelelahan pada tenaga keperawatan dapat muncul akibat interaksi berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah durasi kerja yang panjang. Semakin lama seseorang terjaga dan melakukan aktivitas, semakin besar dorongan fisiologis untuk tidur. AHRQ menjelaskan bahwa dorongan tidur meningkat seiring lamanya waktu seseorang terjaga dan menjadi semakin kuat setelah periode terjaga yang panjang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi dan pengambilan keputusan.

Shift yang panjang dapat menyebabkan perawat bekerja selama periode ketika kapasitas fisik dan mental mulai menurun. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi penting karena tuntutan pekerjaan tidak selalu berkurang menjelang akhir shift. Pasien dapat mengalami perubahan kondisi tepat ketika tenaga telah bekerja dalam waktu lama.

Lembur merupakan faktor lain. Lembur dapat terjadi ketika tenaga diminta memperpanjang jam kerja setelah shift selesai atau masuk pada waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat. Dalam kondisi tertentu, lembur mungkin diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat. Namun, apabila menjadi mekanisme rutin untuk menutupi kekurangan tenaga, lembur dapat mengurangi waktu pemulihan dan meningkatkan akumulasi kelelahan. Bukti keselamatan menunjukkan peningkatan risiko kesalahan ketika perawat bekerja lebih dari 12 jam, melakukan overtime, atau tidak memperoleh waktu istirahat yang memadai.

Penyebab berikutnya adalah beban kerja yang tinggi. Perawat dapat menghadapi banyak pasien, pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi, peningkatan admisi dan pemulangan, kondisi klinis kompleks, tuntutan dokumentasi, koordinasi antarprofesi, serta berbagai tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Semakin tinggi intensitas pekerjaan, semakin besar energi fisik dan mental yang dibutuhkan.

Kekurangan staffing dapat memperburuk situasi. Ketika jumlah tenaga lebih sedikit daripada kebutuhan pelayanan, tenaga yang tersedia harus menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah lebih besar. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, kelelahan tidak lagi menjadi kejadian sementara, tetapi menjadi bagian dari pola kerja. ANA pada 2026 secara eksplisit mengaitkan nurse fatigue dengan jam kerja panjang, heavy patient workload, inadequate staffing, dan shiftwork.

Pola rotasi shift juga memengaruhi kelelahan. Perawat yang berpindah dari pagi ke sore, kemudian malam, harus menyesuaikan waktu tidur dan aktivitasnya. Tubuh manusia memiliki ritme sirkadian yang secara alami

dipengaruhi siklus terang dan gelap. Perubahan waktu kerja dapat menyebabkan waktu tidur tidak selaras dengan ritme fisiologis tubuh.

Waktu istirahat antarshift yang terlalu singkat merupakan faktor risiko berikutnya. Secara administratif, seorang perawat mungkin telah menyelesaikan satu shift dan kembali bekerja pada shift berikutnya setelah beberapa jam. Namun, waktu di antara kedua shift tidak seluruhnya menjadi waktu tidur. Tenaga masih membutuhkan waktu perjalanan, makan, mandi, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan diri untuk bekerja kembali. Akibatnya, waktu tidur aktual dapat jauh lebih sedikit.

Ketidakteraturan jadwal juga dapat meningkatkan fatigue. Jadwal yang sering berubah secara mendadak membuat tenaga sulit membentuk pola tidur yang stabil. Jika seseorang baru beradaptasi terhadap shift malam kemudian segera berpindah ke shift pagi, tubuh membutuhkan penyesuaian kembali.

Faktor lingkungan kerja turut memengaruhi. Pencahayaan yang kurang sesuai, kebisingan, suhu yang tidak nyaman, keterbatasan tempat beristirahat, tingginya tekanan lingkungan, serta interupsi yang terus-menerus dapat meningkatkan kelelahan.

Faktor pekerjaan emosional juga penting. Perawat berhadapan dengan pasien yang mengalami nyeri, kegawatan, kecemasan, kematian, dan konflik keluarga. Walaupun fatigue tidak identik dengan kelelahan emosional, tuntutan psikologis yang tinggi dapat memperberat pengalaman kelelahan secara keseluruhan.

Faktor individu seperti kondisi kesehatan, kualitas tidur di rumah, perjalanan menuju tempat kerja, tanggung jawab keluarga, kebiasaan tidur, konsumsi kafein, dan aktivitas di luar pekerjaan juga dapat memengaruhi fatigue. Namun, faktor individual tidak seharusnya digunakan untuk mengabaikan masalah sistem. Ketika fatigue terjadi secara luas pada tenaga di suatu organisasi, staffing, scheduling, dan kondisi kerja perlu ditinjau.

3. Dampak Kerja Shift terhadap Pola Tidur

Tidur memiliki hubungan erat dengan ritme sirkadian. Tubuh manusia secara fisiologis cenderung memiliki periode kewaspadaan lebih tinggi pada siang hari dan kecenderungan mengantuk pada malam hingga dini hari. Sistem shift, khususnya shift malam, memaksa tenaga bekerja pada periode ketika tubuh secara biologis mempersiapkan diri untuk tidur.

Perawat yang bekerja malam kemudian harus tidur pada siang hari. Tidur siang setelah shift malam sering kali memiliki kualitas berbeda dibandingkan

tidur malam. Cahaya, kebisingan lingkungan, aktivitas keluarga, suhu, dan berbagai kewajiban dapat menyebabkan tidur lebih mudah terganggu.

Akibatnya, jumlah waktu tidur dapat berkurang. Seseorang mungkin memiliki waktu delapan atau sembilan jam sebelum shift berikutnya, tetapi tidak berarti seluruh periode tersebut dapat digunakan untuk tidur. Kekurangan tidur dari satu hari kemudian dapat terakumulasi apabila tenaga menjalani beberapa shift secara berturut-turut.

AHRQ mencatat bahwa kurang tidur mengganggu fungsi seperti mood, motivasi, response time, dan initiative. Sebagian besar orang dewasa sehat membutuhkan tidur yang cukup untuk mempertahankan fungsi optimal, sementara gangguan tidur akut maupun kronis dapat menurunkan performa kognitif.

Gangguan ritme sirkadian juga dapat menyebabkan tenaga sulit tidur meskipun merasa lelah. Setelah pulang dari shift malam, tubuh mulai terpapar cahaya pagi yang memberikan sinyal biologis untuk meningkatkan kewaspadaan. Kondisi ini dapat membuat seseorang lebih sulit mempertahankan tidur panjang pada siang hari.

Rotasi shift memperumit situasi karena tubuh harus beradaptasi berulang kali. Perawat yang baru menyesuaikan pola tidur untuk shift malam kemudian kembali menjalani shift pagi harus mengubah waktu tidur sekali lagi.

Kualitas tidur juga dapat dipengaruhi kecemasan menjelang pekerjaan. Tenaga yang mengetahui akan menjalani shift dengan beban tinggi atau kekurangan staf dapat mengalami kesulitan tidur karena memikirkan pekerjaan berikutnya. Dengan demikian, hubungan antara shift dan tidur tidak hanya bersifat fisiologis, tetapi juga psikologis.

Gangguan tidur berulang dapat menciptakan sleep debt atau utang tidur. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi selama beberapa hari. Tidur tambahan pada satu hari belum tentu sepenuhnya mengembalikan fungsi yang terganggu apabila pola kekurangan tidur berlangsung lama.

Karena itu, manajemen shift perlu mempertimbangkan pola rotasi, panjang shift, jeda antardinas, dan jumlah hari kerja berturut-turut. Jadwal yang secara matematis berhasil menutup seluruh kebutuhan staffing belum tentu merupakan jadwal yang aman apabila menghasilkan waktu tidur yang tidak memadai.

4. Dampak Shift Malam terhadap Kondisi Fisik dan Psikologis

Shift malam memberikan tuntutan fisiologis yang berbeda karena tenaga harus tetap terjaga dan melakukan pekerjaan kompleks ketika kecenderungan

biologis untuk tidur meningkat. Penurunan kewaspadaan umumnya menjadi lebih nyata pada dini hari. Dalam periode tersebut, perawat tetap harus melakukan observasi pasien, pemberian terapi, dokumentasi, dan merespons keadaan darurat.

Dampak langsung yang dapat dirasakan meliputi rasa mengantuk, berkurangnya energi, penurunan kecepatan respons, kesulitan mempertahankan perhatian, serta menurunnya kemampuan konsentrasi. Tenaga juga dapat merasakan sakit kepala, gangguan pencernaan, atau rasa tidak nyaman akibat perubahan pola makan dan tidur.

Kerja malam dapat mengubah kebiasaan makan. Perawat mungkin makan pada waktu ketika tubuh biasanya beristirahat atau mengonsumsi makanan cepat saji karena pilihan makanan terbatas pada malam hari. Penggunaan kafein juga dapat meningkat untuk mempertahankan kewaspadaan.

Dalam jangka lebih panjang, ANA menyebut nurse fatigue dan kondisi kerja yang menyebabkannya berkaitan dengan spektrum gangguan kesehatan fisik dan mental. Karena itu, organisasi tidak seharusnya memandang kerja malam hanya sebagai konsekuensi rutin profesi, tetapi sebagai paparan kerja yang memerlukan pengelolaan risiko.

Dari sisi psikologis, perawat shift malam dapat mengalami perubahan mood, iritabilitas, penurunan motivasi, dan kesulitan berinteraksi secara optimal apabila mengalami kurang tidur. Kelelahan dapat membuat individu lebih mudah merasa frustrasi atau mengalami penurunan toleransi terhadap tekanan.

Kerja malam juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan keluarga. Perawat dapat tidur ketika anggota keluarga sedang aktif dan bekerja ketika keluarga sedang beristirahat. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat menyulitkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Namun, dampak shift malam tidak sama pada setiap individu. Beberapa tenaga dapat beradaptasi lebih baik dibandingkan tenaga lainnya. Faktor usia, kondisi kesehatan, kronotipe, tanggung jawab keluarga, lama perjalanan, kualitas lingkungan tidur, dan pengalaman bekerja malam dapat memengaruhi kemampuan adaptasi.

Karena respons individu berbeda, manajemen tetap perlu menggunakan prinsip keselamatan umum sekaligus memperhatikan kebutuhan spesifik tenaga. Sistem yang aman tidak mengasumsikan semua orang memiliki toleransi yang sama terhadap kerja malam.

5. Hubungan Kelelahan dengan Risiko Kesalahan Pelayanan

Kelelahan dapat memengaruhi berbagai fungsi yang sangat penting dalam pekerjaan keperawatan. Salah satunya adalah perhatian. Perawat perlu memperhatikan berbagai informasi secara simultan, mulai dari kondisi pasien, hasil pemeriksaan, terapi, jadwal pemberian obat, hingga informasi dari anggota tim.

Ketika fatigue meningkat, kemampuan mempertahankan perhatian dapat menurun. Individu dapat lebih mudah kehilangan fokus, melewatkan informasi, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses suatu kondisi.

Memori kerja juga dapat terpengaruh. Dalam pelayanan, perawat sering harus mengingat beberapa informasi dalam waktu singkat, misalnya perubahan dosis, instruksi baru, waktu pemeriksaan, atau prioritas tindakan. Kurang tidur dapat mengurangi kemampuan tersebut.

Waktu reaksi juga dapat melambat. Dalam keadaan kegawatdaruratan, keterlambatan beberapa detik atau menit dapat memiliki konsekuensi klinis.

Kemampuan mengambil keputusan dapat menurun karena fatigue mengganggu proses penilaian risiko dan situational awareness. AHRQ menekankan bahwa pekerjaan pelayanan kesehatan membutuhkan kemampuan menilai situasi yang berubah, memperkirakan kondisi berikutnya, mengenali konsekuensi tindakan, dan memperbarui rencana secara cepat—fungsi-fungsi yang sensitif terhadap kurang tidur dan fatigue.

Risiko kesalahan pemberian obat menjadi salah satu perhatian. Tinjauan tahun 2023 yang dirangkum AHRQ menelaah 38 studi mengenai fatigue dan medication administration errors atau near misses pada perawat. Sebanyak 31 studi melaporkan bahwa jam kerja panjang, shift work, overtime, dan/atau kualitas tidur yang buruk berkontribusi terhadap kesalahan pemberian obat atau kejadian nyaris cedera, walaupun metode pengukuran antarpenelitian berbeda.

Kelelahan juga dapat meningkatkan risiko kesalahan dokumentasi. Perawat yang berada pada akhir shift panjang dapat menunda dokumentasi, melewatkan informasi, atau melakukan kesalahan dalam memasukkan data.

Komunikasi dapat terganggu karena individu yang lelah cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk memproses percakapan kompleks. Pada saat handover, kondisi ini dapat menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan secara optimal.

Namun, fatigue tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya penjelasan ketika terjadi kesalahan. Keselamatan pasien merupakan hasil interaksi banyak faktor. Jika kesalahan terjadi pada tenaga yang lelah, organisasi tetap perlu

menilai staffing, scheduling, workflow, teknologi, komunikasi, supervisi, dan sistem lainnya.

6. Dampak Kelelahan terhadap Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien sangat bergantung pada kemampuan tenaga keperawatan melakukan surveillance secara terus-menerus. Perawat berada pada posisi penting untuk mengenali perubahan tanda vital, perubahan kesadaran, peningkatan nyeri, kesulitan bernapas, atau tanda deteriorasi lainnya.

Fatigue dapat mengurangi kewaspadaan terhadap perubahan kecil. Apabila perubahan tersebut terlambat dikenali, eskalasi pelayanan juga dapat tertunda.

Kesalahan pemberian obat merupakan salah satu risiko yang paling jelas, tetapi bukan satu-satunya. Kelelahan dapat memengaruhi kemampuan memeriksa identitas pasien, melakukan double check, mengikuti prosedur, berkomunikasi, serta mempertahankan perhatian pada tindakan yang membutuhkan ketelitian.

Fatigue juga dapat berkontribusi terhadap missed nursing care. Ketika tenaga bekerja dengan kapasitas menurun sekaligus menghadapi beban tinggi, beberapa aktivitas dapat tertunda. Aktivitas seperti mobilisasi, edukasi, pemantauan, atau dokumentasi dapat mengalami penundaan apabila tenaga harus memprioritaskan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak.

Studi mengenai tidur perawat menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih pendek sebelum shift berkaitan dengan penilaian yang lebih rendah terhadap budaya keselamatan pasien. Temuan tersebut memperkuat pentingnya memandang tidur sebagai salah satu komponen yang mendukung kemampuan tenaga memberikan pelayanan aman.

AHRQ menyimpulkan bahwa terdapat bukti peningkatan kesalahan keperawatan ketika shift berlangsung lebih dari 12 jam, ketika perawat bekerja overtime, atau ketika tenaga tidak memperoleh waktu istirahat yang memadai.

Dampak fatigue terhadap pasien juga dapat bersifat tidak langsung. Perawat yang sangat lelah mungkin memiliki waktu dan energi yang lebih sedikit untuk komunikasi terapeutik, edukasi, serta koordinasi dengan keluarga. Hal tersebut dapat memengaruhi pengalaman dan kepuasan pasien.

Karena itu, pengelolaan fatigue merupakan bagian dari program keselamatan pasien. Organisasi perlu menempatkan risiko kelelahan sejajar dengan risiko lain yang dapat diidentifikasi, dinilai, dan dikendalikan.

7. Dampak Kelelahan terhadap Keselamatan Perawat

Fatigue tidak hanya membahayakan pasien, tetapi juga tenaga keperawatan. Perawat yang lelah memiliki risiko lebih besar mengalami kesalahan saat menggunakan alat, cedera saat melakukan mobilisasi pasien, atau kecelakaan kerja karena konsentrasi berkurang.

Risiko lain terjadi setelah shift selesai. Perawat yang mengalami kantuk berat dapat menghadapi risiko selama perjalanan pulang, terutama apabila harus mengemudikan kendaraan setelah shift malam atau jam kerja panjang.

Kelelahan fisik dapat memengaruhi kemampuan mempertahankan postur dan teknik kerja yang aman. Pada pekerjaan yang melibatkan mobilisasi pasien, transfer, membungkuk, atau mengangkat beban, penurunan kekuatan dan konsentrasi dapat meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal.

Fatigue juga dapat memengaruhi kesehatan mental. Kurang tidur dapat memperburuk mood, meningkatkan iritabilitas, dan mengurangi kemampuan menghadapi stres. Jika kondisi berlangsung terus-menerus bersamaan dengan tuntutan kerja tinggi, kesejahteraan tenaga dapat semakin menurun.

Kelelahan kronis juga dapat berkontribusi terhadap ketidakhadiran. Tenaga yang terus bekerja dalam kondisi fatigue memiliki kemungkinan lebih besar membutuhkan waktu pemulihan atau mengalami masalah kesehatan yang mengurangi kemampuan bekerja.

Pada tingkat organisasi, kondisi tersebut dapat membentuk siklus. Kekurangan tenaga meningkatkan beban kerja, beban kerja meningkatkan fatigue, fatigue meningkatkan absensi atau turnover, dan berkurangnya tenaga kemudian meningkatkan beban bagi staf yang tersisa.

ANA pada 2026 karena itu menempatkan fatigue sebagai persoalan kesehatan dan keselamatan tenaga sekaligus keselamatan pasien dan menuntut pendekatan yang tidak bersifat menghukum ketika tenaga melaporkan bahwa dirinya terlalu lelah untuk bekerja secara aman.

8. Pencegahan dan Pengendalian Fatigue

Pencegahan fatigue sebaiknya dilakukan melalui pendekatan berlapis. Tingkat pertama adalah pencegahan pada organisasi. Rumah sakit perlu menyediakan staffing yang sesuai dengan beban pelayanan sehingga tenaga tidak secara rutin dipaksa mengandalkan lembur.

Perencanaan tenaga harus memasukkan kemungkinan cuti, sakit, pelatihan, dan perubahan beban pasien. Jika setiap ketidakhadiran segera menyebabkan kekurangan staf, maka sistem staffing terlalu rapuh.

Organisasi juga membutuhkan contingency staffing plan yang dapat digunakan ketika terjadi absensi mendadak atau peningkatan kebutuhan pasien. ANA memasukkan appropriate staffing, realistic workloads, pengaturan jam kerja, serta reliable contingency staffing plans sebagai bagian penting pencegahan fatigue.

Pengaturan jadwal merupakan intervensi penting berikutnya. Rangkaian shift perlu ditinjau agar tidak menghasilkan perubahan waktu kerja yang sangat cepat. Shift malam berturut-turut juga perlu dikelola secara hati-hati.

Waktu istirahat selama shift perlu dipertahankan. Perawat tidak seharusnya secara rutin kehilangan waktu makan atau istirahat karena kekurangan staf. Break yang memadai membantu mengurangi akumulasi kelelahan dan memberikan kesempatan pemulihan singkat.

AHRQ mencatat sejumlah strategi mitigasi fatigue yang telah direkomendasikan dalam keselamatan pelayanan kesehatan, antara lain risk assessment, handoff yang kuat, keterlibatan staf dalam desain jadwal, fatigue management plan, edukasi sleep hygiene, serta penyediaan lingkungan yang memungkinkan istirahat. Planned naps dan penggunaan kafein secara strategis juga telah dibahas sebagai pendekatan mitigasi, walaupun penerapannya perlu mengikuti kebijakan dan kondisi organisasi.

Edukasi tenaga tetap penting. Perawat perlu memahami tanda fatigue, seperti rasa mengantuk berat, sering menguap, kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, penurunan koordinasi, atau kesulitan mempertahankan perhatian.

Sleep hygiene dapat membantu tenaga memaksimalkan kualitas istirahat. Lingkungan tidur sebaiknya gelap, tenang, dan nyaman. Setelah shift malam, paparan terhadap gangguan dapat diminimalkan agar tenaga memperoleh tidur yang lebih baik.

Penggunaan kafein perlu dilakukan secara bijaksana. Kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan sementara, tetapi konsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu proses pemulihan.

Dukungan tim juga penting. Anggota tim perlu dapat menyampaikan bahwa mereka mengalami fatigue tanpa takut mendapat stigma. Budaya keselamatan memungkinkan tenaga meminta bantuan ketika kemampuan kerjanya menurun.

Manajer harus mampu mengenali tanda fatigue pada anggota tim. Jika seorang tenaga terlihat sangat mengantuk atau menunjukkan penurunan

kemampuan yang nyata, manajer perlu menilai risiko dan mempertimbangkan redistribusi tugas atau intervensi lainnya.

9. Pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Pengaturan waktu kerja menjadi komponen utama dalam pencegahan fatigue. Tujuannya bukan sekadar memenuhi jumlah jam kerja, tetapi memastikan pola kerja memungkinkan tenaga mempertahankan kewaspadaan dan memperoleh waktu pemulihan.

Panjang shift perlu dipertimbangkan. Shift panjang dapat memiliki keuntungan berupa lebih sedikit pergantian handover dan lebih banyak hari bebas kerja, tetapi dapat meningkatkan fatigue menjelang akhir periode. AHRQ melaporkan adanya peningkatan kesalahan keperawatan dalam situasi shift lebih dari 12 jam dan overtime.

Organisasi perlu berhati-hati ketika shift panjang dikombinasikan dengan lembur. Perawat yang telah bekerja 12 jam kemudian diminta memperpanjang pekerjaan menghadapi risiko kelelahan yang lebih besar dibandingkan tenaga yang baru memulai shift.

Jeda antarshift harus memungkinkan waktu tidur yang realistis. Menghitung jeda hanya berdasarkan selisih jam selesai dan mulai kerja tidak cukup. Perjalanan, makan, aktivitas rumah tangga, dan persiapan menuju tempat kerja mengurangi waktu yang tersedia untuk tidur.

Hari kerja berturut-turut juga perlu diperhatikan. Fatigue dapat terakumulasi ketika tenaga menjalani terlalu banyak shift tanpa hari pemulihan.

Setelah shift malam, waktu pemulihan perlu diberikan sebelum tenaga kembali ke jadwal pagi. Pergantian dari malam langsung menuju pola kerja pagi dalam interval singkat dapat mengurangi waktu tidur.

ANA pada posisi 2026 bahkan menyatakan ekspektasi jam kerja yang berkelanjutan perlu dibatasi dan menempatkan expected work hours tidak lebih dari 40 jam per minggu sebagai salah satu rekomendasi sistemik dalam konteks pencegahan nurse fatigue. Prinsip ini menekankan bahwa jam kerja harus dilihat sebagai faktor keselamatan, bukan hanya persoalan produktivitas.

Namun, penerapan jam kerja konkret tetap harus mengikuti regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan yang berlaku di wilayah serta fasilitas masing-masing. Prinsip utama dalam buku ajar adalah bahwa setiap tambahan jam kerja perlu dinilai dari konsekuensinya terhadap kapasitas fisik dan kognitif tenaga.

10. Strategi Menciptakan Sistem Shift yang Lebih Aman

Sistem shift yang aman dimulai dari staffing yang memadai. Penjadwalan tidak dapat memperbaiki kekurangan struktural tenaga. Jika unit membutuhkan delapan tenaga tetapi hanya memiliki enam tenaga yang tersedia secara rutin, perubahan pola shift hanya memindahkan kekurangan dari satu periode ke periode lain.

Strategi berikutnya adalah menggunakan data beban kerja. Jumlah tenaga pada pagi, sore, dan malam perlu didasarkan pada pola pasien, acuity, admisi, pemulangan, serta intensitas tindakan. Hal ini membuat jadwal lebih responsif terhadap kebutuhan aktual.

Skill mix harus dipastikan pada setiap shift. Shift malam tidak boleh hanya dianggap sebagai periode dengan jumlah tindakan yang lebih sedikit lalu diisi tenaga dengan pengalaman terbatas. Kondisi pasien dapat berubah kapan saja sehingga tenaga dengan kemampuan melakukan assessment, eskalasi, dan pengambilan keputusan harus tetap tersedia.

Desain jadwal sebaiknya meminimalkan perubahan cepat antarshift. Rotasi yang dapat diprediksi membantu tenaga menyesuaikan pola tidur. Jadwal juga sebaiknya diterbitkan cukup awal sehingga tenaga memiliki kesempatan merencanakan waktu pemulihan.

Organisasi dapat melibatkan tenaga dalam penyusunan jadwal. Partisipasi meningkatkan rasa kontrol dan memungkinkan kebutuhan individual dipertimbangkan. Namun, self-scheduling perlu memiliki batas yang mencegah staf memilih rangkaian kerja yang justru meningkatkan fatigue.

Sistem juga membutuhkan mekanisme menangani absensi. Float pool, tenaga cadangan, atau contingency staffing dapat membantu mencegah situasi di mana staf yang sudah bekerja panjang kembali dipanggil untuk menutup kekurangan.

Overtime perlu dipantau sebagai indikator. Tingginya penggunaan lembur bukan hanya persoalan biaya, tetapi dapat menjadi tanda bahwa staffing dasar tidak memadai.

Data fatigue juga dapat dimasukkan ke dalam indikator manajemen. Organisasi dapat memantau kejadian lembur, ketidakhadiran, sick leave, pergantian shift, insiden keselamatan pada periode tertentu, serta keluhan tenaga terkait kelelahan.

Handover perlu diperkuat terutama pada akhir shift panjang. Tenaga yang telah mengalami fatigue dapat mengalami penurunan konsentrasi, sehingga proses transfer informasi sebaiknya menggunakan struktur yang konsisten agar informasi penting tidak terlewat.

Kebijakan organisasi harus memungkinkan tenaga melaporkan fatigue tanpa rasa takut. ANA menekankan perlunya kondisi yang memungkinkan perawat mengenali dan melaporkan fatigue tanpa konsekuensi yang bersifat menghukum. Pendekatan ini sejalan dengan budaya keselamatan karena fokusnya adalah mengendalikan risiko sebelum terjadi cedera.

Pendidikan mengenai fatigue perlu diberikan kepada perawat dan manajer. Program NIOSH untuk perawat mengenai shift work dan long work hours secara khusus dikembangkan untuk membantu tenaga klinis dan administrator memahami risiko serta strategi mitigasi kelelahan. Program tersebut telah direvisi pada 2024.

Manajer keperawatan juga perlu memberikan contoh. Budaya yang menganggap bekerja tanpa istirahat sebagai tanda dedikasi dapat mendorong tenaga mengabaikan fatigue. Sebaliknya, budaya yang menghargai keselamatan akan mengakui bahwa istirahat merupakan bagian dari kesiapan profesional.

Evaluasi sistem shift perlu dilakukan secara berkala. Apabila suatu pola menghasilkan banyak keluhan, overtime, ketidakhadiran, pertukaran jadwal, atau insiden, manajemen perlu menilai kembali desainnya. Sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun tidak otomatis masih sesuai dengan kondisi pelayanan saat ini.

Pada akhirnya, kelelahan kerja dalam sistem shift bukan sekadar persoalan rasa mengantuk, tetapi merupakan risiko keselamatan yang dapat memengaruhi kemampuan fisik, kognitif, emosional, serta profesional tenaga keperawatan. Shift malam, jam kerja panjang, kekurangan tidur, staffing yang tidak memadai, beban kerja tinggi, lembur, dan waktu pemulihan yang terbatas dapat saling berinteraksi dan meningkatkan fatigue. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perhatian, komunikasi, waktu respons, pengambilan keputusan, pemberian obat, dokumentasi, dan kemampuan mendeteksi perubahan kondisi pasien.

Oleh karena itu, pengendalian fatigue harus dilakukan melalui pendekatan sistem yang mengintegrasikan staffing yang memadai, workload yang realistis, jadwal yang aman, waktu istirahat yang mencukupi, contingency staffing, edukasi, budaya pelaporan yang tidak menghukum, serta evaluasi berkelanjutan. Perawat juga memiliki tanggung jawab untuk mengenali kondisi dirinya dan menggunakan waktu pemulihan secara baik, tetapi organisasi tetap memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan tenaga bekerja secara aman. Dengan sistem shift yang dirancang berdasarkan kebutuhan pelayanan sekaligus batas fisiologis manusia, organisasi dapat

melindungi kesehatan tenaga keperawatan sekaligus mempertahankan mutu dan keselamatan pasien.

N. Evaluasi dan Optimalisasi Staffing dan Scheduling

1. Tujuan Evaluasi Staffing dan Scheduling

Evaluasi staffing dan scheduling merupakan proses sistematis untuk menilai apakah jumlah, komposisi, distribusi, penempatan, dan pengaturan waktu kerja tenaga keperawatan telah sesuai dengan kebutuhan pasien dan tuntutan pelayanan. Evaluasi diperlukan karena kebutuhan tenaga keperawatan bersifat dinamis. Jumlah pasien, tingkat ketergantungan, kompleksitas kondisi klinis, pola admisi dan pemulangan, kompetensi tenaga, teknologi, serta kapasitas unit dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, staffing dan scheduling yang pernah dianggap sesuai belum tentu tetap efektif ketika kondisi pelayanan mengalami perubahan.

Tujuan utama evaluasi adalah memastikan bahwa tenaga yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan pelayanan secara aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Evaluasi tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai apakah jumlah tenaga sudah cukup, tetapi juga apakah tenaga ditempatkan pada unit yang tepat, apakah komposisi kompetensi pada setiap shift sesuai, apakah beban kerja terdistribusi secara proporsional, serta apakah jadwal memberikan kesempatan istirahat yang memadai.

Evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan tenaga dan kondisi aktual. Suatu unit dapat secara administratif memiliki jumlah tenaga sesuai formasi, tetapi dalam praktik masih sering mengalami kekurangan staf karena tingkat ketidakhadiran tinggi, cuti yang tidak terantisipasi, pelatihan, turnover, atau penggunaan tenaga untuk tugas lain. Sebaliknya, terdapat kemungkinan suatu unit memiliki jumlah tenaga relatif besar tetapi produktivitas dan distribusinya belum optimal.

Evaluasi staffing dan scheduling juga bertujuan menilai dampak pengelolaan tenaga terhadap mutu pelayanan. Jumlah tenaga, skill mix, beban kerja, panjang shift, penggunaan lembur, dan tingkat kelelahan dapat memengaruhi kemampuan perawat memberikan pelayanan secara lengkap dan tepat waktu. Oleh sebab itu, evaluasi SDM perlu dihubungkan dengan indikator mutu dan keselamatan pasien, bukan dilakukan secara terpisah.

American Nurses Association menempatkan evaluasi sebagai salah satu prinsip utama dalam staffing. Evaluasi staffing seharusnya mempertimbangkan indikator keselamatan pasien serta luaran klinis, administratif, dan operasional yang relevan dengan masing-masing area pelayanan.

Evaluasi juga menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Data hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen, redistribusi tenaga, pengembangan kompetensi, perubahan pola shift, pengurangan lembur, penyempurnaan sistem penjadwalan, maupun penyesuaian metode penugasan. Dengan demikian, evaluasi bukan aktivitas administratif di akhir periode, melainkan bagian dari siklus manajemen SDM yang mendukung perbaikan berkelanjutan.

2. Evaluasi Kecukupan Jumlah Tenaga

Kecukupan jumlah tenaga merupakan salah satu komponen utama yang perlu dievaluasi. Namun, penilaian kecukupan tidak seharusnya hanya membandingkan jumlah perawat yang dimiliki dengan jumlah formasi. Evaluasi harus melihat apakah jumlah tenaga yang benar-benar tersedia pada setiap shift mampu memenuhi kebutuhan pasien.

Salah satu langkah awal adalah membandingkan kebutuhan tenaga yang telah dihitung dengan jumlah tenaga aktual. Jika hasil analisis kebutuhan menunjukkan suatu unit memerlukan 30 perawat, tetapi hanya tersedia 25 tenaga aktif, maka terdapat kesenjangan yang perlu ditangani. Namun, analisis tersebut perlu diperluas karena jumlah tenaga yang tercatat dalam daftar kepegawaian belum tentu sama dengan jumlah tenaga efektif.

Tenaga dapat tidak tersedia karena cuti, sakit, pelatihan, pendidikan, tugas organisasi, atau alasan lain. Oleh karena itu, evaluasi perlu memperhatikan jumlah full-time equivalent atau kapasitas kerja efektif, bukan hanya jumlah individu.

Kecukupan tenaga juga perlu dinilai berdasarkan shift. Suatu unit dapat memiliki jumlah tenaga total yang cukup, tetapi mengalami kekurangan pada malam hari karena distribusi jadwal tidak seimbang. Sebaliknya, shift tertentu mungkin memiliki jumlah tenaga berlebih sementara shift lain selalu membutuhkan lembur atau bantuan tenaga dari unit lain.

Jumlah pasien dan tingkat ketergantungan harus menjadi bagian dari evaluasi. Dua shift dengan jumlah tenaga yang sama belum tentu memiliki tingkat kecukupan yang sama apabila acuity pasien berbeda. Ketika sebagian besar pasien membutuhkan perawatan total, kebutuhan tenaga meningkat dibandingkan ketika sebagian besar pasien relatif mandiri.

Perubahan turnover pasien juga perlu diperhatikan. Unit dengan banyak pasien masuk, pindah, dan pulang membutuhkan waktu lebih besar untuk pengkajian, dokumentasi, koordinasi, edukasi, serta persiapan pelayanan.

Karena itu, hanya menggunakan sensus pasien pada satu waktu dapat memberikan gambaran yang kurang lengkap.

WHO dalam State of the World's Nursing 2025 menekankan bahwa tenaga keperawatan perlu tersedia secara memadai, didistribusikan secara adil, dan didukung oleh kondisi kerja yang memungkinkan pelayanan kesehatan berlangsung efektif. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tenaga perlu mempertimbangkan ketersediaan sekaligus distribusi dan kondisi kerja.

Kecukupan staffing juga dapat dinilai melalui indikator tidak langsung. Tingginya lembur, frequent call-in, staf yang sering dipindahkan antarunit, kepala ruang yang terus-menerus harus menggantikan perawat pelaksana, atau meningkatnya missed nursing care dapat menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga belum terpenuhi meskipun secara administratif jumlah staf terlihat cukup.

Evaluasi perlu dilakukan pada beberapa periode, bukan hanya satu hari. Beban pelayanan dapat berubah antara hari kerja dan akhir pekan, musim tertentu, atau periode ketika tingkat hunian meningkat. Data beberapa bulan memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan pengamatan singkat.

3. Evaluasi Distribusi dan Penempatan Tenaga

Setelah jumlah tenaga dinilai, langkah berikutnya adalah mengevaluasi distribusi dan penempatannya. Permasalahan SDM tidak selalu berupa kekurangan jumlah tenaga secara keseluruhan. Kadang-kadang masalah utama justru berasal dari distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Distribusi dapat dievaluasi antarunit maupun antarshift. Unit dengan acuity tinggi seharusnya memperoleh alokasi tenaga yang sebanding dengan beban pelayanannya. Tidak tepat jika distribusi hanya berdasarkan jumlah tempat tidur tanpa mempertimbangkan kompleksitas pasien.

Evaluasi juga harus memperhatikan skill mix. Sebuah shift yang diisi enam orang perawat belum tentu memiliki kapasitas yang sama dengan shift lain yang juga diisi enam orang apabila pengalaman dan kompetensinya berbeda. Komposisi tenaga perlu memastikan adanya tenaga yang mampu melakukan assessment, mengambil keputusan klinis, mengoordinasikan pelayanan, serta memberikan supervisi.

Penempatan tenaga baru juga perlu dievaluasi. Apabila terlalu banyak tenaga baru ditempatkan dalam satu shift atau satu unit tanpa supervisi yang cukup, beban tenaga senior dapat meningkat. Keadaan ini dapat

menyebabkan jumlah tenaga terlihat mencukupi secara numerik tetapi kapasitas efektif tim tetap terbatas.

Evaluasi penempatan dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian kompetensi terhadap karakteristik unit. Tenaga yang ditempatkan pada unit intensif, gawat darurat, perioperatif, neonatal, atau unit khusus lainnya membutuhkan kemampuan yang relevan. Penempatan tidak boleh hanya didasarkan pada adanya kekosongan jadwal.

Distribusi antarshift juga perlu memperhatikan beban waktu. Jika hampir seluruh tenaga berpengalaman ditempatkan pada pagi hari sementara shift malam didominasi tenaga baru, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko. Pasien tetap dapat mengalami deteriorasi pada malam hari sehingga kompetensi klinis harus tersedia selama seluruh periode pelayanan.

Evaluasi juga dapat melihat frekuensi redistribusi atau floating. Jika satu unit selalu meminta bantuan dari unit lain, kemungkinan terdapat ketidaksesuaian staffing dasar. Sebaliknya, unit yang terus-menerus dapat mengirim staf keluar mungkin memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding kebutuhan rata-ratanya.

Data distribusi tenaga dapat dikombinasikan dengan indikator volume pelayanan, acuity, overtime, absensi, dan mutu untuk menentukan apakah penempatan telah efektif.

4. Tingkat Absensi dan Keterlambatan

Absensi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi staffing karena ketidakhadiran langsung memengaruhi jumlah tenaga yang tersedia. Tingkat absensi yang tinggi dapat menyebabkan jadwal yang telah disusun menjadi tidak efektif, meningkatkan penggunaan lembur, memaksa redistribusi tenaga, dan meningkatkan beban perawat yang hadir.

Absensi perlu dibedakan antara ketidakhadiran yang telah direncanakan dan tidak direncanakan. Cuti tahunan, pendidikan, atau kegiatan organisasi dapat diantisipasi dalam jadwal. Sementara itu, sakit atau kondisi darurat pribadi biasanya lebih sulit diprediksi.

Data absensi sebaiknya dianalisis berdasarkan pola. Manajemen dapat menilai apakah ketidakhadiran lebih sering terjadi setelah rangkaian shift malam, pada unit tertentu, pada hari tertentu, atau pada periode dengan beban kerja tinggi. Pola tersebut dapat membantu mengidentifikasi akar masalah.

Tingkat absensi yang meningkat tidak seharusnya langsung dianggap sebagai masalah kedisiplinan. Absensi dapat berkaitan dengan kelelahan, kesehatan, burnout, beban kerja, ketidakpuasan, atau lingkungan kerja. Oleh karena itu, evaluasi perlu melihat konteks.

Keterlambatan juga perlu diperhatikan. Keterlambatan menyebabkan shift sebelumnya harus menunggu lebih lama atau menyebabkan jumlah tenaga pada awal shift berada di bawah kebutuhan. Jika sering terjadi, kontinuitas pelayanan dan proses handover dapat terganggu.

Manajemen perlu memiliki sistem pencatatan yang konsisten. Data absensi dan keterlambatan dapat dihitung setiap bulan dan dibandingkan antarperiode. Perubahan mendadak dapat menjadi sinyal adanya masalah yang perlu ditelusuri.

Namun, evaluasi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan perbaikan sistem. Ketika tingkat absensi meningkat, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya "siapa yang sering tidak hadir?", tetapi juga "apa yang terjadi dalam sistem kerja sehingga ketidakhadiran meningkat?".

5. Penggunaan Lembur

Lembur atau overtime sering digunakan untuk memenuhi kekurangan tenaga sementara. Dalam keadaan tertentu, lembur dapat membantu mempertahankan pelayanan ketika terjadi absensi mendadak atau peningkatan kebutuhan pasien. Namun, penggunaan lembur secara terus-menerus menunjukkan bahwa sistem staffing dasar mungkin belum memadai.

Evaluasi lembur dapat dilakukan dengan menghitung jumlah jam lembur setiap bulan, proporsi tenaga yang melakukan lembur, frekuensi lembur per individu, serta unit yang paling sering membutuhkan lembur.

Penggunaan lembur yang terkonsentrasi pada beberapa individu perlu mendapat perhatian. Tenaga yang sering bersedia mengambil shift tambahan dapat mengalami akumulasi fatigue. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan tenaga dan keselamatan pelayanan.

Lembur juga berkaitan dengan biaya. Dalam jangka pendek, menggunakan tenaga lembur mungkin tampak lebih mudah daripada merekrut tenaga baru. Namun, jika kebutuhan lembur bersifat kronis, biaya tambahan, kelelahan, absensi, dan turnover dapat membuat strategi tersebut kurang efisien dalam jangka panjang.

Evaluasi perlu membedakan lembur yang terjadi karena keadaan tidak terduga dengan lembur yang telah menjadi bagian rutin operasional unit. Jika

unit membutuhkan tambahan tenaga hampir setiap minggu, kebutuhan staffing seharusnya dihitung kembali.

Jam kerja panjang dan overtime juga perlu ditinjau dari aspek keselamatan. Bukti keselamatan pasien menunjukkan bahwa beban kerja, jam kerja panjang, dan fatigue dapat memengaruhi kemampuan tenaga melakukan pelayanan secara aman. Karena itu, penggunaan overtime tidak boleh dievaluasi semata-mata dari kemampuan menutup jadwal, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap performa tenaga.

6. Produktivitas Tenaga Keperawatan

Produktivitas tenaga keperawatan menggambarkan hubungan antara sumber daya tenaga yang digunakan dengan pelayanan atau luaran yang dihasilkan. Produktivitas tidak seharusnya dimaknai sebagai membuat perawat menangani sebanyak mungkin pasien dengan jumlah tenaga seminimal mungkin. Pendekatan seperti itu dapat mengabaikan kualitas pelayanan.

Produktivitas yang baik berarti tenaga digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan. Evaluasi dapat mempertimbangkan jumlah pasien yang dilayani, jam perawatan, tindakan, waktu pelayanan langsung, penggunaan sumber daya, serta berbagai indikator mutu.

Produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Kompetensi tenaga, tata ruang, ketersediaan alat, sistem dokumentasi, teknologi, kepemimpinan, koordinasi, jumlah staf pendukung, serta model penugasan semuanya dapat memengaruhi seberapa efektif waktu kerja digunakan.

Sebagai contoh, rendahnya waktu pelayanan langsung kepada pasien tidak selalu berarti tenaga kurang produktif. Perawat mungkin menghabiskan banyak waktu untuk dokumentasi berulang, mencari alat, menghubungi unit lain, atau melakukan tugas administratif. Dalam kondisi tersebut, perbaikan workflow dapat meningkatkan produktivitas tanpa menambah beban.

Evaluasi produktivitas karena itu harus melihat bagaimana waktu digunakan. Analisis dapat dilakukan melalui work sampling, time and motion study, atau data sistem informasi.

Produktivitas juga perlu dikaitkan dengan kualitas. Dua unit dapat memiliki jumlah pasien per perawat yang sama, tetapi unit dengan insiden keselamatan lebih rendah, dokumentasi lebih baik, dan kepuasan pasien lebih tinggi dapat menunjukkan efektivitas kerja yang lebih baik.

Penggunaan indikator produktivitas harus berhati-hati agar tidak mendorong perilaku yang berorientasi hanya pada kuantitas. Dalam keperawatan, beberapa aktivitas penting seperti komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan emosional tidak selalu mudah diukur dalam angka tetapi tetap memiliki nilai klinis.

7. Kepuasan Kerja Perawat

Kepuasan kerja merupakan indikator penting dalam mengevaluasi staffing dan scheduling karena pengalaman tenaga terhadap pekerjaan dipengaruhi langsung oleh beban kerja, jadwal, keadilan pembagian shift, kepemimpinan, kesempatan berkembang, serta dukungan organisasi.

Perawat yang merasa jumlah tenaga tidak memadai dapat mengalami tekanan karena harus terus memilih prioritas pelayanan. Perawat juga dapat mengalami ketidakpuasan apabila jadwal sering berubah tanpa pemberitahuan, sulit memperoleh cuti, terlalu banyak shift malam, atau harus sering menggantikan rekan kerja.

Keadilan scheduling memengaruhi persepsi terhadap organisasi. Jika shift malam, akhir pekan, dan hari libur dianggap selalu diberikan kepada tenaga tertentu, konflik dapat muncul. Sebaliknya, aturan yang transparan dan kesempatan menyampaikan preferensi dapat meningkatkan penerimaan terhadap jadwal.

Kepuasan juga berkaitan dengan kontrol terhadap waktu kerja. Sistem self-rostering atau electronic rostering pada beberapa konteks telah dikaitkan dengan peningkatan kontrol tenaga, kepuasan, dan work-life balance. Namun, tinjauan sistematis tahun 2024 juga menemukan bahwa self-rostering dapat menimbulkan masalah keadilan serta peningkatan permintaan perubahan shift atau overtime apabila tidak diatur dengan baik.

Pengukuran kepuasan dapat dilakukan melalui survei berkala, diskusi kelompok, wawancara, exit interview, maupun forum staf. Data tersebut dapat digunakan bersama indikator objektif seperti absensi dan turnover.

Penting untuk memahami bahwa kepuasan kerja bukan sekadar masalah kenyamanan. Ketidakpuasan kronis dapat memengaruhi motivasi, keterlibatan, hubungan antaranggota tim, serta keputusan untuk meninggalkan organisasi.

8. Turnover Tenaga Keperawatan

Turnover merupakan keluarnya tenaga dari unit atau organisasi dan menjadi salah satu indikator penting dalam manajemen SDM. Turnover dapat

terjadi karena pensiun, perpindahan tempat kerja, pendidikan, perubahan karier, kondisi keluarga, ketidakpuasan, atau berbagai faktor lainnya.

Tidak seluruh turnover dapat dicegah. Namun, tingkat turnover yang tinggi dan terus-menerus dapat mengindikasikan masalah dalam lingkungan kerja atau pengelolaan tenaga.

Dampak turnover tidak hanya berupa berkurangnya jumlah staf. Organisasi juga kehilangan pengalaman, pengetahuan tentang unit, kemampuan klinis, serta hubungan kerja yang telah terbentuk. Tenaga baru membutuhkan proses rekrutmen, orientasi, pelatihan, dan supervisi sebelum mampu bekerja secara mandiri.

Selama proses tersebut, tenaga berpengalaman dapat menerima beban tambahan sebagai preceptor atau pembimbing. Jika turnover tinggi, organisasi dapat memasuki siklus di mana staf senior terus-menerus membimbing tenaga baru sambil tetap memenuhi tanggung jawab pasien.

Evaluasi turnover perlu melihat siapa yang keluar dan dari unit mana. Kehilangan beberapa perawat dengan kompetensi khusus dapat memberikan dampak lebih besar daripada angka turnover yang sama pada komposisi lain.

Data exit interview dapat memberikan informasi penting mengenai alasan tenaga meninggalkan organisasi. Jika alasan yang berulang berkaitan dengan beban kerja, jadwal, kepemimpinan, atau keterbatasan pengembangan karier, manajemen dapat menggunakan informasi tersebut untuk perbaikan.

WHO 2025 menekankan bahwa investasi dalam pekerjaan keperawatan, kondisi kerja, pendidikan, kepemimpinan, dan retensi tenaga merupakan bagian penting dari penguatan workforce.

9. Dampak Staffing terhadap Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien

Staffing memiliki hubungan langsung dengan kemampuan perawat memberikan asuhan secara lengkap dan tepat waktu. Jumlah dan komposisi tenaga menentukan berapa banyak waktu yang tersedia untuk pengkajian, intervensi, monitoring, edukasi, komunikasi, dokumentasi, serta koordinasi pelayanan.

Ketika staffing tidak memadai, tenaga dapat menghadapi beberapa tuntutan secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, aktivitas yang dianggap paling mendesak diprioritaskan sementara kebutuhan lain dapat tertunda.

Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah missed nursing care. AHRQ menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang telah banyak

didokumentasikan antara kecukupan nurse staffing dengan berbagai patient outcomes dan menempatkan missed nursing care sebagai salah satu mekanisme yang dapat menghubungkan staffing dengan keselamatan.

Evaluasi mutu dapat mencakup kejadian jatuh, pressure injury, medication error, infeksi terkait pelayanan, keterlambatan respons, readmission tertentu, kepuasan pasien, serta berbagai indikator yang relevan dengan karakteristik unit.

Namun, hubungan staffing dengan mutu tidak sebaiknya ditafsirkan secara sederhana. Luaran pasien juga dipengaruhi kondisi klinis, teknologi, kepemimpinan, teamwork, kompetensi, protokol, lingkungan kerja, dan banyak faktor lainnya. Staffing merupakan salah satu bagian penting dari sistem tersebut.

Karena itu, evaluasi perlu mengintegrasikan data staffing dengan indikator mutu. Misalnya, manajemen dapat menilai apakah peningkatan insiden tertentu terjadi bersamaan dengan meningkatnya rasio pasien, absensi, overtime, atau penggunaan tenaga baru.

Evaluasi semacam ini lebih informatif dibandingkan melihat insiden secara terpisah. Jika berbagai indikator menunjukkan pola yang sama, organisasi dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan perubahan staffing.

ANA juga menekankan bahwa setiap setting pelayanan perlu memiliki pedoman staffing yang memperhatikan patient safety indicators serta luaran klinis dan operasional yang spesifik bagi area tersebut.

10. Pemanfaatan Teknologi dalam Penjadwalan

Perkembangan teknologi memungkinkan proses scheduling dilakukan secara lebih sistematis dibandingkan metode manual. Electronic rostering atau e-rostering merupakan penggunaan sistem digital untuk membantu menyusun, mengelola, memantau, dan melakukan perubahan jadwal tenaga.

Sistem penjadwalan elektronik dapat menyimpan informasi mengenai jumlah tenaga, kompetensi, kontrak kerja, pola shift, cuti, ketidakhadiran, preferensi jadwal, serta batasan jam kerja. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu penyusunan roster.

Salah satu manfaatnya adalah mengurangi pekerjaan administratif. Pada sistem manual, kepala ruang perlu memeriksa jadwal satu per satu dan memastikan tidak terjadi benturan. Sistem elektronik dapat memberikan

peringatan ketika tenaga dijadwalkan pada dua shift yang bertabrakan, melebihi jam tertentu, atau tidak memenuhi syarat tertentu.

Teknologi juga memungkinkan integrasi antara scheduling dengan data staffing. Sistem dapat memberikan gambaran jumlah tenaga yang tersedia pada setiap shift serta menunjukkan gap terhadap kebutuhan.

Electronic rostering juga dapat mendukung self-scheduling. Tenaga dapat mengajukan preferensi shift melalui sistem, kemudian manajer melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan unit. Namun, keputusan akhir tetap memerlukan pertimbangan klinis dan manajerial.

Tinjauan sistematis mixed-method tahun 2024 terhadap electronic dan self-rostering menemukan manfaat yang dilaporkan berupa efisiensi roster, peningkatan kepuasan dan rasa kontrol, work-life balance, retensi, penurunan absensi pada beberapa studi, serta efisiensi organisasi. Namun, hasil juga menunjukkan potensi masalah seperti ketidakadilan dalam self-rostering dan peningkatan overtime atau permintaan perubahan shift. Oleh karena itu, teknologi bukan pengganti tata kelola yang baik.

Teknologi juga dapat digunakan untuk analisis prediktif. Data historis mengenai tingkat hunian, pola kunjungan, acuity pasien, absensi, dan kebutuhan staffing dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga pada periode berikutnya.

Penggunaan kecerdasan buatan dalam manajemen keperawatan juga mulai berkembang. Tinjauan sistematis tahun 2024 menunjukkan bahwa teknologi berbasis AI telah digunakan untuk mendukung resource management, risk assessment, pengambilan keputusan, komunikasi, dan efisiensi administratif dalam manajemen keperawatan, meskipun kualitas bukti masih bervariasi dan implementasinya memerlukan pelatihan serta perhatian terhadap persoalan etika.

Namun, otomatisasi tidak boleh menghilangkan pertimbangan profesional. Sistem dapat menyarankan bahwa suatu shift telah memiliki enam orang staf, tetapi tidak selalu memahami konteks klinis secara lengkap. Kepala ruang tetap perlu memeriksa apakah keenam tenaga tersebut memiliki kombinasi kompetensi yang sesuai.

Data pribadi tenaga juga harus dilindungi. Sistem penjadwalan dapat menyimpan informasi sensitif terkait cuti, kesehatan, dan pola kerja. Karena itu, pengelolaan akses dan keamanan data menjadi bagian penting dalam implementasi teknologi.

11. Strategi Perbaikan Staffing dan Scheduling

Perbaikan staffing dan scheduling perlu didasarkan pada masalah yang ditemukan melalui evaluasi. Tidak semua masalah membutuhkan penambahan jumlah tenaga. Beberapa masalah dapat berasal dari distribusi yang tidak tepat, workflow yang tidak efisien, kompetensi yang tidak merata, atau desain jadwal yang kurang baik.

Jika masalah utama adalah kekurangan jumlah tenaga secara konsisten, organisasi perlu mempertimbangkan rekrutmen, pengembangan tenaga yang tersedia, redistribusi, atau strategi retensi.

Jika jumlah tenaga sebenarnya cukup tetapi distribusinya tidak seimbang, manajemen dapat melakukan perubahan alokasi antarunit atau antarshift. Data acuity dan beban kerja menjadi dasar yang lebih baik daripada membagi tenaga secara sama rata.

Perbaikan skill mix dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi. Tenaga dapat mengikuti pelatihan agar unit tidak terlalu bergantung pada beberapa staf senior. Cross-training juga dapat meningkatkan fleksibilitas untuk kondisi tertentu selama tetap sesuai kewenangan klinis.

Sistem float pool dapat dikembangkan untuk membantu unit yang mengalami fluktuasi kebutuhan. Tenaga float sebaiknya dipersiapkan dan memiliki kompetensi untuk bekerja pada beberapa unit yang telah ditentukan.

Penggunaan lembur perlu dikurangi apabila telah menjadi strategi rutin. Organisasi dapat menetapkan mekanisme monitoring terhadap jumlah jam overtime dan melakukan analisis ketika suatu unit melewati batas internal tertentu.

Scheduling dapat diperbaiki dengan meningkatkan prediktabilitas. Jadwal yang diterbitkan lebih awal membantu tenaga mengatur kehidupan pribadi dan mengurangi permintaan perubahan mendadak.

Partisipasi tenaga juga dapat ditingkatkan. Kepala ruang dapat mengumpulkan preferensi staf sebelum jadwal dibuat. Namun, kebutuhan pelayanan dan keadilan tetap menjadi pertimbangan utama.

Teknologi dapat digunakan untuk mengurangi beban administratif dan mendeteksi konflik jadwal. Tetapi sistem harus dikonfigurasi sesuai aturan kerja dan kebutuhan klinis organisasi.

Workflow juga perlu dievaluasi. Jika banyak waktu perawat digunakan untuk tugas nonkeperawatan, organisasi dapat mempertimbangkan dukungan administrasi atau perubahan proses. Optimalisasi tidak selalu berarti menambah perawat; dapat pula berarti memastikan waktu perawat digunakan untuk pekerjaan yang memang membutuhkan kompetensi keperawatan.

Pengembangan lingkungan kerja yang sehat juga menjadi bagian dari strategi. Retensi tenaga lebih mungkin dicapai apabila tenaga merasa didukung, memiliki kesempatan berkembang, memperoleh supervisi yang baik, serta bekerja dalam beban yang realistis.

WHO 2025 menekankan perlunya investasi yang berkelanjutan pada pendidikan, pekerjaan, pelayanan, kondisi kerja, dan kepemimpinan keperawatan. Optimalisasi staffing karena itu perlu dipandang sebagai investasi terhadap kapasitas pelayanan, bukan sekadar komponen pengeluaran.

12. Evaluasi dan Perbaikan secara Berkelanjutan

Staffing dan scheduling perlu dikelola menggunakan prinsip continuous improvement. Proses tidak berhenti ketika kebutuhan tenaga telah dihitung atau jadwal bulanan telah diterbitkan. Kondisi aktual perlu dipantau, hasil dievaluasi, masalah diidentifikasi, kemudian dilakukan perbaikan.

Siklus evaluasi dapat dimulai dengan pengumpulan data. Data dapat mencakup jumlah pasien, acuity, jumlah tenaga, jam kerja, lembur, absensi, keterlambatan, cuti, turnover, pertukaran shift, penggunaan float staff, missed care, insiden keselamatan, kepuasan pasien, dan kepuasan tenaga.

Data tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola. Sebagai contoh, jika overtime selalu meningkat pada akhir pekan, manajemen perlu menilai apakah staffing akhir pekan terlalu rendah. Jika absensi meningkat setelah rangkaian shift malam, desain rotasi perlu dievaluasi. Jika satu unit memiliki turnover lebih tinggi daripada unit lain, lingkungan kerja unit tersebut perlu dikaji.

Tahap berikutnya adalah menentukan akar masalah. Organisasi perlu menghindari solusi yang hanya mengatasi gejala. Misalnya, tingginya lembur tidak selalu diselesaikan dengan melarang lembur. Jika penyebabnya adalah kekurangan tenaga, pelarangan tanpa penambahan kapasitas justru dapat menyebabkan kekurangan staffing.

Setelah akar masalah diketahui, dilakukan intervensi. Intervensi dapat berupa perubahan distribusi tenaga, penambahan staf, pengembangan kompetensi, revisi pola jadwal, pembentukan float pool, perbaikan proses cuti, penerapan e-rostering, atau perubahan workflow.

Hasil intervensi kemudian perlu diukur kembali. Jika dilakukan perubahan pola shift, manajemen dapat membandingkan absensi, lembur, keluhan staf, dan indikator mutu sebelum dan setelah perubahan.

Pendekatan tersebut dapat mengikuti prinsip Plan–Do–Study–Act. Pada tahap Plan, organisasi menentukan masalah dan rencana perbaikan. Tahap Do merupakan pelaksanaan perubahan. Tahap Study digunakan untuk menilai hasil berdasarkan data. Tahap Act menentukan apakah perubahan perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau dihentikan.

Benchmarking juga dapat digunakan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Perbandingan dengan unit atau rumah sakit lain perlu mempertimbangkan perbedaan pasien, jenis pelayanan, teknologi, skill mix, dan sistem kerja. Angka staffing yang efektif di satu tempat belum tentu langsung dapat diterapkan di tempat lain.

Keterlibatan tenaga penting dalam evaluasi. Perawat yang bekerja langsung di unit memiliki informasi mengenai masalah yang mungkin tidak terlihat dalam laporan angka. Pengalaman mereka dapat membantu menjelaskan mengapa jadwal tertentu sulit dijalankan atau mengapa beban pada suatu shift lebih tinggi daripada yang diperkirakan.

Evaluasi juga perlu dilaporkan kepada manajemen secara teratur. Informasi staffing tidak hanya penting bagi bidang keperawatan, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan anggaran, mutu, keselamatan, pengembangan layanan, dan strategi organisasi.

Pada akhirnya, evaluasi dan optimalisasi staffing dan scheduling merupakan proses yang menghubungkan kebutuhan pasien, kapasitas tenaga, kualitas lingkungan kerja, efisiensi organisasi, dan keselamatan pelayanan. Kecukupan jumlah tenaga perlu dinilai bersama distribusi, kompetensi, absensi, lembur, produktivitas, kepuasan, turnover, serta indikator mutu. Teknologi dapat membantu mengelola data dan penjadwalan, tetapi keputusan tetap membutuhkan penilaian profesional dan pemahaman terhadap kondisi klinis.

Optimalisasi tidak berarti mengurangi tenaga sebanyak mungkin atau membuat seluruh perawat bekerja pada kapasitas maksimum. Sistem yang terlalu ketat justru tidak memiliki cadangan ketika terjadi peningkatan kebutuhan, ketidakhadiran, atau perubahan kondisi pasien. Optimalisasi berarti menyediakan jumlah dan komposisi tenaga yang tepat, pada tempat dan waktu yang tepat, dengan beban kerja yang realistis, pola jadwal yang aman, serta sistem yang cukup fleksibel menghadapi variasi pelayanan.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berbasis data, organisasi dapat mendeteksi masalah lebih awal, mengurangi ketergantungan terhadap lembur, memperbaiki distribusi tenaga, meningkatkan kepuasan dan retensi perawat, serta mempertahankan mutu pelayanan. Dengan demikian,

evaluasi staffing dan scheduling bukan hanya bagian akhir dari proses manajemen SDM keperawatan, tetapi merupakan mekanisme pengendalian dan pembelajaran organisasi yang memastikan sistem tenaga terus berkembang sesuai perubahan kebutuhan pasien dan pelayanan.

O. Latihan Soal

Soal 1

Seorang kepala ruang penyakit dalam menerima laporan pada awal shift pagi. Terdapat 24 pasien yang dirawat oleh 5 perawat. Pada hari sebelumnya jumlah tersebut masih mencukupi. Namun, pagi ini 6 pasien mengalami penurunan kondisi dan membutuhkan pemantauan lebih sering, 5 pasien membutuhkan bantuan total, serta terdapat 3 pasien baru. Dua perawat yang bertugas merupakan perawat baru.

Apakah tindakan kepala ruang yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. Membagi pasien sama rata.
B. Mempertahankan jumlah tenaga yang tersedia.
C. Meningkatkan kecepatan kerja seluruh perawat yang bertugas.
D. Menambah tenaga sesuai tingkat ketergantungan dan kompetensi yang dibutuhkan.
E. Menunda pengkajian pasien baru sampai seluruh beban pelayanan di ruangan mengalami penurunan.

Kunci jawaban: D. Menambah tenaga sesuai tingkat ketergantungan dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pembahasan:

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah pasien. Meskipun jumlah pasien tidak mengalami perubahan yang sangat besar, kompleksitas pelayanan meningkat karena terdapat pasien yang mengalami penurunan kondisi, beberapa pasien membutuhkan bantuan total, dan terdapat pasien baru yang memerlukan pengkajian awal. Selain itu, dua perawat merupakan tenaga baru sehingga komposisi kompetensi atau *skill mix* juga harus diperhatikan.

Kepala ruang perlu melakukan penilaian kembali terhadap beban kerja dan menentukan apakah jumlah serta kompetensi tenaga yang tersedia masih mampu memenuhi kebutuhan pasien secara aman. Apabila tidak mencukupi, penambahan atau redistribusi tenaga yang memiliki kompetensi sesuai merupakan tindakan yang paling tepat.

Mengapa opsi lain tidak tepat?

A tidak tepat karena pembagian pasien secara sama rata belum tentu menghasilkan pembagian beban kerja yang seimbang. Pasien memiliki tingkat ketergantungan dan kompleksitas yang berbeda.
B tidak tepat karena jumlah tenaga yang sebelumnya cukup belum tentu tetap mencukupi setelah kondisi pasien berubah.
C tidak tepat karena meningkatkan kecepatan kerja bukan solusi terhadap peningkatan beban pelayanan dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko kesalahan.
E tidak tepat karena pengkajian pasien baru merupakan bagian penting dalam menentukan kondisi dan kebutuhan asuhan sehingga tidak seharusnya ditunda hanya karena staffing tidak memadai.

Soal 2

Seorang kepala ruang bedah menyusun penugasan shift malam. Terdapat 18 pasien, terdiri atas 4 pasien pascaoperasi yang membutuhkan pemantauan ketat, 8 pasien dengan ketergantungan sebagian, dan 6 pasien yang relatif mandiri. Empat perawat bertugas malam itu. Satu perawat telah bekerja selama 8 tahun, satu perawat berpengalaman 3 tahun, dan dua perawat lainnya masih baru serta membutuhkan supervisi.
Apakah pengaturan penugasan yang paling tepat?

A. Membagi pasien merata.
B. Memberikan pasien berat kepada perawat baru.
C. Menugaskan perawat senior hanya menangani pasien yang mandiri.
D. Menjadikan perawat senior sebagai penanggung jawab dan membagi pasien sesuai kompetensi.
E. Menugaskan setiap perawat melakukan satu jenis tindakan yang sama kepada seluruh pasien selama shift.

Kunci jawaban: D. Menjadikan perawat senior sebagai penanggung jawab dan membagi pasien sesuai kompetensi.

Pembahasan:

Penugasan tenaga harus mempertimbangkan *skill mix*, yaitu kombinasi kompetensi, pengalaman, pendidikan, dan kewenangan tenaga yang tersedia dalam satu shift. Pada kasus tersebut terdapat pasien pascaoperasi yang memerlukan observasi lebih ketat dan dua perawat baru yang masih membutuhkan supervisi.
Perawat senior sebaiknya berperan sebagai penanggung jawab shift sekaligus membantu memastikan pembagian pasien sesuai tingkat kompleksitas dan kompetensi masing-masing tenaga. Perawat baru tetap dapat diberikan tanggung

jawab terhadap pasien, tetapi perlu memperoleh pasien yang sesuai dengan tingkat kemampuan serta dukungan supervisi.

Mengapa opsi lain tidak tepat?

A tidak tepat karena jumlah pasien yang sama belum tentu menghasilkan beban kerja yang sama.

B tidak tepat karena pasien dengan kebutuhan kompleks tidak seharusnya diberikan kepada tenaga baru tanpa dukungan kompetensi dan supervisi yang memadai.

C tidak tepat karena kemampuan perawat senior justru diperlukan untuk mengelola kondisi pasien kompleks dan melakukan supervisi.

E kurang tepat karena metode fungsional berpotensi menyebabkan fragmentasi pelayanan dan tidak paling sesuai untuk kondisi pasien yang membutuhkan koordinasi klinis yang kuat.

Soal 3

Seorang perawat telah menjalani shift malam selama tiga hari berturut-turut. Pada akhir shift malam ketiga, satu perawat shift pagi mendadak sakit. Kepala ruang mempertimbangkan meminta perawat tersebut melanjutkan pekerjaan. Perawat menyampaikan bahwa dirinya sangat mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu bekerja dengan aman. Tersedia seorang perawat *float* yang memiliki kompetensi sesuai dengan unit.

Apakah tindakan kepala ruang yang paling tepat?

A. Meminta perawat melanjutkan shift.
B. Meminta perawat minum kopi terlebih dahulu.
C. Membagi pasien tambahan kepada seluruh staf yang hadir.
D. Mengizinkan perawat beristirahat dan menggunakan tenaga *float* yang kompeten.
E. Meminta perawat tetap bekerja dengan mengurangi dokumentasi serta beberapa aktivitas pelayanan yang dianggap tidak mendesak.

Kunci jawaban: D. Mengizinkan perawat beristirahat dan menggunakan tenaga float yang kompeten.

Pembahasan:

Perawat menunjukkan tanda fatigue berupa rasa mengantuk berat dan kesulitan berkonsentrasi setelah menjalani beberapa shift malam berturut-turut. Fatigue dapat menurunkan perhatian, waktu respons, kemampuan mengambil keputusan, dan ketelitian dalam pelayanan.

Karena tersedia tenaga *float* yang memiliki kompetensi sesuai, pilihan yang paling aman adalah menggunakan tenaga tersebut sebagai pengganti dan memberikan

kesempatan kepada perawat yang mengalami fatigue untuk memperoleh waktu pemulihan.

Mengapa opsi lain tidak tepat?

A tidak tepat karena memperpanjang waktu kerja tenaga yang telah mengalami fatigue dapat meningkatkan risiko kesalahan pelayanan.

B tidak tepat karena konsumsi kafein hanya dapat meningkatkan kewaspadaan sementara dan tidak menggantikan kebutuhan istirahat.

C tidak tepat karena pembagian beban kepada tenaga yang sudah bertugas dapat meningkatkan beban kerja seluruh tim.

E tidak tepat karena dokumentasi dan aktivitas keperawatan yang dibutuhkan pasien tidak boleh dikurangi sebagai cara mengatasi kekurangan tenaga.

Soal 4

Pada pukul 13.30, kepala ruang neurologi menerima informasi bahwa satu perawat shift sore tidak dapat hadir karena sakit. Shift sore seharusnya terdiri atas 4 perawat untuk merawat 20 pasien. Terdapat 5 pasien dengan risiko jatuh tinggi, 3 pasien membutuhkan bantuan total, dan 2 pasien baru direncanakan masuk. Ruang lain memiliki beban pelayanan lebih rendah dan terdapat seorang perawat yang pernah bertugas di ruang neurologi serta memiliki kompetensi yang sesuai.

Apakah tindakan kepala ruang yang paling tepat?

A. Menjalankan shift dengan tiga perawat.
B. Membagi seluruh pasien kepada tenaga yang tersedia.
C. Memanggil kembali perawat yang telah menyelesaikan shift pagi.
D. Meredistribusikan perawat kompeten dari unit dengan beban pelayanan lebih rendah.
E. Membatalkan seluruh penerimaan pasien baru tanpa terlebih dahulu menilai alternatif pemenuhan tenaga yang tersedia.

Kunci jawaban: D. Meredistribusikan perawat kompeten dari unit dengan beban pelayanan lebih rendah.

Pembahasan:

Ketidakhadiran mendadak perlu direspons dengan melakukan penilaian terhadap kebutuhan pasien, jumlah tenaga yang masih tersedia, *skill mix*, serta alternatif pengganti. Dalam kasus tersebut, jumlah pasien cukup banyak dan terdapat beberapa pasien dengan tingkat ketergantungan serta risiko tinggi.

Redistribusi tenaga dari unit yang memiliki beban lebih rendah dapat dilakukan apabila tenaga tersebut memiliki kompetensi yang relevan. Pada kasus ini, perawat yang tersedia pernah bekerja di ruang neurologi sehingga memiliki pengalaman dan kompetensi yang lebih sesuai.

Mengapa opsi lain tidak tepat?

A tidak tepat karena kondisi pasien menunjukkan bahwa berkurangnya satu tenaga dapat menyebabkan staffing berada di bawah kebutuhan.

B tidak tepat karena membagi seluruh beban kepada tiga tenaga tanpa menilai kecukupan dapat meningkatkan risiko overload.

C tidak tepat karena langsung memanggil tenaga yang baru selesai bekerja dapat memperpanjang jam kerja dan meningkatkan risiko fatigue.

E tidak tepat karena penghentian seluruh penerimaan pasien bukan tindakan pertama apabila masih tersedia alternatif staffing yang aman.

Soal 5

Seorang manajer keperawatan mengevaluasi pelayanan ruang rawat inap selama tiga bulan. Jumlah pasien relatif stabil, tetapi jam lembur terus meningkat. Tingkat absensi bertambah, pertukaran jadwal semakin sering, dua perawat mengundurkan diri, dan laporan *missed nursing care* meningkat pada shift malam. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perawat merasa jumlah tenaga malam kurang dan pola rotasi terlalu padat.

Apakah tindakan manajer keperawatan yang paling tepat?

A. Memberikan teguran kepada staf.
B. Membatasi seluruh pertukaran jadwal perawat.
C. Meningkatkan kewajiban lembur pada shift yang kekurangan tenaga.
D. Mengganti seluruh tenaga malam dengan perawat yang memiliki pengalaman lebih lama.
E. Mengevaluasi kembali kebutuhan tenaga, distribusi shift, beban kerja, dan pola scheduling berdasarkan data pelayanan.

Kunci jawaban: E. Mengevaluasi kembali kebutuhan tenaga, distribusi shift, beban kerja, dan pola scheduling berdasarkan data pelayanan.

Pembahasan:

Kasus menunjukkan masalah yang bersifat sistemik. Peningkatan lembur, absensi, pertukaran jadwal, turnover, dan *missed nursing care* yang muncul secara bersamaan menunjukkan bahwa staffing dan scheduling perlu ditinjau secara menyeluruh.

Manajer perlu menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi kecukupan jumlah tenaga, distribusi tenaga pada shift malam, beban kerja, *skill mix*, pola rotasi, serta waktu istirahat. Jika masalah berasal dari kekurangan tenaga atau pola scheduling yang tidak sesuai, intervensi perlu diarahkan pada akar masalah tersebut.

Mengapa opsi lain tidak tepat?

A tidak tepat karena masalah yang terjadi tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan disiplin individu.

B tidak tepat karena pertukaran jadwal dapat merupakan akibat dari pola scheduling yang tidak sesuai dan bukan penyebab utama.

C tidak tepat karena lembur sudah tinggi sehingga penambahan lembur berpotensi meningkatkan fatigue dan risiko keselamatan.

D tidak tepat karena masalah tidak hanya berkaitan dengan pengalaman tenaga malam, tetapi juga jumlah staf, distribusi, beban kerja, dan desain jadwal.

P. Rangkuman Materi

Manajemen sumber daya manusia keperawatan merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan, kompetensi, penempatan, distribusi, serta pengaturan waktu kerja tenaga keperawatan. Pengelolaan tenaga yang efektif tidak cukup hanya memastikan jumlah perawat tersedia, tetapi juga harus menjamin bahwa tenaga yang tepat dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai berada pada unit dan waktu yang tepat. Staffing dan scheduling merupakan dua komponen yang saling berkaitan, yaitu staffing menentukan jumlah, jenis, kompetensi, dan penempatan tenaga, sedangkan scheduling mengatur distribusi tenaga berdasarkan waktu kerja, shift, hari kerja, hari libur, cuti, dan kebutuhan pelayanan.

Perencanaan kebutuhan tenaga harus didasarkan pada kondisi nyata pelayanan. Jumlah pasien, tingkat ketergantungan, kompleksitas kondisi, volume tindakan, pola admisi dan pemulangan, karakteristik unit, kompetensi tenaga, serta waktu kerja efektif merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan. Analisis beban kerja membantu organisasi memahami hubungan antara tuntutan pelayanan dan kapasitas tenaga sehingga kebutuhan staf tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah tempat tidur atau rasio tenaga secara sederhana. Perhitungan kebutuhan tenaga selanjutnya perlu memperhitungkan jam perawatan pasien, norma waktu, volume kerja, cuti, pelatihan, izin, ketidakhadiran, serta berbagai aktivitas langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh perawat.

Pelaksanaan staffing juga harus memperhatikan skill mix, pengalaman, dan kewenangan klinis. Jumlah tenaga yang memadai secara numerik belum tentu menjamin pelayanan yang aman apabila komposisi kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Penempatan tenaga, redistribusi antarunit, serta pemilihan model penugasan perlu disesuaikan dengan karakteristik pasien dan pelayanan. Metode fungsional, metode tim, metode kasus, dan primary nursing memiliki kelebihan serta keterbatasan masing-masing sehingga tidak terdapat satu model penugasan yang dapat diterapkan secara sama pada seluruh unit. Pemilihan

model harus mempertimbangkan kompleksitas pasien, jumlah tenaga, kemampuan tim, kebutuhan kontinuitas asuhan, serta pola komunikasi dan koordinasi di unit pelayanan.

Scheduling tenaga keperawatan harus menjamin kontinuitas pelayanan selama dua puluh empat jam sekaligus memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan tenaga. Penyusunan jadwal perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap shift, skill mix, pola rotasi, waktu istirahat, pembagian hari libur, cuti, pertukaran jadwal, serta kemungkinan terjadinya ketidakhadiran mendadak. Jadwal yang baik tidak hanya ditandai dengan terisinya seluruh shift, tetapi juga oleh distribusi tenaga yang adil, transparan, fleksibel, dan sesuai dengan beban kerja. Penggunaan tenaga cadangan, float nurse, maupun redistribusi dapat menjadi strategi ketika terjadi kekurangan tenaga, tetapi tetap harus memperhatikan kompetensi dan keselamatan.

Kelelahan kerja atau fatigue menjadi salah satu risiko penting dalam sistem shift. Jam kerja yang panjang, shift malam berturut-turut, lembur, kurang tidur, perubahan jadwal yang cepat, serta waktu pemulihan yang tidak memadai dapat menurunkan kemampuan fisik dan kognitif perawat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perhatian, konsentrasi, komunikasi, dokumentasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan mengenali perubahan kondisi pasien. Oleh karena itu, pengendalian fatigue harus menjadi bagian dari sistem manajemen melalui staffing yang memadai, beban kerja yang realistis, pengaturan waktu kerja dan istirahat yang aman, contingency staffing, serta evaluasi pola shift secara berkala.

Evaluasi staffing dan scheduling perlu dilakukan secara berkelanjutan karena kebutuhan pelayanan dan kondisi tenaga selalu dapat berubah. Evaluasi harus mencakup kecukupan jumlah tenaga, distribusi dan penempatan, absensi, keterlambatan, penggunaan lembur, produktivitas, kepuasan kerja, turnover, missed nursing care, serta indikator mutu dan keselamatan pasien. Pemanfaatan teknologi seperti e-rostering dapat membantu pengelolaan jadwal dan analisis kebutuhan tenaga, tetapi keputusan tetap memerlukan pertimbangan profesional dan penilaian kondisi klinis. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki distribusi tenaga, pola jadwal, kompetensi, alur kerja, serta sistem pendukung lainnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, manajemen SDM keperawatan yang efektif menuntut keterpaduan antara perencanaan kebutuhan tenaga, analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan, staffing, skill mix, model penugasan, scheduling, pengendalian fatigue, serta evaluasi berkelanjutan. Seluruh proses tersebut harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pasien, kemampuan organisasi, dan kesejahteraan tenaga keperawatan. Pengelolaan tenaga yang tepat

akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan efektivitas dan produktivitas tenaga, menjaga kontinuitas asuhan, serta memperkuat mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Q. Daftar Pustaka

Agency for Healthcare Research and Quality. (2024a). *Fatigue, sleep deprivation, and patient safety*. PSNet.

Agency for Healthcare Research and Quality. (2024b). *Missed nursing care*. PSNet.

American Nurses Association. (n.d.). *Nurse staffing measures*.

American Nurses Association. (2019). *Principles for nurse staffing* (3rd ed.).

American Nurses Association. (2023, September 7). *Delegation in nursing: How to build a stronger team*.

American Nurses Association. (2026, May 27). *Addressing nurse fatigue to promote health, safety, and well-being for all* [Position statement].

Bell, T., Sprajcer, M., Flenady, T., & Sahay, A. (2023). Fatigue in nurses and medication administration errors: A scoping review. *Journal of Clinical Nursing, 32*(17–18), 5445–5460. doi: 10.1111/jocn.16620.

Drennan, J., Murphy, A., McCarthy, V. J. C., Ball, J., Duffield, C., Crouch, R., Kelly, G., Loughnane, C., Murphy, A., Hegarty, J., Brady, N., Scott, A., & Griffiths, P. (2024). The association between nurse staffing and quality of care in emergency departments: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies, 153*, Article 104706. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2024.104706.

Gonzalez-Garcia, A., Pérez-González, S., Benavides, C., Pinto-Carral, A., Quiroga-Sánchez, E., & Marqués-Sánchez, P. (2024). Impact of artificial intelligence-based technology on nurse management: A systematic review. *Journal of Nursing Management, 2024*, Article 3537964. doi: 10.1155/2024/3537964.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Mitchell, B. G., Gardner, A., Stone, P. W., Hall, L., & Pogorzelska-Maziarz, M. (2018). Hospital staffing and health care-associated infections: A systematic review of the literature. *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, 44*(10), 613–622. doi: 10.1016/j.jcjq.2018.02.002.

National Institute for Occupational Safety and Health. (2024). *NIOSH training for nurses on shift work and long work hours* (DHHS [NIOSH] Publication No. 2015-115, revised April 2024). Centers for Disease Control and Prevention. doi: 10.26616/NIOSHPUB2015115revised102023.

O'Connell, M., Barry, J., Hartigan, I., Cornally, N., & Saab, M. M. (2024). The impact of electronic and self-rostering systems on healthcare organisations and healthcare workers: A mixed-method systematic review. *Journal of Clinical Nursing, 33*(7), 2374–2387. doi: 10.1111/jocn.17114.

Phillips, J., Malliaris, A. P., & Bakerjian, D. (2021). Nursing and patient safety. *PSNet*. Agency for Healthcare Research and Quality.

Stimpfel, A. W., Fatehi, F., & Kovner, C. (2020). Nurses' sleep, work hours, and patient care quality, and safety. *Sleep Health, 6*(3), 314–320. doi: 10.1016/j.sleh.2019.11.001.

World Health Organization. (2023). *Workload indicators of staffing need (WISN): User manual* (2nd ed.).

World Health Organization. (2025a). *Health and care workforce planning tools: A rapid review* (Human Resources for Health Observer Series No. 29).

World Health Organization. (2025b). *State of the world's nursing report 2025*.

World Health Organization. (2025c). *Workload indicators of staffing need (WISN): Software manual*.

R. Glosarium

Acuity

Tingkat keparahan, kompleksitas kondisi, dan intensitas kebutuhan pelayanan seorang pasien yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan beban kerja dan kebutuhan tenaga keperawatan.

Beban Kerja Keperawatan

Keseluruhan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga keperawatan dalam periode tertentu, mencakup jumlah aktivitas, kompleksitas tugas, tanggung jawab, kebutuhan waktu, serta tuntutan fisik, mental, dan emosional.

E-Rostering

Sistem penjadwalan tenaga secara elektronik yang digunakan untuk membantu menyusun, mengelola, memantau, dan menyesuaikan jadwal kerja berdasarkan jumlah tenaga, kompetensi, pola shift, cuti, ketidakhadiran, dan kebutuhan pelayanan.

Fatigue

Kondisi penurunan kemampuan fisik, mental, dan kognitif akibat kurang tidur, jam kerja panjang, beban kerja tinggi, kerja shift, atau waktu pemulihan yang tidak memadai sehingga dapat memengaruhi keselamatan tenaga dan pasien.

Float Nurse

Perawat yang dipersiapkan untuk bekerja atau membantu pada beberapa unit pelayanan sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki, terutama ketika terjadi kekurangan tenaga atau peningkatan beban pelayanan.

Missed Nursing Care

Asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien tetapi terlambat dilakukan, hanya dilakukan sebagian, atau tidak dilakukan karena keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, staffing yang tidak memadai, atau faktor sistem lainnya.

Scheduling

Proses perencanaan dan pengaturan waktu kerja tenaga keperawatan yang mencakup pembagian shift, hari kerja, hari libur, cuti, rotasi, dan distribusi tenaga untuk menjamin kontinuitas pelayanan.

Skill Mix

Komposisi tenaga dalam suatu unit atau shift berdasarkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, kewenangan klinis, dan peran yang berbeda agar kebutuhan pasien dapat dipenuhi secara aman dan efektif.

Staffing

Proses menentukan jumlah, jenis, kompetensi, komposisi, distribusi, dan penempatan tenaga keperawatan berdasarkan kebutuhan pasien, beban kerja, dan karakteristik pelayanan.

Turnover

Perpindahan atau keluarnya tenaga keperawatan dari unit maupun organisasi akibat berbagai faktor, seperti pengunduran diri, mutasi, pensiun, pendidikan, atau ketidakpuasan kerja, yang dapat memengaruhi stabilitas dan kecukupan tenaga.

BAB 5

MANAJEMEN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENDIDIKAN

CPL-4	CPMK	Sub-CPMK
Mengelola SDM keperawatan meliputi staffing, scheduling, supervisi, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja.	CPMK 4: Mendesain pengorganisasian pelayanan dan pengelolaan SDM (model asuhan, staffing, scheduling) sesuai beban kerja dan kompetensi	5.1 Menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dan kompetensi 5.2 Menyusun jadwal dinas yang adil dan aman serta rencana penyesuaian saat kekurangan staf.
	CPMK 5: Menyusun rencana pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi serta mengintegrasikan aspek anggaran dan logistik unit.	6.1 Menetapkan indikator kinerja individu/tim dan mekanisme penilaian yang terukur. 6.2 Menyusun rencana pengembangan kompetensi (orientasi, pelatihan, preseptorship) berbasis gap kinerja

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menentukan mutu dan keselamatan pasien. Perawat tidak hanya dituntut mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, tetapi juga harus memiliki kinerja yang optimal sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pelayanan yang terus berkembang. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, keberhasilan organisasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam mengelola kinerja serta mengembangkan kompetensi tenaga keperawatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi menjadi aspek strategis dalam manajemen keperawatan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan masyarakat (Kewuan, 2018; Marquis & Huston, 2021)

Manajemen kinerja keperawatan pada dasarnya merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan setiap perawat mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi. Proses tersebut meliputi perencanaan kinerja, pemantauan, supervisi, evaluasi, pemberian umpan balik, hingga pengembangan kapasitas individu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target kerja, tetapi juga menekankan pengembangan profesionalisme dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Dalam praktiknya, manajemen kinerja membantu organisasi kesehatan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tenaga keperawatan sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat dalam meningkatkan produktivitas dan mutu pelayanan keperawatan (Muthmainnah, 2023 ; Gillies, 1994).

Perubahan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks menuntut perawat memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kompetensi perawat tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, kepemimpinan, kolaborasi interprofesional, dan pengambilan keputusan klinis. Kondisi tersebut menyebabkan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari praktik keperawatan profesional. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, supervisi klinik, dan continuing professional development (CPD) akan membantu perawat mempertahankan kualitas praktik sesuai standar profesi dan kebutuhan masyarakat (Metilda et al., 2026).

Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi utama dalam pengembangan sumber daya manusia keperawatan. Pendidikan tidak hanya bertujuan

meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap profesional, kemampuan analitis, serta keterampilan klinis yang mendukung pelayanan keperawatan bermutu. Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang dinamis, pelatihan berbasis kompetensi menjadi pendekatan penting untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelayanan dan perkembangan teknologi kesehatan. Program pelatihan yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan diri, motivasi kerja, dan kualitas pengambilan keputusan klinis perawat sehingga berdampak positif terhadap mutu pelayanan Kesehatan (Yustina et al., 2025 ; Darmojo et al., 2024).

Selain pendidikan formal dan pelatihan, pengembangan kompetensi perawat juga dipengaruhi oleh sistem pembinaan dan pengembangan karir dalam organisasi. Supervisi, coaching, mentoring, dan sistem jenjang karir (career ladder) menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja profesional di lingkungan pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut memungkinkan perawat memperoleh dukungan dalam meningkatkan kemampuan klinis maupun manajerial secara berkelanjutan. Lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional terbukti mampu meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas organisasi, dan retensi tenaga keperawatan. Sebaliknya, kurangnya dukungan pengembangan kompetensi dapat berdampak pada penurunan motivasi, burnout, serta rendahnya kualitas pelayanan keperawatan (Cherry & Jacob, 2018).

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan saat ini juga sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara objektif dan sistematis membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan tenaga keperawatan secara lebih tepat. Penilaian kinerja tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pengawasan semata, tetapi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan profesional bagi perawat. Pendekatan evaluasi yang konstruktif dapat mendorong perawat lebih reflektif terhadap praktik yang dilakukan serta meningkatkan komitmen terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan (Hughes, 2008).

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan kesehatan turut membawa perubahan dalam praktik manajemen keperawatan. Penggunaan electronic nursing documentation, sistem informasi rumah sakit, dan metode evaluasi berbasis elektronik menuntut tenaga keperawatan memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap teknologi. Perawat yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan lebih mudah meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi dokumentasi, serta koordinasi antarprofesi dalam pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu mendukung peningkatan literasi digital tenaga keperawatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan (Huber, 2021 ; Potter et al., 2020).

B. Konsep Manajemen Kinerja Keperawatan

1. Definisi Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja individu maupun kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, manajemen kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kerja, tetapi juga pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan pengembangan profesional tenaga kesehatan. Pendekatan ini menempatkan sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi yang perlu dikelola secara terencana dan berkelanjutan (Kewuan, 2018).

Dalam keperawatan, manajemen kinerja diartikan sebagai proses pengelolaan kinerja perawat melalui kegiatan perencanaan, supervisi, evaluasi, pemberian umpan balik, dan pengembangan kompetensi agar pelayanan keperawatan berjalan sesuai standar profesi dan kebutuhan pasien. Manajemen kinerja membantu organisasi kesehatan memastikan bahwa setiap perawat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, aman, dan bermutu. Sistem manajemen kinerja yang baik juga mendukung terciptanya budaya kerja yang produktif dan kolaboratif di lingkungan pelayanan kesehatan (Muthmainnah, 2023).

Manajemen kinerja keperawatan tidak hanya berfokus pada hasil kerja, tetapi juga pada proses kerja dan pengembangan kapasitas individu. Evaluasi kinerja dilakukan bukan semata-mata untuk menilai kelemahan tenaga keperawatan, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, manajemen kinerja memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kompetensi, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan profesionalisme perawat secara berkelanjutan.

2. Tujuan Manajemen Kinerja

Tujuan utama manajemen kinerja adalah memastikan bahwa seluruh tenaga keperawatan mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkualitas. Melalui manajemen kinerja, organisasi dapat menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan institusi sehingga setiap perawat memahami

peran dan kontribusinya terhadap mutu pelayanan kesehatan. Keselarasan tersebut penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelayanan keperawatan (Kewuan, 2018).

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen kinerja juga bertujuan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme perawat. Proses evaluasi dan supervisi membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pendidikan, maupun pengembangan karir tenaga keperawatan. Dengan adanya sistem pengembangan yang terarah, perawat dapat meningkatkan kemampuan klinis, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam praktik profesional (Muthmainnah, 2023).

Manajemen kinerja juga bertujuan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja perawat melalui pemberian umpan balik, penghargaan, dan pengembangan karir yang adil. Lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesional akan meningkatkan loyalitas, komitmen organisasi, dan retensi tenaga keperawatan. Pada akhirnya, manajemen kinerja yang efektif akan berdampak pada peningkatan keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Nursalam, 2022).

3. Fungsi Manajemen Kinerja dalam Pelayanan Keperawatan

Manajemen kinerja memiliki fungsi sebagai alat pengendalian mutu pelayanan keperawatan. Melalui proses monitoring dan evaluasi, organisasi dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan perawat telah sesuai dengan standar operasional prosedur, standar profesi, dan prinsip keselamatan pasien. Fungsi pengendalian ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan pelayanan serta meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara berkelanjutan (Seniwati et al., 2022).

Selain sebagai alat pengendalian mutu, manajemen kinerja juga berfungsi sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia keperawatan. Hasil evaluasi kinerja digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi, serta promosi jabatan. Dengan demikian, organisasi dapat merencanakan pengembangan tenaga keperawatan secara lebih sistematis dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan (Muthmainnah, 2023).

Fungsi lain dari manajemen kinerja adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja dalam organisasi pelayanan kesehatan. Proses supervisi dan pemberian umpan balik menciptakan interaksi yang lebih terbuka antara pimpinan dan staf keperawatan. Komunikasi yang efektif membantu membangun budaya kerja yang kolaboratif, meningkatkan motivasi kerja, dan

memperkuat komitmen profesional tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu (Shibiru et al., 2023).

4. Prinsip Manajemen Kinerja

a. Efektivitas

Efektivitas dalam manajemen kinerja mengacu pada kemampuan organisasi dan tenaga keperawatan dalam mencapai tujuan pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan keperawatan dikatakan efektif apabila asuhan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan pasien, meningkatkan keselamatan pasien, serta mencapai hasil pelayanan yang optimal. Dalam praktik keperawatan, efektivitas tidak hanya dinilai dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap kondisi pasien. Penerapan prinsip efektivitas memerlukan adanya standar kerja yang jelas, koordinasi yang baik antar tenaga kesehatan, serta dukungan sumber daya yang memadai sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai target mutu dan keselamatan pasien (Kewuan, 2018).

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan prinsip manajemen kinerja yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil pelayanan yang maksimal tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan keperawatan, efisiensi berkaitan dengan kemampuan mengelola waktu, tenaga, biaya, dan fasilitas secara tepat sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan berkualitas. Perawat dituntut mampu menentukan prioritas tindakan, mengatur beban kerja, dan melakukan koordinasi pelayanan secara efektif agar tidak terjadi pemborosan sumber daya maupun kelelahan kerja. Penerapan sistem kerja yang terorganisir dan berbasis standar akan membantu meningkatkan produktivitas pelayanan keperawatan secara efisien dan aman bagi pasien (Nursalam, 2022).

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap tindakan dan keputusan perawat harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, etik, dan hukum sesuai standar praktik keperawatan. Dalam pelayanan kesehatan, akuntabilitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, dokumentasi keperawatan yang lengkap dan akurat, serta pelaksanaan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Perawat yang memiliki akuntabilitas tinggi akan

bekerja secara hati-hati, menjaga integritas profesi, dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan yang dilakukan kepada pasien, organisasi, maupun profesi. Penerapan prinsip ini sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Kewuan, 2018).

d. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan prinsip penting dalam manajemen kinerja yang mencerminkan sikap, perilaku, kompetensi, dan tanggung jawab perawat dalam menjalankan praktik profesional sesuai standar etik dan profesi. Profesionalisme ditunjukkan melalui kemampuan memberikan pelayanan yang aman, komunikasi terapeutik yang baik, penghormatan terhadap hak pasien, serta komitmen terhadap pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Perawat profesional tidak hanya memiliki keterampilan klinis yang baik, tetapi juga mampu bekerja secara kolaboratif, menjaga etika profesi, dan menerapkan evidence based nursing dalam pelayanan kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan perlu mendukung profesionalisme tenaga keperawatan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, supervisi, dan pengembangan jenjang karir profesional (Shibiru et al., 2023).

e. Continuous Improvement

Continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip manajemen kinerja yang menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan secara terus-menerus untuk mencapai kualitas pelayanan yang lebih baik. Dalam pelayanan keperawatan, prinsip ini dilakukan melalui monitoring kinerja, audit keperawatan, refleksi praktik klinik, pengembangan kompetensi, serta penerapan inovasi pelayanan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Budaya continuous improvement membantu organisasi pelayanan kesehatan menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan, tenaga keperawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat budaya keselamatan pasien, dan menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih efektif serta profesional (Metilda et al., 2026).

5. Komponen Manajemen Kinerja

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dalam manajemen kinerja yang bertujuan menetapkan target kerja, standar pelayanan, indikator pencapaian, serta pembagian tugas tenaga keperawatan agar pelayanan berjalan terarah dan sesuai tujuan organisasi. Dalam praktik keperawatan, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasien, jumlah tenaga, beban kerja, dan standar keselamatan pasien sehingga pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. Perencanaan yang baik juga membantu meningkatkan koordinasi kerja, motivasi perawat, serta pencapaian mutu pelayanan kesehatan secara optimal (Muthmainnah, 2023).

b. Monitoring Kinerja

Monitoring kinerja merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian target kerja tenaga keperawatan secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar operasional prosedur dan indikator mutu yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan melalui supervisi klinik, observasi langsung, audit dokumentasi, maupun evaluasi kepatuhan terhadap SOP. Selain membantu mendeteksi hambatan atau penyimpangan pelayanan, monitoring juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan dukungan bagi perawat agar kualitas pelayanan, disiplin kerja, dan keselamatan pasien tetap terjaga (Kewuan, 2018).

c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi sistematis terhadap kemampuan, perilaku kerja, dan hasil pelayanan tenaga keperawatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan organisasi. Penilaian dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, audit dokumentasi, checklist kompetensi, peer review, dan evaluasi kepuasan pasien untuk mengetahui kualitas pelayanan serta tingkat pencapaian kerja perawat. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, promosi jabatan, maupun perbaikan mutu pelayanan sehingga membantu meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan (Muthmainnah, 2023).

d. Umpan Balik (Feedback)

Umpan balik merupakan informasi yang diberikan kepada tenaga keperawatan mengenai hasil kerja dan perilaku profesional selama menjalankan tugas sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja. Umpan

balik yang efektif harus disampaikan secara objektif, spesifik, komunikatif, dan berorientasi pada perbaikan sehingga dapat membantu perawat memahami kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Dalam pelayanan keperawatan, pemberian feedback yang suportif dapat meningkatkan motivasi kerja, rasa percaya diri, komunikasi profesional, dan komitmen terhadap mutu pelayanan serta keselamatan pasien (Shibiru et al., 2023).

e. Pengembangan Kinerja

Pengembangan kinerja merupakan proses peningkatan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme tenaga keperawatan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi pelayanan kesehatan. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, seminar, workshop, coaching, mentoring, maupun continuing professional development (CPD) untuk meningkatkan kemampuan klinis, manajerial, komunikasi, dan berpikir kritis perawat. Dukungan organisasi terhadap pengembangan kinerja sangat penting agar tenaga keperawatan mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi Kesehatan (Metilda et al., 2026).

6. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat

a. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Perawat yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih produktif, mampu bekerja sama dengan baik, serta memiliki kepedulian yang lebih besar terhadap kebutuhan pasien dan mutu pelayanan Kesehatan (Muthmainnah, 2023).

Motivasi kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penghargaan, lingkungan kerja, hubungan interpersonal, kesempatan pengembangan karir, dan dukungan pimpinan. Organisasi pelayanan kesehatan perlu menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan memberikan apresiasi terhadap kinerja perawat agar motivasi kerja tetap terjaga serta berdampak positif terhadap kualitas pelayanan keperawatan (Kewuan, 2018).

b. Beban Kerja

Beban kerja merupakan jumlah tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan perawat dalam periode tertentu sesuai kebutuhan pelayanan pasien. Beban kerja dipengaruhi oleh jumlah pasien, tingkat

ketergantungan pasien, kompleksitas tindakan keperawatan, dan ketersediaan tenaga keperawatan di unit pelayanan (Nursalam, 2022).

Beban kerja yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres kerja, kelelahan fisik dan emosional, penurunan konsentrasi, hingga burnout pada perawat. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu melakukan pengaturan tenaga, pembagian tugas yang adil, dan pengelolaan jadwal kerja secara seimbang agar pelayanan tetap berjalan optimal dan keselamatan pasien tetap terjaga (Muthmainnah, 2023).

c. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan kondisi fisik maupun nonfisik di tempat kerja yang memengaruhi pelaksanaan tugas tenaga keperawatan. Lingkungan fisik mencakup fasilitas pelayanan, keamanan kerja, pencahayaan, ventilasi, dan ketersediaan alat kesehatan, sedangkan lingkungan nonfisik meliputi komunikasi, budaya organisasi, hubungan interpersonal, dan dukungan pimpinan (Nursalam, 2022).

Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan meningkatkan produktivitas, motivasi, serta kualitas pelayanan keperawatan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang mendukung dapat memicu stres kerja, konflik interpersonal, dan penurunan kepuasan kerja sehingga berdampak pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Kewuan, 2018).

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tenaga keperawatan untuk mencapai tujuan organisasi pelayanan kesehatan. Dalam keperawatan, kepala ruang atau manajer keperawatan memiliki peran penting dalam mengatur pelayanan, memberikan supervisi, menyelesaikan konflik, serta membangun budaya kerja profesional (Muthmainnah, 2023)

Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan kepuasan kerja perawat sehingga berdampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang kurang komunikatif atau tidak adil dapat menurunkan semangat kerja dan memengaruhi kinerja tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien (Nursalam, 2022).

e. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman kerja sesuai standar praktik keperawatan. Kompetensi yang

baik sangat penting dalam mendukung kualitas asuhan keperawatan, keselamatan pasien, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan menuntut perawat untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, seminar, dan praktik berbasis evidence based nursing. Organisasi pelayanan kesehatan perlu mendukung pengembangan kompetensi agar tenaga keperawatan mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai kebutuhan pasien (Sitinjak et al., 2019).

f. Reward dan Remunerasi

Reward dan remunerasi merupakan bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada tenaga keperawatan atas kontribusi dan pencapaian kerja yang dilakukan. Reward dapat berupa penghargaan finansial maupun nonfinansial, sedangkan remunerasi berkaitan dengan sistem kompensasi yang diterima tenaga keperawatan sesuai tanggung jawab dan beban kerja yang dimiliki.

Sistem reward dan remunerasi yang adil dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas organisasi, dan kepuasan kerja tenaga keperawatan. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu menerapkan sistem penghargaan yang objektif, transparan, dan berbasis kinerja agar mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan (Muthmainnah, 2023).

7. Indikator Kinerja Perawat

a. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perawat karena berkaitan langsung dengan mutu asuhan keperawatan yang diterima pasien. Pelayanan yang berkualitas terlihat dari kemampuan perawat memberikan tindakan secara tepat, aman, responsif, serta sesuai kebutuhan pasien. Selain keterampilan klinis, kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh komunikasi terapeutik, kepedulian, dan kemampuan perawat membangun hubungan profesional dengan pasien dan keluarga sehingga tercipta rasa aman dan nyaman selama proses perawatan (Kewuan, 2018).

Kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada individu perawat, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan organisasi seperti fasilitas pelayanan, supervisi, pelatihan, dan budaya mutu yang diterapkan di tempat kerja. Organisasi pelayanan kesehatan perlu melakukan evaluasi

mutu secara berkala agar pelayanan tetap sesuai standar profesi dan kebutuhan pasien. Dengan kualitas pelayanan yang baik, tingkat kepuasan pasien akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terjaga (Marquis & Huston, 2017).

b. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja perawat karena pelayanan keperawatan memiliki hubungan langsung dengan risiko terjadinya kesalahan tindakan maupun kejadian tidak diharapkan. Dalam praktik pelayanan kesehatan, keselamatan pasien mencakup upaya mencegah kesalahan pemberian obat, infeksi nosokomial, pasien jatuh, maupun kesalahan identifikasi pasien. Perawat memiliki peran besar dalam menjaga patient safety karena menjadi tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan pasien selama proses perawatan berlangsung (Kewuan, 2018).

Kinerja perawat dalam aspek keselamatan pasien dapat dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penerapan hand hygiene, komunikasi efektif, serta kemampuan melaporkan insiden keselamatan pasien secara tepat. Budaya keselamatan pasien yang baik perlu didukung oleh organisasi melalui pelatihan, supervisi, dan sistem pelaporan yang tidak menyalahkan individu. Dengan budaya patient safety yang kuat, kualitas pelayanan kesehatan akan meningkat dan risiko kesalahan pelayanan dapat diminimalkan (Hughes, 2008).

c. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan catatan tertulis mengenai seluruh proses asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja perawat. Dokumentasi yang lengkap dan akurat mencerminkan tanggung jawab profesional perawat serta membantu memastikan kesinambungan pelayanan antar tenaga kesehatan. Selain sebagai alat komunikasi klinis, dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti hukum dan sumber informasi dalam evaluasi pelayanan pasien (Kozier et al., 2022).

Kinerja dokumentasi dapat dinilai dari kelengkapan pengkajian, ketepatan diagnosis keperawatan, implementasi tindakan, evaluasi, serta ketepatan waktu pencatatan. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat memicu kesalahan komunikasi dan menurunkan keselamatan pasien. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu melakukan audit dokumentasi dan pembinaan secara rutin agar proses pencatatan

dilakukan sesuai standar pelayanan keperawatan yang berlaku (Kewuan, 2018).

d. Kepatuhan SOP

Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perawat karena SOP berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan terstandar. Kepatuhan terhadap SOP terlihat dari kemampuan perawat menjalankan tindakan sesuai prosedur, menerapkan prinsip aseptik, menggunakan alat kesehatan secara benar, serta mengikuti aturan keselamatan pasien dalam setiap tindakan keperawatan (Gillies, 1994).

Kepatuhan SOP dipengaruhi oleh pengetahuan, motivasi kerja, supervisi, dan budaya organisasi di lingkungan pelayanan kesehatan. Organisasi perlu memberikan pelatihan berkala, monitoring, dan evaluasi kepatuhan agar seluruh tenaga keperawatan mampu menerapkan SOP secara konsisten. Dengan tingkat kepatuhan yang baik, risiko kesalahan pelayanan dapat ditekan dan mutu pelayanan kesehatan akan lebih terjamin (Muthmainnah, 2023).

e. Komunikasi Profesional

Komunikasi profesional merupakan kemampuan perawat dalam menyampaikan informasi secara jelas, terapeutik, dan etis kepada pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan lainnya. Dalam pelayanan keperawatan, komunikasi menjadi bagian penting karena memengaruhi hubungan terapeutik, kepuasan pasien, dan efektivitas kerja sama tim kesehatan. Perawat yang memiliki kemampuan komunikasi baik akan lebih mudah memahami kebutuhan pasien dan menciptakan suasana pelayanan yang nyaman dan manusiawi (Arnold & Boggs, 2019).

Komunikasi profesional juga sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien dan kualitas kolaborasi antarprofesi di rumah sakit. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan tindakan, hingga konflik dalam tim kesehatan. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga keperawatan melalui pelatihan, supervisi, dan penerapan budaya komunikasi efektif agar pelayanan kesehatan berjalan lebih aman dan berkualitas (Shibiru et al., 2023)

8. Metode Penilaian Kinerja

a. Checklist

Checklist merupakan metode penilaian kinerja yang menggunakan daftar indikator atau prosedur kerja untuk menilai apakah tindakan keperawatan telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam praktik keperawatan, checklist sering digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap SOP, penerapan patient safety, tindakan klinik, serta kelengkapan dokumentasi keperawatan. Metode ini banyak digunakan karena sederhana, mudah diterapkan, dan membantu memastikan setiap prosedur pelayanan dilakukan secara sistematis dan konsisten.

Meskipun praktis, checklist memiliki keterbatasan karena hanya menunjukkan ada atau tidaknya tindakan tanpa menggambarkan kualitas pelaksanaannya secara mendalam. Oleh karena itu, penggunaan checklist sebaiknya dikombinasikan dengan metode penilaian lain agar evaluasi kinerja tenaga keperawatan menjadi lebih objektif dan komprehensif. Dengan evaluasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan (Muthmainnah, 2023).

b. Rating Scale

Rating scale merupakan metode penilaian yang menggunakan skala nilai tertentu untuk mengukur tingkat kemampuan, perilaku kerja, dan pencapaian tenaga keperawatan. Dalam metode ini, penilai memberikan skor berdasarkan performa perawat, misalnya dalam aspek komunikasi terapeutik, keterampilan klinis, disiplin kerja, kerja sama tim, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan Kesehatan.

Metode rating scale membantu organisasi melihat tingkat pencapaian kerja perawat secara lebih rinci dibandingkan checklist. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan berupa kemungkinan munculnya subjektivitas penilai karena dipengaruhi persepsi pribadi atau hubungan interpersonal. Oleh sebab itu, organisasi perlu menetapkan indikator penilaian yang jelas dan memberikan pelatihan kepada evaluator agar hasil penilaian lebih adil dan akurat (Nursalam, 2022).

c. Peer Review

Peer review merupakan metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan sejawat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, kompetensi profesional, dan perilaku kerja tenaga keperawatan. Penilaian ini dianggap efektif karena sesama perawat lebih memahami kondisi kerja, standar

praktik, dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Dalam praktiknya, peer review dapat dilakukan melalui observasi tindakan klinis, diskusi kasus, maupun evaluasi dokumentasi keperawatan. Metode ini membantu membangun budaya saling belajar, refleksi profesional, dan komunikasi yang lebih terbuka antar tenaga keperawatan. Namun, peer review harus dilakukan secara objektif dan etis agar tidak menimbulkan konflik interpersonal maupun rasa tidak nyaman di lingkungan kerja (Sitinjak et al., 2019).

d. Self Assessment

Self assessment merupakan metode penilaian yang dilakukan oleh perawat terhadap kemampuan dan hasil kerjanya sendiri melalui proses refleksi profesional. Metode ini membantu perawat mengenali kekuatan, kelemahan, serta area kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam praktik pelayanan kesehatan. Self assessment juga mendorong tenaga keperawatan lebih bertanggung jawab terhadap pengembangan profesional dan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien .

Meskipun bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan reflektif, self assessment memiliki keterbatasan karena hasil penilaian dapat dipengaruhi oleh persepsi subjektif individu. Sebagian perawat mungkin memberikan penilaian terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, metode ini sebaiknya dikombinasikan dengan supervisi dan evaluasi dari pihak lain agar hasil penilaian lebih objektif dan akurat (Modok et al., 2026).

e. Audit Keperawatan

Audit keperawatan merupakan metode evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai mutu pelayanan keperawatan berdasarkan standar profesi dan prosedur yang berlaku. Audit dilakukan dengan meninjau dokumentasi asuhan keperawatan, kepatuhan terhadap SOP, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Melalui audit, organisasi dapat mengetahui apakah pelayanan keperawatan telah berjalan sesuai standar mutu dan prinsip keselamatan pasien.

Pelaksanaan audit membantu organisasi mengidentifikasi kesalahan pelayanan, ketidaklengkapan dokumentasi, maupun ketidaksesuaian praktik dengan standar yang berlaku. Hasil audit kemudian digunakan sebagai dasar dalam perbaikan mutu pelayanan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan. Agar audit berjalan efektif, proses evaluasi perlu dilakukan secara edukatif dan konstruktif

sehingga tenaga keperawatan tidak merasa disalahkan, tetapi terdorong untuk memperbaiki kualitas pelayanan (Nursalam, 2022).

9. Kendala dalam Penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja dalam pelayanan keperawatan sering menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi objektivitas dan efektivitas evaluasi. Salah satu hambatan yang paling sering terjadi adalah subjektivitas penilai, yaitu penilaian yang dipengaruhi hubungan pribadi, persepsi tertentu, atau faktor emosional sehingga hasil evaluasi tidak sepenuhnya menggambarkan kemampuan tenaga keperawatan secara nyata. Selain itu, beberapa organisasi pelayanan kesehatan juga belum memiliki indikator penilaian yang jelas dan terukur sehingga proses evaluasi menjadi kurang konsisten dan sulit digunakan sebagai dasar pengembangan profesional perawat (Muthmainnah, 2023).

Kendala lain yang sering muncul adalah tingginya beban kerja kepala ruang atau supervisor sehingga proses evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan secara optimal. Tanggung jawab administratif dan pelayanan yang cukup besar sering membuat penilaian dilakukan secara terburu-buru dan kurang memberikan umpan balik yang konstruktif kepada tenaga keperawatan. Di sisi lain, sebagian perawat juga masih menganggap evaluasi sebagai bentuk pengawasan atau kritik terhadap pekerjaan sehingga muncul rasa takut, defensif, dan kurang terbuka terhadap masukan yang diberikan. Kondisi ini dapat menghambat terciptanya budaya evaluasi yang sehat dalam organisasi pelayanan Kesehatan (Nursalam, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penilaian kinerja tenaga keperawatan. Penggunaan sistem dokumentasi elektronik dan penilaian berbasis digital menuntut tenaga keperawatan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang baik. Jika organisasi tidak menyediakan pelatihan dan dukungan yang memadai, proses evaluasi dapat mengalami hambatan dan memengaruhi kualitas penilaian kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu membangun sistem evaluasi yang objektif, suportif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar penilaian kinerja benar-benar mampu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan (Marquis & Huston, 2017).

C. Pengembangan Kompetensi Perawat

1. Konsep Kompetensi Keperawatan

a. Definisi Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai profesional yang sesuai dengan standar pekerjaan tertentu. Dalam profesi keperawatan, kompetensi menjadi dasar utama bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, pengambilan keputusan klinis, serta kemampuan bekerja sama dalam tim kesehatan (Darmojo et al., 2024).

Kompetensi keperawatan menggambarkan kesiapan seorang perawat dalam menjalankan praktik profesional sesuai standar profesi dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Perawat yang kompeten mampu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan, melaksanakan intervensi, dan melakukan evaluasi asuhan secara tepat. Kompetensi juga menunjukkan kemampuan perawat dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan klinik, serta etika profesi dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.

Dalam perkembangan pelayanan kesehatan modern, kompetensi perawat terus mengalami perubahan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi harus dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik profesional. Pengembangan kompetensi menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan (Sitinjak et al., 2019).

b. Jenis Kompetensi

Kompetensi perawat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai aspek kemampuan yang diperlukan dalam praktik profesional. Salah satu jenis kompetensi yang utama adalah kompetensi klinis, yaitu kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Kompetensi klinis meliputi kemampuan melakukan pengkajian, tindakan keperawatan, pemberian edukasi kesehatan, penggunaan alat kesehatan, serta penerapan patient safety dalam pelayanan Kesehatan (Darmojo et al., 2024).

Selain kompetensi klinis, terdapat kompetensi manajerial yang berkaitan dengan kemampuan mengelola pelayanan keperawatan dan sumber daya di lingkungan kerja. Kompetensi ini mencakup kemampuan kepemimpinan, komunikasi organisasi, supervisi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan pengelolaan mutu pelayanan kesehatan. Kompetensi manajerial sangat penting terutama bagi kepala ruang dan manajer keperawatan dalam mengoordinasikan pelayanan secara efektif.

Jenis kompetensi lainnya adalah kompetensi interpersonal dan profesional. Kompetensi interpersonal berkaitan dengan kemampuan komunikasi terapeutik, kerja sama tim, empati, dan hubungan profesional dengan pasien maupun tenaga kesehatan lain. Sementara itu, kompetensi profesional mencakup kepatuhan terhadap etika profesi, tanggung jawab hukum, pengembangan diri, dan kemampuan menerapkan evidence based nursing dalam praktik pelayanan kesehatan. Seluruh jenis kompetensi tersebut saling berkaitan dalam mendukung profesionalisme perawat (Sitinjak et al., 2019).

c. Standar Kompetensi Perawat

Standar kompetensi perawat merupakan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki seorang perawat dalam menjalankan praktik profesional sesuai ketentuan organisasi profesi dan regulasi kesehatan. Standar kompetensi disusun untuk memastikan bahwa setiap perawat memiliki kemampuan yang sesuai dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu kepada pasien. Standar ini menjadi pedoman dalam pendidikan keperawatan, uji kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan profesional tenaga keperawatan (PPNI, 2013).

Standar kompetensi perawat di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti praktik profesional, asuhan keperawatan, komunikasi efektif, penerapan patient safety, pengelolaan pelayanan, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Perawat diwajibkan mampu menerapkan seluruh kompetensi tersebut dalam praktik sehari-hari agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien. Standar kompetensi juga membantu organisasi pelayanan kesehatan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan SDM keperawatan (Sitinjak et al., 2019).

Penerapan standar kompetensi dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Perawat yang bekerja sesuai standar kompetensi akan lebih mampu memberikan pelayanan yang

aman, bertanggung jawab, dan berbasis kebutuhan pasien. Oleh karena itu, organisasi kesehatan perlu mendukung pengembangan kompetensi perawat secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan supervisi professional (Fadhilah et al., 2020).

2. Model Pengembangan Kompetensi

a. Continuing Professional Development (CPD)

Continuing Professional Development (CPD) merupakan proses pembelajaran berkelanjutan yang dilakukan tenaga keperawatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional sepanjang karirnya. CPD bertujuan memastikan bahwa perawat tetap memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Program CPD dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, workshop, pendidikan lanjut, penelitian, maupun kegiatan ilmiah lainnya (Metilda et al., 2026).

CPD menjadi bagian penting dalam pengembangan profesional karena dunia kesehatan terus mengalami perubahan yang cepat. Perawat yang aktif mengikuti CPD cenderung memiliki kemampuan klinis dan pengetahuan yang lebih baik dibandingkan perawat yang tidak melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kompetensi, CPD juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada pasien.

Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, CPD juga menjadi bagian dari persyaratan registrasi dan pengembangan karir tenaga keperawatan. Organisasi pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memiliki tanggung jawab mendukung pelaksanaan CPD dengan menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan (Nursalam & Efendi, 2020).

b. Career Ladder

Career ladder merupakan sistem jenjang karir yang disusun untuk memberikan kesempatan pengembangan profesional dan promosi jabatan bagi tenaga keperawatan berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja, pendidikan, dan pencapaian profesional. Sistem ini bertujuan meningkatkan motivasi kerja dan memberikan arah pengembangan karir yang jelas bagi perawat dalam organisasi pelayanan Kesehatan (Kewuan, 2018).

Penerapan career ladder membantu organisasi mempertahankan tenaga keperawatan yang kompeten dan meningkatkan loyalitas terhadap institusi. Perawat yang memiliki kesempatan pengembangan karir cenderung lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan. Selain itu, sistem jenjang karir juga mendukung terciptanya budaya kerja profesional dan kompetitif secara sehat di lingkungan pelayanan kesehatan.

Career ladder dalam keperawatan biasanya dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan kompetensi klinis dan tanggung jawab profesional. Setiap jenjang memiliki standar kompetensi tertentu yang harus dicapai perawat sebelum naik ke tingkat berikutnya. Sistem ini membantu organisasi memastikan bahwa pengembangan karir dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi profesional (Muthmainnah, 2023).

c. Credentialing

Credentialing merupakan proses evaluasi terhadap kompetensi, pendidikan, pengalaman kerja, dan kewenangan klinis tenaga keperawatan sebelum diberikan hak untuk melakukan praktik profesional tertentu. Credentialing bertujuan memastikan bahwa perawat yang memberikan pelayanan kesehatan memiliki kemampuan sesuai standar dan aman bagi pasien (Ridwan & Damanik, 2025).

Dalam pelayanan kesehatan, credentialing dilakukan melalui penilaian dokumen pendidikan, sertifikat pelatihan, pengalaman klinis, serta evaluasi kompetensi profesional. Proses ini penting untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien karena setiap tindakan keperawatan harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang sesuai.

Credentialing juga membantu organisasi pelayanan kesehatan mengelola sumber daya manusia secara lebih profesional dan terstruktur. Dengan adanya sistem credentialing, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh tenaga keperawatan bekerja sesuai kompetensi dan lingkup praktik yang dimiliki sehingga risiko kesalahan pelayanan dapat diminimalkan (Sitinjak et al., 2019).

d. Preceptorship

Preceptorship merupakan model pembimbingan klinik yang dilakukan oleh perawat berpengalaman kepada perawat baru atau mahasiswa keperawatan dalam proses adaptasi praktik klinik. Model ini

bertujuan membantu peserta didik atau perawat baru mengembangkan kompetensi klinis, komunikasi profesional, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja pelayanan Kesehatan (Nursalam & Efendi, 2020).

Preceptor berperan sebagai pembimbing, role model, dan fasilitator pembelajaran dalam praktik klinik. Melalui preceptorship, peserta didik memperoleh kesempatan belajar secara langsung dalam situasi pelayanan nyata dengan pendampingan tenaga profesional yang berpengalaman. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan klinis, dan kesiapan praktik profesional perawat baru.

Pelaksanaan preceptorship memerlukan kemampuan komunikasi, supervisi, dan pembelajaran klinik yang baik dari seorang preceptor. Organisasi pelayanan kesehatan perlu memberikan pelatihan dan dukungan kepada preceptor agar proses pembimbingan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi tenaga keperawatan (Nursalam & Efendi, 2020).

e. Mentoring dan Coaching

Mentoring merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh tenaga keperawatan yang lebih berpengalaman kepada perawat yang lebih junior untuk mendukung pengembangan karir dan kompetensi profesional. Mentoring tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga membantu pengembangan sikap profesional, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan.

Sementara itu, coaching merupakan proses pembimbingan yang lebih terarah untuk membantu individu meningkatkan performa kerja dan mencapai tujuan tertentu. Dalam pelayanan keperawatan, coaching dilakukan untuk meningkatkan keterampilan klinis, komunikasi, kepemimpinan, maupun kemampuan manajerial tenaga keperawatan. Coaching membantu perawat mengidentifikasi hambatan kerja dan menemukan solusi secara mandiri melalui proses diskusi dan refleksi professional.

Mentoring dan coaching memiliki peran penting dalam menciptakan budaya belajar dan pengembangan profesional berkelanjutan di lingkungan pelayanan kesehatan. Organisasi yang menerapkan sistem mentoring dan coaching secara efektif cenderung memiliki tenaga keperawatan yang lebih kompeten, percaya diri, dan siap menghadapi perubahan pelayanan Kesehatan (Laila Batool et al., 2025).

D. Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan

1. Konsep Pendidikan Keperawatan

Pendidikan keperawatan merupakan proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mempersiapkan individu menjadi tenaga perawat profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai etik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pendidikan keperawatan tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga menekankan kemampuan praktik klinik, komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan, dan penerapan asuhan keperawatan secara holistik. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam pembentukan kompetensi dan profesionalisme tenaga keperawatan (Nursalam & Efendi, 2020).

Dalam pelayanan kesehatan modern, pendidikan keperawatan memiliki peran penting dalam menyesuaikan kemampuan tenaga keperawatan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Perawat dituntut mampu berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan menerapkan evidence based nursing dalam praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sistem pendidikan keperawatan harus mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi perubahan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks (Gasper et al., 2025).

Pendidikan keperawatan juga merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan. Setelah menyelesaikan pendidikan formal, perawat tetap perlu mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya untuk mempertahankan kompetensi profesional. Konsep lifelong learning menjadi prinsip penting dalam profesi keperawatan karena perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan berlangsung secara cepat dan dinamis (Nursalam & Efendi, 2020).

2. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan utama pendidikan dan pelatihan keperawatan adalah meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan agar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan bermutu kepada pasien. Pendidikan dan pelatihan membantu perawat meningkatkan pengetahuan, keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, serta sikap profesional dalam menjalankan praktik keperawatan sehari-hari. Dengan kompetensi yang baik, tenaga keperawatan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan pasien dan mendukung pencapaian mutu pelayanan Kesehatan (Nursalam & Efendi, 2020).

Selain meningkatkan kemampuan teknis, pendidikan dan pelatihan juga bertujuan membentuk karakter profesional dan etika kerja tenaga

keperawatan. Melalui proses pembelajaran, perawat dibimbing untuk memiliki tanggung jawab profesional, kemampuan bekerja sama dalam tim, kepedulian terhadap keselamatan pasien, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam situasi klinis. Pembentukan sikap profesional ini sangat penting karena pelayanan keperawatan berkaitan langsung dengan kehidupan dan keselamatan pasien.

Pendidikan dan pelatihan juga bertujuan meningkatkan adaptasi tenaga keperawatan terhadap perkembangan sistem pelayanan kesehatan dan teknologi medis. Perubahan prosedur pelayanan, digitalisasi dokumentasi kesehatan, dan perkembangan alat kesehatan menuntut perawat untuk terus memperbarui kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu menyediakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan sesuai standar profesi (Nursalam & Efendi, 2020).

3. Jenis Pendidikan dan Pelatihan

a. In House Training

In house training merupakan program pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan organisasi. Pelatihan ini biasanya dilakukan di lingkungan kerja dengan materi yang berfokus pada peningkatan kompetensi praktis, penerapan SOP, penggunaan alat kesehatan, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan. In house training membantu organisasi menyesuaikan kemampuan tenaga keperawatan dengan kebutuhan pelayanan secara spesifik (Kanapi et al., 2025).

Pelaksanaan in house training memiliki beberapa keuntungan, seperti biaya yang lebih efisien, materi yang sesuai kebutuhan organisasi, serta kemudahan dalam penerapan hasil pelatihan ke lingkungan kerja. Selain itu, pelatihan internal juga membantu meningkatkan kerja sama antar tenaga kesehatan dan memperkuat budaya organisasi dalam pelayanan Kesehatan.

Agar efektif, in house training perlu dirancang berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pelatihan tenaga keperawatan. Materi pelatihan harus relevan dengan permasalahan pelayanan yang dihadapi organisasi sehingga hasil pelatihan dapat langsung diterapkan dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari (Nursalam & Efendi, 2020).

b. Continuing Nursing Education

Continuing nursing education merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang dilakukan perawat untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional sepanjang karirnya. Program ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, kursus, konferensi ilmiah, maupun pendidikan formal lanjutan. Continuing nursing education menjadi bagian penting dalam pengembangan profesional karena ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terus berkembang (Mlambo et al., 2021).

Melalui continuing nursing education, perawat dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan evidence based practice dan kebutuhan pelayanan kesehatan terkini. Pendidikan berkelanjutan juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, dan kualitas pelayanan kepada pasien. Perawat yang aktif mengikuti pendidikan berkelanjutan cenderung memiliki kompetensi profesional yang lebih baik dibandingkan perawat yang tidak melakukan pengembangan diri secara rutin.

Organisasi pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung continuing nursing education dengan menyediakan kesempatan pendidikan, fasilitas pelatihan, dan dukungan pengembangan karir tenaga keperawatan. Dukungan organisasi akan meningkatkan motivasi tenaga keperawatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan (Dewi, 2020).

c. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan metode pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tenaga keperawatan sesuai standar kompetensi tertentu. Fokus utama pelatihan ini adalah pencapaian keterampilan dan kemampuan kerja yang dapat diukur secara objektif. Pelatihan berbasis kompetensi biasanya disusun berdasarkan kebutuhan pelayanan dan standar profesi keperawatan (Fukada, 2019).

Dalam pelaksanaannya, pelatihan berbasis kompetensi menekankan praktik langsung, demonstrasi keterampilan, simulasi klinik, dan evaluasi kemampuan peserta. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan secara nyata dalam praktik pelayanan kesehatan. Kompetensi yang dilatih dapat berupa keterampilan klinis, komunikasi

terapeutik, manajemen patient safety, maupun penggunaan teknologi Kesehatan (Nursalam & Efendi, 2020).

Pelatihan berbasis kompetensi membantu organisasi memastikan bahwa tenaga keperawatan memiliki kemampuan sesuai tuntutan pelayanan kesehatan modern. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, pendekatan ini juga membantu mengurangi kesalahan tindakan dan meningkatkan keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.

d. Pelatihan Patient Safety

Pelatihan patient safety merupakan program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menjaga keselamatan pasien selama proses pelayanan kesehatan berlangsung. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti identifikasi pasien, komunikasi efektif, pencegahan infeksi, keamanan pemberian obat, serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan sehingga seluruh tenaga keperawatan wajib memahami prinsip-prinsip patient safety (Shibiru et al., 2023).

Pelatihan patient safety membantu meningkatkan kesadaran tenaga keperawatan terhadap risiko kesalahan pelayanan dan pentingnya budaya keselamatan dalam organisasi kesehatan. Perawat yang memahami prinsip patient safety akan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan, mengikuti SOP, dan melakukan komunikasi efektif dengan tim kesehatan maupun pasien.

Pelaksanaan pelatihan patient safety secara rutin sangat penting untuk mempertahankan mutu pelayanan dan menurunkan angka kejadian tidak diharapkan di fasilitas kesehatan. Organisasi pelayanan kesehatan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan patient safety agar budaya keselamatan dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh tenaga Kesehatan (Park & Park, 2019).

4. Metode Pembelajaran SDM Keperawatan

a. Lecture

Lecture atau metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyampaian materi secara lisan oleh pengajar kepada peserta pelatihan atau mahasiswa. Metode ini banyak digunakan dalam pendidikan keperawatan karena efektif untuk menyampaikan konsep, teori, dan informasi kepada peserta dalam jumlah besar. Lecture

membantu peserta memperoleh dasar pengetahuan sebelum melakukan praktik klinik atau pelatihan keterampilan.

Meskipun efektif untuk penyampaian teori, metode lecture memiliki keterbatasan karena peserta cenderung bersifat pasif selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, metode ceramah sebaiknya dikombinasikan dengan diskusi, studi kasus, atau simulasi agar peserta lebih aktif dan mampu memahami penerapan teori dalam praktik pelayanan Kesehatan (Nursalam & Efendi, 2020).

b. Case Study

Case study atau studi kasus merupakan metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau simulasi kasus sebagai bahan analisis dan diskusi peserta. Metode ini membantu tenaga keperawatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, dan pemecahan masalah dalam pelayanan kesehatan.

Dalam pendidikan keperawatan, studi kasus memungkinkan peserta menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Peserta belajar menganalisis kondisi pasien, menentukan prioritas masalah, serta merencanakan tindakan keperawatan berdasarkan data klinis yang tersedia. Metode ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan klinis dan profesionalisme tenaga keperawatan (Mendonça, 2026).

c. Simulation

Simulation merupakan metode pembelajaran yang menggunakan situasi tiruan untuk melatih keterampilan klinis dan kemampuan pengambilan keputusan tenaga keperawatan. Simulasi dapat dilakukan menggunakan phantom, manekin, standardized patient, maupun skenario klinik tertentu yang menyerupai kondisi nyata di pelayanan kesehatan.

Metode simulasi membantu peserta belajar dalam lingkungan yang aman tanpa membahayakan pasien secara langsung. Peserta dapat melatih keterampilan teknis, komunikasi, kerja sama tim, dan penanganan situasi darurat sebelum terjun ke praktik klinik nyata. Simulasi juga efektif meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan tenaga keperawatan dalam menghadapi situasi klinis kompleks (Liu et al., 2025).

d. Bedside Teaching

Bedside teaching merupakan metode pembelajaran klinik yang dilakukan langsung di samping pasien dengan bimbingan instruktur atau preceptor. Metode ini bertujuan membantu peserta mengembangkan kemampuan klinis, komunikasi terapeutik, dan penerapan asuhan keperawatan secara langsung dalam situasi nyata pelayanan kesehatan.

Melalui bedside teaching, peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan realistis karena berinteraksi langsung dengan pasien. Metode ini juga membantu meningkatkan kemampuan observasi, pengkajian klinis, dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kenyamanan, privasi, dan keselamatan pasien (Nursalam & Efendi, 2020).

e. Role Play

Role play merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memainkan peran tertentu sesuai situasi pelayanan kesehatan. Metode ini sering digunakan untuk melatih komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, manajemen konflik, dan kerja sama tim dalam pelayanan keperawatan.

Role play membantu peserta memahami perspektif pasien maupun tenaga kesehatan lain sehingga meningkatkan empati dan kemampuan interpersonal. Selain itu, metode ini juga membantu peserta lebih percaya diri dalam menghadapi situasi komunikasi yang kompleks di lingkungan pelayanan Kesehatan (Fukada, 2019).

5. Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi pendidikan dan pelatihan merupakan proses penilaian terhadap efektivitas program pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai serta sejauh mana peserta mampu menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik pelayanan kesehatan. Evaluasi menjadi bagian penting dalam pengembangan SDM keperawatan karena membantu organisasi memperbaiki kualitas program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

Evaluasi pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pre-test dan post-test, observasi keterampilan klinis, penilaian praktik, wawancara, maupun evaluasi kepuasan peserta. Penilaian tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga kemampuan aplikasi keterampilan dan perubahan perilaku kerja tenaga keperawatan setelah mengikuti pelatihan (Nursalam & Efendi, 2020).

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam perbaikan metode pembelajaran, pengembangan materi pelatihan, serta penyusunan program pengembangan kompetensi berikutnya. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis membantu organisasi memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan.

E. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus 1: Pengembangan Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap

Seorang kepala ruang di ruang rawat inap penyakit dalam menemukan adanya penurunan kualitas dokumentasi keperawatan dan meningkatnya keluhan pasien terkait keterlambatan respons perawat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian perawat belum memahami standar dokumentasi terbaru dan masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan beban kerja. Selain itu, beberapa perawat jarang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi karena jadwal kerja yang padat.

Pihak manajemen rumah sakit kemudian merencanakan program supervisi, pelatihan dokumentasi keperawatan, dan evaluasi kinerja berbasis mutu pelayanan. Kepala ruang diminta melakukan monitoring kinerja serta memberikan coaching kepada perawat yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.

Hasil pengkajian situasi:

1. Dokumentasi keperawatan masih belum lengkap pada beberapa pasien
2. Perawat mengeluhkan tingginya beban kerja pada shift malam
3. Sebagian perawat belum mengikuti pelatihan patient safety terbaru
4. Komunikasi antar anggota tim keperawatan kurang efektif
5. Supervisi dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara rutin
6. Lingkungan ruangan cukup ramai sehingga komunikasi kurang fokus

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah manajemen kinerja yang terjadi pada kasus tersebut.
2. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja perawat pada kasus.
3. Analisis pentingnya supervisi dan evaluasi kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan.
4. Jelaskan strategi pengembangan kompetensi yang dapat diterapkan oleh kepala ruang.
5. Uraikan peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Rubrik penilaian aktivits 1

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Identifikasi masalah	Tidak mampu mengidentifikasi masalah	Mengidentifikasi sebagian masalah	Mengidentifikasi masalah dengan tepat	Mengidentifikasi masalah secara lengkap dan mendalam
Analisis faktor penyebab	Analisis tidak tepat	Analisis sebagian benar	Analisis tepat	Analisis mendalam dan kontekstual
Strategi penyelesaian	Solusi tidak relevan	Solusi kurang sesuai	Solusi sesuai	Solusi inovatif dan aplikatif
Komunikasi dan diskusi	Tidak aktif berdiskusi	Kurang aktif	Aktif berdiskusi	Sangat aktif dan mampu memimpin diskusi
Presentasi hasil diskusi	Penyampaian tidak sistematis	Penyampaian kurang jelas	Penyampaian cukup jelas	Penyampaian sistematis, jelas, dan argumentatif

F. Aktivitas 2 — Problem Solving

Analisis Kasus Supervisi dan Evaluasi Kinerja

Kasus 2:

Di sebuah rumah sakit tipe B, hasil audit keperawatan menunjukkan masih rendahnya kepatuhan perawat terhadap SOP hand hygiene dan dokumentasi electronic nursing record. Kepala bidang keperawatan kemudian meminta seluruh kepala ruang melakukan supervisi rutin dan menyusun program pelatihan berbasis kompetensi.

Namun, dalam pelaksanaannya beberapa perawat merasa evaluasi kinerja hanya digunakan untuk mencari kesalahan sehingga muncul resistensi terhadap proses supervisi. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga keperawatan menyebabkan proses monitoring belum berjalan optimal.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Analisis kendala dalam pelaksanaan penilaian kinerja pada kasus.

2. Jelaskan dampak rendahnya kepatuhan SOP terhadap keselamatan pasien.
3. Susun strategi supervisi dan coaching yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan perawat.
4. Jelaskan pentingnya budaya evaluasi yang suportif dalam pelayanan keperawatan.
5. Buat rekomendasi program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kasus.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Rubrik Penilaian Aktivitas 2

Aspek Penilaian	1 (Tidak Kompeten)	2 (Kurang Kompeten)	3 (Kompeten)	4 (Sangat Kompeten)
Ketepatan analisis kasus	Tidak tepat	Kurang tepat	Tepat	Sangat tepat dan mendalam
Kemampuan problem solving	Solusi tidak sesuai	Solusi kurang aplikatif	Solusi cukup aplikatif	Solusi inovatif dan realistis
Penerapan konsep manajemen keperawatan	Tidak mampu menerapkan konsep	Penerapan sebagian konsep	Penerapan konsep tepat	Penerapan konsep komprehensif
Kerja sama kelompok	Tidak bekerja sama	Kurang aktif	Aktif	Sangat aktif dan kolaboratif
Kemampuan presentasi	Tidak sistematis	Kurang jelas	Cukup jelas	Sangat jelas, runtut, dan argumentatif

G. Daftar Pustaka

Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2019). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier.

Cherry, B., & Jacob, S. R. (2018). Contemporary nursing: Issues, trends. In *Contemporary nursing: Issues, trends, & management* (8th ed.).). Elsevier.

Darmojo, H. S., Rossa, M. A., & Suciana, E. (2024). *The Role of Competency-Based Nursing Education in Improving the Quality of Health Services*. *8*(2), 66–72.

Dewi, M. (2020). Model Uji Regresi Logistik. *Analysis of Incidence Rates*, 211–232. https://doi.org/10.1201/9780429055713-12

Fadhilah, H., Mustikasari, & Sunadi, A. (2020). *Standar Profesi Perawat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Fukada, M. (2019). Nursing competency: Definition, structure and development. *Yonaga Acta Medica*, *61*(1), 1–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5871720/pdf/yam-61-001.pdf

Gasper, I., Yauri, I., Rohana, & Listautin. (2025). *Konsep Dasar Keperawatan*. PT Media Pustaka Indo.

Gillies, D. A. (1994). *Nursing management: A systems approach* (7th ed.). Saunders Elsevier.

Guo, Y., Luo, Y., Lam, L., Cross, W., Plummer, V., & Zhang, J. P. (2024). Professional competence and communication skills among nurses in clinical practice: A systematic review. *Journal of Nursing Management*, *32*(2), 210–221. https://doi.org/10.1111/jonm.14021

Huber, D. (2021). *Leadership and nursing care management* (7th ed.).). Elsevier.

Hughes, R. G. (2008). *Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses*. Agency for Healthcare Research and Quality.

Kanapi, Inayah, I., & Rohayani, L. (2025). In House Training Terhadap Pengetahuan Dan Implementasi Pelaksanaan Metode Tim. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *2*(April), 306–312.

Kewuan, N. N. (2018). *Manajemen kinerja keperawatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2022). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson.

Laila Batool, Javeria Murtaza, Aniqa Malik, Ayesha Noureen, Maria Zakir, Aqib Dil Awaiz, & Nida Abid. (2025). the Effectiveness of Mentoring and Coaching in the Career Development of Nurses Into the Tertiary Healthcare. *Journal of Medical & Health Sciences Review*, *2*(1), 3384–3402. https://doi.org/10.62019/2e9j9832

Liu, H., Huang, H., Li, M., Mao, P., Zhang, A., Sun, Y., Liu, Z., Tao, H., Zhao, S., Xia, Y., Zhou, J., & Liu, J. (2025). The Effect of "Online–Simulation–Bedside" Three-Step Teaching Method in Team Cardiopulmonary Resuscitation Skills Training of Emergency Department and Critical Care Nursing Interns—An Analysis Based on Kirkpatrick Model. *Journal of Nursing Management*, *2025*(1). https://doi.org/10.1155/jonm/8624274

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2017). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application* (10th ed.). Lippincott Williams \& Wilkins.

Mendonça, S. (2026). Nurses' Clinical Reasoning Process: A Grounded Theory Study. *Healthcare*, *14*(2), 230. https://doi.org/10.3390/healthcare14020230

Metilda, Aeni, S. D. I. N., Destianti, S., Lutfiah, S. V., Oveliya, S., Zaelani, S. N. E., & Salsabilla, T. (2026). Pengaruh Continuing Professional Development (Cpd)Terhadap Pengembangan Jenjang Karir Perawat:Literatur Review. *Bina Generasi ; Jurnal Kesehatan*, *2*, 77–93.

Mlambo, M., Silén, C., & McGrath, C. (2021). Lifelong learning and nurses' continuing professional development, a metasynthesis of the literature. *BMC Nursing*, *20*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00579-2

Modok, J. M., Wattilah, K., Wairissal, L. C., Pangkey, B. C. A., Barus, N. S., Keperawatan, P. S., Keperawatan, F., & Harapan, U. P. (2026). Self-Assessment Perawat Terhadap Penerapan Patient Safety Di Indonesia : Studi Deskriptif. *Jurnal Aisyiyah Medika*, *11*(1).

Muthmainnah. (2023). *Manajemen keperawatan: Perawat, kinerja, motivasi dan remunerasi*. Deepublish.

Nursalam. (2022). *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional* (6th ed.). salemba medika.

Nursalam, & Efendi, F. (2017). *Pendidikan Dalam Keperawatan Nursalam Ferry Efendi* (Issue March 2014). Airlangga University.

Nursalam, & Efendi, F. (2020). *Pendidikan dalam keperawatan*. Salemba Medika.

Park, K. H., & Park, K. H. (2019). *Patient Safety Education: Team Communication and Interprofessional Collaboration*. *21*(1), 22–30.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of nursing-e-book*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tfpVEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=caring+patient&ots=V_M7OFpOtj&sig=2sAOv3JYrdY8MyVyX-LMI1EQ4Zc

PPNI. (2013). Standar Kompetensi Perawat Indonesia. In *Standar Kompetensi Perawat Indonesia*. Persatuan Perawat Nasional indonesia.

Ridwan, J., & Damanik, S. R. H. (2025). Penerapan Teori Patricia Benner dalam

Proses Kredensial Keperawatan Ditinjau dari Sudut Pandang Filosofi di Rsud Kota Dumai. *Jurnal Ners*, *9*(3), 4436–4443. https://doi.org/10.31004/jn.v9i3.46882

Seniwati, Ita, Anugrahwati, R., Silitonga, J. M., & Hutagaul, R. (2022). *Buku Ajar Manajemen Keperawatan*. Feniks Muda Sejahtera.

Shibiru, S., Aschalew, Z., Kassa, M., Bante, A., & Mersha, A. (2023). *Clinical Competence of Nurses and the Associated Factors in Public Hospitals of Gamo Zone , Southern Ethiopia : A Cross-Sectional Study*. *2023*.

Sitinjak, L., Tola, B., & Ramly, M. (2019). *Evaluasi Standar Kompetensi Perawat Indonesia Dengan Menggunakan Model*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Yustina, Sari, D. W. P., Ardian, I., & Abdurrouf, M. (2025). Literature Review: Positive Impact Of Training In Improving Nursing Care Quality Competencies. *Indonesian Journal of Global Health Research*, *7*(2), 1051–1058.

BAB 6

MANAJEMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menerapkan prinsip profesionalisme, etik-legal, dan tata kelola layanan dalam manajemen keperawatan.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-6
CPL-2	Menganalisis fungsi manajemen dan kepemimpinan untuk pengambilan keputusan dalam unit pelayanan keperawatan.	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-3
CPL-3	Menyusun perencanaan strategis-operasional dan pengorganisasian pelayanan keperawatan yang efektif.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-4	Mengelola SDM keperawatan meliputi staffing, scheduling, supervisi, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Mengelola sumber daya unit (keuangan dan logistik) secara efisien, akuntabel, dan berorientasi mutu.	CPMK-5, CPMK-6
CPL-6	Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, komunikasi-kolaborasi, serta perubahan dan informatika untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-6, CPMK-7, CPMK-2

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep, fungsi, dan prinsip dasar manajemen keperawatan serta implikasinya pada tata kelola unit.
CPMK-2	Menganalisis kepemimpinan, pengambilan keputusan, delegasi, dan supervise untuk mencapai tujuan unit keperawatan.
CPMK-3	Menyusun rencana strategis dan operasional unit keperawatan berdasarkan analisis kebutuhan, indikator, dan prioritas.
CPMK-4	Mendesain pengorganisasian pelayanan dan pengelolaan SDM (model asuhan, staffing, scheduling) sesuai beban kerja dan kompetensi.
CPMK-5	Menyusun rencana pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi serta mengintegrasikan aspek anggaran dan logistik unit.
CPMK-6	Menerapkan manajemen mutu dan keselamatan pasien termasuk audit, indicator mutu, dan tindaklanjut perbaikan.
CPMK-7	Mengelola komunikasi, kolaborasi, konflik, serta perubahan/inovasi dan informatika keperawatan untuk peningkatan layanan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 8. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien	8.1 Menentukan indicator mutu dan metode audit untuk memantau kinerja unit.	8.2 Menyusun rencana tindak lanjut insiden keselamatan dan perbaikan proses (QI) berbasis data.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-7

Uraian Materi

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan yang kian kompleks menuntut adanya upaya peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan. Kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja organisasi pelayanan kesehatan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, efektivitas pelayanan, serta tingkat kepuasan pasien. Oleh karena itu, setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengimplementasikan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dalam seluruh rangkaian proses pelayanan kesehatan.

Manajemen mutu merupakan suatu pendekatan yang terencana dan terstruktur dalam mengelola kualitas pelayanan melalui tahapan perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Penerapan manajemen mutu bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar profesional dan standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, manajemen mutu juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2020).

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, penilaian mutu tidak hanya didasarkan pada hasil akhir yang diterima pasien, tetapi juga mencakup proses pelayanan serta sistem yang mendukung pelaksanaannya. Konsep ini menegaskan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh tenaga kesehatan dalam organisasi pelayanan kesehatan.

Salah satu aspek krusial dalam manajemen mutu pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien (*patient safety*). Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien akibat kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan keselamatan pasien dilakukan melalui identifikasi risiko, pelaporan insiden keselamatan, serta penerapan berbagai strategi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan (Joint Commission International, 2020).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, perawat memegang peranan yang sangat vital dalam implementasi manajemen mutu dan keselamatan pasien. Hal ini dikarenakan perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling intens berinteraksi langsung dengan pasien selama proses perawatan. Oleh sebab itu, perawat

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan telah sesuai dengan standar praktik keperawatan serta prinsip-prinsip keselamatan pasien.

Bab ini akan menguraikan berbagai aspek terkait manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan, meliputi konsep dasar manajemen mutu, tujuan dan prinsip-prinsipnya, indikator mutu pelayanan kesehatan, berbagai model peningkatan mutu, serta konsep keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.

B. Konsep Dasar Manajemen Mutu

Manajemen mutu merupakan suatu pendekatan strategis yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Di tengah era globalisasi serta persaingan layanan kesehatan yang semakin kompetitif, mutu menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan organisasi dalam menyediakan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Mutu pelayanan tidak hanya dilihat dari capaian hasil klinis, tetapi juga mencakup pengalaman pasien serta tingkat efisiensi dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2020).

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengembangkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi. Sistem ini dirancang agar setiap proses pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku serta mampu memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Dengan demikian, manajemen mutu tidak lagi bersifat opsional, tetapi telah menjadi suatu keharusan dalam praktik pelayanan kesehatan modern (Institute of Medicine, 2001).

Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan semakin meningkatkan kompleksitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan, terutama perawat, untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep mutu agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, manajemen mutu menjadi salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki dalam praktik keperawatan (American Nurses Association, 2015).

1. Definisi Manajemen Mutu

Berikut beberapa definisi manajemen mutu di bawah ini:

a. Sumiati et al. (2023): Manajemen mutu pelayanan kesehatan merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan secara komprehensif

dengan melibatkan seluruh komponen dalam sistem pelayanan kesehatan, guna meningkatkan kepuasan pasien, efisiensi, serta luaran kesehatan secara menyeluruh.

b. Maulia & Hartono (2024): Manajemen mutu adalah suatu pendekatan strategis yang diterapkan untuk mengelola sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui metode yang sistematis, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien serta efisiensi operasional dalam organisasi pelayanan kesehatan.
c. Triani & Yuwono (2025): Manajemen mutu merupakan konsep pengelolaan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sistem, sumber daya, serta persepsi pasien terhadap mutu layanan yang diterima.
d. Asti et al. (2025): Manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan adalah suatu upaya terpadu yang memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan kesehatan guna mencapai hasil pelayanan yang optimal bagi pasien.
e. Kartono & Wirawan (2024): Manajemen mutu adalah suatu sistem pengelolaan organisasi yang berorientasi pada pelanggan dengan menekankan prinsip perbaikan berkelanjutan, pendekatan berbasis proses, serta pengendalian mutu untuk meningkatkan kepuasan pasien dan mengurangi keluhan dalam pelayanan kesehatan.
f. Prayogo et al. (2023): Manajemen mutu pelayanan kesehatan merupakan pendekatan manajemen yang terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan melalui pengelolaan sistem pelayanan secara menyeluruh, sehingga mampu mendukung perkembangan serta daya saing organisasi pelayanan kesehatan.

Secara konseptual, manajemen mutu tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir pelayanan, tetapi juga pada proses yang berlangsung selama pelayanan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan perlu dikelola secara komprehensif, mencakup aspek input, proses, hingga output pelayanan.

Di samping itu, manajemen mutu juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen dalam organisasi pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas. Keterlibatan tersebut mencakup tenaga medis, perawat, manajemen, serta pasien sebagai penerima layanan. Pendekatan

kolaboratif ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas dalam penerapan manajemen mutu (Nguyen et al., 2021; Doyle et al., 2020).

Dalam implementasinya, manajemen mutu kerap diterapkan melalui berbagai pendekatan, seperti *Total Quality Management* (TQM) dan *Continuous Quality Improvement* (CQI). Kedua pendekatan tersebut menekankan pentingnya upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten (Taylor et al., 2021; O'Connor et al., 2022). Dengan demikian, manajemen mutu dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan melalui pendekatan yang sistematis, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.

2. Tujuan Manajemen Mutu

Berikut adalah tujuan dari manajemen mutu:

a. Meningkatkan kepuasan pasien

Salah satu tujuan utama manajemen mutu adalah meningkatkan tingkat kepuasan pasien melalui pemberian pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, serta standar pelayanan yang berlaku. Implementasi manajemen mutu terbukti mampu memperbaiki pengalaman pasien serta meningkatkan kepercayaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (Maulia & Hartono, 2024).

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan

Manajemen mutu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pendekatan ini membantu organisasi dalam mengurangi pemborosan serta meningkatkan kinerja pelayanan secara menyeluruh (Maulia & Hartono, 2024).

c. Menjamin keselamatan pasien

Tujuan penting lainnya adalah memastikan keselamatan pasien dengan meminimalkan risiko kesalahan medis dan kejadian tidak diharapkan. Penerapan manajemen mutu berperan dalam memperkuat sistem keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan (Putri et al., 2022).

d. Meningkatkan kualitas hasil pelayanan

Manajemen mutu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pelayanan, baik dari aspek klinis maupun non-klinis. Hal ini mencakup peningkatan derajat kesehatan pasien serta konsistensi mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan (Sumiati et al., 2023).

e. Mendorong perbaikan berkelanjutan

Penerapan manajemen mutu diarahkan untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Proses evaluasi yang dilakukan secara rutin serta pemanfaatan data menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara terus-menerus (Sumiati et al., 2023).

f. Meningkatkan daya saing organisasi pelayanan kesehatan

Manajemen mutu bertujuan untuk memperkuat daya saing organisasi pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kepuasan pasien, sehingga organisasi mampu berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat (Prayogo et al., 2023).

Dengan demikian, manajemen mutu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta kepuasan pasien secara menyeluruh.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Mutu

Prinsip manajemen mutu merupakan dasar dalam pengembangan sistem mutu yang efektif dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi pedoman bagi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara sistematis.

a. Berorientasi pada Pasien (Patient-Centered Care)

Pelayanan kesehatan harus dirancang dengan menempatkan pasien sebagai pusat perhatian utama, dengan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, serta preferensi individu dalam setiap proses pelayanan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan tingkat kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta hasil klinis yang lebih optimal karena pelayanan diberikan secara lebih personal dan responsif terhadap kondisi pasien (Kartono & Wirawan, 2024).

b. Keselamatan Pasien sebagai Landasan Utama

Keselamatan pasien merupakan elemen esensial dalam manajemen mutu yang tidak dapat diabaikan. Penerapan sistem keselamatan pasien, seperti pelaporan insiden, identifikasi potensi risiko, serta penguatan budaya keselamatan, berkontribusi signifikan dalam menurunkan kejadian yang tidak diharapkan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh (Budiman & Yudiansyah, 2024).

c. Peningkatan Mutu Secara Berkesinambungan (Continuous Quality Improvement)

Manajemen mutu menuntut adanya upaya peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus melalui proses evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi kesehatan

untuk melakukan inovasi berbasis data serta meningkatkan kinerja pelayanan secara sistematis dan berkelanjutan (Septiawan, 2025).

d. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Pendekatan berbasis risiko menekankan pentingnya proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko dalam setiap aktivitas pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan prinsip ini, organisasi mampu mengantisipasi potensi kesalahan serta meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan secara proaktif (Kartono & Wirawan, 2024).

e. Peran Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi

Kepemimpinan yang efektif serta komitmen yang kuat dari manajemen puncak menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen mutu. Pemimpin yang memiliki orientasi mutu mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan budaya keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan (Rezeki et al., 2022).

f. Penguatan Budaya Mutu dan Keselamatan

Budaya mutu mencerminkan nilai dan perilaku seluruh tenaga kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan. Organisasi dengan budaya keselamatan yang baik biasanya ditandai dengan keterbukaan dalam melaporkan kesalahan serta komitmen untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan dari setiap insiden yang terjadi (Ghofar et al., 2022).

g. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence-Based Decision Making)

Keputusan dalam manajemen mutu sebaiknya didasarkan pada data yang valid, indikator kinerja, serta bukti ilmiah terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kebijakan dan efektivitas intervensi dalam pelayanan kesehatan (Septiawan, 2025).

h. Keterlibatan Tenaga Kesehatan dan Kolaborasi Tim

Partisipasi aktif tenaga kesehatan dalam pelaksanaan program mutu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kerja sama tim yang efektif dan kolaborasi antarprofesi juga terbukti dapat meningkatkan keselamatan pasien serta mengurangi risiko kesalahan dalam praktik pelayanan (Budiman & Yudiansyah, 2024).

i. Optimalisasi Teknologi dan Inovasi Digital

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mutu pelayanan di era digital saat ini (Asti et al., 2025).

j. Pengelolaan Sumber Daya Secara Optimal

Pengelolaan sumber daya yang meliputi tenaga kesehatan, fasilitas, dan pembiayaan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna menjamin keberlangsungan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penggunaan sumber daya yang tepat akan mendukung tercapainya pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan (Purbasari, 2025).

4. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan terdiri atas berbagai dimensi yang digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pasien. Dimensi-dimensi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek-aspek penting yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan dapat dikatakan bermutu.

Secara umum, dimensi mutu pelayanan kesehatan mencakup efektivitas, efisiensi, keselamatan, ketepatan waktu, orientasi pada pasien, dan keadilan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana pelayanan mampu mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa terjadinya pemborosan (World Health Organization, 2020).

Keselamatan pasien menjadi salah satu dimensi krusial karena berhubungan langsung dengan upaya pencegahan cedera atau kerugian yang dapat timbul akibat kesalahan dalam proses pelayanan. Selain itu, ketepatan waktu mencerminkan bahwa pelayanan diberikan secara cepat dan tanpa penundaan yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi pasien. Sementara itu, orientasi pada pasien menekankan pentingnya penghargaan terhadap kebutuhan, nilai, serta preferensi pasien dalam setiap tahapan pelayanan (Institute of Medicine, 2001).

Dimensi keadilan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, di mana setiap individu berhak memperoleh pelayanan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Pemahaman terhadap seluruh dimensi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih holistik, adil, dan berkualitas tinggi (World Health Organization, 2020).

Mutu pelayanan kesehatan memiliki beberapa dimensi utama yang menjadi indikator dalam menilai kualitas pelayanan adalah:

a. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas pelayanan kesehatan mengacu pada kemampuan layanan dalam menghasilkan outcome klinis yang sesuai dengan standar praktik

berbasis bukti. Pelayanan yang efektif ditandai dengan intervensi yang tepat, terukur, dan mampu meningkatkan kondisi kesehatan pasien secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pelayanan karena berkaitan langsung dengan hasil klinis pasien (Yudha et al., 2024)

b. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi mencerminkan sejauh mana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini meliputi pengelolaan tenaga kesehatan, waktu, serta biaya secara rasional untuk menghindari pemborosan. Studi terbaru menunjukkan bahwa efisiensi berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan (Yudha et al., 2024).

c. Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Keselamatan pasien merupakan dimensi fundamental yang menitikberatkan pada upaya pencegahan cedera atau kejadian yang merugikan pasien selama proses pelayanan kesehatan. Implementasi sistem keselamatan pasien, termasuk identifikasi risiko dan pelaporan insiden, terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta menekan angka kesalahan medis (Hardianti et al., 2023).

d. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Ketepatan waktu dalam pelayanan kesehatan menunjukkan kemampuan fasilitas layanan dalam memberikan tindakan secara cepat dan tanpa penundaan yang tidak diperlukan. Pelayanan yang terlambat dapat berdampak negatif terhadap kondisi pasien serta menurunkan tingkat kepuasan, sehingga dimensi ini menjadi indikator penting dalam evaluasi mutu pelayanan (Yudha et al., 2024).

e. Berorientasi pada Pasien (Patient-Centeredness)

Dimensi ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif pasien dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diterima (Khairunnisa et al., 2025).

f. Keadilan (Equity)

Keadilan dalam pelayanan kesehatan berkaitan dengan pemberian layanan yang setara kepada seluruh individu tanpa adanya diskriminasi. Setiap pasien memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga dimensi ini menjadi indikator

penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata (Yudha et al., 2024).

g. Integrasi Pelayanan (Integrated Care)

Integrasi pelayanan menekankan pentingnya koordinasi antar tenaga kesehatan dan antar unit layanan untuk memastikan kesinambungan perawatan pasien. Pelayanan yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi tindakan, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi pasien (Yudha et al., 2024).

h. Kualitas Interaksi Pelayanan (Dimensi SERVQUAL)

Selain aspek sistem, mutu pelayanan juga ditentukan oleh kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Dimensi ini meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang secara signifikan memengaruhi persepsi pasien terhadap kualitas layanan serta tingkat kepuasan yang dirasakan (Sianturi et al., 2025; Askarila & Kholidah, 2024).

5. Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator mutu merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan secara objektif. Indikator ini digunakan untuk memantau kinerja pelayanan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Indikator mutu pelayanan kesehatan terdiri dari:

a. Indikator Outcome Klinis (Clinical Outcome Indicators)

Indikator outcome klinis digunakan untuk mengevaluasi hasil akhir dari pelayanan kesehatan yang diterima pasien, seperti tingkat kesembuhan, angka kematian, serta kejadian komplikasi. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas intervensi medis dan keberhasilan pelayanan secara keseluruhan. Pengukuran outcome klinis memungkinkan fasilitas kesehatan melakukan evaluasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas layanan (Hardianti et al., 2023).

b. Indikator Keselamatan Pasien (Patient Safety Indicators)

Indikator keselamatan pasien mencakup berbagai kejadian yang berkaitan dengan insiden keselamatan, seperti kejadian tidak diharapkan serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Indikator ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan dalam pelayanan. Penerapan indikator keselamatan secara konsisten terbukti dapat meningkatkan mutu pelayanan serta menurunkan angka kesalahan medis (Syahrul et al., 2021).

c. Indikator Proses Pelayanan (Process Indicators)

Indikator proses digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya meliputi tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar tindakan, ketepatan prosedur klinis, serta waktu respons pelayanan. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan secara konsisten dan sesuai standar mutu yang berlaku (Fauziah et al., 2023).

d. Indikator Efisiensi Pelayanan (Efficiency Indicators)

Indikator efisiensi berkaitan dengan tingkat pemanfaatan sumber daya dalam pelayanan kesehatan, seperti lama rawat inap, tingkat hunian tempat tidur, serta perputaran penggunaan tempat tidur. Indikator ini berfungsi untuk menilai produktivitas dan efisiensi operasional rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang optimal (Rosita & Tanastasya, 2019).

e. Indikator Kepuasan Pasien (Patient Satisfaction Indicators)

Kepuasan pasien merupakan indikator yang mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Aspek yang dinilai meliputi komunikasi tenaga kesehatan, kenyamanan, serta pengalaman selama mendapatkan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan (Hardianti et al., 2023).

f. Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan (Timeliness Indicators)

Indikator ketepatan waktu mengukur kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan kepada pasien, seperti waktu tunggu dan waktu respons tenaga kesehatan. Pelayanan yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi pasien serta meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diterima (Rubina et al., 2024).

g. Indikator Kepatuhan terhadap Standar (Compliance Indicators)

Indikator ini menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar pelayanan, pedoman klinis, serta regulasi yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kualitas pelayanan yang baik dan konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip mutu (Fauziah et al., 2023).

h. Indikator Kinerja Manajemen (Management Performance Indicators)

Indikator kinerja manajemen mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mutu dalam organisasi pelayanan kesehatan. Indikator ini membantu menilai efektivitas sistem manajemen mutu serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan (Akmar, 2025).

Indikator mutu pelayanan keperawatan:

a. Kepatuhan terhadap Standar Asuhan Keperawatan

Kepatuhan terhadap standar asuhan keperawatan menggambarkan tingkat konsistensi perawat dalam melaksanakan proses keperawatan secara menyeluruh, mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi, sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini menjadi indikator penting dalam menjamin kualitas dan kesinambungan pelayanan keperawatan kepada pasien (Fauziah, 2023).

b. Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Keperawatan

Keselamatan pasien merupakan aspek utama dalam mutu pelayanan keperawatan yang berfokus pada upaya pencegahan kesalahan tindakan serta kejadian yang merugikan pasien. Penerapan prinsip keselamatan pasien, seperti identifikasi yang tepat dan sistem pelaporan insiden, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalkan risiko cedera (Syahrul et al., 2021).

c. Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Keperawatan

Kepuasan pasien mencerminkan persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang diterima, termasuk aspek komunikasi, empati, dan kecepatan respons perawat. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan pasien serta standar mutu yang ditetapkan (Ningsih et al., 2023).

d. Kompetensi dan Kinerja Perawat

Kompetensi dan kinerja perawat merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan secara tepat dan aman. Kinerja yang optimal mencerminkan penguasaan keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan (Ellina et al., 2023).

e. Dokumentasi Asuhan Keperawatan

Kelengkapan dan ketepatan dalam pencatatan asuhan keperawatan menjadi indikator penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan serta aspek legal praktik keperawatan. Dokumentasi yang sistematis menunjukkan bahwa proses keperawatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku (Kartika et al., 2022).

f. Komunikasi Terapeutik

Kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik merupakan salah satu indikator mutu yang berperan penting dalam membangun hubungan interpersonal dengan pasien. Komunikasi yang

efektif dapat meningkatkan kepercayaan pasien serta mendukung keberhasilan proses penyembuhan (Ningsih et al., 2023).

g. Ketepatan dan Kecepatan Respons Keperawatan

Indikator ini menilai kemampuan perawat dalam memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan pasien, baik dalam kondisi rutin maupun darurat. Respons yang optimal sangat penting dalam mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan pasien (Murni & Sidaria, 2023).

h. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP)

Penerapan sistem pelayanan keperawatan profesional mencerminkan efektivitas pengelolaan tim keperawatan, termasuk pembagian tugas, koordinasi, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Implementasi sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan melalui kerja tim yang terorganisir dengan baik (Murni & Sidaria, 2023).

i. Pengembangan Kompetensi Perawat

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi indikator penting dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawat berpengaruh terhadap pencapaian indikator mutu pelayanan secara keseluruhan (Hidayah & Nursanty, 2025).

j. Manajemen dan Supervisi Keperawatan

Manajemen dan supervisi keperawatan meliputi kegiatan pengawasan, pembinaan, serta evaluasi terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan. Supervisi yang efektif berperan dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai standar serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan (Hartatie et al., 2024).

6. Model Manajemen Mutu

a. Model Donabedian

Model Donabedian merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan dalam menilai mutu pelayanan kesehatan melalui tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan outcome. Komponen struktur mencakup ketersediaan sumber daya, fasilitas, serta tenaga kesehatan yang mendukung pelayanan. Sementara itu, komponen proses meliputi seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Komponen outcome menggambarkan hasil akhir dari

pelayanan kesehatan, seperti tingkat kesembuhan, kepuasan pasien, serta peningkatan kualitas hidup. Model ini menegaskan bahwa mutu pelayanan yang optimal dapat dicapai apabila terdapat hubungan yang efektif antara struktur yang memadai dan proses pelayanan yang berkualitas (Donabedian, 1988).

b. Total Quality Management (TQM)

Total Quality Management merupakan pendekatan manajerial yang berorientasi pada peningkatan mutu secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi tim, fokus pada kepuasan pelanggan, serta komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan organisasi (Sallis, 2014). Dalam pelayanan kesehatan, penerapan TQM dilakukan melalui pendekatan sistematis yang melibatkan seluruh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Implementasi TQM terbukti mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Mosadeghrad, 2015).

c. Continuous Quality Improvement (CQI)

Continuous Quality Improvement merupakan pendekatan yang berfokus pada upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui proses evaluasi dan perbaikan sistem pelayanan. Pendekatan ini umumnya menggunakan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) sebagai metode untuk mengidentifikasi permasalahan serta merancang solusi dalam pelayanan kesehatan (Institute of Medicine, 2001). Melalui pendekatan ini, organisasi pelayanan kesehatan dapat melakukan inovasi serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan pelayanan. Oleh karena itu, CQI menjadi strategi yang penting dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan (Sallis, 2014).

7. Implementasi Manajemen Mutu Dalam Praktek Keperawatan

Perawat memiliki posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan manajemen mutu karena merupakan tenaga kesehatan yang paling intens berinteraksi langsung dengan pasien dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, perawat dituntut untuk mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip mutu ke dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan guna menjamin kualitas pelayanan yang optimal (American Nurses Association, 2015).

Penerapan manajemen mutu dalam praktik keperawatan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan standar asuhan keperawatan, penggunaan praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), serta penyusunan

dokumentasi yang lengkap, akurat, dan sistematis. Dokumentasi yang berkualitas tidak hanya mendukung proses evaluasi mutu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien (Mosadeghrad, 2015). Selain itu, kegiatan audit keperawatan dan supervisi klinik menjadi komponen penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan. Melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, perawat dapat mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan serta melakukan perbaikan yang diperlukan secara tepat (Sallis, 2014).

8. Peran Tenaga Kesehatan Dalam Manajemen Mutu

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam implementasi manajemen mutu karena mereka merupakan pelaksana utama dalam pelayanan kesehatan. Peran tersebut antara lain:

a. Pelaksana pelayanan klinis yang berkualitas

Tenaga kesehatan berperan sebagai pelaksana utama dalam pemberian pelayanan kepada pasien, sehingga mutu pelayanan sangat bergantung pada kompetensi dan kinerja yang dimiliki. Pelayanan yang diberikan secara profesional, sesuai standar, dan berorientasi pada kebutuhan pasien terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pasien (Triana et al., 2025).

b. Implementasi keselamatan pasien (Patient Safety)

Tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam menerapkan prinsip keselamatan pasien melalui identifikasi risiko, pelaporan insiden, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip ini terbukti dapat meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan kejadian yang tidak diharapkan (Rorosati et al., 2023).

c. Pengelolaan sumber daya secara efektif

Tenaga kesehatan juga berperan dalam memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, termasuk pemanfaatan waktu, tenaga, dan fasilitas pelayanan. Pengelolaan sumber daya yang optimal berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan serta menjamin keberlangsungan pelayanan yang berkualitas (Purbasari, 2025).

d. Peran dalam manajemen sumber daya manusia

Selain sebagai pelaksana pelayanan, tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem manajemen sumber daya manusia yang mencakup pengembangan kompetensi, pelatihan, serta evaluasi kinerja. Pengelolaan SDM yang baik terbukti berpengaruh terhadap peningkatan

mutu pelayanan dan pencapaian standar akreditasi (Purba & Ningsih, 2025).

e. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan informasi kesehatan

Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan data pasien secara akurat melalui sistem dokumentasi dan informasi kesehatan. Pengelolaan data yang baik mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperkuat sistem manajemen mutu (Ridwan, 2025).

f. Kolaborasi interprofesional

Kerja sama antar tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu merupakan komponen penting dalam manajemen mutu. Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan, meminimalkan kesalahan, serta memperbaiki hasil pelayanan kesehatan bagi pasien (Rudiansyah et al., 2025).

g. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi rumah sakit, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (Asti et al., 2025).

h. Pelaksanaan audit dan evaluasi mutu

Tenaga kesehatan terlibat dalam kegiatan audit mutu serta evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Melalui evaluasi yang sistematis, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi permasalahan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan (Purba & Ningsih, 2025).

i. Pengembangan budaya mutu dan keselamatan

Tenaga kesehatan berkontribusi dalam membangun budaya mutu dan keselamatan melalui penerapan standar, komunikasi terbuka, serta pembelajaran dari setiap kesalahan yang terjadi. Budaya mutu yang kuat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi manajemen mutu di fasilitas pelayanan kesehatan (Purba & Ningsih, 2025).

j. Peningkatan kompetensi berkelanjutan

Tenaga kesehatan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kompetensi ini berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin keselamatan pasien (Ridwan, 2025).

Dengan demikian, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan implementasi manajemen mutu, karena mereka berada di garis terdepan dalam pelayanan kesehatan dan berinteraksi secara langsung dengan pasien.

9. Peran Organisasi Dalam Peningkatan Mutu

Organisasi pelayanan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu. Kepemimpinan yang efektif serta komitmen kuat dari pihak manajemen menjadi faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan budaya mutu yang berkelanjutan (Sallis, 2014).

Di samping itu, organisasi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang memadai, meliputi tenaga kesehatan yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta sistem informasi yang mendukung. Ketersediaan sumber daya tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien (Mosadeghrad, 2015).

Kolaborasi antar tenaga kesehatan juga merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. Kerja sama yang baik dapat meningkatkan koordinasi dalam proses pelayanan serta menurunkan risiko terjadinya kesalahan medis.

10. Dokumentasi Dalam Sistem Manajemen Mutu

Dokumentasi merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen mutu karena berfungsi sebagai bukti bahwa pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dokumentasi yang tersusun dengan baik akan mempermudah proses evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktik keperawatan, dokumentasi meliputi seluruh tahapan proses asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Dokumentasi yang lengkap dan akurat dapat menunjang keselamatan pasien serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan (American Nurses Association, 2015).

Selain itu, dokumentasi juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan audit mutu dan proses akreditasi. Melalui dokumentasi yang tersedia, organisasi pelayanan kesehatan dapat membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

11. Implementasi Sistem Manajemen Mutu

Implementasi sistem manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan. Tahapan-tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mutu dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan (World Health Organization, 2020).

Salah satu metode yang umum digunakan dalam penerapan sistem mutu adalah siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan (Institute of Medicine, 2001).

Keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu sangat ditentukan oleh komitmen seluruh anggota organisasi serta dukungan penuh dari pihak manajemen. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap pentingnya mutu pelayanan (Sallis, 2014).

C. Konsep Dasar Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera yang tidak diinginkan akibat kesalahan dalam proses pelayanan. Dalam beberapa dekade terakhir, isu keselamatan pasien menjadi perhatian global seiring dengan tingginya angka kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) di berbagai fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2021).

Kompleksitas sistem pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi serta penggunaan teknologi yang beragam meningkatkan potensi terjadinya kesalahan medis. Kesalahan tersebut dapat muncul pada setiap tahapan pelayanan, mulai dari proses diagnosis hingga tindakan terapeutik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengendalikan risiko guna melindungi pasien dari kemungkinan bahaya (Institute of Medicine, 2001).

Dalam praktik keperawatan, keselamatan pasien menjadi tanggung jawab utama karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi secara langsung dengan pasien. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keselamatan pasien sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang aman dan berkualitas (American Nurses Association, 2015).

1. Definisi Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera atau kerugian pada pasien melalui proses identifikasi, analisis, dan pengendalian berbagai risiko yang muncul selama pelayanan berlangsung. Konsep ini menekankan pentingnya upaya pengurangan kesalahan serta penerapan praktik yang aman guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Kotwal et al., 2025).

Keselamatan pasien juga dapat dipahami sebagai rangkaian upaya terpadu yang dirancang untuk menurunkan risiko insiden yang merugikan pasien, baik akibat kesalahan manusia maupun kegagalan sistem. Pendekatan ini melibatkan penguatan budaya keselamatan, peningkatan komunikasi efektif, serta penerapan standar operasional yang aman dalam praktik pelayanan kesehatan (Hendri et al., 2024).

Dalam konteks keperawatan, keselamatan pasien merupakan bagian dari budaya organisasi yang berorientasi pada perlindungan pasien dari potensi bahaya yang dapat dicegah, melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, sistem pelaporan insiden, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap kesalahan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien merupakan tanggung jawab bersama antara individu dan sistem pelayanan kesehatan (Glarcher & Vaismoradi, 2024).

Keselamatan pasien juga dimaknai sebagai penerapan praktik klinis yang aman dengan memanfaatkan protokol, teknologi, dan sistem pelayanan yang efektif untuk meminimalkan kesalahan medis, terutama di era digitalisasi pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap aspek keselamatan guna mencegah munculnya risiko baru (Ibrahim et al., 2024).

Selain itu, keselamatan pasien merupakan hasil dari upaya berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan sistem dalam organisasi pelayanan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran tenaga kesehatan serta pengembangan budaya mutu dalam pelayanan (Naomi & Bahari, 2024).

2. Tujuan Dan Manfaat Keselamatan Pasien

Tujuan utama keselamatan pasien adalah untuk mencegah serta menurunkan risiko terjadinya cedera selama proses pelayanan kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui penerapan standar pelayanan yang aman serta pengembangan sistem yang mampu mengidentifikasi dan mencegah

kesalahan sebelum berdampak pada pasien (Tadia et al., 2025). Selain itu, keselamatan pasien juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan yang aman terbukti mampu memperbaiki hasil klinis pasien serta menurunkan angka kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) dalam sistem pelayanan kesehatan (Hesgrove et al., 2024).

Keselamatan pasien juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Pasien yang merasa terlindungi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta kepercayaan yang lebih kuat terhadap tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan (Ramos & Abós, 2024). Dari perspektif organisasi, penerapan keselamatan pasien dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan menekan biaya yang timbul akibat kesalahan medis. Insiden keselamatan pasien seringkali menimbulkan beban biaya tambahan yang signifikan bagi sistem kesehatan (Vibe et al., 2024). Dengan demikian, keselamatan pasien tidak hanya berdampak pada individu pasien, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi organisasi pelayanan kesehatan serta sistem kesehatan secara keseluruhan

3. Prinsip-prinsip Keselamatan Pasien

Prinsip keselamatan pasien merupakan pedoman penting dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek yang harus diterapkan secara konsisten oleh tenaga kesehatan dalam setiap proses pelayanan.

a. Mengutamakan keselamatan pasien.

   Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan. Setiap keputusan klinis yang diambil perlu mempertimbangkan potensi risiko yang dapat berdampak pada pasien (World Health Organization, 2021).

b. Pendekatan sistem.

   Kesalahan dalam pelayanan kesehatan umumnya tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga oleh kelemahan dalam sistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi serta memperbaiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kesalahan (Reason, 2000).

c. Pelaporan Insiden.

   Pelaporan insiden merupakan komponen penting dalam keselamatan pasien karena memungkinkan organisasi belajar dari kejadian

yang telah terjadi. Sistem pelaporan yang efektif akan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan (Institute of Medicine, 2001).

d. Pembelajaran dari kesalahan.

Setiap insiden yang terjadi perlu dianalisis untuk menemukan akar penyebabnya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan sistem dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang (World Health Organization, 2021).

e. Komunikasi efektif.

Komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan sangat berperan dalam mencegah kesalahan selama proses pelayanan. Informasi yang disampaikan secara jelas dan tepat dapat meningkatkan keselamatan pasien (Joint Commission, 2021).

f. Keterlibatan pasien.

Pelibatan pasien dan keluarga dalam proses pelayanan kesehatan menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan yang diberikan (World Health Organization, 2021).

4. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran keselamatan pasien digunakan untuk meningkatkan keselamatan pelayanan kesehatan dengan tujuan mengurangi risiko kesalahan yang dapat membahayakan pasien. Sasaran keselamatan pasien biasanya mencakup:

a. Identifikasi pasien secara tepat

Ketepatan dalam mengidentifikasi pasien merupakan komponen mendasar dalam upaya pencegahan kesalahan medis, seperti kekeliruan pemberian obat, tindakan, maupun prosedur klinis. Praktik yang direkomendasikan adalah penggunaan minimal dua identitas unik pasien, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, yang harus diverifikasi sebelum setiap intervensi. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa kepatuhan tenaga kesehatan terhadap prosedur identifikasi pasien berkorelasi dengan penurunan insiden keselamatan pasien serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Saptomo et al., 2025; Nugraheni et al., 2024).

b. Meningkatkan komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif di antara tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan serta meminimalkan risiko kesalahan klinis. Penerapan metode komunikasi terstruktur, seperti

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), terbukti meningkatkan kejelasan penyampaian informasi dan mengurangi potensi miskomunikasi. Berbagai studi mengungkapkan bahwa kegagalan komunikasi merupakan faktor dominan penyebab insiden keselamatan pasien, sehingga penguatan komunikasi efektif menjadi prioritas dalam sistem pelayanan kesehatan (Fauzi et al., 2025; Wahid & Mudayana, 2021).

c. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai

Pengelolaan obat, khususnya obat dengan tingkat risiko tinggi, merupakan aspek krusial dalam keselamatan pasien. Upaya yang dilakukan meliputi penerapan sistem pelabelan yang jelas, penyimpanan khusus, serta proses verifikasi berlapis sebelum obat diberikan kepada pasien. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam pemberian obat masih sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan penguatan sistem manajemen obat yang terstandar dan berorientasi pada keselamatan pasien (Sendoh et al., 2023; Fauzi et al., 2025).

d. Memastikan lokasi, prosedur, dan pasien yang tepat (tepat Ooperasi)

Kesalahan dalam prosedur pembedahan, seperti salah pasien, salah lokasi, atau salah tindakan, merupakan kejadian serius yang sebenarnya dapat dicegah. Salah satu strategi yang efektif adalah penerapan surgical safety checklist secara konsisten dalam setiap prosedur operasi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan checklist ini mampu menurunkan angka komplikasi serta mortalitas perioperatif, sehingga meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan. Oleh karena itu, proses verifikasi sebelum tindakan menjadi bagian integral dalam sistem keselamatan pasien (Hardy et al., 2023; Wahid & Mudayana, 2021).

e. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan

Infeksi yang terjadi selama proses pelayanan kesehatan merupakan indikator penting dalam evaluasi keselamatan pasien. Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan standar pencegahan dan pengendalian infeksi, termasuk praktik kebersihan tangan sesuai pedoman WHO, penggunaan alat pelindung diri, serta prosedur sterilisasi alat medis. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap protokol tersebut secara signifikan dapat menekan angka kejadian infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan (Sendoh et al., 2023; Fauzi et al., 2025).

f. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh

Insiden pasien jatuh merupakan salah satu masalah keselamatan yang sering dijumpai, terutama pada kelompok pasien lanjut usia atau dengan keterbatasan mobilitas. Strategi pencegahan meliputi asesmen

risiko jatuh secara berkala, penggunaan alat bantu yang sesuai, serta pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program pencegahan jatuh yang terstruktur mampu mengurangi kejadian cedera serta meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (Hardy et al., 2023; Saptomo et al., 2025).

5. Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien adalah seperangkat nilai, sikap, dan tindakan dalam sebuah institusi yang mengutamakan keselamatan pasien. Budaya ini menunjukkan dedikasi institusi untuk membangun lingkungan operasional yang aman (Ramos & Abós, 2024). Indikator kuat dari budaya keselamatan yang efektif meliputi komunikasi yang transparan dalam melaporkan insiden, pertukaran informasi yang lancar, dan penolakan terhadap budaya yang mencari kesalahan. Pemeliharaan sebuah lingkungan yang mendorong pengungkapan kekeliruan merupakan elemen krusial dalam memajukan sistem penyampaian layanan (Butler et al., 2024)

Studi mengindikasikan bahwa budaya keselamatan pasien yang kokoh berkontribusi pada peningkatan mutu layanan dan penurunan insiden yang tidak diharapkan secara substansial (Hesgrove et al., 2024). Kepemimpinan memainkan peran krusial dalam pembentukan budaya keselamatan pasien. Para pemimpin yang mengedepankan keselamatan pasien akan memotivasi para profesional kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga keselamatan pasien (Sadeghi et al., 2025). Oleh karena itu, budaya keselamatan pasien menjadi pilar fundamental dalam pengembangan sistem layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan.

6. Peran Perawat Dalam Keselamatan Pasien

Perawat memegang peranan krusial dalam menjamin keamanan pasien mengingat interaksi berkelanjutan sepanjang waktu. Perawat memiliki kewajiban untuk mengonfirmasi bahwa setiap prosedur yang dilaksanakan sejalan dengan protokol yang berlaku (American Nurses Association, 2015).

Fungsi perawat dalam aspek keselamatan pasien mencakup verifikasi identitas pasien yang akurat, administrasi medikasi yang aman, sarana komunikasi yang efisien, dan pencatatan data yang tepat. Lebih lanjut, perawat juga bertugas melaporkan kejadian yang tidak diinginkan dan memberikan penyuluhan kepada pasien beserta keluarganya (World Health Organization, 2021).

Melalui peningkatan kapabilitas dan pemahaman mengenai keselamatan pasien, perawat dapat turut serta dalam mewujudkan layanan kesehatan yang aman dan bermutu tinggi (Institute of Medicine, 2001).

7. Implementasi Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Keselamatan pasien diaplikasikan melalui beragam inisiatif, termasuk adopsi prosedur operasi standar (SOP), pemanfaatan teknologi digital, dan program pengembangan profesional bagi para praktisi medis. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk meminimalkan potensi kekeliruan dan menyempurnakan mutu layanan yang diberikan (World Health Organization, 2021).

Salah satu metode yang terbukti berhasil dalam mewujudkan keselamatan pasien adalah penerapan Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis/RCA) untuk menginvestigasi kejadian yang tidak diinginkan. Pendekatan ini memfasilitasi organisasi dalam menentukan faktor-faktor fundamental di balik suatu persoalan dan merumuskan intervensi yang sesuai (Institute of Medicine, 2001).

Lebih lanjut, pembentukan kultur keselamatan yang kuat serta partisipasi aktif dari seluruh staf medis merupakan elemen krusial bagi keberhasilan dalam mewujudkan keselamatan pasien. Dengan fondasi ini, institusi dapat membangun sistem penyediaan layanan yang aman dan lestari (Reason, 2000).

D. Insiden Keselamatan Pasien Dan Manajemen Resiko

Peristiwa yang berkaitan dengan keselamatan pasien adalah kejadian yang tidak diinginkan yang berakibat kesakitan atau kemungkinan kesakitan pada pasien selama proses pemberian layanan medis. Kejadian-kejadian ini berfungsi sebagai penanda krusial dalam evaluasi kualitas dan keamanan layanan kesehatan. Frekuensi kejadian yang tinggi mengindikasikan adanya kekurangan dalam sistem pelayanan yang memerlukan tindakan korektif segera (World Health Organization, 2021).

Kompleksitas dalam penyediaan layanan kesehatan, yang mencakup beragam disiplin ilmu, perangkat teknologi, dan protokol prosedural, berkontribusi pada peningkatan potensi terjadinya insiden keselamatan pasien. Konsekuensinya, strategi terstruktur sangat esensial untuk mendeteksi, mengkaji, dan menghindari insiden semacam itu. Strategi ini lazim disebut sebagai manajemen risiko dalam sektor layanan kesehatan (Institute of Medicine, 2001).

Manajemen risiko dirancang untuk menurunkan probabilitas kesalahan dan membatasi konsekuensi jika suatu insiden terjadi. Implementasi manajemen risiko

yang efisien memungkinkan institusi untuk memperbaiki keamanan pasien dan mutu layanan secara menyeluruh (Reason, 2000).

1. Definisi Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien adalah peristiwa yang tidak diinginkan yang berakibat atau dapat berakibat terjadinya cedera pada pasien. Peristiwa ini bisa timbul dari kekeliruan dalam alur pelayanan atau kegagalan sistem dalam institusi penyedia layanan kesehatan (Tadia et al., 2025).

Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, insiden keselamatan pasien merujuk pada seluruh kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien, meliputi yang mengakibatkan cedera maupun yang tidak menimbulkan konsekuensi langsung. (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Isu keselamatan pasien tidak semata-mata merefleksikan kekhilafan perseorangan, tetapi juga mengindikasikan adanya defisiensi dalam mekanisme pelayanan. Konsekuensinya, investigasi insiden perlu dilaksanakan secara komprehensif demi menentukan penyebab fundamentalnya (Reason, 2000).

2. Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan konsekuensi dan kemungkinan yang timbul (Butler et al., 2024).

a. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

   KTD merupakan insiden yang mengakibatkan kerugian pada pasien yang disebabkan oleh intervensi medis atau kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan. Kejadian ini berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap keamanan pasien

b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

   KNC adalah insiden yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, namun berhasil dihindari sebelum terjadi pada pasien. Insiden ini menyediakan kesempatan untuk evaluasi dan perbaikan tanpa menimbulkan dampak negatif secara langsung.

c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)

   KTC merupakan insiden yang terjadi namun tidak berakibat pada cedera pasien. Walaupun tidak menyebabkan kerugian langsung, insiden semacam ini tetap memerlukan pelaporan dan investigasi.

d. Kondisi Potensial Cedera (KPC)

KPC merujuk pada suatu keadaan yang memiliki kemungkinan memicu cedera apabila tidak segera diatasi. Pengenalan KPC sangatlah krusial guna menghindari terwujudnya insiden yang berimplikasi lebih serius.

e. Kejadian Sentinel

Kejadian sentinel didefinisikan sebagai sebuah insiden dengan tingkat keparahan tinggi yang berakibat pada hilangnya nyawa pasien atau timbulnya cedera permanen. Kejadian semacam ini menuntut dilakukannya investigasi komprehensif guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali peristiwa serupa.

Kekeliruan dalam praktik medis berkontribusi signifikan terhadap terjadinya insiden dalam aspek keselamatan pasien. Kesalahan tersebut dapat muncul dalam berbagai tahapan penyediaan layanan, termasuk proses diagnosis, administrasi terapi farmakologis, serta interaksi komunikasi di antara para profesional kesehatan (Hesgrove et al., 2024).

3. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Identifikasi dan pelaporan kejadian merupakan komponen krusial dalam kerangka kerja keselamatan pasien, memfasilitasi pembelajaran organisasi dari kekeliruan yang teridentifikasi. Sebuah mekanisme pelaporan yang efisien seharusnya mengadopsi pendekatan yang tidak menghukum, yang berarti individu yang melaporkan kejadian tidak akan dikenakan sanksi (World Health Organization, 2021).

Proses pelaporan kejadian memerlukan pendekatan yang terstruktur, serta pengumpulan data yang komprehensif terkait dengan peristiwa yang terjadi. Informasi yang dikumpulkan melalui pelaporan ini akan berkontribusi pada evaluasi dan penyempurnaan prosedur layanan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Pembentukan etos pelaporan yang positif akan memperkuat keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam lingkungan organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mendeteksi potensi masalah sejak awal dan menghindari terulangnya insiden yang lebih parah (Reason, 2000).

Studi terbaru menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan masih menghadapi masalah dengan pelaporan insiden. Banyak insiden yang tidak dilaporkan karena budaya menyalahkan organisasi (Ramos & Abós, 2024). Oleh karena itu, sistem pelaporan insiden yang efisien sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan.

a. Jenis Insiden yang Dilaporkan

Jenis insiden yang perlu dilaporkan mencakup berbagai kategori, yaitu kejadian tidak diharapkan (adverse event), kejadian nyaris cedera (near miss), kejadian tanpa cedera (no harm incident), serta kondisi potensial cedera. Seluruh kategori tersebut penting untuk dilaporkan karena memberikan informasi yang bermanfaat dalam mendeteksi risiko serta mencegah kejadian yang lebih serius di masa mendatang. Penelitian menunjukkan bahwa pelaporan tidak hanya difokuskan pada kejadian yang menimbulkan cedera, tetapi juga pada kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya (Nofita & Wulandari, 2025).

b. Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Proses pelaporan insiden keselamatan pasien umumnya melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi kejadian, pelaporan oleh tenaga kesehatan, pencatatan dalam sistem yang tersedia, analisis insiden menggunakan metode seperti *root cause analysis*, serta tindak lanjut berupa perbaikan sistem. Penelitian menunjukkan bahwa pelaporan sebaiknya dilakukan segera, idealnya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian, guna memastikan keakuratan informasi dan efektivitas proses tindak lanjut (Lombongkaehe et al., 2023).

4. Faktor Penyebab Insiden Keselamatan Pasien

Berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam sistem pelayanan kesehatan dapat menyebabkan insiden keselamatan pasien. Salah satu penyebab utama kesalahan pelayanan adalah komunikasi yang tidak efektif (Tadia et al., 2025). Faktor-faktor organisasi seperti ketidakjelasan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan sistem pengawasan yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien (Hesgrove et al., 2024).

Faktor manusia seperti kelelahan, stres kerja, dan ketidakmampuan juga berkontribusi terhadap kesalahan medis. Kondisi kerja yang tidak sehat dapat berdampak pada seberapa baik karyawan kesehatan memberikan layanan (Ramos & Abós, 2024). Selain itu, teknologi yang tidak digunakan dengan benar dapat menjadi sumber risiko bagi layanan kesehatan. Kesalahan lebih mungkin terjadi ketika teknologi digunakan tanpa pelatihan yang tepat (Alabdullah & Karwowski, 2024). Oleh karena itu, pendekatan sistem yang komprehensif diperlukan untuk menemukan dan secara efektif mengatasi masalah yang mengancam keselamatan pasien.

5. Manajemen Resiko Dalam Pelayanan Kesehatan

Proses sistematis yang digunakan untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan layanan kesehatan dikenal sebagai manajemen risiko. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengurangi kemungkinan insiden dan dampak yang ditimbulkannya (World Health Organization, 2021).

Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko adalah langkah-langkah dalam manajemen risiko, untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif, setiap langkah harus dilakukan secara sistematis (Reason, 2000).

Manajemen risiko biasanya melibatkan seluruh tenaga kesehatan dan memerlukan dukungan dari manajemen organisasi. Organisasi dapat membuat lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien dengan menerapkan manajemen risiko yang baik (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

6. Implementasi Manajemen Resiko

Manajemen risiko diterapkan melalui berbagai cara, seperti membuat kebijakan, memberikan pelatihan kesehatan, dan menggunakan teknologi informasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendorong tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengelola risiko (World Health Organization,2021). Guna memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik, monitoring dan evaluasi rutin juga diperlukan, ini akan membantu organisasi menemukan masalah dan memperbaikinya (Institute of Medicine, 2001).

Manajemen risiko sangat bergantung pada komitmen seluruh staf dan budaya keselamatan yang kuat. Oleh karena itu, organisasi dapat terus meningkatkan keselamatan pasien.

E. Mini Case

Kasus 1.

Seorang perawat di ruang rawat inap melakukan tindakan pemberian obat kepada pasien tanpa melakukan verifikasi dua identitas pasien secara lengkap. Dalam audit internal bulanan, ditemukan bahwa dari 50 observasi tindakan keperawatan, hanya 38 tindakan yang memenuhi standar identifikasi pasien yang benar sesuai SOP rumah sakit. Tim mutu kemudian mencatat adanya ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan (100%) dengan capaian aktual.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa kasus diatas, pertanyaan diskusi:

1. Analisis ketepatan proses audit yang dilakukan dalam kasus di atas
2. Identifikasi kesenjangan antara standar dan capaian
3. Tentukan akar masalah menggunakan pendekatan (misalnya fishbone atau RCA)
4. Rancang rekomendasi perbaikan berbasis indikator mutu

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Kasus 2.

Seorang perawat di ruang rawat inap memberikan obat injeksi kepada pasien tanpa melakukan verifikasi dua identitas pasien. Perawat hanya menanyakan nama pasien tanpa mencocokkan dengan gelang identitas. Setelah pemberian obat, diketahui bahwa obat tersebut seharusnya diberikan kepada pasien lain dengan nama yang mirip.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa kasus diatas, pertanyaan diskusi:

1. Analisis kejadian berdasarkan prinsip keselamatan pasien
2. Identifikasi faktor penyebab
3. Berikan rekomendasi perbaikan

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Kasus 3.

Di ruang ICU, dua jenis obat dengan kemasan dan nama yang mirip disimpan berdekatan tanpa label khusus. Seorang perawat secara tidak sengaja mengambil obat yang salah dan memberikannya kepada pasien.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisa kasus diatas, pertanyaan diskusi:

1. Identifikasi jenis kesalahan
2. Analisis faktor sistem
3. Berikan rekomendasi perbaikan

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

F. Rangkuman Materi

Manajemen mutu merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mampu meningkatkan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan keperawatan, manajemen mutu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga menekankan pada proses pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Konsep dasar manajemen mutu mencakup *continuous quality improvement* (CQI), pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*), pengambilan keputusan berbasis data, serta keterlibatan seluruh tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan mutu. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu memerlukan budaya organisasi yang mendukung kualitas, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.

Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efektivitas, efisiensi, keselamatan pasien, aksesibilitas, kesinambungan pelayanan, dan kepuasan pasien. Dalam praktik keperawatan, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kompetensi perawat, kemampuan komunikasi terapeutik, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Faktor-faktor tersebut menjadi penentu utama dalam menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas bagi pasien.

Implementasi manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan dilakukan melalui berbagai metode, seperti audit mutu, penggunaan indikator mutu, akreditasi rumah sakit, serta penerapan siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Audit mutu berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan indikator mutu digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pelayanan secara objektif dan berkelanjutan.

Salah satu komponen utama dalam manajemen mutu adalah keselamatan pasien, yang berfokus pada upaya pencegahan kesalahan medis dan kejadian tidak

diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penerapan standar keselamatan pasien, sistem pelaporan insiden, serta pembelajaran organisasi terhadap kesalahan yang terjadi. Insiden keselamatan pasien umumnya disebabkan oleh faktor manusia, kesalahan komunikasi, maupun kelemahan sistem pelayanan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keselamatan pasien menjadi sangat penting, seperti identifikasi pasien yang tepat, komunikasi yang efektif, serta pelaporan insiden secara terbuka tanpa budaya menyalahkan (*no blame culture*). Budaya keselamatan pasien harus dibangun agar tercipta lingkungan pelayanan yang aman dan mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dengan demikian, manajemen mutu dalam pelayanan keperawatan merupakan suatu proses berkesinambungan yang membutuhkan komitmen organisasi, kepemimpinan yang efektif, serta partisipasi aktif seluruh tenaga kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan dapat dicapai melalui penerapan sistem yang terstruktur, penggunaan indikator mutu yang tepat, serta keterlibatan seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada pasien.

G. Daftar Pustaka

Akmar, M. (2025). Implementasi indikator kinerja dalam peningkatan mutu layanan RSUD

Al Kuwaiti, A., et al. (2020). Healthcare quality improvement. *International Journal of Health Care Quality Assurance*.

Alabdullah, H., & Karwowski, W. (2024). Patient safety culture in hospital settings: A systematic review. *Applied Sciences*.

Alolayyan, M. N., et al. (2021). Healthcare quality and performance. *Journal of Healthcare Quality*.

American Nurses Association. (2015). *Nursing: Scope and standards of practice*.

Askarila, A. A., & Kholidah, D. (2024). Analisis dimensi mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 10(2). https://doi.org/10.31290/jiki.v10i2.5052

Asti, R. D., et al. (2025). Inovasi manajemen organisasi kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan di era digital. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 9(2). https://doi.org/10.57214/jka.v9i2.974

Asti, R., Pratama, D., & Lestari, Y. (2025). Implementasi manajemen mutu berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Abdi Masyarakat*, 6(1), 45–53. https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/jka/article/view/974

Bass, E. B., et al. (2024). Patient safety practices.

Bates, D. W., & Singh, H. (2021). Patient safety and quality improvement. *BMJ Quality & Safety*.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics*.

Budiman, A., & Yudiansyah, R. (2024). Manajemen patient safety dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 239–248. https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5693

Butler, L. R., et al. (2024a). Patient safety culture. *Frontiers in Health Services*.

Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *JAMA*, 260(12), 1743–1748.

Doyle, C., et al. (2020). Patient experience and healthcare quality. *BMJ Open*.

dr. Hasri Ainun Habibie. *Journal of Innovation Research and Knowledge*.

Ellina, A. D., et al. (2023). Implementasi penilaian kinerja berbasis indikator mutu keperawatan. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 31–42. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i1.508

Fauzi, M. D., et al. (2025). Faktor yang memengaruhi implementasi sasaran keselamatan pasien. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 8(1), 45–53.

Fauziah, F. (2023). Hubungan pengetahuan perawat dengan pemenuhan indikator mutu. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4). https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.21791

Ghofar, A., et al. (2022). Manajemen budaya keselamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien. *Jurnal EDUNursing*, 5(2). https://doi.org/10.26594/edunursing.v5i2.2949

Glarcher, M., & Vaismoradi, M. (2024). Specialized nurses and patient safety culture. *Journal of Advanced Nursing*, 81(9), 5248–5263. https://doi.org/10.1111/jan.16105

Hardianti, E., et al. (2023). Penerapan indikator nasional mutu rumah sakit. *Jurnal Kajian Kesehatan Masyarakat*, 5(1). https://doi.org/10.36656/jk2m.v5i1.1497

Hardy, B. L., et al. (2023). Analisis implementasi keselamatan pasien. *J-REMI*, 4(2), 120–128.

Hardy, S. M., & Paramarta, V. (2024). Risk management and service quality on patient satisfaction.

Hendri, K., et al. (2024). Patient safety culture review. *Medical Profession Journal of Lampung*.

Hesgrove, B., et al. (2024). Patient safety culture and workplace safety. *BMC Health Services Research*.

Hidayah, K. N., & Nursanty, O. E. (2025). Pengetahuan perawat dan indikator mutu. *Jurnal Kesehatan Tambusai*.

Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm*. National Academy Press.

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001: Quality management systems*.

Jumila, R. (2022). Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(5).

Kartono, B., & Wirawan, H. (2024). Penerapan manajemen mutu. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 8(2), 112–120.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman keselamatan pasien rumah sakit*.

Khairunnisa, W., et al. (2025). Dimensi mutu pelayanan kesehatan. *Applicare Journal*, 2(4), 259–270.

Kotwal, N., et al. (2025). Patient safety culture study. *Journal of Family Medicine and Primary Care*.

Lombongkaehe, C. M. N., et al. (2023). Pelaporan insiden keselamatan pasien. *Medical Scope Journal*, 4(2).

Maulia, S., & Hartono, A. (2024). Strategi manajemen mutu. *Ovum: Jurnal Kesehatan*, 3(1), 25–33.

Montolalu, I. A., et al. (2024). Patient safety and reporting. *Journal of Academic Science*.

Mosadeghrad, A. M. (2015). Healthcare service quality. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 26(3), 203–219.

Mulyani, S., et al. (2024). Pengetahuan tenaga kesehatan dengan patient safety.

Muniifah, A. N. A., et al. (2025). Fungsi manajemen dengan patient safety.

Naomi, R., & Bahari, H. (2024). Patient safety education. *International Journal of Patient Safety and Quality*.

Nguyen, H., et al. (2021). Healthcare quality improvement. *Healthcare Journal*.

Nofita, S. A., & Wulandari, C. I. (2025). Pelaporan insiden keselamatan pasien. *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA*, 8(3).

Nugraheni, S. W., et al. (2024). Patient identification. *Procedia of Engineering and Life Science*, 4, 1–7.

O'Connor, P., et al. (2022). Safety science in healthcare. *Safety Science*.

Prayogo, A., et al. (2023). Manajemen mutu organisasi kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 7(2), 78–86.

Putri, D., et al. (2022). Implementasi patient safety. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 101–109.

Ramos, M. J. R., & Abós, S. C. (2024). Patient safety culture. *Healthcare*.

Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*.

Sadeghi, R., et al. (2025). Patient safety culture. *BMC Nursing*.

Saefulmilah, H., et al. (2024). Digitalisasi pelaporan insiden. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(2).

Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.

Saptomo, R. B., et al. (2025). Identifikasi pasien. *Journal of Telenursing*, 7(1), 15–25.

Sendoh, A., et al. (2023). Evaluasi keselamatan pasien. *Medical Scope Journal*, 5(1), 33–41.

Slawomirski, L., et al. (2021). Patient safety policy. *OECD Health Working Papers*.

Sumiati, S., et al. (2023). Manajemen mutu pelayanan kesehatan era JKN.

Susanto, A., & Handiyani, H. (2023). Pelaporan insiden pasien. *Quality: Jurnal Kesehatan*, 17(1), 52–63.

Taylor, M. J., et al. (2021). Quality improvement methods. *BMJ Quality & Safety*.

Triani, L., & Yuwono, B. (2025). Konsep manajemen mutu. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(1), 15–24.

Vibe, A., et al. (2024). Predictors of patient safety culture. *Journal of Patient Safety*.

Wahid, N., & Mudayana, A. A. (2021). Implementasi keselamatan pasien. *International Journal of Healthcare Research*, 4(2), 78–86.

Wahono, W., et al. (2025). Budaya keselamatan pasien. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1429–1439.

World Health Organization. (2020). *Quality of care*.

World Health Organization. (2021). *Patient safety*.

World Health Organization. (2024). *Global patient safety report*.

BAB 7

MANAJEMEN PERUBAHAN, INOVASI, DAN INFORMATIKA KEPERAWATAN

CPL

CPL-6: Menerapkan manajemen mutu, keselamatan pasien, komunikasi-kolaborasi, serta perubahan dan informatika untuk perbaikan berkelanjutan .

CPMK

CPMK-7: Mengelola komunikasi, kolaborasi, konflik, serta perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan untuk peningkatan layanan .

Sub-CPMK

1. Menyusun rencana perubahan/inovasi layanan yang mencakup tujuan, langkah implementasi, strategi komunikasi, kolaborasi tim, mitigasi risiko, dan indikator
2. Memanfaatkan data dan sistem informasi keperawatan untuk monitoring indikator mutu dan keselamatan pasien serta pengambilan

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi perubahan, termasuk resistensi staf dan potensi konflik
3. Menyusun rencana perubahan/inovasi layanan yang mencakup identifikasi masalah, tujuan, strategi implementasi, komunikasi, kolaborasi, mitigasi risiko, dan indikator keberhasilan.
4. Menerapkan prinsip komunikasi profesional dan kolaborasi tim dalam pelaksanaan perubahan .
5. Memanfaatkan data dan sistem informasi keperawatan untuk monitoring indikator mutu dan pengambilan keputusan .

Pendahuluan

Perubahan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam setiap organisasi, termasuk organisasi pelayanan kesehatan. Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan masyarakat, regulasi pemerintah, standar akreditasi, dan kemajuan teknologi digital. Dalam konteks keperawatan, perubahan tidak hanya berkaitan dengan pembaruan prosedur klinis, tetapi juga menyangkut cara berpikir, budaya kerja, sistem dokumentasi, pola komunikasi, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola perubahan, mengembangkan inovasi, dan memanfaatkan informatika keperawatan secara efektif agar pelayanan yang diberikan tetap bermutu tinggi, aman, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien [Salma & Waelli, 2022; World Health Organization, 2020].

Perubahan dalam pelayanan kesehatan terjadi dengan sangat cepat. Globalisasi, perkembangan teknologi medis, peningkatan kompleksitas penyakit, perubahan demografi penduduk, dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap mutu layanan mendorong organisasi kesehatan untuk terus melakukan pembaruan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bahwa sistem pelayanan kesehatan harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap kondisi yang dinamis. Perawat sebagai profesi dengan jumlah terbesar dalam sistem kesehatan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu kontinuitas dan keselamatan asuhan pasien [McGonigle & Mastrian, 2022].

Dalam praktik sehari-hari, perubahan dapat berupa penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru, penggunaan alat medis yang lebih canggih, penerapan rekam medis elektronik, perubahan model asuhan keperawatan, restrukturisasi organisasi, hingga implementasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Meskipun perubahan bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi, proses implementasinya sering menghadapi tantangan seperti resistensi staf, keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, dan budaya organisasi yang belum mendukung. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan manajemen perubahan yang sistematis agar setiap perubahan dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dipertahankan secara berkelanjutan [Croke, 2021].

Manajemen perubahan merupakan proses terstruktur untuk mempersiapkan individu dan organisasi dalam menghadapi transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan. Dalam ilmu manajemen, berbagai model perubahan telah dikembangkan, seperti model tiga tahap Kurt Lewin (unfreezing, changing, refreezing)

dan delapan langkah perubahan John P. Kotter. Model-model tersebut sangat relevan dalam keperawatan karena membantu pemimpin keperawatan mengidentifikasi kebutuhan perubahan, membangun komitmen tim, mengatasi hambatan, dan memastikan perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi. Perawat manajer, kepala ruangan, dan pemimpin klinis perlu memahami prinsip-prinsip tersebut agar dapat memimpin transformasi pelayanan secara efektif [Leading Change].

Selain kemampuan mengelola perubahan, perawat juga dituntut untuk mengembangkan inovasi. Inovasi merupakan proses menciptakan atau mengadaptasi ide, metode, produk, atau sistem baru yang memberikan nilai tambah bagi pelayanan kesehatan. Inovasi dalam keperawatan dapat berupa pengembangan metode edukasi pasien, penggunaan aplikasi monitoring, penyederhanaan alur kerja, pemanfaatan media digital, hingga penciptaan alat bantu keperawatan. Inovasi sangat penting karena dapat meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi kerja, kepuasan pasien, dan kepuasan tenaga kesehatan. Organisasi profesi seperti American Nurses Association menekankan bahwa inovasi merupakan salah satu kompetensi utama perawat modern.

Budaya inovasi membutuhkan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, kolaborasi interprofesional, pembelajaran berkelanjutan, dan keberanian mencoba pendekatan baru. Pemimpin keperawatan berperan penting dalam menciptakan iklim organisasi yang terbuka terhadap ide-ide baru serta memberikan dukungan sumber daya dan penghargaan terhadap inisiatif staf. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tertentu, tetapi menjadi budaya bersama dalam organisasi pelayanan kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bidang informatika keperawatan (nursing informatics), yaitu integrasi ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan dalam praktik keperawatan. Informatika keperawatan memungkinkan perawat mendokumentasikan asuhan secara elektronik, mengakses data pasien secara real time, menggunakan clinical decision support systems, melakukan analisis data, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti [McGonigle & Mastrian, 2022].

Healthcare Information and Management Systems Society menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan kualitas, keselamatan pasien, efisiensi operasional, dan pengalaman pasien. Contoh penerapan informatika keperawatan meliputi Electronic Health Record, computerized physician order entry, barcode medication administration, telehealth, mobile health applications, dashboard mutu, dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Teknologi-teknologi tersebut membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan koordinasi tim, dan menyediakan data yang akurat untuk evaluasi mutu.

Dalam era digital dan konsep Industry 4.0, perawat tidak lagi hanya mengandalkan keterampilan klinis tradisional, tetapi juga harus memiliki kompetensi digital. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan menggunakan perangkat lunak kesehatan, menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien, menganalisis informasi klinis, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu asuhan. Kurikulum pendidikan keperawatan berbasis Outcome-Based Education (OBE) menempatkan kompetensi ini sebagai capaian pembelajaran yang penting agar lulusan siap menghadapi kebutuhan praktik profesional masa kini dan masa depan.

Pendekatan Outcome-Based Education menekankan bahwa proses pembelajaran harus berfokus pada hasil belajar yang terukur dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu menganalisis kebutuhan perubahan, merancang inovasi sederhana, dan menggunakan prinsip informatika keperawatan dalam situasi nyata di rumah sakit maupun komunitas. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi menghasilkan kompetensi praktis yang dapat diterapkan secara langsung.

Bab ini disusun secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami keterkaitan antara manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar perubahan organisasi, teori dan model manajemen perubahan, strategi mengatasi resistensi, prinsip-prinsip inovasi, hingga penerapan teknologi informasi dalam praktik keperawatan. Pada bagian akhir, mahasiswa akan diajak menganalisis studi kasus dan refleksi penerapan konsep dalam lingkungan pelayanan kesehatan.

Pemahaman terhadap manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan sangat penting bagi perawat masa kini. Ketiga konsep tersebut saling melengkapi: perubahan menyediakan arah transformasi, inovasi menghasilkan solusi kreatif, dan informatika menyediakan dukungan data serta teknologi untuk memastikan keputusan yang tepat. Dengan menguasai kompetensi ini, perawat dapat menjadi agen perubahan yang mampu memimpin transformasi pelayanan kesehatan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, aman, dan berpusat pada pasien.

A. Teori Dasar

Manajemen perubahan adalah proses terstruktur untuk membawa organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan agar layanan menjadi lebih efektif, aman, dan adaptif [StatPearls, 2022; Croke, 2021]. Dalam keperawatan, perubahan dapat muncul karena kebutuhan mutu, keselamatan pasien, tuntutan akreditasi, pembaruan teknologi, atau masalah operasional di unit layanan [Salma & Waelli, 2022].

Model Lewin menjelaskan perubahan melalui tiga tahap, yaitu **unfreezing, changing, dan refreezing** [Lewin, 1951 dalam StatPearls, 2022]. Tahap pertama bertujuan membuka kesiapan perubahan, tahap kedua menjalankan perubahan, dan tahap ketiga memastikan perubahan menjadi kebiasaan baru dalam budaya kerja [StatPearls, 2022; Croke, 2021].

Review ilmiah menunjukkan bahwa perubahan di layanan kesehatan sering gagal bila hanya berfokus pada instruksi tanpa memperhatikan kesiapan staf, komunikasi, dan konteks lapangan [Salma & Waelli, 2022; Croke, 2021]. Karena itu, perubahan yang efektif harus melibatkan staf sejak awal dan disertai evaluasi berkelanjutan [Salma & Waelli, 2022; World Health Organization, 2023].

B. Faktor Keberhasilan Perubahan

Keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin keperawatan dalam membangun komunikasi yang efektif, kolaborasi antarprofesi, dan pengelolaan konflik. Komunikasi yang jelas membantu staf memahami alasan perubahan, manfaat yang diharapkan, serta peran masing-masing dalam proses implementasi. Kolaborasi memungkinkan seluruh anggota tim terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perubahan. Apabila muncul resistensi atau perbedaan pendapat, pemimpin perlu menerapkan teknik manajemen konflik seperti negosiasi, mediasi, dan problem solving agar perubahan tetap berjalan secara konstruktif (Yoder-Wise, 2023; American Nurses Association, 2023; Croke, 2021)

C. Konsep Inovasi Keperawatan

Inovasi keperawatan adalah penerapan ide, metode, atau proses baru untuk meningkatkan kualitas layanan [Kroning & Bleich, 2024; Press & Jones, 2024]. Inovasi tidak selalu berupa teknologi besar; perbaikan alur handover, penggunaan checklist, atau edukasi digital juga dapat disebut inovasi bila memberi dampak pada hasil pelayanan [Kroning & Bleich, 2024].

Penelitian menunjukkan bahwa inovasi lebih berhasil bila berangkat dari masalah nyata di unit, didukung oleh pimpinan, dan diukur dengan indikator yang

jelas [Zahra & George, 2023; Press & Jones, 2024]. Dengan demikian, inovasi sebaiknya dipahami sebagai proses perbaikan berkelanjutan, bukan proyek sekali selesai [Kroning & Bleich, 2024].

D. Informatika Keperawatan

Informatika keperawatan adalah pemanfaatan data, informasi, dan teknologi untuk mendukung praktik, pendidikan, manajemen, dan penelitian keperawatan [McGonigle & Mastrian, 2022; Saba & McCormick, 2021]. Dalam praktik modern, informatika membantu dokumentasi yang lebih sistematis, komunikasi antarprofesi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan berbasis data [Topaz & Pruinelli, 2024].

Sistem informasi keperawatan dan rekam medis elektronik dapat digunakan untuk memantau indikator mutu, mendeteksi risiko, dan mempercepat respon terhadap perubahan kondisi pasien [Elgazzar & Elgazzar, 2025; World Health Organization, 2020]. Karena itu, perawat perlu memiliki literasi data yang cukup agar tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga mampu menafsirkan informasi untuk tindakan klinis [McGonigle & Mastrian, 2022; Topaz & Pruinelli, 2024].

E. Langkah Menyusun Rencana Perubahan

Rencana perubahan yang baik minimal memuat:

1. Identifikasi masalah.
2. Analisis akar penyebab.
3. Tujuan perubahan.
4. Strategi implementasi.
5. Strategi komunikasi perubahan.
6. Mekanisme kolaborasi dan pembagian peran.
7. Jadwal pelaksanaan.
8. Identifikasi risiko dan mitigasi.
9. Indikator keberhasilan.
10. Metode monitoring dan evaluasi.

(Kotter, 2012; Croke, 2021; Salma & Waelli, 2022).

Contoh: bila unit rawat ingin menerapkan handover digital, maka langkah awal adalah memetakan masalah komunikasi saat pergantian shift, melakukan sosialisasi, pelatihan, uji coba terbatas, dan evaluasi hasil [Salma & Waelli, 2022; World Health Organization, 2023].

F. Analisis Kasus

Seorang kepala ruangan ingin menerapkan sistem handover digital untuk mengurangi miskomunikasi antar shift. Sebagian perawat menolak karena merasa sistem baru memperlambat pekerjaan dan khawatir tidak mampu menggunakan teknologi.

Masalah utama tidak hanya terletak pada resistensi staf, tetapi juga pada kurangnya komunikasi sejak tahap awal, minimnya pelibatan anggota tim, dan kekhawatiran terhadap perubahan peran kerja. Strategi yang tepat adalah melakukan sosialisasi manfaat perubahan, melibatkan perawat senior sebagai champion, menyediakan pelatihan dan pendampingan, membuka forum diskusi untuk menampung masukan, serta menerapkan pilot project sebelum implementasi penuh (Kotter, 2012; Press & Jones, 2024; Topaz & Pruinelli, 2024).

Keberhasilan perubahan dapat diukur melalui:

1. Tingkat kepatuhan penggunaan sistem handover digital.
2. Penurunan insiden miskomunikasi.
3. Peningkatan kepuasan staf.
4. Peningkatan kelengkapan dokumentasi.
5. Efisiensi waktu handover.

G. Aktivitas Belajar

Knows

Mahasiswa menjelaskan konsep perubahan, inovasi, informatika keperawatan, komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konflik.Mahasiswa menjelaskan konsep perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-Case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Topik: Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan

Kasus

Di ruang rawat inap sebuah rumah sakit, hasil audit mutu menunjukkan bahwa kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan elektronik hanya mencapai 65%, sedangkan standar rumah sakit menetapkan minimal 95%. Akibatnya, beberapa informasi penting mengenai kondisi pasien tidak tercatat secara lengkap sehingga meningkatkan risiko kesalahan komunikasi antar perawat dan keterlambatan pengambilan keputusan klinis.

Hasil wawancara dengan staf menunjukkan bahwa:

- Sebagian perawat merasa sistem dokumentasi elektronik terlalu rumit.
- Belum semua perawat mendapatkan pelatihan penggunaan sistem.
- Tidak tersedia panduan singkat atau video tutorial.

- Waktu dokumentasi dianggap terlalu lama pada jam-jam sibuk.
- Kepala ruangan ingin meningkatkan kepatuhan dokumentasi dalam waktu satu bulan.

Seorang mahasiswa praktik manajemen keperawatan diminta membantu kepala ruangan untuk menganalisis masalah, merancang strategi perubahan, mengembangkan inovasi, dan memanfaatkan data sistem informasi untuk meningkatkan mutu dokumentasi.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah utama yang terjadi pada unit tersebut.
2. Analisis faktor-faktor penyebab masalah menggunakan pendekatan manajemen perubahan.
3. Tentukan strategi perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dokumentasi elektronik.
4. Usulkan inovasi sederhana yang dapat membantu perawat menggunakan sistem dengan lebih efektif.
5. Jelaskan bagaimana informatika keperawatan dapat dimanfaatkan untuk memantau keberhasilan perubahan.
6. Tentukan indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil intervensi.
7. Jelaskan dampak perbaikan dokumentasi elektronik terhadap keselamatan pasien.

SOAL OSCE KEPERAWATAN

Station: Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor Station	..... (Dikosongkan)
2	Judul Station	Implementasi Manajemen Perubahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Dokumentasi Elektronik Keperawatan
3	Waktu yang Dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan Station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam menganalisis masalah mutu, menyusun strategi perubahan, merancang inovasi sederhana, memanfaatkan informatika keperawatan,

No.	Komponen	Isi
		serta melakukan edukasi kepada staf mengenai peningkatan dokumentasi elektronik.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan kepemimpinan 2. Pengkajian masalah organisasi 3. Analisis dan perencanaan perubahan 4. Pengembangan inovasi 5. Pemanfaatan informatika keperawatan 6. Evaluasi hasil 7. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Manajemen mutu 2. Keselamatan pasien 3. Manajemen perubahan 4. Inovasi keperawatan 5. Informatika keperawatan
7	Instruksi untuk Peserta Ujian	**SKENARIO:** Hasil audit menunjukkan kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan elektronik di ruang rawat inap hanya 65%, sedangkan standar rumah sakit minimal 95%. Beberapa perawat mengeluhkan sistem terlalu rumit dan belum semua mendapatkan pelatihan. Kepala ruangan meminta Anda membantu menyusun solusi. **TUGAS:** 1. Lakukan pengkajian fokus terhadap masalah yang terjadi pada Klien Standar (KS) yang berperan sebagai kepala ruangan. 2. Tuliskan identifikasi akar masalah pada lembar jawaban. 3. Tuliskan rencana perubahan untuk meningkatkan kepatuhan dokumentasi elektronik. 4. Usulkan satu inovasi sederhana yang dapat membantu staf. 5. Jelaskan cara memanfaatkan data sistem informasi untuk memantau keberhasilan.

No.	Komponen	Isi
		6. Lakukan edukasi singkat kepada kepala ruangan mengenai rencana yang Anda susun.
8	Instruksi untuk Penguji	**Hal yang Dinilai:** 1. Kemampuan mengidentifikasi masalah utama (kepatuhan dokumentasi rendah). 2. Kemampuan menganalisis penyebab (kurang pelatihan, sistem dianggap rumit, tidak ada panduan cepat). 3. Ketepatan menyusun strategi perubahan (sosialisasi, pelatihan, monitoring). 4. Relevansi inovasi (video tutorial, kartu saku, QR code panduan). 5. Kemampuan menjelaskan pemanfaatan informatika keperawatan (audit otomatis dan dashboard). 6. Kemampuan komunikasi dan edukasi. 7. Profesionalisme peserta. Penguji tidak diperkenankan memberikan petunjuk tambahan selain yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk Klien Standar	**Peran:** Kepala Ruangan. **Informasi yang Disampaikan Bila Ditanya:** 1. Kelengkapan dokumentasi elektronik hanya 65%. 2. Standar rumah sakit minimal 95%. 3. Sebagian perawat belum pernah mengikuti pelatihan. 4. Perawat menganggap sistem terlalu rumit. 5. Tidak tersedia panduan singkat penggunaan sistem. 6. Kepala ruangan berharap target tercapai dalam satu bulan. 7. Kepala ruangan terbuka terhadap usulan inovasi praktis dan mudah diterapkan.
10	Setting Station	Ruang Kepala Ruangan / Ruang Diskusi Manajemen. Tata letak: 1. Meja dan kursi peserta

No.	Komponen	Isi
		2. Kursi Klien Standar (Kepala Ruangan) 3. Meja penguji 4. Laptop/monitor (simulasi dashboard audit) 5. Hand sanitizer 6. Lembar jawaban peserta
11	Peralatan yang Dibutuhkan	1. Lembar soal dan lembar jawaban peserta 2. Checklist penilaian penguji 3. Laptop atau printout data audit dokumentasi 4. Grafik kepatuhan dokumentasi 5. Alat tulis 6. Stopwatch/timer 7. Laboran untuk menyiapkan station
12	Penulis	Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep
13	Referensi	American Nurses Association. (2023). *Fostering a Culture of Innovation: A Nurse Manager's Call to Action*. John P. Kotter. (2012). *Leading Change*. Elizabeth M. Borycki. (2025). Nursing Informatics Research in Review. *JMIR Nursing*. Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017–2019). SDKI, SIKI, dan SLKI. Jakarta: DPP PPNI.

SOP / Checklist Penilaian OSCE

Station: Implementasi Manajemen Perubahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Dokumentasi Elektronik Keperawatan

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
1	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan kegiatan kepada kepala ruangan	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
2	Menunjukkan sikap profesional, percaya diri, dan menjaga komunikasi terapeutik selama interaksi	☐	☐	☐	☐
3	Mengidentifikasi masalah utama bahwa kelengkapan dokumentasi elektronik hanya 65% (standar ≥95%)	☐	☐	☐	☐
4	Menggali data tambahan mengenai pelatihan staf, kendala penggunaan sistem, dan ketersediaan panduan	☐	☐	☐	☐
5	Menganalisis akar masalah secara logis (kurang pelatihan, sistem dianggap rumit, keterbatasan waktu)	☐	☐	☐	☐
6	Menjelaskan urgensi perubahan terkait mutu pelayanan dan keselamatan pasien	☐	☐	☐	☐
7	Menyusun tujuan perubahan yang spesifik dan terukur (misalnya kepatuhan meningkat menjadi ≥95% dalam 1 bulan)	☐	☐	☐	☐
8	Menyusun strategi perubahan (sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring)	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
9	Mengusulkan inovasi sederhana seperti video tutorial, kartu saku, atau QR code panduan	☐	☐	☐	☐
10	Menjelaskan pemanfaatan informatika keperawatan untuk audit dan monitoring data	☐	☐	☐	☐
11	Menentukan indikator keberhasilan dan metode evaluasi	☐	☐	☐	☐
12	Menjelaskan dampak perbaikan dokumentasi terhadap patient safety	☐	☐	☐	☐
13	Melakukan edukasi singkat kepada kepala ruangan secara sistematis dan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
14	Menjawab pertanyaan atau tanggapan kepala ruangan dengan tepat	☐	☐	☐	☐
15	Menyimpulkan rencana tindakan dan menutup interaksi dengan sopan	☐	☐	☐	☐

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Implementasi Manajemen Perubahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Dokumentasi Elektronik Keperawatan

Skala Penilaian

- **0** = Tidak dilakukan
- **1** = Dilakukan tetapi tidak lengkap/tidak sistematis
- **2** = Dilakukan cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kecil
- **3** = Dilakukan lengkap, sistematis, tepat, dan mandiri

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
1	Komunikasi dan Profesionalisme	Memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, serta menunjukkan sikap profesional selama interaksi	☐	☐	☐	☐	1	
2	Pengkajian Masalah	Mengidentifikasi masalah utama bahwa kepatuhan dokumentasi elektronik hanya 65% (standar ≥95%)	☐	☐	☐	☐	2	
3	Pengumpulan Data Tambahan	Menggali informasi tentang pelatihan staf, kendala sistem, dan ketersediaan panduan	☐	☐	☐	☐	2	
4	Analisis Akar Masalah	Menentukan penyebab utama secara logis dan sistematis	☐	☐	☐	☐	3	
5	Penetapan Tujuan Perubahan	Menyusun tujuan spesifik, terukur, realistis, dan berbatas waktu	☐	☐	☐	☐	2	
6	Perencanaan Strategi Perubahan	Menyusun langkah sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring	☐	☐	☐	☐	3	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
7	Pengembangan Inovasi	Mengusulkan inovasi seperti video tutorial, kartu saku, atau QR code	☐	☐	☐	☐	2	
8	Informatika Keperawatan	Menjelaskan penggunaan data sistem informasi untuk audit dan evaluasi	☐	☐	☐	☐	3	
9	Evaluasi dan Indikator Keberhasilan	Menentukan indikator keberhasilan dan metode evaluasi	☐	☐	☐	☐	2	
10	Edukasi kepada Kepala Ruangan	Menjelaskan rencana secara runtut, jelas, dan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	3	
11	Patient Safety	Menjelaskan dampak perubahan terhadap keselamatan pasien	☐	☐	☐	☐	2	
12	Penutupan	Menyimpulkan rencana dan menutup interaksi dengan baik	☐	☐	☐	☐	1	
		TOTAL					**26**	**.....**

II. Rekapitulasi Nilai

- Nilai Akhir = (Total Skor yang Diperoleh ÷ Skor Maksimal) × 100
- Skor Maksimal = 3 × 26 = 78

III. Kriteria Kelulusan

- ≥ 75 : Kompeten
- 60–74 : Kompeten dengan Supervisi
- < 60 : Perlu Remedial

IV. Catatan Penguji

.....

.....

V. Identitas Penilai

- Nama Peserta : .....
- NIM : .....
- Tanggal Ujian : .....
- Nama Penguji : .....
- Tanda Tangan Penguji : .....

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: Implementasi Manajemen Perubahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Dokumentasi Elektronik Keperawatan

I. Rubrik Penilaian

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
Komunikasi dan Profesionalisme	Tidak memberikan salam, tidak memperkenalkan diri, dan tidak menjelaskan tujuan kegiatan.	Memberikan salam atau memperkenalkan diri tetapi kurang lengkap dan kurang profesional.	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan dengan cukup baik, namun masih kurang sistematis.	Memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan menunjukkan sikap profesional secara lengkap dan percaya diri.	1	
Pengkajian Masalah	Tidak mampu mengidentifikasi masalah utama.	Mengidentifikasi masalah tetapi tidak sesuai dengan data.	Mengidentifikasi masalah utama dengan cukup tepat.	Mengidentifikasi masalah utama secara tepat, yaitu kepatuhan dokumentasi elektronik 65% (standar ≥95%).	2	
Analisis Akar Masalah	Tidak melakukan analisis	Analisis kurang logis dan tidak lengkap.	Analisis cukup logis namun belum komprehensif.	Menganalisis penyebab secara sistematis,	3	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
	penyebab masalah.			logis, dan komprehensif (kurang pelatihan, sistem rumit, tidak ada panduan).		
Perencanaan Strategi Perubahan	Tidak menyusun rencana perubahan.	Menyusun rencana tetapi tidak realistis atau tidak sistematis.	Menyusun rencana cukup baik namun belum lengkap.	Menyusun strategi perubahan yang jelas: sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring.	3	
Pengembangan Inovasi	Tidak mengusulkan inovasi.	Inovasi tidak relevan dengan masalah.	Inovasi cukup relevan namun kurang praktis.	Mengusulkan inovasi yang kreatif dan aplikatif, כגון video tutorial, kartu saku, atau QR code.	2	
Pemanfaatan Informatika Keperawatan	Tidak menjelaskan penggunaan teknologi informasi.	Penjelasan kurang tepat.	Penjelasan cukup tepat namun kurang rinci.	Menjelaskan pemanfaatan data sistem informasi untuk audit, monitoring, dan evaluasi secara tepat.	3	
Evaluasi dan Indikator Keberhasilan	Tidak menentukan indikator keberhasilan.	Indikator tidak jelas atau tidak terukur.	Indikator cukup jelas namun kurang lengkap.	Menentukan indikator spesifik, misalnya kepatuhan dokumentasi	2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S × B)
				meningkat menjadi ≥95% dalam satu bulan.		
Edukasi kepada Kepala Ruangan	Tidak mampu menjelaskan rencana.	Penjelasan tidak runtut dan sulit dipahami.	Penjelasan cukup jelas namun kurang sistematis.	Menjelaskan rencana secara runtut, jelas, persuasif, dan mudah dipahami.	3	
Patient Safety	Tidak mengaitkan dengan keselamatan pasien.	Penjelasan kurang relevan.	Menjelaskan hubungan secara umum.	Menjelaskan secara tepat bahwa dokumentasi lengkap mengurangi risiko kesalahan komunikasi dan terapi.	2	
Penutupan	Tidak menyimpulkan dan tidak menutup interaksi.	Menutup interaksi tetapi kurang tepat.	Menyimpulkan dan menutup dengan cukup baik.	Menyimpulkan rencana, meminta umpan balik, dan menutup dengan sopan.	1	
				TOTAL BOBOT	**22**	**.....**

Keterangan Skor

- **0** = Tidak dilakukan.
- **1** = Dilakukan tetapi tidak lengkap, kurang tepat, atau memerlukan banyak arahan.
- **2** = Dilakukan cukup baik, sebagian besar benar, namun masih terdapat kekurangan kecil.
- **3** = Dilakukan lengkap, sistematis, tepat, komunikatif, dan mandiri.

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

H. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Manajemen Perubahan , Inovasi dan Informatika Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus di Lahan Praktik
Definisi DOPS	Metode penilaian autentik melalui observasi langsung terhadap kemampuan mahasiswa saat melaksanakan tugas nyata di lahan praktik. Penilai menggunakan checklist terstruktur, memberikan umpan balik singkat, dan menentukan tingkat kompetensi mahasiswa.	Preseptor mengamati mahasiswa ketika memimpin implementasi perubahan format handover, membuat inovasi edukasi, atau mendokumentasikan asuhan keperawatan pada sistem elektronik rumah sakit.
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan secara nyata, profesional, dan efektif.	Mahasiswa dinilai apakah mampu mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengimplementasikan tindakan, dan mengevaluasi hasil secara langsung di unit kerja.
Observer/Penilai	Dosen pembimbing klinik, preseptor, kepala ruangan, atau manajer keperawatan.	Kepala ruangan mengamati mahasiswa saat melakukan edukasi kepada staf mengenai perubahan prosedur dokumentasi elektronik.

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus di Lahan Praktik
Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan saat mahasiswa menjalankan tugas nyata selama praktik klinik atau praktik manajemen keperawatan.	Pada minggu praktik manajemen, mahasiswa ditugaskan memperbaiki kepatuhan penggunaan checklist handover.
Instrumen Penilaian	Checklist observasi yang memuat aspek kemampuan analisis, perencanaan, implementasi, penggunaan teknologi, komunikasi, evaluasi, dan profesionalisme.	Preseptor menilai kemampuan mahasiswa menginput data pada Electronic Medical Record (EMR) dan menjaga kerahasiaan informasi pasien.
Aspek yang Dinilai	1) Identifikasi masalah, 2) Perencanaan perubahan/inovasi, 3) Pelaksanaan, 4) Penggunaan informatika, 5) Komunikasi, 6) Evaluasi, 7) Etika dan profesionalisme.	Mahasiswa mengidentifikasi keterlambatan dokumentasi, membuat panduan singkat, melatih staf, dan memantau peningkatan kelengkapan dokumentasi.
Umpan Balik	Penilai memberikan masukan tentang kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rekomendasi tindak lanjut.	"Mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi masalah dengan baik, namun perlu meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif kepada staf senior."
Keputusan Akhir	Hasil observasi dikategorikan menjadi Kompeten, Kompeten dengan Supervisi, atau Perlu Remedial.	Mahasiswa dinyatakan "Kompeten dengan Supervisi" karena telah menjalankan inovasi dengan baik tetapi masih memerlukan bimbingan saat evaluasi hasil.

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus di Lahan Praktik
Contoh DOPS Manajemen Perubahan	Observasi kemampuan mahasiswa menerapkan langkah perubahan terstruktur, seperti identifikasi masalah, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa menemukan rendahnya kepatuhan hand hygiene, membuat poster pengingat, melakukan edukasi, dan memantau peningkatan kepatuhan staf.
Contoh DOPS Inovasi Keperawatan	Observasi kemampuan mahasiswa menciptakan dan menerapkan solusi kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan.	Mahasiswa membuat video edukasi pencegahan jatuh pasien dan mengujinya pada pasien serta keluarga di ruang rawat inap.
Contoh DOPS Informatika Keperawatan	Observasi kemampuan mahasiswa menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dokumentasi dan pengambilan keputusan keperawatan.	Mahasiswa menggunakan sistem informasi rumah sakit untuk mendokumentasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi secara lengkap dan tepat waktu.
Bukti Performa (Does)	Menunjukkan kompetensi nyata mahasiswa di lingkungan praktik, bukan hanya simulasi atau studi kasus.	Mahasiswa berhasil meningkatkan kepatuhan dokumentasi elektronik dari 70% menjadi 95% melalui pelatihan dan panduan penggunaan sistem.
Keterkaitan dengan Piramida Miller	DOPS berada pada level tertinggi, yaitu “Does”, yang menilai performa aktual di tempat kerja.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori perubahan dan inovasi, tetapi mampu menerapkannya secara nyata dalam praktik manajemen keperawatan.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
Hakikat Portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti autentik yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa selama proses pembelajaran dan praktik.	Mahasiswa mengumpulkan proposal perubahan, hasil inovasi, dokumentasi penggunaan sistem informasi keperawatan, serta refleksi praktik selama rotasi manajemen keperawatan.
Tujuan Portofolio	Menilai perkembangan kompetensi secara berkelanjutan, mendokumentasikan proses belajar, dan memberikan gambaran utuh tentang kemampuan mahasiswa.	Dosen menilai konsistensi kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, merancang inovasi, menerapkan perubahan, dan mengevaluasi hasil.

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
OSCE dan DOPS	OSCE memberikan bukti kemampuan dalam simulasi terstruktur, sedangkan DOPS menunjukkan performa nyata melalui observasi langsung di lahan praktik.	Mahasiswa terlebih dahulu mensimulasikan presentasi rencana perubahan pada OSCE, kemudian diamati saat memimpin implementasi checklist digital handover di ruangan melalui DOPS.
Catatan Kasus Singkat	Ringkasan tertulis mengenai masalah yang ditemukan, intervensi yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh.	Mahasiswa mendokumentasikan masalah rendahnya kepatuhan dokumentasi elektronik dan tindakan perbaikan berupa pelatihan penggunaan sistem.
Refleksi Patient Safety	Uraian reflektif tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan berkontribusi terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan.	Mahasiswa menuliskan bahwa dokumentasi elektronik yang lengkap membantu mencegah kesalahan pemberian obat dan meningkatkan kontinuitas asuhan.
Feedback CI/Dosen	Umpan balik tertulis dari Clinical Instructor atau dosen mengenai kekuatan, area perbaikan, dan rekomendasi tindak lanjut.	CI menilai mahasiswa sangat kreatif dalam membuat inovasi edukasi, tetapi perlu meningkatkan keterampilan komunikasi persuasif kepada staf.
Karakteristik Penilaian	Bersifat autentik, komprehensif, longitudinal, reflektif, dan berbasis bukti nyata dari berbagai sumber.	Penilaian tidak hanya berdasarkan satu ujian, tetapi dari kumpulan bukti selama praktik, termasuk hasil implementasi perubahan dan penggunaan teknologi.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan performa yang baik secara terus-menerus, bukan hanya pada satu kesempatan.	Mahasiswa secara konsisten menghasilkan analisis masalah yang baik, mengembangkan inovasi, dan mendokumentasikan tindakan dengan akurat selama seluruh rotasi praktik.

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
Makna dalam OBE	Portofolio menjadi bukti ketercapaian CPL, CPMK, dan Sub-CPMK karena menampilkan performa nyata dan hasil belajar yang terukur.	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi kepemimpinan, inovasi, manajemen perubahan, dan penggunaan informatika keperawatan dalam praktik profesional.

Tabel. Case Report pada Manajemen Perubahan, Inovasi dan Informatika keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
Hakikat Case Report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus nyata yang ditangani mahasiswa selama praktik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan profesional.	Mahasiswa menyusun laporan tentang rendahnya kepatuhan perawat dalam mengisi dokumentasi elektronik dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di ruang rawat inap.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data, menganalisis masalah, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi, dan mengevaluasi hasil secara sistematis.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengidentifikasi akar masalah, merancang strategi perubahan, menciptakan inovasi berupa panduan cepat, dan mengevaluasi peningkatan kepatuhan dokumentasi.
Isi Laporan	Isi case report biasanya mencakup latar belakang masalah, data awal, analisis penyebab, rencana	Laporan memuat data audit dokumentasi, analisis fishbone, pembuatan video tutorial

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
	perubahan, inovasi yang diterapkan, pemanfaatan informatika, implementasi, hasil, dan pembelajaran.	penggunaan sistem, pelaksanaan pelatihan, dan hasil audit pasca intervensi.
Fokus Penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan identifikasi masalah, kualitas analisis, logika perencanaan, relevansi inovasi, penggunaan teknologi, dan evaluasi hasil.	Dosen menilai apakah mahasiswa mampu memilih solusi yang realistis dan menggunakan data sistem informasi untuk membuktikan keberhasilan intervensi.
Nilai Edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, dokumentasi ilmiah, dan refleksi praktik profesional.	Mahasiswa belajar bahwa perubahan organisasi memerlukan data objektif, komunikasi efektif, dukungan pimpinan, dan inovasi yang mudah diterapkan.
Makna dalam OBE	Dalam Outcome-Based Education, case report menjadi bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Laporan menunjukkan mahasiswa telah mencapai kompetensi dalam memimpin perubahan, menciptakan inovasi, dan memanfaatkan informatika keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
Hakikat Refleksi Patient Safety	Refleksi patient safety adalah tulisan singkat yang menggambarkan pemikiran mahasiswa mengenai	Mahasiswa merefleksikan bahwa rendahnya kelengkapan dokumentasi elektronik dapat menyebabkan informasi penting

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
	bagaimana tindakan yang dilakukan berpengaruh terhadap keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan pencegahan insiden.	pasien tidak tercatat, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pemberian obat dan miskomunikasi antar perawat.
Tujuan Refleksi	Membantu mahasiswa memahami hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan risiko keselamatan pasien serta mendorong pembelajaran dari pengalaman praktik.	Mahasiswa menyadari bahwa perubahan sederhana pada proses dokumentasi dapat berdampak besar terhadap keselamatan pasien dan kontinuitas asuhan.
Situasi yang Direfleksikan	Menjelaskan masalah nyata yang ditemukan selama praktik yang memiliki potensi memengaruhi patient safety.	Audit menunjukkan kepatuhan dokumentasi elektronik hanya 65%, sedangkan standar rumah sakit adalah minimal 95%.
Risiko Keselamatan Pasien	Mengidentifikasi potensi bahaya atau insiden yang dapat terjadi apabila masalah tidak diperbaiki.	Informasi alergi, kondisi klinis, atau instruksi terapi mungkin tidak tercatat secara lengkap sehingga meningkatkan risiko kesalahan tindakan.
Tindakan yang Dilakukan	Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan pasien.	Mahasiswa menyusun pelatihan singkat, membuat video tutorial, dan menyediakan QR code panduan penggunaan sistem dokumentasi.
Peran Inovasi	Menjelaskan kontribusi ide baru atau solusi kreatif terhadap peningkatan patient safety.	Video tutorial membantu perawat memahami penggunaan sistem secara cepat sehingga dokumentasi menjadi lebih lengkap dan akurat.

Komponen	Deskripsi	Contoh Kasus pada Manajemen Perubahan, Inovasi, dan Informatika Keperawatan
Peran Informatika Keperawatan	Menjelaskan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi keselamatan pasien.	Data audit dari sistem informasi rumah sakit digunakan untuk memantau peningkatan kepatuhan dokumentasi setiap minggu.
Hasil yang Dicapai	Menjelaskan perubahan yang terjadi setelah intervensi.	Kepatuhan dokumentasi meningkat dari 65% menjadi 95% dalam satu bulan, sehingga komunikasi antar tenaga kesehatan menjadi lebih efektif.
Pembelajaran yang Diperoleh	Menjelaskan wawasan atau pelajaran penting yang diperoleh mahasiswa.	Mahasiswa memahami bahwa perubahan berbasis data dan inovasi sederhana dapat memberikan dampak signifikan terhadap mutu dan keselamatan pasien.
Rencana Perbaikan	Menyebutkan langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil.	Mahasiswa merekomendasikan pelatihan berkala, evaluasi rutin, dan pengembangan dashboard mutu untuk pemantauan berkelanjutan.
Makna dalam OBE	Menjadi bukti kemampuan reflektif mahasiswa dalam mengaitkan teori, praktik, dan patient safety secara bertanggung jawab.	Refleksi menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menilai dampak manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan terhadap keselamatan pasien.

I. Rangkuman Materi

Manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan merupakan tiga komponen utama yang mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan modern. Manajemen perubahan membantu organisasi keperawatan beradaptasi terhadap tuntutan akreditasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat melalui proses yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Keberhasilan perubahan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, keterlibatan staf, dukungan pimpinan, kolaborasi interprofesional, serta evaluasi berbasis data.

Inovasi keperawatan merupakan upaya menciptakan atau mengadaptasi ide, metode, dan sistem baru untuk meningkatkan efisiensi kerja, kualitas asuhan, dan kepuasan pasien. Inovasi dapat berupa perbaikan alur pelayanan, penggunaan media edukasi digital, penerapan checklist, maupun pengembangan teknologi sederhana yang mempermudah praktik keperawatan.

Informatika keperawatan berperan sebagai integrasi ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi untuk mengelola data, informasi, dan pengetahuan. Pemanfaatan rekam medis elektronik, dashboard indikator mutu, telehealth, dan sistem pendukung keputusan klinis memungkinkan perawat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti.

Ketiga konsep tersebut saling melengkapi: perubahan memberikan arah transformasi, inovasi menghasilkan solusi kreatif, dan informatika menyediakan dukungan teknologi dan data. Dengan menguasai kompetensi ini, perawat dapat berperan sebagai agen perubahan yang mampu memimpin transformasi pelayanan kesehatan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, aman, dan berpusat pada pasien.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Tabel Red Flags & Eskalasi pada Manajemen Perubahan, Inovasi dan Informatika keperawatan

Nama Mahasiswa : .....

NIM : .....

Unit Praktik : .....

Tanggal : .....

Program Perubahan/Inovasi : .....

No	Red Flags	Makna Klinis/Organisasional	Tindakan Eskalasi
1	Resistensi staf yang tinggi terhadap perubahan	Perubahan berpotensi gagal karena kurangnya penerimaan dan dukungan	Lakukan komunikasi intensif, diskusi kelompok, coaching, dan libatkan pemimpin informal (*change champion*)
2	Tujuan perubahan tidak dipahami oleh staf	Menimbulkan kebingungan, kesalahan implementasi, dan rendahnya motivasi	Sosialisasi ulang visi, tujuan, manfaat, dan indikator keberhasilan perubahan
3	Kurangnya dukungan pimpinan	Program perubahan kehilangan legitimasi dan sumber daya	Eskalasi kepada kepala unit, manajer keperawatan, atau direktur untuk memperoleh komitmen
4	Tidak tersedia sumber daya yang memadai	Implementasi inovasi tidak berjalan optimal	Ajukan kebutuhan SDM, anggaran, sarana, dan pelatihan kepada manajemen
5	Inovasi tidak berbasis kebutuhan nyata	Program tidak memberikan manfaat signifikan	Lakukan analisis masalah dan kajian kebutuhan sebelum implementasi
6	Tidak ada indikator evaluasi	Keberhasilan perubahan tidak dapat diukur	Tetapkan indikator mutu, keselamatan pasien, dan kepuasan pengguna
7	Gangguan pada sistem Electronic	Dokumentasi keperawatan dan pelayanan pasien terganggu	Hubungi tim Information Technology (IT)

No	Red Flags	Makna Klinis/Organisasional	Tindakan Eskalasi
	Medical Record (EMR)		Department dan aktifkan prosedur downtime
8	Data pasien tidak lengkap atau salah input	Risiko kesalahan klinis dan keputusan yang tidak tepat	Verifikasi data, koreksi segera, dan laporkan kepada atasan serta tim IT bila sistemik
9	Pelanggaran kerahasiaan data pasien	Menimbulkan risiko etik dan hukum	Laporkan ke atasan, komite mutu, dan tim keamanan informasi
10	Staf belum terlatih menggunakan sistem informasi	Menyebabkan kesalahan dokumentasi dan rendahnya produktivitas	Jadwalkan pelatihan dan pendampingan intensif
11	Duplikasi dokumentasi manual dan elektronik	Menambah beban kerja dan meningkatkan potensi inkonsistensi data	Evaluasi alur kerja dan sederhanakan proses dokumentasi
12	Tidak ada umpan balik dari pengguna	Masalah implementasi tidak teridentifikasi	Lakukan survei, forum evaluasi, dan pengumpulan masukan berkala
13	Penurunan mutu pelayanan setelah perubahan	Menandakan perubahan belum efektif	Audit proses, analisis akar masalah, dan revisi strategi implementasi
14	Meningkatnya insiden keselamatan pasien	Perubahan berpotensi menimbulkan risiko klinis	Hentikan sementara implementasi dan lakukan investigasi
15	Inovasi tidak berkelanjutan	Perubahan hanya bersifat sementara	Integrasikan ke SOP, indikator mutu, dan budaya organisasi
16	Kurangnya kolaborasi antarprofesi	Menyebabkan hambatan koordinasi	Adakan rapat lintas profesi dan penetapan peran yang jelas

No	Red Flags	Makna Klinis/Organisasional	Tindakan Eskalasi
17	Ketidakpatuhan terhadap SOP baru	Menurunkan efektivitas perubahan	Supervisi, audit kepatuhan, dan pemberian umpan balik
18	Keterlambatan pelaporan data	Menghambat pengambilan keputusan	Tetapkan batas waktu dan sistem pengingat otomatis
19	Overload informasi digital	Menurunkan fokus dan meningkatkan risiko kesalahan	Prioritaskan data penting dan optimalkan tampilan dashboard
20	Tidak adanya budaya inovasi	Organisasi sulit berkembang	Bangun sistem penghargaan, kompetisi inovasi, dan dukungan pimpinan

Form Checklist "Saya sudah bisa…"
Bab Manajemen Perubahan, Inovasi dan Informatika Keperawatan
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan "Saya Sudah Bisa…"	Sudah	Belum	Capaian (%) / Catatan
1	Menjelaskan pengertian manajemen perubahan dalam keperawatan	☐	☐	
2	Menjelaskan alasan pentingnya perubahan dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	
3	Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan	☐	☐	
4	Menjelaskan teori perubahan Kurt Lewin (Unfreezing–Changing–Refreezing)	☐	☐	
5	Menjelaskan delapan langkah perubahan John P. Kotter	☐	☐	

No	Pernyataan “Saya Sudah Bisa…”	Sudah	Belum	Capaian (%) / Catatan
6	Menganalisis resistensi terhadap perubahan dan cara mengatasinya	☐	☐	
7	Menjelaskan konsep inovasi dalam keperawatan	☐	☐	
8	Mengidentifikasi karakteristik perawat yang inovatif	☐	☐	
9	Menjelaskan tahapan proses inovasi	☐	☐	
10	Memberikan contoh inovasi pelayanan keperawatan di rumah sakit	☐	☐	
11	Menjelaskan pengertian informatika keperawatan	☐	☐	
12	Menjelaskan manfaat informatika keperawatan dalam praktik klinik	☐	☐	
13	Mengidentifikasi komponen sistem informasi keperawatan	☐	☐	
14	Menjelaskan penerapan Electronic Medical Record (EMR) dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	
15	Menjelaskan manfaat Clinical Decision Support System (CDSS)	☐	☐	
16	Menjelaskan pentingnya keamanan data dan kerahasiaan pasien	☐	☐	
17	Menjelaskan penerapan teknologi digital dalam dokumentasi keperawatan	☐	☐	
18	Menganalisis hubungan antara perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan	☐	☐	
19	Menyusun rencana perubahan sederhana di unit keperawatan	☐	☐	
20	Merancang ide inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan	☐	☐	
21	Menggunakan aplikasi komputer untuk dokumentasi dan pelaporan keperawatan	☐	☐	

No	Pernyataan "Saya Sudah Bisa..."	Sudah	Belum	Capaian (%) / Catatan
22	Menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi	☐	☐	
23	Bekerja sama dalam tim untuk mengimplementasikan inovasi	☐	☐	
24	Mengevaluasi keberhasilan program perubahan di unit kerja	☐	☐	
25	Menyimpulkan peran perawat sebagai agen perubahan dan inovator	☐	☐	

K. Daftar Pustaka

American Nurses Association. (2023). *Fostering a culture of innovation: A nurse manager's call to action*. American Nurses Association.

Croke, E. M. (2021). Where do models for change management, improvement, and implementation research overlap? *Journal of Nursing Administration, 51*(7/8), 388–393.

Elgazzar, S. E., & Elgazzar, H. M. (2025). Nursing informatics and digital transformation in healthcare systems: Emerging trends and future directions. *Journal of Nursing Management, 33*(2), 145–154.

Healthcare Information and Management Systems Society. (2024). *Nursing informatics and digital health transformation*. HIMSS.

John P. Kotter. (2012). Leading Change. Harvard Business Review Press.

Kroning, M., & Bleich, M. R. (2024). Nurse-led innovation in healthcare delivery: Implications for practice transformation. *Nursing Management*.

McGonigle, D., & Mastrian, K. G. (2022). *Nursing informatics and the foundation of knowledge* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. *Medical Teacher, 29*(9–10), 855–871.

Press, A. N., & Jones, K. (2024). How nurses can lead innovation in healthcare. *Health Management Journal*.

Saba, V. K., & McCormick, K. A. (2021). *Essentials of nursing informatics* (7th ed.). McGraw-Hill.

Salma, U., & Waelli, M. (2022). Managing change in healthcare organizations: Implications for nursing leadership. *International Journal of Healthcare Management, 15*(4), 401–409.

StatPearls Publishing. (2022). *Change management in health care*. StatPearls Publishing.

Topaz, M., & Pruinelli, L. (2024). Advances in nursing informatics and data-driven clinical decision making. *JMIR Nursing, 7*, e58421.

World Health Organization. (2020). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.

World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. World Health Organization.

World Health Organization. (2023). *Patient safety: Global action plan 2021–2030*. World Health Organization.

Yoder-Wise, P. S. (2023). *Leading and managing in nursing* (8th ed.). Elsevier.

Zahra, S. A., & George, G. (2023). Innovation and organizational learning in healthcare settings. *International Journal of Innovation Management*.

PROFIL PENULIS



Dr. Muh. Abdurrouf, S.Kep, Ns. M.Kep Lahir di Demak, 05 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2002. Pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 sebagai dosen di Akper Islam Sultan Agung. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Sultan Agung mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan syariah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku praktik manajemen keperawatan, publikasi di beberapa jurnal terindeks SINTA, dan SCOPUS, seminar keperawatan tingkat regional dan nasiona**l.** Penulis aktif di beberapa organisasi antara lain ; pengurus Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan, Sekretaris Wilayah Himpunan Perawat Manajer Indonesia Jawa Tengah, Pengurus Lembaga Kesehatan PWNU. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: abdurrouf@unissula.ac.id



Dr. Iwan Ardian, SKM, S.Kep., M.Kep lahir di Brebes, 22 Agustus 1974. Pendidikan yang ditempuh meliputi S1 Keperawatan di Universitas Diponegoro (2001), S2 Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Airlangga (2013), dan S3 Ilmu Keperawatan di Universitas Airlangga (2023).

Riwayat pekerjaan dimulai sebagai Dosen di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) pada 2001–2007, kemudian menjadi Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (2007–sekarang). Mata kuliah yang diampu antara lain Manajemen Keperawatan , Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Pendidikan dan Promosi Kesehatan, serta Keperawatan Berbasis Syariah.

Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, memiliki banyak publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta dan internasional terindeks Scopus. Penulis juga aktif menulis buku dan artikel.

Selain itu, penulis aktif dalam organisasi profesi dan akademik sebagai Anggota Kolegium Nasional dan Pengurus MUKISI Pusat, serta menjadi reviewer untuk jurnal bereputasi dari Sinta hingga Scopus Q1 sampai Q4. Penulis dapat dihubungi melalui iwanardian@unissula.ac.id , ORCID: 0000-0002-9286-1638, Scopus ID: 6037952.

PROFIL PENULIS



(Ns. Putro Simeulu, S.Kep.M.Kep) Lahir di Meudang Ara, 09 Januari 1974, Aceh Barat Daya, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Studi Ilmu Keperawatan universitas Syiah Kuala tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2013. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai dosen tetap di Akper Pemkab Aceh Selatan, saat ini penulis menjadi dosen tetap di Prodi D-III keperawatan Banda Aceh Poltekkes Kemenkes Aceh, mengampu mata kuliah manajemen Keperawatan, Penulis Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar, penulis dapat di hubungi melalui e-mail : putroe_rafi@yahoo.co.id

Motto: Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar diri kita bermanfaat untuk orang lain.



Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Thahirah, S.Kep., Ns., M.Kep. adalah dosen pada Program Studi Diploma III Keperawatan, Fakultas Kesehatan di Universitas Salakanagara, dengan bidang keahlian Manajemen Keperawatan. Ia memulai pendidikan Sarjana Keperawatan pada tahun 2010 di UIN Alauddin Makassar dan melanjutkan Pendidikan Profesi Ners di institusi yang sama pada tahun 2014. Pendidikan Magister Keperawatan diselesaikannya pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam kegiatan akademik, karya ilmiah, dan penelitiannya, saya berfokus pada manajemen pelayanan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan, dan keselamatan pasien. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, saya berkomitmen berkontribusi terhadap pengembangan praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Motto: Terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat.

PROFIL PENULIS



Hetti Marlina Pakpahan, SKep,.Ners,.M.Kep Lahir di Pematang Siantar, 12 November1964. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan,Universitas Darma Agung Tahun 2009,Profesi Ners Tahun 2012 di STIKeS Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988- 1996 sebagai Perawat di RSU Herna Medan, kemudian menjadi Dosen di Universitas Darma Agung Tahun 1996 - 2025 Saat ini penulis bekerja di Universitas AUDI Indonesia mengampu mata kuliah Keperawatan Paliatif, Etika Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop, dan melakukan penelitian Nasional dan International dan Juga melakukan Pengabdian ke pada Masyarakat di Komunitas dan Pendidikan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail hettiskepns@yahoo.co.id
Motto: "Hidup Adalah Belajar"



Ns. Sri Hayulita, S.Kep, M.Kep, Lahir di Bukittinggi, 17 Juli 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Akademi Keperawatan Perintis Bukittinggi lulus tahun 1995, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Andalas tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai tenaga pengajar tetap di SPK Yarsi Bukittinggi, tahun 2000-2008 sebagai dosen tetap di AKPER Yarsi Bukittinggi, tahun 2008-2014 sebagai dosen tetap STKes Yarsi Sumbar Bukittinggi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Mohammad Natsir Yarsi Bukittinggi mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan dan Keperawatan Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, narasumber dilingkungan keperawatan Yarsi, dan kegiatan sosial serta penyuluhan kesehatan di masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srihayulita@gmail.com

PROFIL PENULIS



Sri Wahyuni, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Karanganyar , 25 Mei1975 . Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus patahun 2025.

Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun 2025 sebagai Dosen Part Timer di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta . Saat ini, penulis bekerja di RS PKU Muhammadiyah Surakarta dan di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan.. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriwahyuni 250522@gmail.com

Motto: “Never stop creating, as every moment is a chance to leave a meaningful legacy.

Sinopsis

Buku Ajar Manajemen Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, fungsi, dan penerapan manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar manajemen keperawatan, teori dan model manajemen, fungsi manajemen, serta peran dan kompetensi manajer keperawatan. Selanjutnya, buku membahas kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam keperawatan, termasuk kepemimpinan situasional, hubungan kepemimpinan dengan kinerja tim, delegasi, supervisi, dan kontribusinya terhadap keselamatan pasien. Aspek perencanaan strategis dan operasional unit keperawatan juga dibahas secara sistematis, mulai dari penyusunan rencana, teori pendukung, hambatan perencanaan, hingga peran kepala ruangan dalam mengelola kebutuhan unit pelayanan.

Pembahasan berikutnya berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia keperawatan melalui perencanaan kebutuhan tenaga, analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan tenaga, *staffing*, penempatan, *skill mix*, model penugasan, *scheduling*, pengelolaan shift, serta pencegahan kelelahan kerja untuk mendukung keselamatan pasien dan tenaga keperawatan. Buku ini juga menguraikan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan profesional perawat. Dalam aspek mutu pelayanan, pembaca diajak memahami konsep manajemen mutu, keselamatan pasien, insiden keselamatan, serta manajemen risiko. Materi diperkuat dengan berbagai pendekatan pembelajaran berupa *mini case*, studi kasus, aktivitas *knows how*, *shows how*, pemecahan masalah, OSCE, DOPS, latihan soal, rangkuman, serta tabel *red flags* dan eskalasi.

Pada bagian akhir, buku membahas manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemajuan teknologi. Pembaca diperkenalkan pada teori perubahan, faktor keberhasilan perubahan, konsep inovasi, informatika keperawatan, serta langkah penyusunan rencana perubahan yang dapat diterapkan dalam organisasi pelayanan. Secara keseluruhan, buku ini mengintegrasikan pengetahuan manajemen dengan kepemimpinan, pengelolaan tenaga, pengembangan kompetensi, mutu dan keselamatan pasien, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. **Buku Ajar Manajemen Keperawatan** diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan sekaligus sumber penguatan bagi pendidik, perawat klinis, kepala ruangan, dan pengelola pelayanan dalam mengembangkan praktik manajemen keperawatan yang efektif, sistematis, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.

Buku Ajar Manajemen Keperawatan disusun sebagai sumber pembelajaran yang memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip, fungsi, dan penerapan manajemen dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Pembahasan diawali dengan konsep dasar manajemen keperawatan, teori dan model manajemen, fungsi manajemen, serta peran dan kompetensi manajer keperawatan. Selanjutnya, buku membahas kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam keperawatan, termasuk kepemimpinan situasional, hubungan kepemimpinan dengan kinerja tim, delegasi, supervisi, dan kontribusinya terhadap keselamatan pasien. Aspek perencanaan strategis dan operasional unit keperawatan juga dibahas secara sistematis, mulai dari penyusunan rencana, teori pendukung, hambatan perencanaan, hingga peran kepala ruangan dalam mengelola kebutuhan unit pelayanan.

Pembahasan berikutnya berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia keperawatan melalui perencanaan kebutuhan tenaga, analisis beban kerja, perhitungan kebutuhan tenaga, staffing, penempatan, skill mix, model penugasan, scheduling, pengelolaan shift, serta pencegahan kelelahan kerja untuk mendukung keselamatan pasien dan tenaga keperawatan. Buku ini juga menguraikan manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan profesional perawat. Dalam aspek mutu pelayanan, pembaca diajak memahami konsep manajemen mutu, keselamatan pasien, insiden keselamatan, serta manajemen risiko. Materi diperkuat dengan berbagai pendekatan pembelajaran berupa mini case, studi kasus, aktivitas knows how, shows how, pemecahan masalah, OSCE, DOPS, latihan soal, rangkuman, serta tabel red flags dan eskalasi.

Pada bagian akhir, buku membahas manajemen perubahan, inovasi, dan informatika keperawatan sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemajuan teknologi. Pembaca diperkenalkan pada teori perubahan, faktor keberhasilan perubahan, konsep inovasi, informatika keperawatan, serta langkah penyusunan rencana perubahan yang dapat diterapkan dalam organisasi pelayanan. Secara keseluruhan, buku ini mengintegrasikan pengetahuan manajemen dengan kepemimpinan, pengelolaan tenaga, pengembangan kompetensi, mutu dan keselamatan pasien, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Buku Ajar Manajemen Keperawatan diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan sekaligus sumber penguatan bagi pendidik, perawat klinis, kepala ruangan, dan pengelola pelayanan dalam mengembangkan praktik manajemen keperawatan yang efektif, sistematis, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-65-1 (PDF)
9 786347 927651